

ACTAS

II CONGRESO ARGENTINO DE TERAPIA FAMILIAR

**Buenos Aires
9, 10 y 11
de Setiembre 1982**



II CONGRESO ARGENTINO DE
TERAPIA FAMILIAR
9 - 10 y 11 de Setiembre de 1982

Organizado por la
SOCIEDAD ARGENTINA
DE TERAPIA FAMILIAR

CELEBRANDO EL 4° ANIVERSARIO DE SU CREACION

COMITE ORGANIZADOR

Presidente	Dr. Alfredo Canevaro
Vicepresidente	Dr. Oscar Czertok
Secretaría General	Dr. Saúl Karol Dr. Walter Martín de Oro Dr. Alejandro Sicardi Dra. María Cristina Ravazzola
Secretaría Científica Cordinador	Dr. Luis A. Albornoz Dr. Rafael Skiadaressis Lic. Juan Carlos Nocetti Lic. Stella Maris Molina Psic. Alberto González
Subcomisión Científica	Lic. Zulema S. de Orlando Dr. Roberto Losso Lic. Eva W. de Slatopolsky Lic. María Cristina Gerlic Dr. Alberto Vázquez Lic. Jaime Szwarcstein Lic. Silvia Stuhlman Lic. Marta Nudelman
Relaciones Interinstitucionales	Dr. Saúl Karol Dr. Oscar Czertok
Secretario de Finanzas	Dr. Walter Martín de Oro

INDICE

Editorial	13
Palabras de Apertura: Dr. Walter M. de Oro	15
Relato Oficial de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar: Dr. Alfredo Canevaro	17

PANELES

Evolución de la Terapia Familiar en la R. Argentina	31
Teoría de la Terapia Familiar	55
Técnicas de la Terapia Familiar	79
Instituciones, entrenamientos y asistencia	97

WORKSHOPS:

Alcances de la terapia familiar en el alcoholismo. Indicación y contraindicación para la inclusión del paciente alcohólico en sesiones de terapia familiar: Lic. Raquel Giordano de Guilligan	117
Un aspecto del entrenamiento de terapeutas familiares; la instrumentación del Genograma: Lic. María Rosa Glasserman - Lic. Juana M. Droeven	120
Abordaje de la familia con un "paciente orgánico crónico": Dra. Analía Kornblit - Lic. Silvia Wasertreguer - Lic. Jaime Szwarsstein	122
Tres niveles de abordaje del grupo familiar: Dr. Alfredo Canevaro - Lic. Alicia Arbiser - Lic. Silvia Quaglia	124
Intersexualidad, un desafío para la estructura familiar: Dr. Roberto Losso - Lic. Silvia Morici	126
Adopción y sus dificultades. Observaciones para la prevención: Dr. Carlos María Díaz Usandivaras	128
Propuesta de un esquema psicoanalítico para el abordaje de una terapia familiar: Lic. Estela S. de Gurman y Dr. Isidoro Gurman	132

Terapia familiar - Enfoque Virginia Satir: Lic. Norma Berdichevsky - Lic. Edit Gross	133
Acerca de la predicción en la terapia familiar: Lic. Estrella Joselevich - Lic. Hugo Hirsch	135
Sobre la atención de familias en crisis por enfermedad coronaria y el control de los factores de riesgo: Dr. Luis Jait y Lic. Silvia Galay	136
Consideraciones acerca del rol de la mujer en la familia: Coordinadora, Lic. María Cristina Vila de Gerlic - Sintetizadora, Lic. Noemí Menadeba de Chebar	139
Hacia una redefinición de la femineidad: Dra. Rosa Becerra de Bonfanti - Arq. Sara Cohen de Melillo - Lic. Lilian Fischer de Arroyo - Lic. María Cristina Florez Monroy - Lic. Diana Lijalad de Bruzzo Iraola - Prof. Juana Loizaga	141
Abordaje de la crisis familiar ante el embarazo e integración del nuevo miembro de la familia (Estrategias desde un equipo de psicoprevención): Coordinadora, Lic. Hilda Schupak - Sintetizadora, Lic. Beatriz Davidson ...	142
Las etapas de la vida familiar: Lic. Rosalía Bikel	144
Sobre el análisis familiar: Dr. Rafael Skiadaressis	146
Terapia familiar con adolescentes. Presentación de un caso (Familia simulada con colaboración de los asistentes). Tratado con el modelo de terapia breve del M. R. I. de Palo Alto: Lic. Dora Abadi - Lic. Susana B. de Breyter - Dra. Ana Giller - Lic. Norma Rosso	148
Terapia familiar con niños: Lic. Celia Z. de Galperin	151
Grupo de familiares mujeres en una comunidad terapéutica: Lic. Susana Barilari - Dra. Rosalinda Gusberti - Dra. Lydia Ravaschino.	152
Tratamiento específico de la sexualidad en el marco de las terapias de pareja: Lic. Laura Caldiz - Dr. León R. Gindin	155
Aproximación al enfoque sistémico en terapia familiar: Dr. Alberto Vázquez - Lic. Zulema Storani de Orlando	157
El rol del auxiliar terapéutico: Elizabeth Rapela de Serigós	158
Psicoterapia psicoanalítica de la pareja con inclusión de técnicas psicodramáticas: Dr. Roberto Losso - Lic. Ana Packciarz de Losso	161
Dinámica de los grupos institucionales - Dr. Carlos Elinger	164
Terapia familiar sistémica: Lic. Sara Jutorán, Dra. Susana F. de Bullrich	165
Mejoramiento de la comunicación en la familia: Lic. Nidia Carranza Oviedo de Barocela - Sintetizador: Lic. Norberto Ianni	166
Modelo para una tarea psicoprofiláctica con parejas y familias: Lic. Norma Bendersky de Iurcovich	168
Comprensión desde el psicoanálisis (relaciones objetales). Abordaje desde la Teoría de los sistemas de la terapia de pareja: Lic. Viviana Loew - Lic. Guillermo Figueira	171
Un modelo de entrenamiento en terapia familiar sistémica: uso de técnicas dramáticas, videgrabación, etc. Dr. Gastón Mazieres - Dra. María Cristina Ravazzola de Mazieres - Sintetizadora, Lic. Silvia Crescini	174
Anorexia nerviosa: Dr. Juan José Morgan - Dr. José Roque Bozzo	177
Aplicación de la terapia familiar en niños y adolescentes: Dra. Anny Speier - Dra. Esnea Auletta - Lic. Ruben Vadagnel	179
De la terapia individual a la terapia de contexto: Dr. Carlos María Díaz Usandivaras - Lic. Marta Wudka de Magud	182
Terapia familiar combinada con otras técnicas individuales: Lic. Nidia Carranza Oviedo de Barocela	184
Un cuento narrado como un objeto transicional activado: Dr. Julio Correa ..	185

Enfoques básicos de psicoterapia comportamental: Terapia marital y sexual: Dr. Claudio Ague	187
La contra o anti-inteligencia en la terapia familiar: Dr. Eduardo Padilla	189
Acerca del caso Schreber. Consideraciones sobre su programación desde la perspectiva familiar: Dra. Elsa Labos y Lic. Aída Tarrab	191
Tiempo para vivir, Video Tape: Lic. Estera Goransky	193
Modelo de restablecimiento del sistema vincular como eje de la terapéutica familiar, instrumentado por el Servicio Social: Lic. Amelia Burlo Mendoza - Lic. Marta Villegas	193

SEMINARIOS

Empresas y familia, intervención en un campo transicional: Lic. Carlos E. Sebbrow	197
Residencia terapéutica intermedia: relato de una experiencia clínica en una institución abierta estructurada como familia terapéutica: Dr. Felipe Díaz Usandivaras y col.	199
Cambios en una institución derivados de la implementación del enfoque familiar sistémico: Dra. Evelina S. de Costa - Dra. Susana B. de Procupet - Lic. Ofelia Elías - Dr. Juan Enrique Kusnir - Dr. Miguel Mihanovich	202
Psicología de la vida cotidiana en el grupo familiar: Dr. Marcos Berstein ...	205
Tratamiento del grupo familiar con psicosis: Dr. Luis A. Albornoz - Dr. Saverio A. Guzzo - Dr. Norberto Mascaro - Lic. María E. Mitre - Dr. Jorge Alonso	208
Propuesta de un sistema vincular para el tratamiento de niños carenciados: Lic. Miryan Berra - Lic. María Ester B. de Martínez - Lic. María Cristina Adriano - Lic. Mónica M. L. M. de Uberto	210
El complejo de Edipo a la luz de la experiencia clínica en el tratamiento familiar con pacientes psicóticos: Dr. Jorge García Badaracco	211
Terapia de pareja: Servicio de Psicopatología. Equipo de Familia. Hospital Parmenio Piñero - Dr. Oscar Taber - Lic. María Elena Lefevre	213
Abordaje del grupo familiar en situaciones de divorcio: Lic. María Elena Gandolla de Czertok y Lic. Haydée M. C. de Toronchik	214
Organización empresarial y estructura familiar inconsciente: Lic. María del Carmen Diz - Lic. Eduardo Mandelbaum	217
Consideraciones teórico-técnicas sobre la familia con adolescentes: Lic. Rodolfo Urribarri	220
Familias adoptantes: un modo peculiar de vivir en familia: Lic. Eva Giberti ..	221
Patriarcado, familia nuclear, y la constitución de la subjetividad femenina: Lic. Gloria Bonder - Lic. Mabel Burin	223
Modelo de abordaje terapéutico en familias con niños pequeños: Lic. Fanny Cohen - Lic. Octavio García Faure	226
Terapia familiar y psicoanálisis individual: integración de recursos terapéuticos: Lic. Eduardo Mandelbaum	227
Trastornos de sueños en la primera infancia. Su relación con los conflictos de la pareja. Lic. Haydée M. C. de Toronchik	230
Los malentendidos en las relaciones de pareja: Psic. Luis Juri	232

COMUNICACIONES LIBRES

Terapia familiar - Servicio de psicopatología en un hospital general (Hospital Parmenio Piñero): Lic. Jorge Pose - Lic. Celia Margiotta - Lic. Mónica Jarak ..	235
--	-----

Psicoprofilaxis quirúrgica y familiar: Lic. María M. Ducos	237
Aproximación a la dinámica familiar e individual de los pacientes con trastornos en la adquisición del lenguaje: Dra. Susana Romero - Psic. Martha Sierra Martínez	238
CEFYP: un centro de formación para terapeutas familiares: Dr. Adolfo Loketek - Lic. Rosalía Bikel	240
Familia del obeso: Dr. Rubén Zukerfeld - Dr. Alberto Cormillot	242
Terapia familiar sistémica: un modelo de abordaje con especial referencia al funcionamiento del equipo: Dra. Norma Fucci - Lic. Elena K. de Lebensohn - Dr. Mario R. Litmanovich - Dr. Carlos Mahuad	245
Reflexiones acerca de la selección de los miembros en la terapia familiar: Dra. Laura Grinberg de Ottado - Lic. Alicia Betría - Rina Palenque de Seinfeld	246
Psicoprofilaxis del embarazo, parto y puerperio desde el enfoque sistémico: Lic. Susana Ferdkin	248
Indicación y contraindicación de terapia de pareja: Lic. Stella Maris Molina	250
Pareja adulta en "crisis de adolescencia": Psic. Nieves Labrucherie Mercón ...	252
Fantasmas que inciden e interfieren en la dinámica familiar: Psic. Rina Frugone de Valeta - Psic. Martha Sierra Martínez - Psic. Nieves Labrucherie Mercón	254
Proyecto para la prevención y asistencia de la familia: Lic. Mara Isabel Rey de Lamberti	256
Anorexia nerviosa. Una comunicación clínica: Lic. Wanda Santi	258
Reflexiones sobre el lugar de la mujer en la familia: Lic. Ana María Daskal	261
Familia. Una novela ... familiar: Lic. Estela Stilman de Gurman	263
Diferentes reflexiones sobre la diáda institución-familia: Lic. Sara Sinay de Olstein	264
Técnicas de intervención en el proceso terapéutico: Lic. Silvia Crescini - Lic. María Ester Panizo	265
Desafío de los esquemas cognitivos en psicoterapia familiar y en psicoterapia cognitiva: Lic. Nidia Carranza Oviedo de Barocela	269
Lugar de la paradoja en la terapia familiar sistémica: Lic. María Inés Dates	271
Factores obstaculizantes y facilitadores en la adquisición del rol de terapeutas de familia. Relato de una experiencia de entrenamiento: Lic. Alicia Urribarri - Lic. Sara Olstein - Lic. Fanny Baranchuk - Lic. Rosa Trajtenberg - Lic. Silvia Quaglia - Lic. Ana Claudia Laterza - Dra. Lilia Canevaro Cacchione - Dr. Lázaro Krakov - Dr. Jorge Bianchi	273
Familia terapéutica, su fundamentación: Dr. Raúl Chirinos - Lic. India Aleman	274
Teoría sistémica. Su aplicación clínica y preventiva: Dr. Eladio Murga Sague - Dr. Juan A. Barbagelata	276
Psicoanálisis y terapia familiar: algunas articulaciones: Dr. Edmundo Zimmerman	277
Constitución de un equipo de salud materno infantil en Cruz Azul - Sanatorio Quintana: Lic. Clarisa V. de Simkin	279
Estructura familiar y enfermedad somática: Dra. Flora Chade	281
Algunos cuestionamientos acerca de la función del terapeuta: Dra. María Cristina Ravazzola de Mazieres	283
El enfermo orgánico. De la relación médico - paciente a la terapia familiar: Dr. Saúl Karol	285
Un modelo de profilaxis familiar: la formación de agentes de salud: Dr. Alberto Vázquez	287

Función del asistente social en la evaluación y orientación de familias en proceso de divorcio. Algunas consideraciones teórico-prácticas: Lic. Mirtha Cimadoro	287
Los argentinos de origen judío y el conflicto de una misión imposible: Lic. Susana Muchnik	287

LABORATORIOS

Familia, comunicación y recursos expresivos (cuándo, cómo y por qué utilizarlos); presentación de un caso clínico: Lic. Eva Waldman de Slapolsky - Sintetizadora: Berta Sperber	291
Modos y niveles de comunicación: Lic. Estera Goransky	293

EDITORIAL

Este volumen contiene el material presentado en el II Congreso Argentino de Terapia Familiar que tuvo lugar en Buenos Aires, en los días 9, 10 y 11 de septiembre de 1982.

Se transcriben textualmente las palabras de apertura, el relato oficial y el desarrollo de los cuatro paneles.

A continuación se presentan resúmenes de las comunicaciones libres, los work-shops, seminarios y laboratorios, en castellano y brevemente en inglés.

Algunos de los trabajos sólo son mencionados por no cortar con los resúmenes correspondientes en el momento de esta edición.

Consideramos que parte del interés de estos encuentros se pone de manifiesto a través de las posteriores discusiones o diálogos con los asistentes, pero no hemos podido incluirlos porque no fueron registrados en las grabaciones.

No obstante, creemos que podemos estar satisfechos con la tarea cumplida. Hemos logrado, no sin esfuerzo, organizar un encuentro y registrarlo.

En este sentido queremos agradecer especialmente la dedicación del Comité Organizador del Congreso en circunstancias tan difíciles de nuestro país, ya que los acontecimientos bélicos de entonces nos hicieron postergar y reorganizar sucesivas veces el momento del encuentro.

Queremos también dejar constancia de nuestro reconocimiento a aquellas instituciones que auspiciaron este Congreso:

- Dirección Nacional de Salud Mental de la República Argentina.*
- Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo.*
- Asociación de Psicólogos de Buenos Aires.*
- Asociación Psicoanalítica Argentina.*
- Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires.*
- Universidad del Salvador.*

- *Community Guidance Center, San Antonio, Texas.*
- *Hanhemann College, Philadelphia, Pennsylvania.*
- *Mental Research Institute, Palo Alto, California.*
- *Ackerman Institute, New York.*

El mayor esfuerzo de compilación y diagramación lo han tenido las integrantes de la Subcomisión de Biblioteca y Publicaciones, las Lic. Silvia Stuhlman y Aída Tarrab, quienes con su generosa labor se han hecho acreedoras de nuestro reconocimiento afectuoso.

Cabe también una especial mención a la tarea de nuestras secretarías Julia Borzone y Verónica Thum, a nuestra editora, Patricia Luppi, y a los colegas por sus sugerencias y apoyo.

LA COMISION DIRECTIVA

PALABRAS DE APERTURA DEL II CONGRESO ARGENTINO DE TERAPIA FAMILIAR

Pronunciadas por Dr. WALTER MARTIN DE ORO

Miembro fundador de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar

Estimados Colegas: Han pasado doce años desde la realización del Primer Congreso Argentino de Terapia Familiar, evento que marcó un hito en nuestro país en el desarrollo de este particular modo de comprender la salud, y tratar la enfermedad.

En el transcurso de estos años, fue fructífero el interés en esta disciplina a lo largo de nuestro país, y en el mundo entero, desarrollándose, una multiplicidad de modelos conceptuales, encuadres de trabajo y estrategias terapéuticas, que han hecho tanto más efectivo nuestro modo de intervenir como terapeutas, pero en la misma medida se ha tornado complejo y difícil compartir e intercambiar nuestras experiencias.

Fue así como hace ya cuatro años, sentimos un grupo de terapeutas la imperiosa necesidad de crear un espacio, un lugar que hiciera posible este anhelado intercambio, y así nació "La Sociedad Argentina de Terapia Familiar", Institución que unificando esfuerzos hizo posible la realización de periódicas Jornadas de Actualización Científica, con la invitación de distinguidos profesionales argentinos y extranjeros, como así también el desarrollo de numerosos cursos y conferencias, que culminan hoy con la realización de este Congreso, que esperamos sea una experiencia intensa y enriquecedora para todos.

En nombre de la Comisión Organizadora me es muy grato dar la más cordial bienvenida a todos los colegas que hoy nos acompañan, y muy especialmente a aquéllos que han venido del exterior y del interior del país.

Con estas palabras declaro inaugurado "El Segundo Congreso Argentino de Terapia Familiar".

RELATO OFICIAL
del II Congreso Argentino de Terapia Familiar

EL CONTEXTO TRIGENERACIONAL EN TERAPIA FAMILIAR
Un modelo de investigación clínica y abordaje terapéutico

Dr. ALFREDO A. CANEVARO

Presidente y Miembro Fundador de la
Sociedad Argentina de Terapia Familiar

El objetivo de esta comunicación es revalorizar la investigación clínica en la terapia familiar y ofrecer un modelo de abordaje terapéutico de las familias disfuncionales teniendo en cuenta el contexto formado por la articulación de ambas familias de origen.

Introducción

Rastreando en la historia de la terapia familiar vemos cómo su origen se debió básicamente a necesidades de orden terapéutico planteadas por pacientes "difíciles" que no mejoraban con los métodos tradicionales de la psicoterapia. Los fracasos terapéuticos en pacientes con una gran dependencia psicológica y emocional de su entorno, como los psicóticos y los niños, indujo a muchos terapeutas, *simultáneamente*, en distintas partes del mundo, a incorporar a familiares significativos, en el ámbito del tratamiento, a fin de mejorar los resultados.(*)

En general psicoanalistas, insatisfechos con los resultados obtenidos con el método psicoanalítico tradicional de la relación bipersonal, fueron sumando silenciosamente una gran cantidad de observaciones clínicas acerca de la influencia familiar en los tratamientos.

En EE.UU., por ejemplo, la gran influencia de Harry Stack Sullivan, con su teoría de las relaciones interpersonales fue abriendo rumbos que luego siguieron algunos de sus discípulos directos como Frieda Fromm Reichman, quien acuñara el término de madre esquizofrenógena, término ya legendario, que muestra el momento histórico de esas investigaciones, o sea el pasaje del individuo a la diada, en una línea de causalidad unidireccional.

Ackerman por otro lado, desde su experiencia como psicoanalista infantil llegaba a una serie de conclusiones en sucesivos trabajos que se redondean hacia 1958 en su primer libro sobre el tema. Antes, psicoanalistas como Flügel, el mismo Adler y otros, señalaron la profunda interrelación de las patologías sobre todo trabajando en diadas madre-hijo o esposo-esposa.

Psicoanalistas de psicóticos como Bowen y Lidz fueron acuñando

observaciones y términos que señalan intentos de conceptualización de hallazgos clínicos que metodológicamente fueron ampliando el campo de investigación a la triada, y luego al entero grupo familiar. Así entonces la "masa indiferenciada del yo familiar" de Bowen o el "cisma y sesgo marital" de Lidz, la "pseudomutualidad" de Wynné a la vez que señalaban una preocupación clínica, ampliaban el campo de observación e incorporaban o extrapolaban términos de otras disciplinas. Seguimos observando una lectura de causalidad unidireccional, una connotación moralista en las descripciones y nomenclaturas y como orientación teórica, a la psicodinámica, en tanto tomaban términos extrapolados de la psicología individual o de la teoría de las relaciones objetales, ambas psicoanalíticas.

Por otro lado, Jackson, también psicoanalista de pacientes psicóticos y discípulo de Sullivan, expone sus primeras observaciones renovadoras acerca de la homeostasis, en una conferencia a la cual asiste Bateson, quien lo invita a incorporarse a un grupo de trabajo que muestra ya otra importante característica de la terapia familiar: los grupos interdisciplinarios.

Un gran antropólogo como Bateson quien venía de escribir junto a Ruesch un libro sobre teoría de la comunicación y psiquiatría, otro antropólogo como Weakland y un ingeniero en comunicaciones como Haley, se juntan para estudiar junto con el fundador del MRI, Jackson, el problema de la comunicación y el lenguaje de los pacientes psicóticos. Ahí nace el famoso "proyecto Bateson" que en 10 años que duró produjo una revolución en el campo de la terapia familiar y de la psicoterapia en general.

Por otro lado, los trabajos del biólogo von Bertalanffy y su Teoría General de los Sistemas son incorporados como marco teórico para comprender fenómenos que debían ser leídos desde distintos ángulos epistemológicos. La teoría general de los sistemas, pensada para "estudiar globalidades" según palabras de Bertalanffy, daba mejor explicación a distintos fenómenos grupales como jerarquía, organización, etc. Los trabajos de Wiener, creador de la cibernética, ofrecieron también modelos para el estudio de sistemas familiares con características disfuncionales.

Vemos entonces, en un corte histórico varios puntos conceptuales: 1o) el pasaje paulatino de la unidad de investigación y tratamiento del individuo al grupo familiar; 2o) el nacimiento de un nuevo paradigma científico que es el de la necesidad de cambiar el contexto para que cambie el individuo; 3o) la importancia de una causalidad circular interrelacionada, en lugar de una causalidad unidireccional.

Para más precisiones sobre este tema se puede recurrir al excelente trabajo de Giacometti (6), a trabajos de protagonistas como Haley (7), Bowen (3), Withaker, a estudios realizados por Zuk y Rubinstein (8) y a mis diálogos con ellos (5) que se incluirán en la bibliografía.

Basta esta introducción para señalar claramente ciertas características de la TF concatenadas entre sí.

1°) Su *delineamiento histórico como ciencia clínica* y la necesidad

de tomar conceptos "prestados" de diversas teorías para dar cuenta de resultados exitosos que no son fácilmente explicables ni siquiera hoy en día.

2°) Su carácter de *disciplina científica en formación*, para lo cual debe ir gestando una teoría que necesariamente debe ser integrada con los recursos técnicos, no por un carácter ecléctico y pragmático, sino porque el fabuloso cúmulo de observaciones clínicas y teóricas dadas por el pasaje de observación del individuo al grupo familiar en interacción necesita para su comprensión y explicación de un reordenamiento conceptual que no es nada fácil.

No obstante, es fundamental señalar que este reordenamiento no debe resignarse a la falacia de pretender tomar a un hecho como causa del otro, solamente porque el primero precede al segundo en orden temporal, lo que los clásicos llamaban *post hoc ergo propter hoc*. Una lectura causalística unidireccional de la evolución de la TF como explicada por teorías previas que fueron creadas *para comprender otros fenómenos* no hace más que poner en evidencia el componente emocional importante que subyace y codetermina la adhesión a diferentes modelos que son siempre recortes arbitrarios de una realidad que no se dirime en una sola lectura.

3°) La necesidad de enfatizar y asegurar el *carácter científico de la investigación clínica de la TF* y de la *evaluación de sus resultados*.

Recordamos al filósofo Rodolfo Mondolfo (citado por Asti Vera) (1), que decía que la investigación surge cuando se tiene conciencia de un problema y nos sentimos impelidos a buscar su solución.

En la TF es fundamental primero *delimitar el objeto de investigación*, para poder discriminar entre los múltiples aportes que se han hecho en el tema. No es lo mismo investigar las relaciones significativas del paciente, que el grupo familiar en interacción, que los sistemas familiares disfuncionales, que el proceso terapéutico de una familia, etc., etc.

Desde el punto de vista histórico, la evolución del pensamiento científico muestra el tránsito de la fase descriptiva a la experimental primero y a la deductiva luego. No obstante cabe destacar que la teoría constituye el núcleo esencial de la ciencia, sin la cual perderían sentido la descripción y la experiencia.

La epistemología define las dos características fundamentales de la investigación científica mediante dos expresiones: a) *el contexto de descubrimiento*; b) *el contexto de justificación*.

El físico y epistemólogo Jean Destouches, citado por Asti Vera (1) afirma que toda noción teórica formulada proposicionalmente, por ejemplo una hipótesis, es el resultado de un proceso mental de esquematización y de abstracción a partir de datos sensibles, pero que ninguna expresión teórica se corresponde exactamente con la realidad exterior. La elaboración de las ideas que han de constituir el punto de partida de una investigación experimental pueden ser razonamientos que apelan a la intuición, a una teoría anterior, a teorías deductivas parciales y combinadas y también a la inducción y la analogía. A esta

elaboración compleja que está en la base de la formulación de hipótesis, la llama *síntesis inductiva*.

La condición esencial del *contexto de justificación* es la *verificación*, clave del método hipotético-deductivo que caracteriza a las ciencias del hombre o ciencias fácticas (1).

El problema de la investigación clínica en TF radica en, a mi juicio, dos grandes dificultades: a) la necesidad de superar las posiciones habitualmente radicalizadas entre los "teóricos" y los "prácticos", falsa antinomia basada más en factores personales de los investigadores o en luchas de poder entre las distintas escuelas, que en reales problemas epistemológicos; b) la difícil evaluación de los resultados (teñidos todavía de mucho subjetivismo), por la carencia de métodos universalmente válidos a tales fines y por los distintos criterios de mejoría y de cambio.

Sintetizando este aspecto del comprender qué es la ciencia queremos adscribir lo que J. B. Conant (citado en 1) llama "la estrategia y las tácticas científicas" o lo que es lo mismo, cuál es el proceso de la investigación científica, a saber: a) qué relaciones vinculan la observación o el experimento con los nuevos conceptos y las nuevas teorías; b) en qué medida las técnicas nuevas modifican la investigación y c) la adecuación de las teorías a los experimentos hasta que son modificados por nuevas observaciones, por experiencias, o por una revolución teórica.

Hecha esta introducción, pasaré al siguiente punto.

— Esbozo de un modelo de investigación clínica y abordaje terapéutico de las familias disfuncionales en un contexto trigeracional.

En la investigación clínica y en la terapia se usan permanentemente modelos para pensar y accionar mejor frente a la solución de los problemas planteados. Representan el papel de hipótesis que pueden ser verificadas en los hechos y a su vez realimentadas por éstos. El peligro de los modelos es olvidarse que son *siempre* simplificaciones de una realidad más compleja y como tal, en modificación dialéctica permanente.

No obstante, son válidos si poseen *fertilidad heurística*, es decir, de acuerdo a su riqueza como fuente de experiencias, hipótesis o nuevas conceptualizaciones.

Primero me voy a ocupar de definir el *contexto familiar* que privilegio, tomando en cuenta a la familia de origen, sus distintos modos de agrupamiento y al estilo de relación configurado.

Decía en un trabajo anterior sobre la ficha clínica familiar (4), (1978), "el cuadro que resulta de la combinación entre dos personas que por el vínculo de alianza intercambian y transmiten el bagaje genético y cultural de sus grupos familiares de origen es obviamente multiforme y estará codeterminado por la influencia directa de los grupos familiares en cuestión. No obstante esto, el conocimiento que el psicoanálisis nos ha dado de las relaciones de objeto intrapsíquicas, o

la familia interna, nos permite afirmar que aún cuando ambos grupos familiares no estén en contacto personalmente, serán recreados fantasmáticamente en la relación, a través de la transferencia entre ambos cónyuges y también con su descendencia y personajes significativos que convivan con ellos.

Por su manera de agruparse, podríamos diferenciar empíricamente dos tipos de grupos: la familia *cohesiva-centrípeto* y la familia *dispersiva-centrífuga*. La combinación de estos dos grupos familiares de origen, a través del vínculo de alianza, crea un nuevo campo psicológico.

La presencia o ausencia, física o en el relato, de personajes significativos de esos grupos familiares, está condicionando un campo estructural real y virtual que, como un fenómeno de figura fondo tiene que estar permanentemente presente en el terapeuta".

Este concepto de cohesivo-centrípeto y dispersivo-centrífugo marca a la vez un *modo de agruparse* y un *estilo de relación*. En una reciente revisión de la escasa literatura mundial sobre este tema, Kelsey Smith y Beavers (7) (1981) señalan que el concepto centrífugo-centrípeto ha sido usado por antropólogos como Kroeber en 1925, etólogos (Wilson, 1975) y psicoanalistas como Erickson (1963) para describir un modo de funcionamiento sin tomar en cuenta la salud o enfermedad. Conceptos similares utiliza Stierlin (1973) al hablar del desprendimiento de los adolescentes del grupo familiar y Minuchin (1974) al hablar de familias enmeshed o disengaged. En otro reciente trabajo (2) (1981) Beavers formula un modelo sistémico de la familia basado en el trabajo clínico, que toma estos conceptos como uno de los parámetros utilizados para la evaluación de una familia dividiéndola en sanas, intermedias y perturbadas severamente, tanto en la modalidad centrípeto como centrífuga.

En general todos estos autores definen el estilo de la familia nuclear, sin tomar en cuenta a la familia de origen. Beavers en su trabajo, sin embargo, lo hace cuando dice: "Desde el punto de vista sistémico, todas las familias empiezan con la conducta y actitudes de *al menos una familia* y *usualmente dos*. La familia de origen es el modelo consciente o inconsciente que tomamos en cuenta en la vida familiar. El influye sobre la clase de intimidad o distancia entre los individuos y los distintos roles que éstos asumen. Una nueva pareja está creando algo potencialmente nuevo y diferente, nunca antes experimentado". He subrayado en el texto *al menos una familia* y *usualmente dos*, para resaltar la diferencia con este enfoque.

Yo enfatizo "el campo estructural *real* y *virtual* que como un fenómeno de figura-fondo tiene que estar permanentemente presente en el terapeuta". Es decir la unión *entre* dos familias de origen va a ser el telón de fondo en el que una nueva familia se va a desempeñar, marcando su estilo, tanto normal como patológico. Estas dos familias de origen van a existir *siempre* en la configuración aún cuando haya un solo representante, formando ese campo virtual que hay que rastrear.

A grosso modo podemos sintetizar estas características: *la familia*

CCP está más orientada hacia el adentro, el afuera es más amenazador, los límites entre los individuos son difusos, se enfatizan los valores de cariño y cercanía, los hijos se desprenden relativamente tarde, la familia DCF está vinculada hacia el afuera. Los valores no están tan referidos a la familia sino más al mundo social, los límites entre los individuos son claros, hay más rechazo a la cercanía física y a la expresión abierta de los sentimientos cariñosos. Los hijos se desprenden más tempranamente del tronco familiar.

Yendo al terreno de la expresión de la disfuncionalidad, ésta va a variar de acuerdo a la combinatoria de ambas familias de origen.

Esquemáticamente podemos plantear tres posibilidades:

a) Ambas familias poseen características cohesivo-centrípetas (CCP + CCP).

b) Una de las familias es cohesivo-centrípeta y la otra dispersivo-centrífuga (CCP + DCF).

c) Ambas son dispersivo-centrífugas (DCF + DCF).

El *estilo de relación* de la pareja será distinto y también con los hijos la expresión de la patología, y asimismo la influencia explícita o implícita de las familias de origen, de acuerdo a las distintas configuraciones se hará presente en forma habitual o en los momentos de crisis.

El valor de este modelo tiene utilización práctica porque orienta la estrategia terapéutica y la técnica a seguir, para la reestructuración menos patológica de la familia.

Por ejemplo, en el caso a) de que *ambas familias de origen posean características cohesivo-centrípetas*, la dependencia de ambos cónyuges con sus familias de origen será muy grande y la relación entre sí tiende a ser frágil e inversamente proporcional a la cercanía con la familia de origen. Este tipo de matrimonios depende mucho de la buena adecuación de ambos grupos de origen entre sí y constituyen lo que en la teoría psicoanalítica se llama una elección narcisística de objeto o "en espejo".

Ambos cónyuges tienden a considerarse parecidos y en general hay mucha similitud en los valores familiares, clase socio-económica, religión, educación, etc.

La intensidad de la relación puede ser muy grande en cuanto a expresión emocional de los conflictos, pero el grado de solidez de la pareja es bajo. Son el tipo de pareja llamada habitualmente "inmaduros" y los riesgos de separación y divorcio son mayores que en los otros tipos de configuración. La simetría de la pareja es explícita y cada uno enfrenta al cónyuge con el respaldo de la propia familia de origen, la cual tiene mucho que ver en los conflictos, por la escasa diferenciación existente entre cada miembro de la pareja y su respectiva familia. La involucración es constante y a doble vía, es decir son triangulados permanentemente o invaden a la joven pareja, según se puntúe la secuencia.

En el segundo caso, uno de los cónyuges proviene de una familia dispersivo-centrífuga y se une a otro que permanece más unido a su familia de estilo cohesivo-centrípeto.

Este estilo de formación de pareja tiende a ser más estable que la

anterior y depende mucho de la mejor o peor aceptación del cónyuge DCF, por así llamarlo, por parte de la familia. Este cónyuge tiene la característica de tener un grado *aparente* de mayor autonomía. Se ha desprendido más tempranamente de su grupo familiar de origen y ha establecido mayores conexiones con el afuera. Las características personales son de establecer mayor distancia en las relaciones objetales, a expresar menos abiertamente las emociones y a tender *aparentemente* a promover mayor independencia en sus relaciones sociales. Digo que *aparentemente* establece relaciones más autónomas, porque en *forma implícita* lleva el anhelo de relaciones más estrechas emocionalmente y se vincula a una familia con características aglutinadas, por considerar que ha carecido de ellas. Le atrae este tipo de familia, porque son más "unidos". Cuando hay patología evidente en la relación con el otro cónyuge y su familia de origen, tiende a aislarse emocionalmente y desarrollar sintomatología psiquiátrica o a establecer relaciones sobrecompensadoras con el adentro, triangulando a algunos de los hijos, o con el afuera, ya sea en el área laboral, ya sea en relaciones extramatrimoniales.

Es interesante señalar en este punto que la falta de comprensión del contexto familiar por parte de algunos terapeutas hace que tomen a estos pacientes en terapia individual, sin darse cuenta del rol que desempeñan en esta situación. Así en la mayor parte de los casos son "triangulados" por la conflictiva y son ineficaces por funcionar como reguladores homeostáticos de un sistema o bien contribuyen a una ruptura matrimonial que con otro enfoque podría ser resuelta de manera más exitosa, incorporando una óptica más abarcativa y una técnica más integradora.

Volviendo a las características de formación de pareja en esta configuración, podemos decir que tiende a una insatisfacción crónica, con una simetría encubierta y son de aquellos que "viven separándose", pero que raramente lo efectivizan. Es la estructura de una familia en la cual los hijos juegan un rol estabilizador más evidente y en estos casos cuando la sintomatología disfuncional se expresa en uno de los hijos, está generalmente referida a la estructura subyacente de la familia de origen DCF, tanto paterna como materna, como si la sintomatología expresara la necesidad de balancear áreas de predominio asimétrico de ambas familias de origen.(**) Es decir, la sintomatología del hijo enfermo tiende a referirse a figuras significativas de la familia de origen DCF en el sentido de las identificaciones o a patrones interaccionales de la misma. Esta vinculación tiene el sentido de llenar necesidades afectivas del padre DCF, no satisfechas en la familia actual.

El tercer grupo, cuando ambos cónyuges provienen de familias de origen dispersivo-centrífugas conforman una pareja particular que tiende a concentrar excesivas funciones compensatorias de la carencia anterior. Son parejas que tienden a ver en el cónyuge un padre-esposo-hermano, etc., madre-esposa-hermana, etc., sobrecargando emocionalmente la relación y conformando un círculo vicioso de dependencia y exigencia. Rara vez se separan, aún cuando el nivel de frustración es

alto y cuando tienen descendencia, tienden a conformar con sus hijos una familia de modalidad CCP.

Distintos niveles de abordaje terapéutico:

Partiendo del modelo anterior un tanto esquemático pero útil clínicamente, el abordaje estratégico de la familia va a variar de acuerdo no sólo al problema presentado sino también a la *configuración contextual que determinen ambos grupos de origen*.

Una terapia familiar *no puede no ser sistémica* en cuanto a que el grupo familiar es un sistema viviente, con una determinada estructura y jerarquía. Lo que varía dentro de los estilos de los terapeutas familiares es su énfasis en determinados aspectos, ya sea del intrapsiquismo cuando privilegian al individuo sobre sus relaciones significativas, ya sea de las reglas disfuncionales del sistema, cuando privilegian a éstas como organizadoras del estilo característico de cada familia, ya sea al centrarse en la reestructuración de los subsistemas familiares cuando la rigidez de las coaliciones impiden el libre conocimiento de sus miembros.

Vamos a tratar de desarrollar brevemente un modelo operativo de abordaje que tenga en cuenta tres niveles de integración dentro del sistema familiar que son progresivamente abarcativos e incluyentes, con una jerarquía de organización en el que cada nivel resume a los que le son inferiores y que representan un recorte arbitrario de una realidad mucho más compleja y polifacética.

Estos tres niveles, dentro de una estratificación más amplia de los sistemas humanos, recortan el área específicamente familiar y definen un contexto en el cual el individuo crece y va adquiriendo su identidad. Por lo tanto, son inseparables entre sí, en tanto conforman una red intersubjetiva y relacional que deja una impronta en cada uno de los miembros del sistema. La esquematización es a simples fines didácticos. En el primer nivel, individual-intrapersonal cada uno de los miembros del sistema es visto en su mayor originalidad, desde un punto de vista descriptivo sin entrar a considerar si ésta depende de una relación complementariamente patológica en el terreno de las relaciones interpersonales, como se verá en el segundo nivel.

Es un nivel que golpea a la vista, no sólo porque habitualmente se hace presente en la función del paciente designado sino también porque es uno de las principales vías de acceso a un sistema familiar estratégicamente hablando. Este nivel tiene también su importancia en la evaluación del proceso terapéutico de una familia, ya que uno de los objetivos principales de la terapia familiar es el logro de una adecuada personalización y autonomía de cada uno de sus miembros en el sentido de una mayor libertad en el logro de su proyecto vital.

Comprende básicamente los niveles cognitivos y afectivos de la persona como así también su conducta. Los mecanismos de defensa intrapersonales están considerados de acuerdo a la posición ocupada dentro del sistema y en relación con los demás miembros del sistema y

también por el peculiar modo de enfrentar las crisis vitales de éste. *Las fronteras individuales* representan el foco de mayor atención y su mayor o menor grado de claridad estará relacionado con los demás integrantes de la familia en los distintos niveles de interacción e integración. Es decir, el esfuerzo en el operador está destinado a captar la originalidad del individuo, en la dimensión de su verdadero self, o sea a la especial configuración interna del precipitado de identificaciones que provienen en su parte principal de la red intersubjetiva que lo une a sus parientes significativos y que constituye la trama que emergerá en el segundo nivel de abordaje que llamamos *relacional-interpersonal*. Este está representado por la red de interacciones que son determinadas por las distintas alianzas, coaliciones y triangulaciones en el interior del sistema familiar y en referencia al contexto de unión de ambas familias de origen. Aquí el foco de mayor atención estará dirigido a las defensas transpersonales en el sentido como lo describió Laing (acciones destinadas a corregir y controlar la conducta de los demás para preservación del propio equilibrio intrapsíquico). Asimismo el *grado de definición de la relación*, en el sentido expresado por Haley, Watzlawick y col. va a mostrar el estilo peculiar de cada familia en el nivel interpersonal.

Este es un nivel menos aparente que el primero y debe ser rastreado activamente desplazando el foco de atención del paciente designado a las relaciones significativas del sistema.

Es el plano ideal para estudiar las relaciones de complementariedad patológica (como lo describiera Boszormenyi-Nagy) y las "lealtades invisibles" (concepto del mismo autor junto con G. Spark) así como las simbiosis narcisísticas ampliamente descritas en la literatura de orientación psicodinámica. Las asimetrías de las relaciones de poder (concepto de Haley) se evidencian en este nivel así como las distintas coaliciones y los procesos de victimización (búsqueda de un chivo-emisario). Es éste el nivel donde se pueden ejercer más claramente las técnicas de reestructuración descritas por Minuchin y las del Go-between process de Zuk.

Finalmente el tercer nivel o *grupal-sistémico* es aquel donde el grupo se recorta más o menos nítidamente en sus fronteras por un lado con las familias de origen y por otro con los macrosistemas comunitarios (trabajo, escuela, amigos, etc.).

Es el nivel definido por las *reglas del juego* de cada familia y que particularizan a cada grupo familiar (recordar el concepto de "cerco de goma" y "pseudomutualidad" descriptos por Wynne en las familias disfuncionales).

El foco de mayor atención está en las reglas del sistema y en su mitología. Es el nivel privilegiado para las prescripciones paradójicas sistémicas con el estilo del grupo de Milán (Selvini Palazzoli y col.). Es un nivel que exige una mayor abstracción del impacto de lo aparente y es mejor estudiado tomando cierta distancia emocional del sistema o

con resguardos técnicos (cámara de Gesell, discusión con el equipo, etc.).

Articulación de los distintos niveles en el proceso terapéutico del grupo familiar.

Dentro del estilo personal de cada terapeuta y del training específico que haya tenido podríamos decir que todo terapeuta debiera utilizar distintos abordajes para cada momento especial del proceso terapéutico y para cada nivel que desee explorar efectivamente.

En un abordaje estratégico de la familia el primer nivel encarado es *el manifiesto a través del paciente designado* (previa hipótesis formulada del campo estructural más amplio y de la función que cumple el paciente designado dentro del sistema). De acuerdo a la respuesta de la familia decidirá si continuar *a través del paciente* hacia lo relacional-interpersonal o si deberá pasar abruptamente al tercer nivel elaborando un abordaje contraparafrástico que desequilibre momentáneamente el sistema para poder pasar nuevamente al segundo nivel con técnicas que representen un mayor acercamiento a los miembros del sistema y una mayor interacción con ellos.

Técnicas de acción terapéutica como confrontación, reestructuración y de abordaje gestáltico destinadas a una mayor movilización emocional y desestructuración de defensas patológicas son probablemente la vía de mejor abordaje del grupo para promover un mayor acercamiento afectivo y posibilitar la instauración de un diálogo *"persona a persona"*.

Las técnicas paradojales de intervención sistémica son ideales, a mi juicio, en el tercer nivel para los "impases terapéuticos" o para el abordaje de grupos severamente disfuncionales. Producido el "descongelamiento", por así decir, permite el compromiso emocional del terapeuta en un contacto más estrecho con cada uno de los miembros del grupo, en tanto se introduce dentro del sistema como una variable modificadora. Este compromiso emocional es el que le permitirá adentrarse en las características de cada miembro, tratando de definir su singularidad y de ayudarlo a reencontrar su verdadero self (en el sentido de Winnicott).

Resumiendo, la estrategia terapéutica global deberá encararse previo diagnóstico de la situación contextual determinada por la configuración formada por el enoentro de ambas familias de origen.

En el primer caso configuración CCP + CCP la estrategia estará destinada a ayudar a ambos cónyuges a madurar y desprenderse de ambas familias de origen. El T. debe situarse *entre las familias de origen y la familia nuclear* y convocar físicamente o en el relato a los representantes de las familias de origen, procurando entender cuáles son los mecanismos disfuncionales que impiden el adecuado desprendimiento de los cónyuges de cada familia de origen. La confrontación entre ambas generaciones y la búsqueda de una fluidez más armónica

entre ambas corregirá automáticamente la distancia emocional entre los cónyuges o la designación de algunos de los hijos.

En el caso CCP + DCF, la estrategia consistirá en colocarse entre los padres y los hijos (habitualmente involucrados en la patología para balancear áreas asimétricas de los padres) y alternativamente entre el cónyuge CCP y su familia de origen. Asimismo tenderá a convocar familiares significativos de la familia de origen DCF, en presencia o en el relato, a fin de evidenciar y corregir la soledad y las carencias emocionales del cónyuge DCF, sobrecompensadas en la patología.

En la configuración DCF + DCF el T. tiene que colocarse entre los cónyuges y los hijos, para evitar que se recree con ellos una relación espuria que en realidad representa a miembros de ambas familias de origen. Esto es la esencia de la llamada "parentalización" de los hijos. El T. destriangulando a los hijos permite esclarecer una situación confusa y confusional y puede pasar a ayudar a los cónyuges a rescatar vínculos significativos con familiares de origen o si esto no es posible, procurar la concreción de una red de pares que los sustituyan.

Para terminar, es importante percibir que un sistema familiar entra en ciertos comportamientos reiterativos y estereotipados característicos de sistemas cerrados cibernéticos, cuando no hay una adecuada *trascendencia* de una generación a otra, de los mandatos afectivos y culturales que permiten la supervivencia de las personas más allá de su muerte física. La difícil elaboración de la propia muerte, duelo básico del ser humano, es la base del mecanismo de desconfirmación que la generación anterior hace de la generación siguiente como continuadora de ella en el curso de la vida. La incomprensión de esta motivación profunda hace que ciertos enfoques sistémicos reduccionistas tiendan a segregar brutalmente a la generación anterior sin tomar en cuenta los equilibrios ecológicos de una familia. Es una clásica posición moralista de victimario, repitiendo los errores del psicoanálisis de otras épocas, cuando segregaba al paciente de sus familiares, en aras de un culto a lo individual. Hoy en día, segregar a la familia nuclear de la familia de origen no hace más que perpetuar ese desencuentro terapéutico. El respeto de la *armonía* entre una generación y la otra es lo que permite que la tarea del terapeuta familiar sea no sólo reestructurante sino también preventiva y es la que permite que la terapia familiar se convierta en una experiencia correctora y existencialmente significativa.

Agradezco a la Lic. ALICIA ARBISER la posibilidad de haber discutido con ella algunos de los conceptos desarrollados en este trabajo.

* Cabe señalar que en nuestro país, las primeras orientaciones en el trabajo con pacientes psicóticos y sus familias fueron iniciadas en la década del 50 por Enrique Pichon Rivière, y una década más tarde por Jorge García Badaracco, ambos primeros en este campo.

** Debo señalar aquí que en mis investigaciones clínicas no se corroboró sino en forma parcial la hipótesis de Isidoro Berenstein sobre la influencia decisiva de la familia materna en la patología de la familia nuclear (cf. Berenstein, Isidoro, Familia y Enfermedad Mental. Editorial Paidós, Bs. Aires, 1976).

PANELES

EVOLUCION DE LA TERAPIA FAMILIAR EN LA ARGENTINA

Dr. OSCAR CZERTOK; Dr. MARCOS BERSTEIN; Dr. FERNANDO TARAGANO; Dr. JORGE GARCIA BADARACCO

Coordinador: Dr. SAUL KAROL

Presentación de los panelistas:

El Dr. Taragano es fundador de la Teoría del Psicoanálisis Gestáltico, es Director de la Escuela de Psiquiatría Psicoanalítica Gestáltica.

El Dr. Oscar Czertok es Miembro Adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina y es Miembro Fundador de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar.

El Dr. Marcos Berstein es Médico, Profesor y Supervisor en la Escuela de Psicología Social fundada por el Dr. Enrique Pichon-Rivière, es Profesor Invitado de la Universidad Nacional Autónoma de México y es Consultor de las Naciones Unidas para la Organización Mundial de la Salud.

El Dr. Jorge García Badaracco es Presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Fundador en 1968 de la Comunidad Terapéutica Psicoanalítica.

Dr. Saúl Karol: Nosotros habíamos pensado para esta mesa, que partiendo de la evolución individual de cada uno, marcásemos cómo habíamos encontrado la Terapia Familiar. ¿Desde qué plano se enfatizaba el interés surgido hacia la terapia familiar? Habíamos pensado que podía ser desde el tratamiento de la psicosis, desde el abordaje de problemas en Pediatría, desde la enfermedad orgánica, desde limitaciones y para el enriquecimiento de la terapia individual. Preguntábamos en ese camino cómo se veían las experiencias concurrentes de otros campos de conocimiento, la antropología social, la sociología, etc.

También si se pensaba que la eclosión de la terapia familiar se inscribía en algunas condiciones sociales, económicas, técnicas, etc., que la posibilitaran y si se pensaba que experiencias extranjeras habían sido las más relevantes, cuáles eran ellas y si había dificultades para su aplicación en nuestro país. Esta era una guía tentativa, que entendemos seguirá siendo válida en nuestro afán de integrar tendencias y

escuelas para una psicoterapia que tome en cuenta también lo peculiar de la conformación de la familia argentina. Hoy dejamos para este panel más abierta la creación. Comenzamos entonces.

Dr. Oscar Czertok: Los terapeutas familiares de raigambre psicoanalítica nos basamos en una técnica terapéutica, en un método de investigación, en una teoría general del psiquismo, interdependientes.

La relación bipersonal del psicoanálisis, que es un encuentro entre dos maneras de aprender a relacionarse deviene en la Terapia Familiar en una intervención del terapeuta en un sistema: la familia; un sistema que ante esta intervención ofrece resistencias a cambiar, con el objeto de subsistir como sistema.

Un gran mérito del Psicoanálisis ha sido intuir, delinear, demostrar la existencia en el individuo de sistemas en interacción, y al individuo mismo como resultado, o como generador de sistemas en interacción. Aprendimos de Enrique Pichon-Rivière sus concepciones sobre el abordaje del mundo interno del sujeto desde el contexto interaccional. De José Bleger su nosología familiar. De David Liberman sus integraciones sobre las ideas de G. Bateson, confrontando teorías de la interacción y la comunicación con las de la transferencia. De E. Liendo sus estudios sobre procesos de identificaciones cruzadas en la pareja relacionadas con las correspondientes identificaciones con la familia de origen. De J. García Badaracco por su personal capacidad para el tratamiento de pacientes psicóticos, sus concepciones sobre el proceso terapéutico, sobre comunidad terapéutica psicoanalítica, visualizados desde el ángulo que entiende a la familia como lugar de constitución del sujeto y a la comunidad terapéutica como un núcleo multifamiliar de reaprendizaje. Debemos a Carlos Martínez Bouquet, Rojas Bermúdez, y otros, el habernos enseñado a trabajar psicodramáticamente la escena en la sesión. A I. Berenstein su teoría sobre la estructura familiar inconsciente fundada en estudios de L. Strauss sobre antropología estructural, situando la visión del TF más allá de los presentes en la sesión, abarcando estructuras que tienen vigencia en el devenir de la pareja. Carlos Sluzki, presidente del Primer Congreso de Psicopatología del Grupo Familiar de 1970, se coloca entre los pensadores argentinos que trabajaron entre nosotros concepciones sistémicas.

En 1978, acompañando los esfuerzos del Dr. A. Canevaro, decidimos fundar la Sociedad Argentina de Terapia Familiar. Habían pasado algo más de 7 años de aquel Primer Congreso que concitara tanta creatividad, que fuera volcada en un libro editado por ACTA, que a pesar de que se agotara casi inmediatamente no tuvo más ediciones. Desde su fundación, asumiendo su calidad de institución madre de la Terapia Familiar, la Sociedad se ocupó de traer a la Argentina para que pudiéramos contactarlos en el más alto de los niveles, a autores conspicuos de la especialidad de gran resonancia en el mundo: personalidades como D. Rubinstein, G. Zuk, I. Zwerling, Ficher, J. Weakland, M. S. Palazzoli, G. Prata, A. Nicolo, etc.; se integraron así a nuestro acervo científico con muchos otros que han ocupado

nuestras mesas de conferencias y las páginas de la Revista de TF, única en Sudamérica. Con ellos vivimos jornadas de aprendizaje y encuentro afectivo. Cuando nos visitó Rubinstein, más allá de su enfoque ecológico de la esquizofrenia, de las diadas depresivas, que llevan a pensar el desarrollo de la libido en función del desarrollo de esas mismas etapas en los progenitores, me impresionó el tipo de medios utilizados para lograr "efectos terapéuticos". Por ejemplo sus habituales indicaciones para cambiar de ubicación espacial a los miembros de la familia en la sesión, su propia ubicación en distintos espacios, incluso sentado en el suelo, en busca de una situación determinada conducente a producir lo que entre nosotros García Badaracco denomina "experiencia compartida correctora". Bateson dice: "La interacción de las partes del espíritu es desencadenada por la diferencia". La posibilidad de producir diferencias de percepción tanto en la familia cuanto en el terapeuta es algo a lo que fuimos habituándonos en el contacto directo con estos autores que conciben estructuras familiares en interacción y maniobran con ellas.

Nuestro contacto permanente con la diversidad de autores jalona etapas de afirmación en la identidad ideológica del terapeuta familiar, que indudablemente han de combinarse con etapas de duda y búsqueda, en que lo desconocido ha de ser reconocido por cada uno de nosotros, si necesario redefinido, para su adecuado ingreso al circuito TEORIA-INVESTIGACION-TECNICA que cada terapeuta viene elaborando desde el comienzo de su formación. Es imposible pensar en un terapeuta formado por la memorización de una serie de maniobras más o menos eficaces.

Ese contacto con diversos autores concita una natural tendencia a comparar e integrar. Por ejemplo, J. Haley (*Estrategias en Psicoterapia*) define el concepto de coalición: en una triada (tres personas no pares pertenecientes a distintas generaciones) un miembro de una generación hace coalición con un miembro de otra, ambos contra una tercera. Haley señala que la coalición genera organizaciones disfuncionales que producen enfermedad mental. I. Berenstein, por su parte, señala que "una seria perturbación mental se genera cuando un sujeto queda expuesto a un conflicto permanente y a una oposición competitiva entre vínculo de alianza y vínculo con la familia materna. En el caso de predominio de este último sobre el primero se dan condiciones para producir desorientación, confusión, desrealización, despersonalización. Se genera una escisión en la mente del Hijo". Es decir, cuando la alianza entre los padres (Haley opone el concepto de coalición al de alianza, que es cuando dos miembros comparten un interés común pero no en contra de un tercero) es interdicta por la familia de origen se produce la coalición patogenética entre un padre y el hijo. Haley estudia el plano de la comunicación y la interacción. Berenstein analiza el plano de la estructura familiar inconsciente. Este hará hincapié en generar insight, en explorar las manifestaciones de ese inconsciente familiar, en avanzar hacia la comprensión. Aquél obviará todo esto y se preocupará por producir un cambio, una diferencia en el sistema. Pero

ambos hablan de un mismo fenómeno: la enfermedad mental como emergente de la perturbación o disfunción familiar. Haley considera que la sintomatología se instala cuando luchan jerarquías incongruentes: entonces será importante dejar sentada una clara organización jerárquica y reestructurar el sistema; las incongruencias tienen que ver con coaliciones que se hacen letales cuando son negadas u ocultadas. Berenstein piensa en la intromisión de la familia materna, eje de las jerarquías a que alude Haley. Serge Leclaire, autor psicoanalítico, a propósito de este concepto de coalición, expresa: "Mi oído, el verdadero, se abrió" cuando Philon, su paciente, un día le dice que no lograba romper el apego hacia su madre... "¿Apego?", pregunta S. Leclaire. "Sí", contesta Philon, "se trataba... de un secreto, de una connivencia, de una intimidad secreta". Leclaire plantea que ese anclaje en la "intimidad secreta" lo fija en la primitiva relación con la madre y le impide resolver el Edipo. Nuevamente la patogeneidad de la coalición... El tratamiento de enfermedades narcisísticas nos familiarizó desde un principio con la necesidad de integrar recursos, dentro de un marco de comprensión psicoanalítica y nos fue fácil y placentero aprender con los diversos autores sus nuevas técnicas, sus nuevas teorías, aunque siempre parecía surgir el parecido de lo nuevo con lo ya conocido; los conceptos de Bleger sobre simbiosis, con su escala de mayor a menor fusión en la familia, que fueron objeto de una aplicación tan oportuna como la que nos presentó hoy el Dr. Canevaro, los vemos ampliados, detallados, publicitados a nivel internacional a través de conceptualizaciones como las de M. Bowen de masa indiferenciada de egos, y de B. Nagy, sobre fusión intersubjetiva.

Por mi parte me he preguntado por qué el Psicoanálisis se ha quedado fijado por decirlo así, en la relación bipersonal como modelo terapéutico, dejando en un cono de sombras, muchas veces intuida, algunas veces apenas nombrada, otras totalmente escotomizada bajo la pretensión de una simbolización transferencial, la familia del paciente. En esa relación bipersonal el surgimiento de la transferencia es una prueba de la existencia del inconsciente, de la pulsión repetitiva, y la ortodoxia del método psicoanalítico requiere la exclusión de la familia del paciente, como condición para salvaguardar los estándares del proceso. Por su lado la Terapia Familiar sería entonces la única manera de probar la existencia de una estructura inconsciente más abarcativa de la situación origen del recuerdo, estructura en que están presentes con su cuerpo todos los actores del drama que motivó la carencia. ¿Es preciso entonces que Psicoanálisis y Terapia Familiar estén en campos opuestos?... ¿Estaré simplificando demasiado mis interrogantes?...

Freud en *El Hombre de los Lobos* ha hecho votos por el progreso del método psicoanalítico. Pienso que la TF es uno de los caminos por los que transcurrirá ese progreso.

Otros autores psicoanalíticos, como M. Abadi, E. Salas, han desarrollado trabajos sobre un elemento que permite visualizar, maniobrar con la dinámica de la familia a la manera de una ecuación algebraica. Se trata de la Función en la Familia: la función paterna;

la función materna. Se entroncan con la teoría del Edipo y la de Estructura Familiar Inconsciente de Berenstein.

El estudio de la enfermedad mental se desarrolla en una espiral en que diferentes investigadores producen incrementos de saber sobre fenómenos similares. A medida que el conocimiento avanza aparece un incremento en la comunicación sobre los hallazgos. Subimos hacia la punta de la Torre donde han de encontrarse diferentes corrientes para dirimir sobre los conceptos esenciales. Y es allí donde tropiezan con las "DIFERENCIAS DE LENGUAJE" que obran a modo de bastiones. El mito bíblico de la Torre de Babel, del que parece participar el desarrollo de los conocimientos sobre la naturaleza del hombre, sugiere un vértice, un tope que obstaculizará el avance: "Cuando quieran encontrar a Dios se van a pelear porque no se van a entender". Participamos de un sistema que impide en cierto punto el desarrollo del conocimiento? Existe una fuerza inconsciente (Narcisismo?) que nos dice "hasta aquí" "no avanzar"?

Una labor que quizás quede reservada a los clínicos, es p. ej. la de deslindar y acortar las diferencias entre teorías que apuntan al insight como base del cambio terapéutico y las teorías que consideran al insight innecesario y perjudicial, puesto que rechazan la idea de la existencia del inconsciente, buscando el cambio mediante maniobras dirigidas a la familia como sistema que se defiende de la intervención terapéutica. Quisiera leerles un trozo de J. Framo, Filadelfia, de la RTF. "Mi propia filosofía terapéutica es la de aprender tantas formas de abordaje como sea posible para tener un repertorio completo de técnicas disponibles para modificar el sistema. Concurro a w-sh. de análisis transaccional, guesáltica, técnicas de encuentro, terapia conductal, racional-emotiva, existencial, lo mismo que todos aquellos métodos de trabajo fuera de mi propia orientación tal como escultura familiar. Uso técnicas de la teoría psicodinámica, de la comunicación, de la terapia de grupo, instrucciones paradójicas, audio y video playback, cualquier cosa que necesite para mover un sistema".

Es esperable que los trabajos psicoanalíticos a su vez han de ser impregnados por las experiencias de los TF, y la clínica, la teoría, y la investigación en ambos campos terapéuticos, el familiar y el individual, vayan enriqueciéndose mutuamente. Como ejemplo podemos citar a un especialista de la terapia grupal, como Didier Anzieu, que ha abordado en un artículo titulado "Transferencia Paradójica" concepciones como las de Doble Vínculo, y la Paradoja, en un tratamiento individual.

Considero que un aspecto fundamental de la tarea que tiene asignada esta Sociedad es la de permitir el encuentro de las distintas ideologías, de los distintos grupos que las detentan.

Dr. Marcos Berstein: La excelentísima disertación que hizo el Dr. Oscar Czertok desarrolla parte de lo que yo pensaba hablar. Es una magnífica exposición de la evolución histórica a través de los distin-

tos autores, especialmente dentro de la Argentina. Entonces yo voy a comenzar por responder a la pregunta con la cual se iniciaba el cuestionario que nos hicieron llegar, que se refería a cómo surge en mí el interés personal en la Terapia Familiar.

Al hacerme esa pregunta surgieron en mí dos respuestas. Una desde el hemisferio izquierdo y otra desde el hemisferio derecho. Esto no es una expresión de disociación esquizofrénica; ni tampoco tiene connotaciones políticas, ni de izquierda ni de derecha. Simplemente me refiero a una respuesta eminentemente racional, intelectual, lógica, que viene desde el hemisferio izquierdo, y que apunta a mis primeras terapias, en donde me encontré con que los pacientes que yo veía en terapia individual, venían con una problemática que indefectiblemente me llevaba a investigar qué es lo que pasaba en su grupo familiar. Pero no para verlo desde afuera, sino para meterme desde adentro. Y en este sentido, jugó en mí un papel muy importante mi formación al lado de Enrique Pichon-Rivière. Yo pienso que todos hemos recibido una formación aquí en la Argentina, proveniente de muy distintas escuelas. Oscar Czertok mencionó a Pichon-Rivière, a Liberman, a Bleger, al Dr. García Badaracco, a quien tenemos aquí hoy, quienes han desarrollado el abordaje de la terapia familiar desde hace ya mucho tiempo.

Yo voy a detenerme específicamente en el aporte de Pichon-Rivière, porque tuve la suerte de poder trabajar con él los últimos 15 años de su vida, muy cercanamente, y aprovechar entonces de su talento creativo.

Este enfoque que les enuncio ahora, lo voy a hacer desde el hemisferio izquierdo. Después vamos a volver a él, pero les quiero decir primero cuál fue la respuesta que me surgió a mí desde el hemisferio derecho, es decir, desde lo emocional, desde lo afectivo. Yo creo que mi interés en la terapia familiar proviene de una búsqueda de conocimiento y comprensión de mi propia historia grupal familiar.

Y creo que quien más, quien menos, todos los que nos dedicamos a esto, tenemos algo de esa inquietud. Y que todas las situaciones conflictivas que vemos en los grupos familiares que atendemos, nos movilizan constantemente escenas de nuestra propia historia grupal familiar.

En ese sentido cada vez que con un grupo yo me siento ansioso, angustiado, paralizado, no sé qué hacer, no entiendo qué pasa, me pregunto: ¿qué me estará moviendo de mi propia historia esta escena de este grupo familiar del aquí y ahora?

Muchas veces, la respuesta que encuentro me permite tomar distancia y hacer una lectura que siempre es enriquecedora. Les quiero agregar algo que está relacionado con mi propia historia grupal familiar. Mi nombre, Marcos Bernstein, era el nombre de mi abuelo -paterno. Curiosamente, en mi grupo familiar nunca se habló mucho de él, a pesar de que yo llevaba su nombre. Ustedes saben que hay culturas y religiones en donde a los hijos que nacen se les

pone el nombre de los padres; en otras religiones el nombre de los abuelos; en unas si están vivos y en otras solamente si es que están muertos. En mi caso, yo nací muy poco tiempo después de que muriera mi abuelo, ya que mi madre estaba embarazada cuando él murió. Bueno, no es necesario explicitar las fantasías inconscientes, y a veces conscientes, de reencarnación y continuidad que existen en un grupo familiar cuando se le pone el nombre de alguien que ha muerto a alguien que nace. Fantasías que van acompañadas de adjudicación de roles.

Yo hace 23 años que me dedico con mucha pasión a la docencia, desde el año 59, exactamente, en que empecé la docencia en la Facultad de Medicina. Recién hace relativamente pocos años que, indagando en mi propio grupo familiar encontré que había una parte de la historia que yo no conocía. Mi abuelo había sido Profesor de Talmud en un pueblito de Europa, y se había dedicado siempre a la enseñanza. La otra cosa que yo no conocía, y que era parte del secreto familiar y por eso no se hablaba de mi abuelo, es que había tenido un cuadro depresivo y había estado internado en el Sanatorio de Open Door (sanatorio de puertas abiertas) a poco de su creación. El conocimiento de todos estos elementos de mi propia historia grupal familiar pienso que fueron importantísimos en mi elección vocacional, pero también el desconocimiento. Hay cosas que en todo grupo familiar se guardan como secreto; hay cosas que no se dicen pero todos las saben, y de alguna manera, hay cosas que algunos las saben explícitamente y otros nada saben explícitamente, pero se perciben... hay algo que se percibe. Esto lleva a ese concepto tan importante que desarrollara Pichon-Rivière: es el "*secreto grupal familiar*". Es uno de los elementos básicos que funciona como base del "mal entendido" en los grupos familiares y que perturba las redes de comunicación. Vamos a volver ahora un poquito al hemisferio izquierdo. Les quería hacer un breve desarrollo del pensamiento de Pichon-Rivière, porque siempre es necesario rescatar algunas cosas, sobre todo aquellas que no están publicadas, que han sido transmitidas oralmente.

En lo personal, Pichon-Rivière se ve también influido por su historia grupal familiar y por el secreto. El era hijo de la segunda esposa de su padre, pero esto era un secreto grupal familiar, y él no se enteró sino a los seis o siete años, ya que los hermanos, que eran hermanastros en realidad, llamaban mamá a la segunda esposa. Esto fue bastante decisivo, contaba Pichon-Rivière, en su interés de investigación en los "secretos de los grupos familiares". Secretos que suelen estar vinculados a situaciones vergonzantes para un grupo familiar, a veces a situaciones de enfermedad mental, alcoholismo o drogadicción, a veces a situaciones de infidelidad, ya sea matrimonial o religiosa, u otro tipo de situaciones consideradas ocultables.

Comienza entonces Pichon-Rivière estas investigaciones en la década del 30, pienso que es importante ir marcando épocas. En la década del 30 investiga en el Asilo de Torres, siendo todavía estu-

diante de medicina; era un asilo para oligofrénicos, y describe un cuadro, la *oligotimia*, que es un retardo pero por carencias afectivas, en donde se encuentra con experiencias muy tempranas en el grupo familiar de privación o de abandono afectivo y las diferencias entonces de las oligofrenias, en donde hay una base orgánica y donde presentan además estigmas degenerativos. Los oligotímicos aparecían como niños rosaditos y muy lindos; sin embargo con un retardo mental significativo.

Su investigación en el grupo familiar sigue como Jefe del Servicio de Admisión en el Hospicio de las Mercedes, a comienzos de la década del 40, en donde, estando en ese servicio de admisión, ve cómo llega el paciente a la internación. Recibe al paciente en estado de crisis y ve ahí la eclosión o reactivación del proceso psicótico. Y allí, la presencia o la ausencia de la familia resulta siempre significativa, por la forma en que se da la presencia o las formas de interacción, o por la ausencia de la familia. Y ahí es donde comienza a investigar ese cuadro del abandonismo familiar, de la segregación del enfermo mental, la depositación en el hospicio y luego el hospitalismo, en donde los pacientes, se negaban a salir porque no querían volver al grupo familiar.

De alguna manera era la percepción de que ahí era donde se habían enfermado, y que mientras no se modificara la situación originaria, corrían el riesgo de volver a enfermarse. Todavía esta forma de abordaje de la enfermedad se daba en una forma asistemática, espontánea, o sea en la época del 40 Pichon-Rivière no tiene sistematizado todo esto.

Se le suma luego la tarea como Jefe de la Sala del Servicio de Adolescentes cuya fecha de creación no está bien delimitada, es entre el 43 y 44, y que es cerrada por razones políticas en el 47. Acá indaga la relación entre la enfermedad —esquizofrenia en la mayoría de los casos— y la situación familiar. Investiga la forma del vínculo, la situación desencadenante y observa las situaciones de pérdidas o de privación como constantes. Estas hipótesis de Pichon-Rivière comienzan a tomar forma, y desde allí desarrolla su noción de grupo interno, que se pone de manifiesto en el vínculo transfereencial, Grupo interno como escenario en el cual se recrean objetos, relaciones, vínculos. Y comienza a desarrollar su hipótesis del “portavoz”. Existe una relación de causalidad no lineal sino dialéctica entre la estructura y la dinámica del grupo familiar y la estructura y la dinámica del mundo interno o grupo interno del portavoz. Entonces surge la noción de portavoz, que es fundamental. Hoy día hablamos de “paciente identificado”, siguiendo las nuevas corrientes, pero ya en aquella época Pichon-Rivière, estamos hablando de la época del 40, comienza a utilizar el término de portavoz para referirse al enfermo mental como depositario. Y hace el juego de las tres D, en donde el enfermo mental aparece como el “Depositario” de toda la patología y de las ansiedades de todo su grupo familiar, los cuales

son entonces los “Depositantes”, y lo que depositan o “lo depositado” son justamente esas ansiedades, esa patología.

En un principio Pichon-Rivière asimila el concepto de portavoz y emergente y dice que el portavoz, es el emergente del grupo familiar enfermo. Luego en una evolución dialéctica, histórica en donde incorpora elementos del positivismo lógico y una concepción dialéctica, va a diferenciar y va a hablar de la enfermedad como lo emergente y del portavoz como el vehículo a través del cual se manifiesta lo emergente. Lo emergente es, entonces, esa cualidad nueva y significativa, acontecimiento sintetizador y significativo dice, que aparece en el campo, que es la enfermedad mental.

Hay ciertas diferencias teóricas que le permiten conceptualizar este hecho, desde George Mead, y el concepto del yo emergente o persona emergente y, por supuesto, desde las ideas de K. Lewin, en donde la conducta de todo ser humano es una función de un campo, es decir aparece en un campo operacional. Estas ideas de Lewin ejercen una influencia muy grande en Pichon-Rivière. La escuela francesa también ejerce una gran influencia en el pensamiento de Pichon-Rivière. Hay un librito muy viejo pero muy bueno que se llama “La unidad de la Psicología”, de Lagache, que es realmente maravilloso, que toma mucho de las ideas de K. Lewin, y que son retomadas luego por Pichon-Rivière; es un libro de la década del 50.

Toma entonces Pichon estos elementos, a los cuales se une toda su formación psicoanalítica, toda su concepción freudiana, kleiniana, y fundamentalmente se inspira en Frida Fromm Reichmann y en Sullivan, y a partir de todo esto, va desarrollando su teoría. Hay muchos más elementos, pero no nos va a dar el tiempo. Sólo les quiero sintetizar el otro abordaje importante que es el concepto de duelo central no elaborado que para encarar la terapia del grupo familiar es una noción fundamental. Pichon Riviere no termina de desarrollar, esta noción de duelo central no elaborado. El la refiere a las situaciones de pérdida, y la diferencia del duelo actual desencadenante con el cual viene la familia, con el cual vemos a la familia cuando nos viene a consultar. El duelo actual o desencadenante, es siempre una situación de pérdida, que puede estar referida a la pérdida de un ser querido, o puede estar referida a situaciones de pérdida muy variadas, como la pérdida de trabajo por parte del padre; o situaciones de crisis evolutivas, en donde hay pérdidas de roles, como en el pasaje de la infancia a la adolescencia o de la adultez a la vejez, cuando los niños crecen y dejan la casa para empezar la escuela, cuando los hijos se empiezan a casar, y los padres se empiezan a quedar solos, cuando empieza la vejez y la jubilación, cambio de roles, pérdida de roles operativos. Y desde todas esas situaciones desencadenantes, duelo actual o desencadenante, Pichon-Rivière decía que había que remitirse siempre al “duelo central no elaborado”. Es decir que atrás de esto había otra situación de duelo, que era importante iluminar y resolver.

Este concepto lo retoma Hernán Kesselman, y luego yo, y lo

seguimos desarrollando. Y entonces diferenciamos en el duelo central no elaborado, tres fases: 1. el duelo familiar parental; 2. el duelo familiar conyugal; 3. el duelo de los hijos; que muy brevemente corresponde a lo siguiente. Cuando un hombre y una mujer se casan y deciden formar una nueva familiar, tienen que elaborar el duelo por la pérdida de sus respectivos grupos familiares de origen. No es que dejen de ser hijos por haberse casado, pero sí van a serlo de otra manera, es decir van a tener que asumir una responsabilidad nueva, van a tener que hacer un abordaje diferente de sus relaciones vinculares con su propio grupo familiar de origen. Este es el duelo familiar parental.

Cuando en un segundo momento deciden tener hijos, llega el momento de la elaboración del duelo familiar conyugal, ya que hasta ese momento han sido una pareja conyugal, han sido dos y desde ese momento ya no van a ser nunca más dos, ya que pueden ser tres o cuatro o cinco, según los que Dios les quiera mandar o los que ellos decidan tener. La cuestión es que no van a ser nunca más dos, se pierde la intimidad de la pareja. Volverán a ser dos en otras condiciones cuando los hijos se vayan y entonces vuelve la intimidad. Intimidad viene del griego: *intymos*, quiere decir afecto entre dos; y dos no van a ser más, siempre va a haber un tercero incluido o excluido, dependerá de cada situación. Y posteriormente aparece el duelo de los hijos, los hijos van sufriendo situaciones de duelo, porque van sufriendo pérdidas. Desde que nacen pierden, pierden el claustro uterino, pierden el pecho, la mamadera, el chupete, y luego terminan comiendo chicles o fumando, reemplazando de alguna manera a través de una oralidad que nunca se ve del todo satisfecha. Entonces nos encontramos con que el duelo central no elaborado es como una olla común, donde se van cocinando a fuego lento estos duelos del grupo familiar. Es importante tener esta concepción dinámica de la historia y de la pre-historia del grupo familiar, e indagar entonces qué es lo que pasó con los grupos familiares de origen cuando se produjo esta unión, qué dificultades hubo, qué pasó cuando vinieron los hijos, cómo se elaboró esta situación, etc.

Por último les quiero decir que cuando yo veo un paciente individual, investigo siempre su problemática familiar y muchas veces como parte de su terapia individual, incluyo entrevistas, ya sea de pareja, o de familia, o con algún miembro o algún personaje significativo en la vida de este paciente. Mi experiencia es que esto es muy útil y enriquecedor para la terapia individual del paciente y que es perfectamente manejable por el terapeuta, es decir que no hay que tener miedo de incluir al grupo familiar cuando se los considere necesario. Quizá los terapeutas de niños sean los que más tempranamente han desarrollado esto, en la medida que vieron la importancia que tenía para la terapia del niño la inclusión de los padres y las entrevistas con los mismos.

Tendríamos que ponernos de acuerdo en el código y ver si denominamos a esto terapia familiar o si le damos otro nombre, que

podría ser entrevistas de orientación familiar o cualquier otra denominación que pudiéramos encontrar, reservando la denominación de terapia familiar estrictamente para los tratamientos centrados exclusivamente en el grupo familiar. Virginia Satir así lo piensa, es decir, reserva la denominación de terapia familiar estrictamente para estos tratamientos y denomina a las otras entrevistas de otra forma. De todas maneras, creo que sería una discusión semántica, y lo que interesa es el contenido de esto. No siempre pero sí muchas veces, la problemática del grupo familiar está más centrada en la interacción de la pareja que en la de los hijos, y modificando la interacción de los padres se modifican las situaciones perturbadas en las conductas de los hijos. Mi hipótesis es que el terapeuta familiar tiene que ser eminentemente activo, es decir, no puede permanecer nunca en la pasividad en que muchas veces nos hemos visto en situaciones de psicoanálisis más ortodoxo. Este enfoque que les he hecho apunta entonces, por un lado, a rescatar una comprensión dinámica de la estructura familiar, de los procesos de interacción, desde el pensamiento de Pichon-Rivière. Pero no nos podemos nunca quedar en una teoría ni en una técnica, y los desarrollos de la terapia familiar han sido muy grandes y muy importantes. Algunos de los que están aquí en esta mesa trabajan conmigo y saben que yo he ido incorporando a este esquema referencial los enfoques de la teoría de la comunicación, la escuela de Palo Alto, los enfoques sistémicos, interaccionista, la utilización de ejercicios, técnicas de acción, dramatizaciones, técnicas gestálticas, etc. En este sentido, retomaría las palabras del Dr. Czertok, de la importancia de la multidisciplinariedad. Es decir, yo creo que en la terapia familiar es imprescindible una orientación multidisciplinaria que permita hacer un enfoque abarcador, que permita hacer un buen diagnóstico, una buena lectura dinámica, una correcta indicación terapéutica y la utilización de distintos recursos técnicos acordes a cada situación y a cada caso. Un enfoque unilateral siempre empobrece. Se sabe que monocultivo y subdesarrollo van juntos, y reducir a un solo instrumento lo que podría ser una orquesta sinfónica es muy empobrecedor.

Por último quiero recordarles, las palabras casi proféticas de Freud, cuando en 1918, en el Congreso Internacional de Psicoanálisis de Budapest dijo: "llegará el día en que el oro puro del Psicoanálisis deberá mezclarse con el cobre de otras técnicas terapéuticas". Yo me permitiría, con el debido respeto, modificar en algo las palabras del maestro, y diría: hoy llegó el día en que el oro del Psicoanálisis debe mezclarse y se está mezclando con, no el cobre, sino el oro de otras técnicas terapéuticas, ya que no son inferiores, ni tampoco superiores, sino distintas, diferentes y complementarias. Esto es aplicable para las terapias de todo tipo en general pero muy especialmente para las terapias familiares. Muchas gracias.

Dr. Fernando Taragano. Luego de la disertación del Dr. M. Bernstein en la que hizo todo un desarrollo histórico evolutivo del pensa-

miento del Dr. Pichon-Rivière, del cual es evidente que nadie de los que estamos aquí, trabajando en la Argentina, hemos podido negar su influencia. Personalmente he tenido un contacto también muy intenso con él, tanto que hemos trabajado en las primeras pruebas de psicología dinámica donde he sido docente de la Escuela durante cinco años, del año 1960-64. Tengo que reordenar todo el pensamiento porque las informaciones son tan abundantes que voy a hacer el esfuerzo ahora.

En cierto momento el Psicoanálisis con las relaciones bipersonales de paciente y terapeuta era evidentemente una relación empobrecedora, con respecto a la realidad de lo que sucede en el ser humano. La inclusión del tercer personaje en la situación triangular y edípica fue un momento enriquecedor. Yo recuerdo en una charla en donde estaba A. Aberastury que defendía muy bien la relación de madre-niño, yo le pregunté: ¿y el padre dónde estaba?, si tenía alguna ingerencia en este asunto, sino era simplemente biológico, o influía en forma directa sobre el niño y en forma directa sobre la madre condicionándola para un mejor trato sobre el niño. Es decir allí se establecía un sistema de vasos comunicantes. Creo que la importancia que hemos venido sintiendo los que trabajamos con grupos familiares es que hemos descubierto que evidentemente lo que les sucede a cualquiera de nuestros pacientes, no puede limitarse a lo intrapsíquico de él, ni siquiera a lo que sucede con su pareja ni a lo que sucede con sus padres, sino que hay todo un grupo familiar que está permanentemente incidiendo en la conducta de todos los miembros que integran ese grupo. El problema del grupo interno que desarrolla Pichon-Rivière yo lo mantuve durante varios años, para evitar los malos entendidos digo públicamente otra vez, que fue mi gran maestro Pichon-Rivière, a quien le dediqué mi primer libro de *Análisis de la operación terapéutica*, publicado en el 67. Hay un trabajo mío, no recuerdo bien la época, creo el 59, un primer trabajo, donde hablo de grupo interno y grupo externo. En el grupo externo evidentemente la teoría que yo había señalado en aquel momento, era que el paciente era el chivo emisario de la locura del grupo familiar. Siguiendo la ideología de Pichon-Rivière, se depositaba en el más fuerte, de ese grupo familiar la locura de todo el grupo. En realidad, generalmente la práctica de éstos, mis primeros trabajos, fueron siempre con grupos familiares de gente de edad avanzada que en el año 59, tenían 55 ó 60 años. Hoy en el año '82, gente de edad avanzada es mucho más, porque estamos todos muy cerca de esa edad, por lo menos yo. He ido corriendo las edades y supongo que en este momento gente de edad avanzada, lo que llamamos viejo es de 75 para arriba; lo acomodé así para tener un margen para seguir trabajando. En trabajos con gente de edad avanzada, 55-60 de aquella época, generalmente cuadros melancólicos, muy a menudo enfermos con lesiones vasculares cerebrales, que habían hecho infartos cerebrales, con o sin secuelas neurológicas donde el enfermo estaba muy disminuido, yo trabajaba con la hipó-

tesis de que había que centrar toda la tarea terapéutica en el hombre enfermo, en el pobre viejo enfermo, que necesitaba el apoyo y la comprensión del grupo familiar.

Trabajando con la hipótesis del chivo emisario descubrí rápidamente que en vez de lograr la integración del grupo familiar estaba consiguiendo a veces efectos contrarios. En la medida en que en el grupo familiar los hijos se sentían acusados de abandonar al padre, éstos culposamente acudían a las sesiones de terapia del grupo familiar. Pero en el fondo yo sentía e iba percibiendo que no mejoraba la relación con ese viejo enfermo, sino que la complicación que estaba descubriendo es que se estaba en realidad, quebrando, ese grupo familiar, no estaba integrando ese grupo familiar como correspondía. Durante las entrevistas parecía estar centrado todo en el paciente, sin embargo mi impresión cuando yo investigaba qué pasaba después de las sesiones, qué pasaba durante la semana en ese grupo familiar, qué pasaba durante el fin de semana, siempre persistía el abandono y esa segregación de la gente grande.

Voy a insistir que esa experiencia que yo básicamente adquiero con grupos de gente de edad avanzada, es aplicable para mí exactamente igual ya sea de un hombre de edad media de 40-45 años o sea un grupo familiar con un adolescente. Siempre sostuve, que lo importante para nosotros los terapeutas es tener una visión completa de los pacientes de todas las edades. Yo nunca tuve condiciones aptas para tratar terapéuticamente a un niño pero sí realicé primeras entrevistas. Sí en cambio tengo experiencias con adolescentes, con adultos jóvenes, adultos maduros, provecos y viejos. Incluso hoy mi paciente de mayor edad tiene 96 años, hace 4 años que la veo, no sesiones semanales ni nada por el estilo, sino que han comenzado siendo semanales, quincenales y después las mantenemos una vez por mes y luego cada vez que van surgiendo las necesidades. Lo importante es que he ido descubriendo que no es la edad, sino la motivación que lleva una persona lo importante; tengo pacientes de 80-82-86 años en terapia. No tiene importancia cuál es la edad. Me encuentro con que la problemática de un adolescente, de una edad media y de un viejo o anciano, 85 años, son exactamente las mismas; lo que varía es la formulación de la necesidad básica. Ustedes recuerdan cuáles son las necesidades básicas de todo ser humano, una necesidad de protección, una necesidad de seguridad, una necesidad afectiva y una necesidad de seguir evolucionando. No hay ningún ser humano que deje de evolucionar cualquiera sea la edad, en el momento que deja de evolucionar envejece; no importa que tenga 40 años, 50, 80 ó 20. A veces encontramos incluso en las experiencias de Pichon-Rivière chicos oligotímicos que por su autismo no se conectan con el mundo y han empobrecido su personalidad así.

En esta metodología de trabajo que doy tuve que ir modificando la teoría psicoanalítica porque una cosa es la metodología de trabajo y otra una técnica de trabajo. Una técnica la podemos aprender en

una hora, una metodología implica una teoría de la personalidad y una teoría de la enfermedad, no sabemos lo que estamos haciendo. Todas las técnicas y todas las metodologías se apoyan en una teoría psicoanalítica de la personalidad y una teoría de la enfermedad.

En ese sentido lo que yo estoy modificando es la teoría psicoanalítica y partiendo más de la teoría de las relaciones interpersonales.

La integración de la personalidad resulta del proceso de las relaciones interpersonales en donde a través de los procesos de comunicación y de interacción el individuo va logrando adquirir sus posibilidades evolutivas que yo centraría como objetivos básicos de todo ser humano cualquiera sea la edad: la autonomía, la autorrealización, la creatividad personal, la libertad de decisión, la libertad de acción, la capacidad de autoprotección, etc. Todos estos elementos son los que hacen a la salud mental de un sujeto. En la teoría de la enfermedad en la que yo me apoyo, que desarrollo, considero que lo básico antes de enfermarse es la carencia de estos factores de salud: autonomía, autorealización, creatividad, libre expresión, capacidad de autoprotección, capacidad defensiva de los derechos personales, respeto por los derechos del otro, si esto no se logra, el sujeto se frustra, entra en situaciones de privación y empieza yo diría, a luchar para intentar obtener todas estas cosas que necesita.

Diré globalmente cuál es mi hipótesis de la neurosis. La neurosis es para mí un proceso de lucha triste en la tentativa de autoprotección y de autoevolución. Si estos objetivos los logramos a través de nuestras relaciones con los demás es por consiguiente importante analizar qué es lo que pasa entre todos los miembros de un grupo familiar para ver todos los sistemas de comunicación, de interacción y dónde están los obstáculos que unos se generan a otros. Esto apunta entonces a lo siguiente, para entrar en la metodología de la terapia del grupo familiar.

A mi juicio no importa quién es el enfermo, en este sentido, no importa si es un adolescente, un adulto o un viejo lesionado cerebral o cardíaco. El que trae la urgencia del problema es el que está más deteriorado, el que ha perdido más la capacidad de autoprotección y de autodefensa, pero los obstáculos los encontramos muy a menudo no en la problemática intrapsíquica aislada sino en nuestra lucha con las personas que nos rodean. Cuando trabajo con un grupo familiar, si bien me centro en la problemática de aquel que está más urgido porque es el que se ha desmoronado, se ha desestructurado más abruptamente, también les presento una problemática de todo el grupo familiar. No hago una terapia direccional, única y exclusivamente hacia el enfermo del grupo, trato de ver las problemáticas, las necesidades, los derechos de todos los integrantes de ese grupo familiar.

Es decir, cada uno está luchando con el otro a los efectos de defenderse y cada uno está siendo un obstáculo para el otro en

forma intencional o no intencional. Ahí aparece el asunto de los malos entendidos, todo el problema de la adjudicación de roles y la asunción de roles, etc.

Entonces la terapia de grupo familiar, yo diría, si me permiten y no nos entendamos mal, es una terapia individual hecha con la técnica grupal. Es decir, yo, para resolver la problemática de aquel que está más desestructurado, más enfermo, tengo que ayudar a resolver las problemáticas de todos los integrantes de ese grupo familiar. Porque en la medida en que cada uno de los miembros de ese grupo es más sano, posibilita la salud del otro. Por consiguiente terapia de grupo familiar es para mí como cualquier grupo de terapia, es terapia individual con la técnica grupal, ayudando a resolver las necesidades de cada uno.

Cuando inicio un grupo terapéutico, lo más frecuente es gente de edad, pero a veces gente de edad avanzada o gente de edad adulta, no obligo a que todos los miembros del grupo vengan, sino solicito quiénes quieren integrarse a ese grupo familiar. Es evidente, como decía el Dr. Berstein, no podemos trabajar con una sola técnica, ni una sola teoría, ni una sola metodología porque eso es totalmente empobrecedor. Entonces, si necesitamos incluir miembros de la familia, solicito aquellos que voluntariamente quieran integrarse. Yo les diría por qué, porque son aquellos que van a mostrar mejor disposición a crear una subestructura familiar más apta para la evolución de todos los integrantes del grupo. Posteriormente pueden integrarse o no los otros integrantes, es decir, es un grupo abierto donde entran y salen; yo no condiciono que tienen que venir a todas las reuniones sino que dejo la libertad que vengan o no vengan. El otro aspecto importante es que las informaciones que traen todos los miembros de un grupo familiar se refieren a hechos anecdóticos que tienen un significado actual, pero que implican una historia análoga que se ha venido repitiendo hasta el presente. Por consiguiente la problemática no es sólo actual sino que es la resultante de un largo proceso que hace eclosión ahora. Tanto es así que consideramos que esa patología individual y esa patología grupal es la síntesis final, presente, actual, de un largo proceso evolutivo. Y cómo interpreto yo la estructuración de la personalidad de cada sujeto, intentando lograr esos objetivos de salud que hagan a su autonomía, y a su evolución y además tiene un sentido prospectivo? Acá hay otro elemento que yo he modificado: la historia me sirve para entender lo que pasa ahora, lo que yo tengo que resolver es el presente, este presente situacional, individual y grupal. Lo que el paciente me trae es una reconstrucción actual de su pasado del cual lo más importante no es el hecho anecdótico sino la significación que el sujeto le otorga al hecho anecdótico. O sea que lo anecdótico-histórico no es lo más importante, es la significación que le da el sujeto al hecho anecdótico y esa significación es actual, y esa significación es temida en el sentido prospectivo. Es decir, lo que yo

temo que me suceda mañana es lo que hoy me está sucediendo y me sucedió siempre.

Entonces aquí hay un vuelco con respecto a la línea temporal digamos de análisis, no es resolver sólo lo histórico, es tomar como apoyatura lo histórico para entender qué es lo que hoy no está resuelto pero con la finalidad de resolverlo para mañana. Es decir lo que a mí me alivia es si yo cambio mi situación actual. Una experiencia importante, un elemento importante que surge en la experiencia de grupo y creo que lo han detectado todos es que el grupo tiene mucha resistencia a hablar de determinadas cosas.

Pichon-Rivière creo que hablaba de ese secreto, pero yo creo que no es un secreto aislado, no es un secreto de un hecho anecdótico, no es que mi padre me haya puesto a mí el nombre de mi abuelo muerto sin que yo lo supiera, sino yo creo que el secreto es el resentimiento y el pesimismo actual que tiene el grupo con respecto al destino del grupo. Es decir lo que se oculta es lo actual, no solamente lo histórico, es lo significativo actual.

En un grupo es difícil a veces que tengan el valor de enfrentar las situaciones actuales de resentimiento que existen entre ellos. Yo creo que es uno de los factores más difíciles a resolver en un grupo familiar, el resentimiento que tienen los padres con los hijos, los hijos con los padres, los hermanos entre sí o todas las combinaciones cruzadas que querramos ver. El pesimismo es otro de los aspectos que entorpecen una terapia familiar. Lo que yo llevo a hablar a un paciente y tomo en cuenta y le doy más importancia es de lo que no habla el grupo. Lo que no se habla generalmente tiene más importancia que aquello de lo que se habla. Les voy a traer un pequeño ejemplo: un grupo familiar que veo, constituido por una mujer viuda de 65 años y cuatro hijos, tres mujeres y un varón, el varón de 35 años, y las mujeres menores; el padre había fallecido hacia cinco años, y el grupo aparentaba tener una muy buena relación, tanto que estaban todos en terapia con miembros de mi equipo; entonces el grupo familiar lo tomo yo. El grupo se muestra con muy buena disposición a hablar entre ellos, pero yo veo que hay una cosa superficial e incluso detecto informaciones corporales. La información que tomamos proviene de todos los campos, lo que se habla, lo que no se habla, lo que se hace corporalmente y en la conducta de movimiento grupal que es importante tener en cuenta. Cuando manifiesto: ¿qué han vivido uds. con respecto a la muerte del padre?, todos dicen, "lo hemos superado totalmente"; nadie habla con nadie de la muerte del padre porque ese era el esquema de él. El padre decía: "no debemos nunca angustiar al otro con nuestras angustias"; por consiguiente ese grupo había quedado paralizado en algo que no había hablado en cinco años. Les señalo: ¿no sería más importante hablar de la angustia de cada uno de uds. frente a la muerte del padre, lo que cada uno de uds. probablemente no se ha comunicado nunca? Y en ese momento el grupo, prácticamente los cinco se ponen a llorar con una intensidad tal que incluso

uno contagiado se mete en el clima ese. Es evidente que si somos terapeutas familiares, digamos si somos psicólogos, psiquiatras, es porque hemos tenido una problemática personal que es la que queremos resolver y también podemos decir que si nos dedicamos a la terapia familiar es porque algún problemita familiar hemos tenido que no lo hemos podido resolver bien. No es nada negativo, creo que a todos nos ha pasado, es una falacia eso de que uno tiene salud mental y que la familia ha sido extraordinaria. Cuanto más nos dice un paciente: mi mujer es perfecta, es cuando más dudo y cuando dicen esta familia es ideal cuando más sospecho. Porque no puede ser una plena salud mental, ni nada que sea perfecto, porque el hombre está en un proceso de evolución y de lucha. Es como una empresa, la personalidad es como una especie de empresa psicológica que todos desarrollamos a los efectos de obtener los objetivos que buscamos en nuestra vida. Bueno este era un ejemplo en donde todos empezaron a llorar e incluso en sesiones sucesivas yo iba detectando la urgencia de cada uno, haciendo que cada uno de los miembros de ese grupo familiar hablara de sus angustias, de sus problemas, de sus proyectos y de sus resentimientos cruzados que tenían entre ellos. Y después de tres o cuatro meses el grupo dejó de ser ese grupo maravilloso que era, porque incluso, todos los terapeutas de mi grupo, decían que era un grupo fantástico, que se querían mucho entre ellos, pero eso era lo aparente, había una buena relación pero había algo que no se hablaba y eso que no se hablaba hacía que las relaciones fueran más superficiales y que realmente no pudieran contar el uno con el otro. Este ejemplo viene un poco a mostrar como he ido muy suscitadamente evolucionando en las técnicas de grupo familiar, centrándome en la comprensión de la problemática de cada uno de los integrantes del grupo defendiendo el derecho de cada uno de hablar de sus problemas, de sus objetivos, mostrando cada uno los resentimientos cruzados, cada uno su pesimismo con respecto al futuro de la unión de esa familia. En cuanto a la metodología creo que sería motivo de otra charla. Lo fundamental para mí entonces, sintéticamente, en este momento sería o diría que toda psicopatología individual y grupal es la síntesis de un proceso existencial de lucha frustrada, donde no hemos logrado los objetivos personales de autonomía y autorealización y que la técnica de terapia grupal que utilizo es técnica de psicoterapia individual hecha con la técnica del grupo familiar.

Esto sería muy suscitadamente la posición personal y lo que yo he ido adquiriendo como evolución en el transcurso de estos 20 y más años de trabajo en terapia de familia. Nada más. Muchas gracias.

Doctor Jorge García Badaracco: Hablar después de exposiciones tan interesantes por una parte facilita las cosas para no decir lo que ya se dijo, por otra parte las hace más difíciles porque la información y las ideas que ya se han vertido en esta mesa son tan ricas

que evidentemente no es que esté todo dicho pero hay mucho ya dicho.

Fui tratando de armar un poco una exposición relacionada más con mi propia trayectoria en relación con algunos aspectos de la terapia familiar que yo considero importantes y es de lo que voy a tratar de hablarles en este momento.

Podría decir muy sucintamente, que hice mi formación psicoanalítica en Francia de los años 50 al 56 aproximadamente, época en la que el psicoanálisis individual estaba digamos separado de todo otro tipo de abordaje psicoterapéutico y estaba muy tipificado como un tipo de terapia absolutamente específica. En esa época, en Francia la terapia familiar prácticamente no era conocida y no había prácticamente terapeutas familiares. En esa misma época en los Estados Unidos se estaban desarrollando algunos de los trabajos más importantes, a mi entender, de terapia familiar, que en la década del '60 tuvieron un desarrollo más amplio. Y en esa misma época Pichon Riviere aquí estaba haciendo aportes sumamente valiosos, como se refirieron esta tarde, que lamentablemente en el extranjero no fueron, yo diría, nunca suficientemente conocidos ni tomados en cuenta. Cuando volví a la Argentina en el año '57, comencé a trabajar en el Hospital, actualmente el Hospital Borda, es decir, el Hospital Neuropsiquiátrico de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento, continuación del Hospicio de Las Mercedes. Empecé a trabajar psicoanalíticamente en el abordaje de los pacientes psicóticos, particularmente los pacientes esquizofrénicos que son la mayor parte de la población de este tipo de instituciones psiquiátricas tradicionales. Traté de aplicar la idea que se estaba desarrollando en Estados Unidos, donde el enfoque terapéutico del paciente psicótico era fundamentalmente el psicoanálisis individual a la manera de Frida F. Reichmann, orientado por ella, con todas las semejanzas y diferencias con la escuela kleiniana, etc. y otras que no voy a mencionar ahora, pero centrado fundamentalmente en el psicoanálisis individual de la psicosis. En esta institución, un poco posteriormente, los aspectos de la familia comenzaron a ser tomados algo en cuenta, pero después quedaron no muy desarrollados. En el Hospital comenzamos a ver que para el abordaje psicoterapéutico del paciente psicótico era necesaria la inclusión de la familia, pero esto no era nada fácil, y aproximadamente en los años '60-'62, también tenía importancia ya la idea de la comunidad terapéutica que venía de los años '50 aproximadamente, con autores como M. Jones en Inglaterra y luego en los Estados Unidos.

La forma en que este grupo multifamiliar se iba gestando en mi servicio de aproximadamente 35 camas, eran una experiencia para mí fundante de unión de una cantidad de elementos muy importantes tanto desde el punto de vista de la teoría, de la técnica y de la clínica. Y en esa experiencia quisiera señalar que me acompañaron los doctores Alfredo Canevaro, Czertok, Martín de Oro, Eduardo Mandelbaum, entre otros, época para mí de una extremada riqueza, de descubrimientos

clínicos de todo tipo. Después hicimos en el año '68 una clínica privada en la cual seguimos trabajando; pero esa época del Hospital sigue representando aspectos básicos muy valiosos a los cuales voy a tratar de referirme en forma más detallada.

El grupo multifamiliar o familiar múltiple era simplemente la reunión grupal de prácticamente todos los pacientes de la sala con los familiares que venían a la misma y también con el enfermero, la enfermera, el personal de la sala (que generalmente era escaso), y los terapeutas que venían a la sala para colaborar. En un primer momento empezamos siendo muy poquitos porque simultáneamente había otro servicio que era el Hospital de día, que lo habíamos inaugurado en esa misma época y que absorbía la mayor parte de las personas que concurrían al servicio. Es decir que teníamos una parte que era el hospital de día y otra la sala de internación, donde empezamos a hacer esta experiencia.

El funcionamiento del grupo multifamiliar es un campo de experiencia en ese sentido muy abarcativo, plurifacético y pluridimensional, o polifacético y pluridimensional. Desde el punto de vista del campo fenoménico eso tiene el funcionamiento de un grupo grande, pero los fenómenos de la dinámica interaccional o inter-relacional son fenómenos de tipo de interacción familiar. Muchos de los fenómenos de interacción familiar que a veces no se pueden dar en la relación de los miembros integrantes de la familia nuclear porque la intensidad de los afectos en juego hacen difícil esa interacción, como decía el Dr. Taragano hace un momento, los resentimientos entre unos y otros, el pesimismo, etc., no se pueden verbalizar, muchas veces se pueden o son verbalizados en formas desplazadas sobre miembros de otras familias. El resentimiento de un hijo hacia su propio padre puede ser expresado en forma disimulada, disfrazada, pero en forma desplazada con otro padre o una actitud digamos particular de una madre con su hijo, un poco secreta, puede ser visualizada mejor a través de la actitud que pueda tener con otro paciente de la comunidad que toma como un desplazamiento de aspectos con su propio hijo o de aspectos conflictivos con su propio hijo.

De tal manera que el campo multifamiliar amplía en este sentido el campo familiar restringido de la familia nuclear.

Por otra parte algunos de los fenómenos transferenciales que son vistos en la terapia individual psicoanalítica, es decir las transferencias y las contra-transferencias también aparecían en estos grupos multifamiliares. Pero se daba la situación de la aparición de fenómenos que muchas veces en la terapia individual se hacen muy difíciles de visualizar y sobre todo muy difícil de trabajar: los fenómenos narcisísticos, fundamentalmente, las situaciones triangulares edípicas que en la situación bipersonal quedan muchas veces excluidas, situaciones de exclusión del tercero por el hecho de la técnica misma bipersonal, que aparecía luego como incluido en el campo de trabajo multifamiliar.

Empezamos a ver que en este campo fenoménico los distintos fenómenos psicopatológicos que se describen habitualmente a través de los distintos enfoques o encuadres, se podían visualizar en distintos momentos y en distintas formas pero de una manera que aparecía tal vez como más específica o revelando aquellos que podía manifestarse como más vigente. Quiero decir, por ejemplo, que el fenómeno de la simbiosis aparecía mucho más en la relación entre la madre y el hijo por ejemplo, en una situación de grupo multifamiliar; el fenómeno de la inter-relación o inter-dependencia patológica de las parejas o el fenómeno de la inter-relación o inter-dependencia de la pareja parental repetido en madre-hijo, padre-hijo, o en la relación de los hermanos. Los fenómenos de las diferencias entre la simbiosis normal y la simbiosis patológica que a veces en la terapia individual se hace difícil de discriminar para el terapeuta que tiene que trabajar con los intentos que el paciente hace de simbiotizarse con uno, en los cuales tiene que tratar de discriminar hasta qué punto el paciente está buscando un manejo patológico de la relación, del vínculo a través de la simbiosis patológica o está reclamando la necesidad de que el terapeuta lo reconozca en una simbiosis sana a partir de la cual podrá hacer un redesarrollo.

De tal manera que la compleja fenoménica que muchas veces se describen en los enfoques freudianos, en los enfoques kleinianos, como diferentes visiones del psicoanálisis individual por ejemplo, aparecían en el contexto multifamiliar como diferencias cualitativas o diferencias en manifestación de fenómenos similares en distintos contextos. Y muchas veces los intentos que hacemos de categorizar específicamente qué es transferencia y qué no es transferencia, si la transferencia psicótica es transferencia o no es transferencia (porque tenemos el modelo de la transferencia neurótica), si en la transferencia paradójica qué es lo que está sucediendo: si es una forma del doble vínculo o del doble mensaje o una forma patológica de la relación que se estableció a través del doble vínculo o del doble mensaje. Es decir que muchas veces podemos ver claramente en la dinámica y funcionamiento del grupo multifamiliar que los fenómenos descritos por los distintos autores en los contextos particulares como fenómenos diferentes, tienen semejanzas y diferencias y articulaciones muy variadas en la dinámica multifamiliar que estoy describiendo. Se hace entonces menos importante establecer diferencias específicas, porque la palabra transferencia se puede emplear solamente en el contexto individual y no se puede emplear en un contexto familiar o institucional por ejemplo, como dicen algunos, para, digamos, pasar a tratar de entender cuáles son los matices diferenciales entre una transferencia y otra. La transferencia que se da en la relación bipersonal del análisis individual o la transferencia que se da de un paciente a un miembro de una familia en un grupo multifamiliar con relación a un terapeuta o co-terapeuta del grupo.

Empezamos a ver además de todo esto, un aspecto que se fue haciendo cada vez más importante en el sentido de las diferencias

cualitativas entre neurosis y psicosis. Si bien es cierto que algunos autores ven en la neurosis y la psicosis una especie de continuum con diferencias solamente cuantitativas, hay también otros que consideran que las diferencias son más bien cualitativas y otros que consideran que hay aspectos cualitativos y cuantitativos. Pero lo que sí es claro es que los pacientes psicóticos y los pacientes neuróticos comparten aspectos conflictivos muy similares. Algunos autores, por ejemplo Harlow, abordan la psicosis desde el punto de vista de la formulación estructural psicoanalítica hablando del yo, superyo y ello. Otros autores señalan que no es posible utilizar este lenguaje y las dos cosas son ciertas. Es decir no es una problemática que no tenga solución, sino que hay que llegar a una concepción más abarcativa que permita comprender por qué algunos autores consideran que se pueden usar las mismas formulaciones estructurales de Freud para la patología psicótica y la patología neurótica y otros autores consideran que no.

Las diferencias aparecen en la naturaleza de los fenómenos en juego, y estos se expresan con una mayor claridad en las estructuras multifamiliares que en las estructuras individuales o familiares nucleares, dentro de las cuales estamos acostumbrados a trabajar.

Yendo un poco más allá, avanzando un poco más en este sentido, empezamos a comprender la estructura misma del funcionamiento institucional de las instituciones psiquiátricas como una estructura o campo psicológico de naturaleza multifamiliar y en el que el grupo multifamiliar no era más que la expresión de un momento particular o privilegiado para ver fenómenos en juego. Muchos de estos fenómenos se dan permanentemente y todo el tiempo en los pasillos sin que nadie conozca su existencia: son los secretos, las cosas desviadas y secretas que se dan y los aspectos conflictivos dentro de los cuales están los aspectos disociados más importantes para incluir en las psicoterapias, en el proceso terapéutico de los pacientes. Y pudimos así empezar a rescatar observaciones fundamentales o de la importancia de las observaciones en uno de los libros más importantes e interesantes sobre el hospital psiquiátrico en la década del '50, aproximadamente, donde el Dr. Schwartz describía en una institución psiquiátrica una organización formal en la cual tenemos los roles del jefe de servicio, los médicos, los enfermeros, de los terapeutas, etc. etc., y los enfermos, los pacientes, los familiares y una organización informal de la vida, de la comunidad o de la institución, que es la parte menos conocida por los médicos.

Empezamos a encontrar entonces las diferencias que encontramos en el Hospital psiquiátrico tradicional, a la mañana cuando entrábamos y estaban los médicos y a la tarde cuando no había nadie, cuando estaban solamente los enfermos. Y donde aquella disociación hacía que lo más importante de la vida de los pacientes se nos perdiera totalmente a los médicos porque no los conocíamos, porque simplemente no estábamos con ellos, porque no nos daban la oportu-

nidad de estar con ellos, porque no traían las problemáticas cuando estábamos nosotros.

Entonces empezamos a descubrir que la relación médico-paciente necesaria para que los procesos terapéuticos con los pacientes más graves pudiera tener lugar, debía incluir aspectos que habitualmente en las terapias conocidas, psicoanalítica individual, o familiar nuclear a la manera psicoanalítica, o inclusive otros enfoques comunicacionales no se contemplaban suficientemente. El problema por ejemplo fundamental de qué es hacerse cargo de un enfermo grave y quién se hace cargo del enfermo grave? El hecho de que un enfermo esquizofrénico tenga un médico que lo atiende, y que es el responsable de él, ese aspecto formal del Hospital, no significa nada desde el punto de vista de su proceso psicopatológico ni de la posibilidad de un verdadero proceso terapéutico. El hacerse cargo del enfermo y que el enfermo sienta que la institución se ha hecho cargo de él es una dimensión que está un poco más allá de esos aspectos formales, y la necesidad de que eso suceda empezó a surgir mucho más claramente cuando empezamos a funcionar en una Institución como una Comunidad terapéutica con una estructura multifamiliar.

Es decir que la estructura multifamiliar constituida por los pacientes, los familiares de los pacientes y el personal de la Institución incluídos los médicos, empezó a ser la estructura continente de las ansiedades psicóticas de los pacientes, realmente continente de los conflictos no resueltos o de las ansiedades básicas de M. Klein o de los aspectos de las necesidades fundamentales como por ejemplo, hablaba el Dr. Taragano, o de aspectos que Pichon-Rivière describió como el Dr. Berstein nos refirió cuando hablaba de los duelos no elaborados. Ahí aparecían en la comunidad todos esos fenómenos con una intensidad inusitada en la medida que el continente, digamos "holding" o campo psicológico, era mucho más capaz de tolerar esos fenómenos. Y en ese sentido la comunidad terapéutica, con la estructura multifamiliar, aparece como el continente más adecuado para la posibilidad de la realización de procesos terapéuticos donde se juegan estructuras psicóticas graves.

Mi abordaje entonces en la terapia familiar, a través de la Comunidad Terapéutica Psicoanalítica de estructuración multifamiliar, me permitió ir pensando que ella, más que una técnica de abordaje, es una dimensión de todo proceso psicoterapéutico. Y en ese sentido incluir la dimensión familiar en todo proceso psicoterapéutico implica un cambio: de una Institución psiquiátrica (como acabo de decir: el hospital tradicional psiquiátrico) de la terapia familiar misma en sus diferentes formas técnicas, y del psicoanálisis individual.

El psicoanálisis individual a la manera de Freud tiene un desarrollo que en algunos aspectos ha quedado un poco digamos detenido en las primeras teorías freudianas, como por ejemplo la teoría de la libido y no incluye suficientemente los aspectos que Freud describió como viscosidad de la libido y deformaciones del yo en la patología grave psicótica. Curiosamente aspectos, de los cuales los psicoanalistas

no hablan nunca. Viscosidad de la libido que aparece por ejemplo en la relación madre-hijo en una estructuración psicótica esquizofrénica típica, como un vínculo perverso entre madre-hijo donde los dos miembros del vínculo están involucrados en un tipo de patología de interdependencia patológica, digamos máxima, que vamos a encontrar en otras formas con menos intensidad. El conocimiento de ese tipo de vínculo perverso nos va a permitir comprender mucho más fenómenos de otro tipo de nivel neurótico que se dan en una pareja, por ejemplo, formas neuróticas de relaciones entre hermanos u otro tipo de miembros.

Por otra parte nos va a permitir también comprender que el psicoanálisis individual con algunos enfermos esquizofrénicos está limitado simplemente por ser una relación bipersonal, porque el paciente esquizofrénico necesita la inclusión de un tercero que lo ayude a simbiotizarse con el analista pero también a des-simbiotizarse de él, para poder trabajar ambos ese aspecto más conflictivo o más difícil de las relaciones entre ellos. En los procesos terapéuticos de los pacientes más graves, más severos, las nociones freudianas o psicoanalíticas básicas clásicas, de inconsciente y de conflicto psíquico, no son suficientes para resolver la patología. Y tenemos que incluir como algo fundamental la noción de "carencia de recursos yoicos" del individuo enfermo para poder resolver esos conflictos que no se ha podido abordar ni resolver por ausencia del tercero como figura paterna para poder tener modelo de identificación, es decir, función paterna, para poder reestructurar su aparato psíquico. Es decir, realizar la elaboración de un complejo de Edipo estructurante del aparato psíquico que no pudo realizar nunca en su vida. En esos niveles aparecen entonces, claramente la necesidad de incluir nuevos conceptos que no son habitualmente utilizados, en técnicas como por ejemplo el psicoanálisis individual, pero que se ven mucho más claramente en la patología familiar o en el proceso terapéutico incluyendo la dimensión familiar del mismo.

En ese sentido encuentro, como en muchas otras oportunidades, puntos de convergencia con la exposición de Taragano, cuando habla de carencia de capacidades de salud, que bueno, yo, me gusta más hablar de carencias de recursos yoicos para elaborar los conflictos y enfrentar la problemática conflictiva, digamos básica, entre la cual están los resentimientos no resueltos, los pesismismos como formas de depresiones crónicas de aspectos no elaborados, de duelos no resueltos, etc. etc.

En eso hay coincidencia y convergencia y por supuesto con muchos de los aspectos de Pichon-Rivière. De Pichon-Rivière seguramente he tomado muchas cosas, yo me consideré amigo de él, él me consideraba, me tenía mucha simpatía, lamentablemente no pude acercarme a él en los momentos en que él estuvo mejor. Pero mi trayectoria la veo muy ligada al pensamiento de Pichon-Rivière, quizá porque él influyó de alguna manera a través de sus escritos, de sus enseñanzas y a través de otras personas. Para terminar el mensaje

básico sería el siguiente: yo creo que tenemos que tratar de intentar volver a integrar las diferentes formas de abordaje terapéuticos de la enfermedad mental en sus distintas formas y en sus distintos niveles con una concepción unitaria que, a mi entender, tendría que darse alrededor de la noción del proceso terapéutico de cada persona dentro de su situación contextual, ya sea individual, ya sea grupal o familiar o multifamiliar. Y en ese sentido entiendo el alcance de lo que por ejemplo Taragano dijo. Sí creo que se puede hablar de la terapia familiar, del grupo familiar como sistema y visualizar en la concepción de sistema a los individuos como engranajes de una estructura sistémica total. Es también un aspecto de una situación, porque el sistema está siempre constituido por los individuos en juego, sino sería como una especie de superestructura en la cual cada individuo de cada grupo familiar sería como una especie, digamos, de muñeco del sistema. Yo creo que esto es un poco así, pero mucho más ligado a la patología del grupo familiar. Es decir, la noción de sistema como se utiliza actualmente en terapia familiar, me gusta más para comprender la patología que para comprender el proceso terapéutico necesario y la salud, porque en todo caso la salud es algo que se va a ir alcanzando a medida que los miembros del grupo familiar (como sistema en cierto modo rígido) pueda ser digamos abandonado por cada uno de los miembros que puede formar en todo caso parte del sistema, o salirse del sistema con más libertad interior y exterior. El problema del grupo interno en relación con el grupo externo tendría mucho que ver con esto, es decir hasta qué punto y qué interrelaciones tiene el sistema externo con el sistema interno. En cierto modo podemos decir que Freud fue el primer sistémico en la historia de la psicopatología y en la historia de la psicoterapia, porque la estructura del aparato psíquico en términos del yo-ello y superyo es el primer sistema y ese sistema lo vamos a tener que encontrar dibujado de alguna manera en la estructura sistémica de la familia.

Freud, por otra parte es el primero que habló del complejo de Edipo como la estructura conflictual típica básica de la patología del ser humano, pero también es una estructura familiar. Quiere decir que Freud tenía desde el comienzo de su obra la estructura familiar incluida dentro de su teoría y dentro de su método terapéutico.

TEORIA DE LA TERAPIA FAMILIAR

Dr. CARLOS MARTINEZ BOUQUET; Lic. JUAN CARLOS NOCETTI;
Lic. HUGO HIRSCH; Lic. SARA JUTORAN; Dr. ROBERTO ILEYASSOFF.

Coordinador: Dr. OSCAR CZERTOK

Dr. Oscar Czertok: Los participantes de esta mesa tratarán sobre la Teoría o las Teorías de la T. F.; sabemos que se trata en realidad de un conjunto heterogéneo no necesariamente coherente de versiones más bien paradigmáticas de enfoques sobre las perturbaciones de la dinámica de la familia.

El común objetivo sería trabajar sobre hipótesis validadas por la experiencia clínica larga y conceptualizada de los aquí presentes.

Quizá estemos muy lejos aún de poder integrar estas teorías, y nos debemos conformar con sólo un cuadro de piezas móviles. Nuestro objetivo de todos modos es llegar a verdades más abarcativas sea de creencias compartibles, sea de la incompatibilidad de creencias.

Los participantes de la mesa son el Licenciado Hugo Hirsch, el Dr. Roberto Yleyassoff, la Licenciada Susana Jutoran, el Doctor Carlos Martínez Bouquet y el Licenciado Juan Carlos Nocetti.

Antes voy a hacerles escuchar un trozo de una sesión en una terapia de pareja a fin de que los participantes traten de mostrar su respectiva manera de pensar el material, desde cada esquema referencial.

H: Tenés una angustia espantosa.

M: Sí, me asusté.

H: ¿Cómo fue?

M: Me falta el aire, tomamos el ascensor y en lugar de subir bajó, tuve la sensación de que no salía más (suspira). ¡Qué angustia!

H ("colaborando" y dándole cuerda a la mujer): Que no salías ¿cómo?

M: ¿Eh?

H (con fastidio): Que no salías ¿cómo?

M: Qué se yo, que no salía más, que me ahogaba...

H: ¿Que te enterrabas viva?

M: Me dio una angustia... (suspira) Qué se yo, no es miedo, es una angustia inconsciente que no puedo definirla; no tengo miedo, más aún, cuando subo en esos ascensores automáticos en los que voy a estar encerrada tanto tiempo, me digo: "no voy a tener miedo, aire hay, y no me voy a ahogar, me van a sacar". Pero claro, es algo totalmente inconsciente.

H (confirmatorio): Totalmente inconsciente.

M: Una angustia que me paraliza toda y quedo así. Y no es por miedo. Y me falta el aire y pienso que si sigo 20 minutos más me voy a morir de un ataque cardíaco.

H: El corazón te empieza a hacer así...

M: Sí, me empieza a palpar y a parárseme al mismo tiempo, una sensación de paralización y yo me analizo en ese momento... es una estupidez... (Pausa).

Ahora me impresiono cuando veo un aviso fúnebre en el que hablan de la persona que murió y tiene hijos chicos, entonces en ese momento siento una gran angustia y siento mucha rabia cuando veo nietos, bisnietos...

H: ¿Y lees siempre los avisos fúnebres?

M: A veces, siento una atracción especial por esa página, entonces la leo. Quedo muy dolorida cuando la persona ha realizado su vida. Cuando dice su esposa, su hijita, entonces siento una angustia espantosa y quedo deprimida todo el día.

H: Como cuando murió Z.

M: Sí, pensé en la viuda, ni una caricia, nadie en ese momento tan trágico.

Lic. Hugo Hirsch: Le pediría a Czertok si fuera posible que antes de empezar, resumiera un poco algunos de los temas que le había propuesto a este panel, como temas centrales, de tal modo que la exposición de cada uno de nosotros tenga cierto sentido desde esta perspectiva, de lo contrario, va a ser difícil cómo darle sentido a la exposición de cada uno de nosotros.

Habíamos acordado una serie de temas centrales y pienso que sería bueno que O. Czertok los recuerde en este momento.

Dr. Oscar Czertok: Los temas centrales que les había pedido que trabajaran son: ESTRUCTURAS - RESISTENCIAS - TRANSFERENCIAS - INDICADORES DEL PROCESO TERAPEUTICO.

Lic. Hugo Hirsch: Lo primero que yo pensé cuando me invitaron a participar de este panel sobre teoría fue ¿teo... qué? Lo que creo que resume bastante bien mi opinión acerca del estado actual de las teorías en el campo de la terapia familiar. Pienso que no existen, salvo quizá en el sentido en que Freud hablaba de una teoría sexual infantil. Lo que hay por ahora es un descubrimiento empírico: bajo ciertas circunstancias parece que la gente mejora más —y creo que

no vale la pena aquí entrar a definir mejoría— si el grupo familiar es tratado como conjunto, en lugar de aisladamente. Como es lógico este descubrimiento llevó a que se formularan conceptos aplicables a ese conjunto, más que a algunos de sus miembros; pero en mi opinión estos conceptos están lejos de merecer el título de teorías. Lo que tenemos son articulaciones variadamente felices de generalizaciones, simplificaciones y modelos de pensamiento provenientes de otros campos. En el mejor de los casos son proto-teorías. Esto no implica negarles valor. Eysenck dijo en alguna parte que los terapeutas no pueden sentarse a esperar a que los científicos les proporcionen lo necesario para trabajar: tienen que ayudar con los medios de que disponen. Estos medios incluyen naturalmente sus conceptualizaciones. Como señala Minuchin: "Cada uno de los terapeutas explica la naturaleza del cambio, y sus explicaciones son diversas. Dado que sus descripciones son convincentes y que todos ellos son curadores competentes que ayudan familias, no podemos escapar del punzante sentimiento de que estamos ante quienes son, no sólo explicadores sino también persuasores". "Supongo, —dice Minuchin— que muchas de las operaciones terapéuticas presentadas por cada uno de los persuasores son isomórficas a niveles formales pero no tenemos hasta ahora un marco conceptual generalizado para integrar sus variados puntos de vista; esta es la dirección del futuro". La de esta mesa hoy.

Comparto con Minuchin estos conceptos y esto me lleva, dada la ausencia de esa teoría o marco conceptual, a utilizar el modelo más simple de entre los que habitualmente se agrupan bajo la categoría de sistémicos.

Dicho sea de paso, me parece difícil pensar en modelos de terapia familiar que no sean sistémicos, pero esto es una cuestión al margen. No es que considere que esté más cerca de la verdad este modelo o que refleja mejor la realidad que los otros, es sólo que es el más sencillo.

Bastantes años de prácticas me han llevado a la conclusión de que no existe ninguna correlación positiva entre la complejidad del modelo y la eficacia de la acción desarrollada en base a él. Me animaría a decir que es a la inversa. Los modelos complejos llevan a que en la práctica la acción a desarrollar sólo rara vez pueda utilizarlos como guía clara, aunque sí son muy apropiados para explicaciones ex post facto.

Por lo que se refiere a los temas del panel yo podría decir que desde este modelo sistema y estructura pueden considerarse sinónimos. Un sistema es en este caso, un conjunto de personas y sus atributos (conductas comunicacionales y sus relaciones significativas). Lo que se considera significativo depende de la cuestión que se trata, o sea del interés de la persona que trata la cuestión. Los sistemas no están ahí, los inventa el observador. En el caso del modelo de Palo Alto se considera significativo el conjunto de relaciones por los que el síntoma se mantiene, expresado a través de una secuencia reglada de conductas.

Quizá esto se entienda mejor si se lo describe en términos de lo que puede considerarse las premisas de un modelo de sistemas. Ellas son:

1. Los individuos tienen que relacionarse uno con el otro a través de conductas pautadas por redundancias; a estas redundancias se las puede describir consecuentemente como reglas.

2. Los sistemas familiares tienen propiedades que son simultáneamente diferentes y no deducibles del examen de las propiedades de los miembros individuales que la componen.

3. La conducta sintomática es un producto del modo en el que una persona se maneja *con* y el modo en que otros lo involucran *en* sus relaciones triádicas.

4. La aparición de conductas sintomáticas es necesaria para el funcionamiento continuado de un sistema familiar particular en un momento dado de su existencia.

5. La conducta sintomática es reforzada constantemente por el sistema familiar, de lo contrario dejaría de existir.

6. El insight histórico genético y un mayor grado de conciencia no lleva necesariamente a la producción de cambios en las pautas transaccionales de relación.

7. La resistencia al cambio en un individuo se centra en torno a la influencia de la familia como grupo, esto quiere decir que en lugar de mirar la resistencia como fenómeno deducible de características del individuo debe entenderse como deducible de las características del grupo familiar del que forma parte.

8. La evaluación de una familia consiste en el estudio de estas redundancias y del modo en que la familia responde a la intervención terapéutica que uno realiza; en este sentido evaluación e intervención son sinónimos.

La meta de la terapia es introducir cambios en la secuencia actual de patrones conductuales entre los miembros de un sistema, por lo tanto los indicadores de cambio son la modificación, otra vez, en términos conductuales, del problema que motivó la consulta y consecuentemente cambios observables en el patrón de secuencia.

En cuanto al problema de resistencia, se lo maneja de tres maneras. Dicho sea de paso, aquí la resistencia no es a hacer consciente lo inconsciente, la resistencia es resistencia al cambio. En mi opinión la resistencia es siempre la resistencia a aquello que el terapeuta propone, si el terapeuta propone hacer consciente lo inconsciente, será resistencia a eso; si lo que el terapeuta propone es otro tipo de cosa será resistencia a lo que el terapeuta proponga. El problema de la resistencia se maneja entonces de tres maneras: 1) disminuyendo al máximo la importancia del cambio a lograr; 2) disminuyendo al máximo la presencia de un terapeuta a quien resistir; 3) adoptando una posición durante la terapia que lleve a que toda resistencia favorezca al cambio en lugar de inhibirlo.

Como éste es un panel sobre teoría creo que no vale la pena entrar a ilustrar cada uno de ellos. En cuanto al pedido de Czertok

de que usemos este fragmento de sesión, como posibilidad de ilustrar algunos de estos puntos que cada uno de nosotros señala, yo en principio quizá esté poco imaginativo, pero encuentro una sola característica en este fragmento que a mí me interesa particularmente y es esta especie de patrón repetido en que el señor parece invitar constantemente a la señora a que haga una exhibición de su angustia, de su susto, de sus posibilidades de sentirse mal y la señora responde con todo entusiasmo agregando siempre un elemento más. Cada vez que ella parece cesar en esta exposición de angustias variadas, él le da un nuevo motivo como para que ella pueda recordar que existe una posibilidad más en este sentido. Desde esta perspectiva esto parecería ser una relación complementaria en la que podríamos decir que la regla consiste en que ella se comporta cada vez más como enferma y él como terapeuta comprensivo; y eso es todo. Gracias.

Dr. Oscar Czertok: Le agradecemos al Lic. Hugo Hirsch, ahora va a tomar la palabra el Dr. R. Ileyassoff, Médico Psiquiatra y Psicoanalista, Profesor de Evolutiva Tercera (Adolescencia), en la Escuela de Psicología Clínica de Niños; Director del Centro Asistencial de APNAD.

Dr. Roberto Ileyassoff: Para este panel preparé una serie de tópicos que considero hacen a la comprensión estructural o sistemática de la terapia familiar.

El psicoanálisis es un cuerpo de doctrina sistemático que puede hacer de marco referencial teórico de la terapia familiar pues es un conjunto de elementos interrelacionados de modo tal que el valor de uno resulte de la relación con los demás y con el todo del que forma parte. El psicoanálisis no sólo emplea la noción de estructura o sistema para definir el complejo de Edipo, y por ende a la familia, sino también para describir el aparato psíquico (1° y 2° tópicos freudianos). Es innegable también, que en la 3° tópica lacaniana están anudados sistemáticamente lo real, lo simbólico y lo imaginario.

La noción de conflicto psíquico también presupone la existencia de un sistema. Lo que “debiera ser” o “debiera ocurrir” (Ideal del Yo) contrasta con lo que “realmente ocurre” (Yo actual): sólo así aparece un conflicto que es a su vez condición necesaria para que aparezca en el sistema, angustia, depresión o represión. Esto está basado en lo que puntualizó Freud en 1914 en “Introducción al Narcisismo”.

El ser humano puede no saber que quiere ser lo que no es y no quiere ser lo que es, gracias a la posibilidad que tiene de construirse un ideal de sí mismo poco acorde con su idiosincracia personal. Esta sería una situación patológica básica que definiría lo que es enfermedad (pretender cumplir un ideal que exige cambios imposibles: tratar de domesticar lo indomesticable). Como se trata de un sistema, el

concepto de enfermedad está en función del de cura; si se varía el primero se modifica el segundo, por lo tanto, de acuerdo a esa concepción del enfermar corresponde concebir al curar como el proceso de diferenciación de lo "imposible de cambiar" (lo estructural) con respecto a lo "posible de cambiar" (lo coyuntural, lo defensivo, lo inhibitorio).

Una vez puestas en claro las limitaciones de la propia idiosincracia a través del proceso de la cura, es necesario hacer de ellas un "emblema" de la propia identidad. La propia identidad equivaldría a la particular manera de ser o el peculiar estilo de gozar, de trabajar, de pensar, de sufrir o de desear. Este peculiar estilo debe ser pasible de ser reconocido como valioso por aquéllos a quienes reconocemos como interlocutores válidos para reconocernos, catectizarnos libidinalmente y equilibrar nuestra autoestima. Todo este proceso de reconocimiento sólo es posible en el seno de una estructura o sistema intersubjetivo que es el Complejo de Edipo. Este funciona a su vez como la estructura subyacente de la familia humana.

Siguiendo un modelo teórico de inspiración lacaniana podríamos decir que en toda familia se da un complejo de relaciones entre tres personajes como mínimo y un lugar. Padre, madre e hijo se empeñan y pelean por ocupar el lugar de lo más valorado, de lo más importante y de lo más deseado e idealizado para el otro: el lugar del falo. Esto da sentido y dinámica al complejo.

Se pueden describir tres tiempos del Edipo (ver Lacan, 1958, Seminario sobre formaciones del inconsciente). En el primer tiempo el hijo viene a colmar ilusoriamente todo lo que a la madre le falta; se lo imagina ideal, completo y perfecto y el niño se lo cree, pues ocupa el lugar de falo para ella. Sería tanto el tapón para todo lo que le falta como la reencarnación de un estado ideal de completud: Yo ideal. Pero esta idealización no se sostiene pues en un segundo tiempo el niño cae de ese lugar y, de serlo todo para la madre pasa a no ser nada para nadie. Es el tiempo del corte, o de la castración, que no solamente se instaura por prohibición paterna de la relación de éxtasis incestuoso y sexual madre-hijo, sino de la propia desilusión materna. Ningún niño real puede sostener por mucho tiempo la ilusión de perfección fálica absoluta. En el tercer tiempo se producirá el rescate de esta situación gracias al rol salvador de la instancia (metafórica) paterna. El padre ya no aparece como "terrible", "temible" o "prohibidor", sino como "permisivo" y "donador". El niño se identifica con un emblema o limitación del padre (cuanto menos discordante con su idiosincracia, más saludable será su futuro) desde el cual podrá volver a ser reconocido como valioso por la madre y por los demás pero ya no como un todo perfecto y maravilloso, sino como alguien marcado y poseedor de un Ideal del yo que lo hará tan deseable como deseable lo fue el padre. A veces no es el padre real el que funciona como instancia paterna. Este modelo es aplicable estructuralmente al proceso de reconocimiento de cualquiera de los miembros de la familia. En el seno del Complejo de Edipo se

instituye, se accidenta y se condiciona el narcisismo, por lo tanto la autoestima. Se instituye en la relación intersubjetiva madre-hijo; se accidenta a través del corte que implica la castración y se condiciona a través del Ideal del yo. Por esto Freud llama al Complejo de Edipo complejo nuclear de las neurosis.

La autoestima condicionada por el proceso de reconocimiento es el elemento fundamental de la salud, por lo tanto lo es de la cura. Como el proceso de constitución de la autoestima tiene que ver con la dialéctica edípica y con la familia, salta a la vista la importancia intrínseca de estas últimas en la terapia familiar.

El falo marca un lugar de máxima valoración al cual se puede tener acceso de acuerdo a condiciones variables. Cada miembro de la familia le da contenido a ese lugar proyectando en él las condiciones que le impone su propio ideal originado en su propio complejo de Edipo que funciona como árbol genealógico.

Por estas razones cuando un miembro de la familia designa a otro miembro de la misma como "paciente" y motiva una consulta, lo hace siempre desde su ideal: es "sano" lo que coincide con su ideal y es "enfermo" lo que se desvía del mismo.

Es necesario tener en claro que para la postura lacaniana así como falo no es pene, sino premisa ilusoria de completud y perfección ("todo el mundo tiene de todo"; "todo el mundo tiene pene"; "a nadie le falta nada"); castración no es pérdida de pene, sino tan sólo la comprobación de la caída de la premisa ilusoria de completud ("no todo el mundo tiene de todo, ni es perfecto, pues el pene puede faltar"). Además, es imprescindible puntualizar que aquí no termina la cuestión, pues la castración no solamente tiene que ver con el hecho de que "el pene puede faltar" sino de que "siempre falta algo para estar completo". Si se es hombre y se tiene pene no se puede procrear, y si se es mujer y se puede procrear no se tiene pene. Esto se relaciona con la "roca de la castración" contra la cual choca todo análisis en su fase de terminación (ver S. Freud, 1937, Análisis terminable o interminable).

Lacan le dá fuerza determinante y matemáticamente ineludible a la cuestión de la castración al relacionarla con la teoría de los conjuntos. Un conjunto presupone siempre un elemento que no forme parte de él como para definirlo como tal. El elemento excluido crea una diferencia significativa. El conjunto de los conjuntos o el conjunto universal no existe. Lo absolutamente perfecto no existe. El falo es una ilusión. La categoría de lo imposible, existe. Siempre se encuentra una limitación o una "castración"... ¡y por suerte! ... pues gracias a esto es posible que algo se diferencie en el seno del todo indiferenciado y adquiera idiosincracia, identidad o estilo. El hecho de que la categoría de lo imposible exista tiene dos tipos de consecuencias fuertes. El primer tipo se articula con lo dicho anteriormente con respecto a qué es curar. Si se trata de cambiar lo "imposible de cambiar", en vez de cura se produce enfermedad (iatrogenia). De ahí que sea tan importante diferenciar de entrada lo

estructural de lo coyuntural y empeñarse en una tarea de diagnóstico diferencial y de semiología para lo cual el método de indagación psicoanalítico se muestra imprescindible. El segundo tipo de consecuencia tiene que ver con el hecho de que toda idiosincrasia personal o estilo, encontrará invariablemente un límite, algo que forzosamente no podía incluir. El límite lo encontrará no solamente por la dotación cromosómica genética y por el hecho de nacer inscripto en un discurso o leyenda familiar que lo determina, sino por las identificaciones estructurantes establecidas en los primeros años de vida.

En el segundo tiempo del Edipo, el tiempo de la castración, cuando el niño abandona el lugar de complemento fálico para la madre, se apropia subjetivamente de este límite. La catectización libidinal de esta limitación requiere atravesar el tercer tiempo pues ahí interviene la instancia paterna como permisiva y donadora y no sólo como temible y prohibidora. Esto le permite ser deseado y querido pese a sus limitaciones o gracias a las mismas dado que se ha identificado a las limitaciones del padre (o a las contrarias en caso de rivalidad); padre que a su vez logró ser reconocido pese a sus limitaciones o gracias a las mismas y las pudo convertir en su ideal del yo.

Pasar del hijo (o padre) soñado e ideal al hijo (o padre) real y concreto que florece mucho más saludablemente en cuanto se deja de exigirle que cambie y se lo mira e interpreta con el lente adecuado a su peculiaridad, requiere atravesar los tres tiempos del complejo nodular. Paradójicamente, el cambio consiste en no pretender cambiar y entender porqué se pretendió eso. (¿Será por envidia frente al espectáculo de gran prestancia que es "el otro" cuando encarna nuestro ideal?) (¿Qué papel desempeña la sexualidad en ese enamoramiento de la imagen del "otro" que se quisiera ser?). Ciertas características o estilos personales sólo son dañinos vistos con determinado lente que usa la familia. El estilo no reconocido tiende a ser reprimido, renegado o excluido a raíz de lo cual no puede orientarse productivamente. La familia tiene el poder de ser el sistema de reconocimiento más privilegiado. La pasión por el reconocimiento es la favorita del ser humano. El modo en que ha sido reconocido en la endogamia marca a sangre y fuego el modo en que esto ocurrirá en la exogamia.

Para el psicoanálisis un síntoma es siempre expresión de la estructura; es más, una estructura sólo se devela a través de sus síntomas. Hay que diferenciar dos clases de síntomas, los que son expresión de la estructura inamovible o idiosincrásica de un sujeto y los síntomas que son producto de la mala relación del sujeto con sus propias características inamovibles: es decir sus síntomas en el primer sentido. Unos serían síntomas que tienen que ver con el modo de ser o con la salud y otros serían síntomas que tienen que ver con la enfermedad.

"¿Dime qué síntoma tienes y te diré quién eres!"

"¿Dime si te aceptan tus síntomas como valiosos, aquéllos a quienes consideras valiosos y te diré si te sientes sano!"

"¿Dime si aquellos que consideran valiosos tus síntomas son a su vez valiosos por no ser destructivos del bienestar más general y te diré que eres sano!"

"¿Dime cómo te las arreglas con tus síntomas y te diré si eres enfermo!"

Marco Aurelio pedía en una de sus sentencias que se le concediera serenidad para aceptar las cosas que no podía cambiar, coraje para cambiar las cosas que podía y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Tendrá esto algo que ver con la tarea de la cura en una familia?

Siempre se trabaja con la familia aún trabajando individualmente pues el psicoanalista tiene en su cabeza la estructura edípica de su paciente. Para Freud toda psicología individual es inicialmente psicología social según lo puntualiza en *Psicología de las Masas y Análisis del Yo* en 1920. ¿Es siempre imprescindible trabajar con la presencia real de la familia? ¿Cuáles son los indicadores para hacerlo? ¿De qué depende? La primera contestación que salta al oído serían dos preguntas: ¿quién consulta? y ¿por qué consulta?

Completaré mi intervención de hoy señalando que dejo hablar libremente a los pacientes y a las familias según el caso. A veces les hago preguntas. Desde esta postura teórica, el lenguaje verbal estructura toda la situación terapéutica y da sentido a lo gestual. A veces lo gestual permite, a través de su discordancia con lo verbal, entender lo verbal mismo. La verdad sólo se puede descubrir cuando alguien intenta mentir y sólo se puede mentir si se habla. No solamente se descubre la verdad si alguien intenta mentir sino también si se equivoca o si omite. Otras veces, los efectos de verdad que proporcionan el sentido buscado, aparecen al cotejar distintas versiones sobre un mismo hecho proporcionadas por distintos miembros de la familia. Las palabras siempre terminan diciendo lo que no debieran decir y si se las sabe escuchar con un oído psicoanalítico (atendiendo especialmente a los desplazamientos y condensaciones, metáforas y metonimias, como si fueran el contenido manifiesto de un sueño) terminan siendo un instrumento semiológico fundamental para hacer el diagnóstico diferencial imprescindible para esta concepción de la cura.

El objetivo principal de la cura es la reubicación de las expectativas de cambio con respecto a la idiosincrasia del sujeto. También comprende la reubicación de lo real en el lugar de mayor importancia fálica ya entonces transformada en ideal del yo y entrar así en la dialéctica del reconocimiento y libidinización en el seno de las relaciones edípicas familiares.

Tanto la desubicación como la reubicación, así como la sanción del ideal del yo y el proceso de reconocimiento no se pueden concebir sin la intervención de la palabra organizada en sistemas de discurso o ideológicos. El terapeuta sólo interviene con palabras: con ellas tranquiliza afectos desencadenados reubicándolos. Los afectos

principales son la angustia y el goce y son una verdadera brújula del proceso. En esta concepción terapéutica, se analiza en transferencia pero no necesariamente la transferencia. La transferencia es el motor del proceso terapéutico.

A través de la palabra también se recoge la historia novelada de la familia o del paciente. Cuando los datos históricos también incluyen lo "extraoficial" se producen efectos de sentido, o de verdad, muy importantes. Un ejemplo sería el caso de una madre que se casa con un hombre "reflexivo", hace un matrimonio de "razón" y le nace un hijo tan "reflexivo" como el padre. Lo desprecia continuamente, lo desconfirma narcisísticamente y lo desconoce hasta provocarle perturbadores síntomas en su desarrollo. Todo esto se entiende cuando se averigua que ella pretendía que el hijo la resarciera convirtiéndose en un "apasionado emprendedor" como lo fue su padre y un anterior pretendiente suyo (con el que casi hizo un matrimonio de "pasión", que no concretó por temor a la inseguridad). Sólo así aceptaba colocar a su hijo en el lugar fálico. Estas condiciones permanecerían inconscientes de no relevar la anamnesis correctamente.

Lo que más llama la atención en el caso que trajeron para hoy es que el hombre parece gozar del hecho de angustiar a su mujer y ésta acepta gozosa entrar en el juego. También es notorio que no se dirijan al terapeuta y no le formulen ningún pedido. No se sabe por qué consultan y si consultan o no, pues el material es incompleto. Esto hace que la situación parezca artificial. Si no hay síntomas ni motivo de consulta que instaure una transferencia, no se estructura la situación terapéutica como para justificar el hacerlos hablar y encontrar las razones de su desequilibrio que luego conducirá a la estructura subyacente y a las palabras mismas en las que cada paciente reconoce la ley que organiza su ser y su idiosincrasia. Para esto hace falta tiempo, elaboración y seguimiento —quizá ésta sea mi diferencia más importante con el enfoque interaccionalista.

Por último, no quiero despedirme de ustedes sin poner el acento sobre lo siguiente: ¡ojo con lo que "resiste", "insiste", o "se repite" en los pacientes pues puede ser un indicio de su propia idiosincrasia y puede conducirnos a su estructuración fantasmática fundamental. Esta última es la clave de su subjetividad y de la legalidad intrínseca de su ser, y puede llegar a expresarse en una pequeña frase en la fase terminal de su tratamiento. Imagínense lo nocivo que puede ser que el analista se alíe inconscientemente con el propio paciente y su familia en sancionar como enferma esta insistencia usando un particular ojo ideológico.

Aquí pongo punto final pues el tiempo apremia, muchas gracias.

Lic. Sara Jutoran: Yo voy a hablar sobre el tema del panel de acuerdo al enfoque del grupo de Milán, del Centro para el Estudio de la Familia de Milán, dirigido por las doctoras Palazzoli y G. Prata.

El modelo sistémico, fundamento epistemológico del Centro per lo Studio della famiglia de Milán, surge a partir de un cambio radical en el pensamiento científico, propuesto por la Teoría General de los Sistemas, la Cibernética, la Teoría de la Comunicación, y fundamentalmente, el pensamiento y obra de Gregory Bateson.

Las ciencias humanas no podían permanecer ajenas a este salto epistemológico que produce un viraje del individuo al sistema, centrándose en Gestalten más amplias que incluyen la dimensión temporal y acentúan la matriz social y cultural. A partir del principio de indeterminación de Heisenberg, el concepto de objetividad pierde validez, incluyéndose al observador en todo fenómeno observado. Las ciencias matemáticas, las ciencias naturales y la ingeniería, con la aparición de la Teoría General de los Sistemas, empiezan a correlacionarse con la Psiquiatría. Fenómenos tales como la entropía, derivada de la 2da. Ley de la Termodinámica, la retroalimentación o feedback, proveniente de la Cibernética, son incorporados para una mayor comprensión de la complejidad de los problemas humanos.

Se pasa así al estudio de sistemas complejos donde se detectan constelaciones de variables interdependientes con cadenas causales circulares y reticulares que ponen en tela de juicio el determinismo causalista. El hombre comienza a ser considerado inseparable de su medio ambiente.

La terapia familiar tampoco permanece ajena a esta revolución del pensamiento científico, y ya a partir de la 2da. mitad de este siglo comienzan a formarse en distintas partes de U.S.A., instituciones que utilizan este marco de referencia.

En 1967, en Milán, la Dra. Mara Selvini Palazzoli organiza el Centro per lo Studio della Famiglia, tomando como fundamento el modelo sistémico. Durante estos 15 años, y a través de una constante interacción entre praxis y teoría, va creando e implementando nuevos métodos de abordaje en terapia familiar, especialmente dedicada a la Anorexia Nerviosa en un principio y luego a la Esquizofrenia.

La familia, dentro de este enfoque, es considerada como un sistema de autorregulación, que se controla a sí mismo por medio de reglas (formulación de las redundancias observadas en el nivel relacional) formadas a través del tiempo por un proceso de ensayo y error. "Vivir juntos implica inevitablemente establecer un sistema de aprendizaje; cómo aprender a vivir juntos. Esto "cómo" no es otra cosa que una serie de ensayos y errores por medio de los cuales la pareja aprenderá a aprender, es decir, encontrará soluciones al principal problema que les concierne: cómo vivir juntos". La familia tiene una historia, con un tiempo de vida propio, está formada por partes o elementos interrelacionados, interdependientes, rodeada de fronteras o límites, y relacionada a otros sistemas mayores y menores.

La familia cumple determinadas funciones biológicas, psicológicas y sociales que no podrían realizarse si la interacción de sus miembros no tuviera una determinada organización. Esta organización del

sistema en base a la permanencia de ciertas relaciones entre sus elementos nos permite comprender el concepto de estructura. Sin embargo, esta permanencia es relativa y limitada en el tiempo. Es decir que podemos comprender una estructura en tanto fija, en un determinado momento, pero los momentos se suceden y a medida que se van sucediendo, la estructura cambia. La definición de estructura que da Piaget, como estructura diacrónica, matriz de estructuras sincrónicas sucesivas, es la que mejor nos permite comprender este concepto.

La estructura familiar es entonces el conjunto de relaciones significativas, jerárquicamente organizadas, en base a reglas implícitas que determinan el contexto de intercambios entre los miembros del sistema y configuran sus patrones de interacción.

Según el modelo del Grupo de Milán, esta estructura está constituida por una red interrelacional no limitada solamente a la familia nuclear, sino que incluye también ambas familias de origen y otros sistemas (escolar, laboral) en cuanto a sus relaciones significativas con el sistema familiar.

Todo sistema viviente es abierto, es decir que intercambia materia, energía e información con su entorno, por lo tanto posee la capacidad de adaptarse a las exigencias del medio que constantemente evoluciona y se transforma. La estructura tiene que modificarse por lo tanto, para adaptarse a tales exigencias, o será destruida. El interjuego que se da entre mantenimiento y transformación de la estructura es lo que permite la supervivencia del sistema.

Un sistema familiar puede ser destruido por una tendencia morfostática tan rígida como para excluir aún la más mínima exigencia de cambio externo o interno.

Pero también puede ser destruido si se adapta indiscriminadamente a toda exigencia de cambio, al punto de perder los presupuestos de la propia subsistencia y por lo tanto disolverse (disolución de la familia).

Un sistema familiar puede ser lo suficientemente elástico como para aceptar sólo aquellas exigencias de cambio que le permitan desarrollarse sin llegar a su disolución.

Esta es la única solución posible para la supervivencia de un sistema.

"En el curso milenar de la historia, la familia sociológicamente ha funcionado siempre como una barrera contra los cambios sociales. Pero debemos reconocer que jamás en la historia, la familia se ha encontrado con el hecho de tener que afrontar cambios tan rápidos y radicales como los de nuestro tiempo". (Dra. M. S. Palazzoli).

Indicadores del Proceso Terapéutico

La Dra. Palazzoli define el proceso terapéutico paradójicamente como una terapia breve de largo alcance. La variable tiempo tan importante en los sistemas vivientes es relevante en este enfoque.

El proceso terapéutico consta de 10 sesiones con un intervalo de un mes o mes y medio. Esta metodología se fundamenta en el hecho que toda intervención o in-put en el sistema necesita de un tiempo suficientemente prolongado, indispensable para una acumulación de retroacciones o retroalimentaciones observables.

Por otra parte, la decisión de limitar el número de sesiones a 10 fue determinada por la convicción de que con familias tan patológicas es necesario descubrir rápidamente ciertas reglas del llamado juego familiar, o se corre el riesgo de ser absorbido dentro del circuito autocorrectivo del sistema. En síntesis, es una terapia breve si se considera el tiempo dedicado a trabajar directamente con la familia, y larga, respecto al tiempo que necesita la familia para organizar su transformación.

Indicadores

1) Desaparición, disminución o modificación de la conducta sintomática del P. D.

2) Modificación de los patrones de relación, por lo menos en cuanto a una mayor variedad de respuestas alternativas entre sus miembros, es decir una mayor complejización del sistema.

3) Una clara demarcación de límites entre los subsistemas, diferenciando a los individuos entre sí y bloqueando las secuencias habituales de interacción, poniendo especial énfasis en la desestructuración de triángulos perversos (coaliciones secretas).

Homeostasis y Resistencia

Todo sistema viviente está regido por dos procesos aparentemente contradictorios: morfogénesis y morfostasis, términos acuñados por el filósofo Magoroh Maruyama.

Morfogénesis, como su nombre lo indica, se refiere a la generación o surgimiento de forma. Es decir a la capacidad de transformación del sistema, ya sea por exigencias internas al sistema (un hijo que entra en la adolescencia), o por estímulos del entorno (crisis económicas). Este proceso amplificador de la desviación implica cadenas de feedback positivo que llevan al sistema más allá de su plateau autorregulador, más allá del rango de estabilidad dentro del cual las fluctuaciones son amortiguadas, es decir, más allá de los límites dentro de los cuales el sistema es autocorrectivo, hacia un nuevo rango de funcionamiento. Este proceso favorece la adaptación del sistema al medio. Enfatiza el cambio.

Morfostasis es el proceso que asegura la constancia del sistema frente a las modificaciones del medio. Esta constancia es lograda a través de la corrección de la desviación por medio de cadenas de feedback negativo, por el cual el sistema responderá a cualquier in-put que promueva el cambio, con un out-put neutralizador de ese cambio, que mantenga el statu-quo del sistema.

El concepto de homeostasis se refiere al equilibrio dinámico que

se da entre estos dos procesos, morfoestasis y morfogénesis. La homeostasis es por lo tanto, más que un estado, un proceso, autorregulador, por el cual los sistemas vivientes tienden a mantener su estructura a la vez que se adaptan a condiciones óptimas para la supervivencia. Esto se logra a través de mecanismos de retroalimentación negativos y positivos que inhiben o amplifican la desviación respectivamente.

En los sistemas patológicos se observa una tendencia creciente del proceso morfoestático. Cada cambio en estas familias es sentido como una amenaza, por lo que el sistema reacciona, a través de cadenas de retroalimentación negativa, aumentando su rigidez, cerrando filas, preservando excesivamente su estructura, repitiendo comportamientos no adaptativos cuya función es evitar toda posibilidad de cambio.

El Grupo de Milán ha puesto especial énfasis en el estudio de las maniobras utilizadas por estos sistemas en cuanto resistencia al cambio. Negaciones, contradicciones, omisiones, sabotajes, descalificaciones del mensaje, del contenido, del contexto, cambios de tema, tangencializaciones, amnesias, desconfirmaciones, y como suprema maniobra —dice la Dra. Palazzoli— el síntoma, mensaje de aquel que invocando el cambio señala a su vez la imposibilidad de cambiar.

El síntoma, por lo tanto, en su mensaje paradójico, es un elemento más en el interjuego patológico del sistema, morfoestático por excelencia, su función es reforzar las estereotipias interaccionales, mantener la rigidez del sistema, y por ende, resistir a todo cambio.

Respecto a la *resistencia* quiero mencionar brevemente el paralelismo que existe entre ésta y una de las artes marciales japonesas, el Aikido. Este es un método de auto-defensa cuya finalidad es neutralizar y reencauzar la agresión del atacante. El contexto del Aikido es aquel en el que una persona se acerca al Aikidoista con un desafío intencional. Con sus acciones el desafiante dice: "Lo estoy desafiando a tratar de cambiarme. Le mostraré que Ud. no puede y que soy más poderoso que Ud." Un paciente, una familia se acerca a un terapeuta con un desafío similar. Según Pittman "La gente viene a terapia para no cambiar, si quisieran cambiar, no vendrían a terapia". En realidad buscan retornar a un estado anterior a aquel en que se produjo la crisis.

Un Aikidoista nunca confronta al desafiante. Acepta, se une y se mueve con la fuerza del desafiante en su propia dirección. De esta manera la resistencia desaparece porque el Aikidoista no ofrece nada ante lo cual resistir. El Aikidoista sólo utiliza la fuerza del desafiante. Así puede convertir la resistencia potencial de éste en energía libre para poder guiarlo en direcciones más positivas y constructivas.

El terapeuta familiar, como el Aikidoista, acepta y fluye con la fuerza y la dirección del desafío, minimizando o eliminando de esta manera la resistencia de la familia, utilizándola para encauzarla hacia el logro de los objetivos terapéuticos. Es en este sentido que utilizamos la resistencia, en cuanto tendencia morfoestática, connotándola

positivamente, aún prescribiéndola con el fin de potenciar los procesos morfogenéticos del sistema familiar. Muchas gracias.

Tomará la palabra el Dr. Carlos Martínez Bouquet, psiquiatra, psicoanalista, psicodramatista, terapeuta de parejas, de familias y Director del Instituto Argentino de Análisis Bio-energético.

El Dr. Martínez Bouquet plantea que además de su interés por curar al enfermo como médico y como psicoterapeuta, se agrega su interés por ayudar al desarrollo espiritual del individuo.

Dr. Carlos Martínez Bouquet: Desde hace aproximadamente 25 años trabajo en psicodrama psicoanalítico, a raíz de lo cual y en función de contar con un basamento teórico adecuado, he formulado la "teoría de la escena".

De acuerdo a esta teoría tenemos que distinguir en las dramatizaciones que se producen en el trabajo psicodramático-psicoanalítico, psicoanalítico-psicodramático; las que, por supuesto, tienen estructura dramática, otra estructura dramática a la que he llamado "escena imaginaria o latente". Esta escena imaginaria o latente subyace y es la causa de las dramatizaciones. A partir de denominar a esta estructura "escena imaginaria o latente", llamamos a las dramatizaciones escenas manifiestas. Se postula la existencia de un nivel manifiesto y un nivel latente reconocible en el material de las sesiones psicodramáticas. Así como en el psicoanálisis hay un material manifiesto dado por lo hablado por el paciente y un material latente, que es el significado y la causa de lo que el paciente habla, en psicodrama psicoanalítico, hay un nivel manifiesto y un material manifiesto que es la dramatización y un nivel latente que es el significado y la causa de la dramatización. El punto de partida de esta teoría fue el descubrimiento de que el material latente tenía también estructura dramática. Ví pronto que las escenas imaginarias o latentes subyacen, no sólo a las dramatizaciones, sino a las demás conductas (verbales o no) del pequeño grupo terapéutico y no sólo del pequeño grupo terapéutico, sino que se podía generalizar a toda relación interpersonal. Así encontré que están presentes también en: lo latente de la relación interpersonal, bipersonal psicoanalítica. Por otro lado se me hizo evidente que hay estructuras dramáticas en el inconsciente del individuo, si bien no se trata de aquellas a las que he denominado escenas imaginarias. En el individuo hay huellas dejadas por las experiencias vividas en las relaciones interpersonales (desde las más tempranas de estas experiencias interpersonales) que se acumulan en forma de escenas o sea en forma de interrelaciones de personajes. Las escenas imaginarias si bien tienen un ritmo vertiginoso de cambio, por lo que su configuración es fugaz, poseen la cualidad de volver a la misma configuración reiteradamente. Se originan en las interrelaciones de las personas a partir de las escenas propias de los individuos, aquellas que están presentes en el inconsciente de los

individuos. En psicodrama-psicoanalítico, las escenas imaginarias son la causa de las dramatizaciones y fuera de la actividad dramática generan la conducta de las personas. Las relaciones interpersonales persistentes producen una mayor fijeza de configuración, más que fijeza, habría que hablar de una aumentada reiteración de ciertas configuraciones. Las escenas imaginarias en parejas, familias y supongo que en instituciones, presentan configuraciones de escenas latentes o imaginarias de las que nos ocuparemos de determinar cuáles son características.

De acuerdo al efecto de tales escenas sobre la pareja, hablamos de escenas conflictivas, no conflictivas y benéficas. Esas escenas latentes producen interacciones de la pareja (que son las conductas observables de la pareja). ¿Cómo investigamos estas escenas latentes? Voy a citar algunas de estas vías. La dramatización hecha por cada uno de los integrantes de la pareja de las quejas, o motivos por los cuales concurre. En este caso, cada integrante tiene que hacer todos los papeles, porque lo que vamos a ver no es la interacción, sino las escenas del integrante de la pareja. Otras vías: mediante la dramatización de escenas claves: el momento en que se conocieron, (nos da cómo se relacionan actualmente, cómo cada uno va en el momento presente hacia el otro). Con las técnicas dramáticas no existe una teoría que explique cómo se produce cierta escena imaginaria a partir de cierta consigna, pero la práctica lleva a que tengamos conocimiento pragmático de qué se debe proponer para tal o cual cosa. Si yo le propongo a una pareja que cada uno piense en el momento en que se conocieron y que después lo dramaticen, cada uno por separado los distintos papeles, voy a saber cómo se encuentran en el momento presente el uno con otro, qué es lo que buscan, qué es lo que encuentran, qué los frustra. Otras escenas claves: la de la primera desavenencia, las relaciones sexuales, (hay distintas técnicas para trabajar sobre las relaciones sexuales por ejemplo una danza, ciertas dramatizaciones simbólicas, etc.). Otra situación clave: el nacimiento del primer hijo; también toda la familia reunida, la pareja y los padres de ambos, aún aquellos ya muertos reunidos en una conversación sobre un tema que fijamos de antemano o no fijamos ningún tema. Otra vía de acceso a las escenas latentes es la observación de las interacciones espontáneas que tiene la pareja en el consultorio, estas interacciones espontáneas son actuaciones no dramatizaciones.

Otra manera: observación de las manifestaciones transferenciales, etc. Lo que acabo de hablar y leer corresponde a estructuras, en mi trabajo lo que busco son las estructuras dramáticas y las estructuras dramáticas complejas, como por ejemplo, interjuegos donde a una escena sigue otra escena y luego otra escena.

Indicadores del proceso terapéutico. Uso por una parte como indicador la mejoría sintomática; el aumento del insight y la comprensión con respecto a sí mismo, con respecto al cónyuge, con respecto a la pareja. Además utilizo indicadores característicos de mi

manera de trabajar, que son indicadores de orden dramático. Por ejemplo cuando las escenas conflictivas disminuyen su intensidad dramática es que el proceso está andando favorablemente. Cuando ciertas escenas conflictivas sostenidamente se mantienen inactivas, esto también es favorable. Cuando se transforman en no conflictivas o benéficas, por supuesto, es favorable. Con respecto a escenas benéficas, cariñosas por ejemplo, el incremento de su intensidad dramática es índice de mejoría, la aparición de nuevas escenas benéficas también (algo que tal vez no sea claro para quien no conozca sobre teoría dramática), la aparición de personajes benéficos en escenas conflictivas, que las neutraliza o las hace cambiar de signo.

Se puede entender gran parte de la psicoterapia como una introducción de personajes benéficos en las escenas propias de los pacientes. Otro indicador es el reconocimiento del origen de conflictos y problemas de la pareja, distribuyéndose el peso de la causa adecuadamente a una de las tres entidades. Les voy a explicar lo que quiero decir con las tres entidades y acá paso a hablar de resistencias.

Como terapeuta de parejas, me ocupo de tres entidades: dos individuos y una pareja, y tomo responsabilidad por las tres. Asimismo, entiendo que hay resistencias de cada uno de los individuos y de cada uno de la pareja. Un ejemplo sería el trabajo que fue leído antes del panel, es un ejemplo de la resistencia de la pareja. Voy a dar un ejemplo de resistencia de la pareja. Es muy frecuente que cierto tipo de peleas y discusiones entre los cónyuges en la sesión estén puestas al servicio de bloquear el trabajo terapéutico. A veces surgen al comenzar a tratar un tema particularmente conflictivo de la pareja. Un cuidadoso trabajo del encuadre disminuye la incidencia de las resistencias.

Con respecto a la teoría de la escena redefino la transferencia, la contratransferencia y las demás funciones afectivas y funcionales existentes en un instante dado, de la terapia son aspectos parciales de una estructura única: la escena imaginaria o latente. Cuando se habla de transferencia se está hablando de un sector de esta escena, cuando se habla de contratransferencia se habla de otro sector de esta escena, la escena imaginaria está en constante cambio, es de una dinámica vertiginosa lo que produce configuraciones fugaces pero con la cualidad de retornar reiteradamente un momento tras otro, produciéndose iguales o parecidas configuraciones, donde los elementos y las relaciones se vuelven a encontrar idénticos o similares. Quisiera aclarar algo con respecto a transferencia: lo que el individuo transfiere, son escenas y son escenas propias o sea escenas que están en su inconsciente, es la escena en conjunto la que es transferida. Todos los integrantes de una interrelación contribuyen con escenas propias activas a la creación de las escenas imaginarias, no sólo entonces los pacientes, sino también los terapeutas. De modo que también importa mucho nuestra actitud ya que puede contribuir favorablemente o negativamente en la producción de un sustrato adecuado sobre el

cual se va a asentar la acción terapéutica, por ejemplo la acción interpretativa u otra acción terapéutica.

También importa que no contribuyan los terapeutas demasiado desplazando al o a los pacientes del lugar central que deben ocupar.

Las parejas o las familias no transfieren escenas propias sino que ya traen escenas imaginarias, yo entiendo las escenas imaginarias o subyacentes o latentes como grupales mientras que las escenas propias son individuales. Escena propia es muy parecido al concepto, aunque difiere, del de fantasía inconsciente y escena imaginaria se parece en el pequeño grupo al concepto de fantasía inconsciente grupal. La pareja transfiere también escenas imaginarias de la pareja que tienen mucho más intensidad y autonomía. No dependen de las escenas propias de cada paciente, ni de las escenas propias del terapeuta para constituirse. Esto es en cuanto a mi enfoque teórico. Con respecto a este diálogo no sabía bien cómo estaba ubicado, no sabía que era el comienzo de una sesión y lo que yo me pregunté es cuál es el encuadre y esto tiene que ver con mi manera de trabajar. Constantemente estoy atento al encuadre, además llevo un plan, sobre todo en el primer período de tratamiento de las parejas. Una serie de pasos a dar para las determinadas situaciones claves, determinados aspectos que voy a buscar. Entonces, me preguntaba dónde estaba colocado, porque yo no dejaría que esto ocurriese. Mostraría inmediatamente ese juego que está haciendo, para que el tratamiento fuera más ágil. Yo ocupé 15 horas para un estudio general de la pareja. Después, sobre las situaciones detectadas puedo hacer recontratos para trabajar sobre una situación, en la que he visto que hay problemas y en la que los pacientes están de acuerdo que hay problemas. Para trabajar con esas 15 horas, tengo que estar constantemente ocupando el tiempo de la manera más provechosa posible. No dejaría que ocurriese esto sino que lo pararía y le diría, "bueno por qué hace esto", "le tiene miedo, a qué". La impresión que a mí me da es que es un hombre que tiene mucho miedo a ansiedades corporales.

Yo pensé a través de esto que podía tener algunas dificultades a nivel sexual, pero tendría que tener datos. Mi impresión es que este hombre se defiende de participar él de sus ansiedades haciendo que las exprese su mujer, la mujer por alguna razón acepta este juego y entre los dos la pareja tiene una finalidad: es la resistencia, mientras esto se haga no se sigue adelante en la terapia, por lo menos en mi manera de trabajar en psicoterapia de pareja. Nada más. Gracias.

La Licenciada Sara Jutoran va a aportar también sus ideas sobre el material clínico.

Lic. Sara Jutoran: En general coincido con el análisis que hizo H. Hirsch. Lo que veo es que ésta es una transacción, entre dos personas que se comunican y analizándolo como un sistema diádico diría que hay una relación complementaria en la cual una persona

induce conductas en el otro y otro acepta, a la vez que permite que el primero siga induciéndolas. Con lo cual se produciría una escalada complementaria, un crescendo en la situación y un aumento de la ansiedad. Nada más.

Va a tomar la palabra el Lic. Juan Carlos Nocetti, Profesor Titular de la Escuela de Post-grado de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Autor de diversos artículos en revistas, especialista en tratamientos de familias y parejas y Miembro de la Sociedad de Terapia Familiar.

Lic. Juan Carlos Nocetti: Poder explicar lo que hace una analista en una sesión no es fácil, mucho menos cuando tenemos el tiempo que este panel nos deja a cada uno, cuando además se espera que eso sea articulado con la teoría y cuando se espera también que demos cuenta de este material que nos ha hecho llegar tan gentilmente el Dr. Czertok, esta mañana.

Me parece quizá, una manera de introducirnos, puede ser a través de una idea de juego que ha estado rondando esta mesa todo el tiempo.

Bateson usaba el juego del ajedrez, para explicar algunas de las modalidades del funcionamiento de la pareja.

El ajedrez es un juego interesante, no sólo es un juego de habilidad, es un juego de estrategia y también de cálculo y posee la posibilidad de revisar y analizar las partidas después de producidas. Aunque tuviéramos ante nosotros las piezas, el tablero, los jugadores, las mismas movidas, nada de todo eso existiría, tendría sentido, sino fuera por la existencia de las reglas. En realidad son las reglas las que constituyen el ajedrez (aunque las reglas no las observemos), a partir de lo que observamos vamos a poder encontrar cuáles son las reglas que cada uno de los jugadores está poniendo en movimiento cada vez que se mueve. Pero algo más, las reglas son las que determinan el lugar de las piezas pero no sólo de las piezas, sino de los jugadores mismos. Una vez que uno sabe que será jugador blanco, sabe que va a tener que jugar primero y el negro será segundo. El lugar de cada uno de los ajedrecistas está determinado por las reglas. Me acordé que Freud en sus trabajos sobre técnicas, comparaba también la sesión con el ajedrez. Pero la pregunta sería, qué clase de juego es este juego de la sesión. Había preparado un breve fragmento de un material clínico.

Les pediría que lo escuchen con atención. El primer impacto es que no tiene absolutamente sentido. Se trata de una pareja internada en un instituto geriátrico por su hijo. El analista es la Lic. Susana Peller, que nos facilitó este material, a partir de una supervisión.

Prefiero relatar en primera persona porque eso nos va a facilitar el comprender.

En la sesión están entonces: José, Sofía y Ernesto, el hijo de ambos que fue quien gestó la internación.

“En aquella sesión José me miró fijamente y me dijo: últimamente escuché que estaban hablando muy mal de Ud., lo ensucian como profesional, lo que yo dije es que Ud. es un brillante profesional, lo que haga de su vida privada no tiene por qué competirle a nadie, ¿no le parece? —La muerte es lo peor que a uno le puede llegar a pasar, eso es lo más terrible, lo más terrible— (qué tiene que ver la muerte con esto de que yo sea o no un brillante profesional), eso es lo más terrible, lo más terrible. En ese momento interviene Sofía y dice: morir joven como mi hermano es lo peor, morir viejo no —morir a su edad sería terrible, ¿no? —¿A mi edad? — ¿Tu hermano murió joven? pregunta Ernesto, ¿si era mayor que yo! —Salomón —aclara José, en un accidente hace 12 años, fue en Cañuelas en el Puente del Arroyo Ludueña. Chocó y el golpe en la cabeza lo mató. —Pero papá, ¿cómo decís esas cosas! José sigue con la palabra en creciente enojo, pero no le voy a contar a Ud. esas cosas personales, porque Ud. no conoce los límites. Las cosas personales no se cuentan. Tal vez se trate entre los límites entre Cañuelas y el Arroyo Ludueña, porque el Arroyo Ludueña queda cerca de Rosario y Cañuelas en Buenos Aires. —Las cosas personales no se cuentan porque a Ud. no le gustaría que yo vaya contando lo que le pasó a su padre. —¿A mi padre? ¿Y cómo enfermó él? Porque Ud. no se va a acordar porque tenía 5 años, cuando Ud. tenía la misma edad de mi hijo Alberto. El creía, su papá, que su querido amigo besaba a su esposa porque era de la familia y porque la quería, pero después descubrieron que era mujeriego y que eso lo hacía con todas las mujeres. Ud. ya no se acuerda. Lo más curioso de todo es que no fue su padre el que se enojó con él, aunque lo pensó hacer, fue su esposa, su propia esposa. En ese momento yo podría preguntarle qué le pasó cuando él tenía 5 años, el asunto es que si uno no entiende las reglas del juego la partida no tiene sentido, es como mirar un partido de fútbol pensando que son 22 personas corriendo detrás de una pelota. Pero el hecho es que si yo quiero entender algo de lo que se trata es de descubrir las reglas del juego. Hay ciertas palabras que en realidad no tienen un referente claro, a no ser que nos remitamos a aquel que las enuncia. Si yo por ejemplo digo: “esta silla” va a ser distinta silla que si alguien que está en el fondo del salón dice: “esta silla”, porque el término “ésta” va a estar en relación a quien la enuncia. Así como el término aquí o allá. Pero sobre todo acerca de los pronombres, porque si yo digo que estoy hablando yo, no es lo mismo que diga yo, otra persona que no sea yo. Ese enunciado que estoy hablando me va a poner en tela de juicio en cuanto a lo que estoy diciendo. El enunciado “estoy hablando” me coloca a mí en un lugar particular frente a lo que estoy diciendo.

Lo que me importa es ver el juego, me importa la sesión, aunque este juego se repite en la sesión constantemente. Dice así “porque a Ud. no le gustaría que yo contara lo que le pasó a su papá”. Se supone que este relato coloca en el lugar del yo que está hablando,

a José e inmediatamente me coloca a mí, analista, en el lugar de Ud. En este juego yo estoy colocado en el lugar de Ud. en el relato, de yo pasa a estar ocupado por José. Indudablemente así no tiene ningún sentido porque él no sabe quien es mi papá ni lo que le pasó, yo lo sé, y seguramente ellos también lo sepan. Si yo invierto la dirección y coloco en el lugar de Ud. donde estaba colocado, el lugar de yo, entonces digo a Ernesto: que ahora yo lo coloco en el lugar de Ud., le digo: porque a Ud. Ernesto no le gustaría que yo contara lo que le pasó a su papá (el papá fue internado a raíz de una enfermedad). Quiero decir que lo que yo hice es cambiar el lugar de un pronombre y con eso reubicar a cada uno de ellos con respecto al discurso. Cuando pregunto qué le pasó a él cuando tenía 5 años, yo no sé quién es él, pero eso va a servir para reubicarlos con respecto a lo que contaron. Para que entiendan más les voy a decir algo que después me enteré con respecto a la historia de ellos. Resulta que Alberto, el que mencionaban, es otro hijo de ellos que murió en una situación bastante oscura (uno podría decir que era un intento de suicidio) era el hermano mayor de Ernesto. Es interesante porque Ernesto dice, “él era mayor que yo”, refiriéndose a Salomón. Yo ya no sé de quien hablaban porque estaban hablando de un muerto. Salomón es un hermano mayor de Sofía —médico como José— ellos vivían en Rosario. Cuando vinieron a Buenos Aires (José ya había llegado antes) e hizo entrar a un servicio donde él mismo trabajaba a este cuñado Salomón. Con el paso del tiempo, Salomón, que era un brillante profesional, según dice José, llegó a ser jefe de servicio. Era soltero pero se comentaba de él que tenía una vida licenciosa. Pasó un tiempo y José y Sofía se enteraron de la vida de su hermano, que por ese entonces vivía con su hermana y que a raíz de la muerte del esposo de esta hermana, otra hermana de Sofía, él se había quedado con algunos campos que este señor tenía en Cañuelas. Parecía haber sido una estafa, una usurpación, no era muy claro tampoco, el hecho es que en una reunión que tuvieron, Sofía se enojó muchísimo con su hermano y le dijo todo lo que pensaba acerca de él, acerca de su vida licenciosa y toda esa situación oscura que había con los campos de Cañuelas. Por otro lado Ernesto no está muy al tanto de toda esta historia. Pero yo sí sé que Ernesto tiene un papel firmado por lo cual pudo vender la casa de los padres (donde vivían antes de su internación) y quedarse con los bienes de los padres. Quizá sea difícil en una rápida lectura darse cuenta de cómo ese relato al principio tan confuso y sin sentido empieza a tener sentido cuando uno cambia de lugar los pronombres y empieza a cambiar la referencia y el lugar y la posición de cada uno con respecto a ese discurso.

De esto trata un analista en una sesión... Pero, ¿de qué juego se trata entonces, se trata simplemente de un juego de palabras? : el sistema con el que estamos tratando es un sistema semiótico. ¿Qué quiere decir un sistema semiótico? Es un sistema cuyos elementos básicos, cuya constitución está hecha a partir de establecer diferen-

cias en un sistema homogéneo y estas diferencias plantearlas en términos de oposición u oposiciones. La familia con que tratamos nada tiene que ver con la familia biológica, porque se trata de una familia que representa un juego semiótico, un juego donde lo que está en juego es la significación. Para pensarla tenemos que partir del tabú del incesto que establece una diferencia y una oposición entre las relaciones matrimoniales y las relaciones de consanguinidad. Es a partir de ahí donde comienza la constitución de ese juego semiótico. ¿Qué es lo que hace un analista en una sesión? Hace hablar. ¿Por qué hace hablar? Porque en el hablar cada uno de nosotros, pone en juego su lugar con respecto a su discurso. Una familia en su hablar va a ir jugando la posición que cada uno cree tener con respecto a lo que dice, pero no sólo eso, no sólo los pacientes hablan, también uno tiene que hablar y ese hablar, y en ese hablar también uno juega su posición.

El doctor Czertok nos hizo llegar una sesión. Voy a tomar cuatro elementos de la sesión.

Una situación inicial: tomamos el ascensor y en lugar de subir bajó.

Al final: como cuando Z murió.

Hay dos situaciones que descolocan a un sujeto, en este caso una pareja. Uno frente al ascensor cuando creía que iba a subir y bajó, y otro frente al hecho de la muerte, donde lo descoloca a uno con respecto a ciertas cosas que pensaba.

Dos elementos más: ella dice, (no sé por qué decimos ella, es femenino, sí está bien). Uno no sabe en realidad cuál es el sexo de las personas que tiene delante, no nos preocupamos por eso, lleva uno bastante tiempo en descubrirlo y es sólo a través del discurso que se puede reconocer.

Tomé estos dos momentos que marcan un descolocamiento brusco a través de una situación. Dos fragmentos más entonces, una sensación de paralización y yo me analizo en ese momento! Es una estupidez; otro fragmento: entonces en ese momento siento una gran angustia y siento mucha rabia cuando veo nietos, biznietos, ... Me parece que cuando ella dice: yo me analizo en ese momento; yo me diría, ¿en ese momento? Yo no sé que van a contestar pero quizá se den cuenta que en este momento se está analizando y no en éste. En este momento es donde están poniendo en juego, quizá un cambio brusco de lugar, no sólo de ellos, en el lugar donde yo hasta ahora estoy colocado porque sólo soy alguien que puede presenciar este diálogo. Si ellos pueden asombrarse de pronto de que en realidad no se daban cuenta que en este momento se están analizando, quizá ese cambio brusco de lugar logre angustiarlos, y ese sería el efecto de esa intervención. Yo me sentiría tranquilo, pude salir de una posición donde el discurso de ellos me había colocado. No siempre es fácil. Si yo al hablar no logro salir de mi posición, he perdido la posibilidad de hacerlo, he perdido otra vez mi lugar como

analista. No me parece que éste sea un juego sádico, me parece que estas son las reglas del juego, y que estas cosas no pasan a todos. Nada más, gracias.

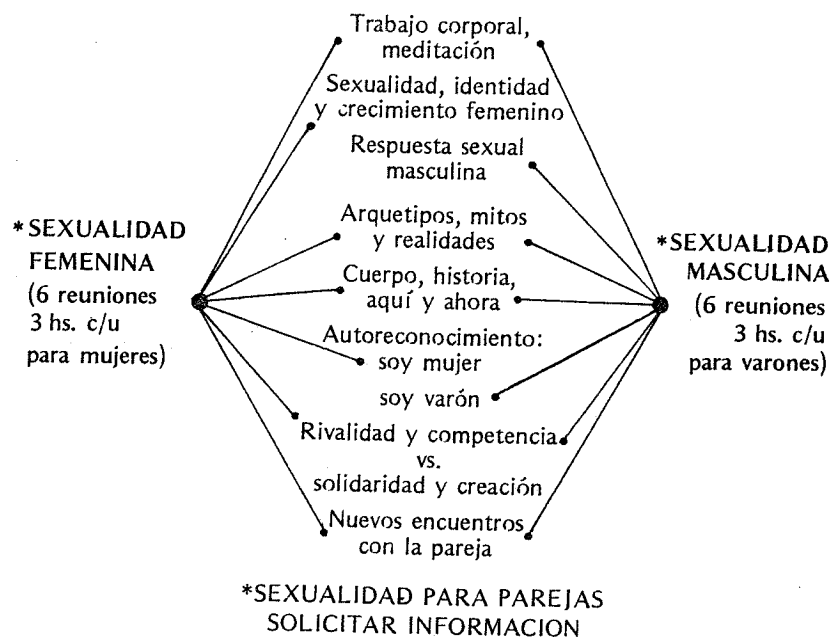
Toma la palabra un participante:

Primero felicito al panel por los aportes que hicieron. Quisiera comentar algunas interpretaciones que yo las vería de otro modo y ver qué opinan Uds.

Por ejemplo, en la escena que tuvieron la pareja, yo en vez de tratar de hacer interpretaciones, buscaría el modo de lograr cambios de la comunicación. Creo que existe una interacción errónea y en vez de buscar ningún tipo de interpretación, ni acusación, buscaría el modo de hacerles sentir corporalmente y sentimentalmente cuál es el efecto de esa comunicación errónea en sí mismo y en el otro haciendo vivir al estilo de Virginia Satir cada uno de los roles y a su vez haciéndoles pasar por los diferentes modos de comunicación hasta lograr la comunicación abierta y franca para lograr un cambio en esa comunicación. Y además en todo lo que Uds. han hablado en relación a estructuras y sistemas me parece excelente, pero también introduciría una simplificación en cuanto a la complejidad con que interactúan en los distintos tratamientos de psicoterapia para ir directamente al cambio, logrando cambios en la comunicación de la interrelación dentro del grupo familiar que es un sistema para poder actuar más rápida y ágilmente. Nada más.

Este sería un momento especial para poder intercambiar pero estamos pasado en tiempo. Damos por finalizado el panel. Les agradecemos mucho a los panelistas la intervención que han tenido.

***CURSOS DE FORMACION
DE POST GRADO**



COORDINADORA GENERAL: Lic. María Luisa Lerer



CENTRO DE
ESTUDIOS,
EDUCACION
Y ASISTENCIA
EN SEXUALIDAD

CORRIENTES 2817 - 4º "A" - (1193) BUENOS AIRES
Tel. 87-8089

TECNICAS DE TERAPIA FAMILIAR

Dr. ISIDORO GURMAN; Dr. GASTON MAZIERES; Dr. FIDEL LEBENSOHN; Dr. ADOLFO LOKETEK; Psic. ALBERTO GONZALEZ; Lic. FRIDA RITTERMAN.

Coordinador: Dr. ALFREDO CANEVARO

Dr. Canevaro: Se va a trabajar sobre el tema de técnicas en terapia familiar. Los paneles tradicionales van a ser de alguna manera contados por nosotros hoy para tratar de evitar cierto autismo compartido que es el que se da en muchos paneles en el que cada expositor hace un racconto de su manera de ver o de entender los problemas de la terapia familiar o hace una exposición teórica o técnica, pero con muy poco intercambio con sus pares y con el público. Vamos a tratar hoy de hacer con un poco de esfuerzo y colaboración de ustedes, un trabajo distinto, en el que ustedes puedan participar emocionalmente e intelectualmente de un intercambio que va a ser en un comienzo hecho entre los panelistas y en un segundo momento con la participación de ustedes.

Vamos a recordar para dar comienzo, que la palabra "técnica", en su raíz etimológica griega: tékne, significa arte. Por lo tanto ello supone algo estrictamente alejado de lo que es la "teoría" que viene del griego theoreo, que significa: observar, contemplar, tomar una cierta distancia de algo. En la técnica el terapeuta está involucrado totalmente como persona y mediatiza una teoría y de alguna manera un concepto a través de sus propias vivencias y experiencias de lo que es o puede ser el cambio en una familia.

Hoy nos acompañan terapeutas de distintas modalidades técnicas y de orientaciones teóricas distintas.

Vamos entonces a comenzar con este intercambio pero recuerden que va a estar centrado básicamente en la experiencia que cada uno ha tenido a lo largo de los años de trabajo con familias. Después vamos a participar más directamente con ustedes.

Hemos charlado hace un rato para ponernos de acuerdo en cómo podíamos centrar este pequeño diálogo, y yo invitaría a alguno de ustedes a que haga un pequeño racconto de cómo se fue iniciando como terapeuta familiar, qué cosas fue pensando, privilegiando o vi-

viendo más intensamente; de manera tal que podamos participar con el público de algo que no es tradicional y que no se puede leer y que más bien es parte de un coloquio, de un diálogo. Bien, ¿quién quiere comenzar?

Dr. Gastón Mazieres: ¿En principio por qué?, por la necesidad de ver al paciente no de un modo o como un personaje aislado, sino básicamente mi necesidad era de verlo en un contexto. Así empecé a acercarme a las técnicas grupales primero, luego a las técnicas de pareja y por último a las familias. Pero así como mi necesidad era la de ver al paciente no aislado y ampliar mi óptica, a través de verlo relacionado, también técnicamente tuve la necesidad de ampliar, de conocer otros mensajes que el paciente me podía transmitir. Es decir, desde lo verbal amplí mis conocimientos hacia las técnicas psicodramáticas, para en esa forma poder explorar mejor la temática que el paciente verbalmente me traía. Y al mismo tiempo lo psicodramático me permitía resolver también las situaciones que se daban y que yo sentía que desde lo verbal estaban en ese momento empobrecidas en mí. Es decir que hubo un doble fenómeno, por un lado ampliar los contextos, por otro la necesidad de explorar mejor el campo limitado de lo verbal y lo otro era la posibilidad también de instrumentar técnicas terapéuticas que ampliaran lo operativo.

Eso me llevó posteriormente al tratamiento de parejas y últimamente al trabajo con familias.

Lic. Frida Riterman: Yo lo escuchaba atentamente a Gastón y me pareció que quizá yo podía aportar, sin que eso se contrapusiera a lo que él acaba de plantear, otra perspectiva. En mi situación yo comencé como terapeuta siendo psicoanalista de niños y lo que aconteció fue que la situación clínica, no mi necesidad como terapeuta, sino la necesidad clínica me fue obligando a ir configurando el campo del quehacer de otra manera. Es decir en alguna medida mi interés por lo que pasaba con el paciente, el niño en este caso, no se veía modificado puesto que desde mi teoría y mi quehacer técnico, como psicoanalista de niños, yo encontraba una forma apropiada de proceder. Pero la situación clínica en sí, me refiero al decir situación clínica, a que si bien yo suponía que podía atender a un niño, en realidad se iba presentando de alguna manera el resto del grupo familiar.

Así fui pasando de trabajar con niños incluyendo a la familia, a luego modificar el campo clínico y trabajar directamente con la familia. Pero yo diría que más que mi propia inquietud fue la situación clínica que me fue transformando e induciéndome a hacer una modificación.

Yo diría que quizá ese sea un rasgo que me caracteriza, que mis cambios se han ido produciendo en función de las modificaciones de la situación clínica, lo cual me lleva a una reflexión sobre esas modificaciones y por lo tanto a un cambio en mi operar técnico.

Dr. Alfredo Canevaro: Quiere decir que primero se fue ampliando en tu esquema conceptual, un pasaje al igual que Gastón, del individuo a la díada, a la tríada y al entero grupo familiar. Entonces se va configurando como una escena en la que intervienen personajes significativos y dentro de esa escena hay personas que privilegian algo y otras, otra cosa. Vos, Adolfo, ¿qué privilegiás, por ejemplo?

Dr. Adolfo Loketek: Interesante la pregunta. Yo me quedé enganchado un poco con lo que planteaban ustedes y pensaba cómo yo hago lo que hago en este momento. Sé que ahora por ejemplo, no se me ocurriría tratar de entender la problemática de un individuo sin observar el contexto. Lo cual queda muy claro que no agota todas las posibilidades de entender la problemática de un individuo, y que en última instancia es una elección que uno hace a partir de ciertas experiencias, a partir de ciertas identificaciones, quizá sea a partir de eso, no sé. Pero pensaba que yo también me inicié trabajando analíticamente con individuos pero paralelamente en un servicio general, del Policlínico Aráoz Alfaro, el servicio del Dr. Goldenberg. También trabajé en un centro de salud mental, en la época 73/76 y todo eso tenga que ver quizá con esta elección. Y también, sin lugar a dudas, han influido personas como Enrique Pichon-Rivière, Liendo, Sluzki y todo el ámbito de Lanús. Si uno pudiera recordar ciertamente, si hay un punto en el que a partir de él hace lo que hace...; es muy difícil proponer un causal inicial que determine este tipo de situación actual. Nada más. No sé si quedó contestado lo que me preguntaron.

Dr. Alfredo Canevaro: Ahora, hay un punto que es difícil de leer en los libros, y que más bien se charla entre amigos, entre colegas o en los pasillos de las instituciones a las que uno pertenece, y es precisamente esos casos complicados, difíciles, en los que uno se embebe, y se empeña completamente, y que quizá hablando con su compañero, con su amigo, con aquel que le da su apoyo psicológico y emocional en ese momento, recién consigue pensar más claramente. Yo creo que ese punto, Fidel, sabiendo que has trabajado en hospital con pacientes graves, con pacientes psicóticos y sus familiares, no sé si vos te lo has planteado desde ese ángulo en algún momento.

Dr. Fidel Lebensohn: Sí, la verdad es que no es la primera vez que me hago esta pregunta en este momento, en el sentido de que últimamente relexioné debido al proceso de un paciente psicótico crónico que vino derivado para hacer terapia familiar. En estos días está justamente en proceso terapéutico la familia. En un momento determinado de la sesión, tuve una vivencia muy importante; recreamos, no es mi costumbre hacerlo, pero debido a la tremenda dificultad de esta paciente, recreamos en un momento determinado una suerte de vivencia psicodramática en donde apareció una historia de hace unos 15 años en el hospital psiquiátrico, donde lidiábamos con una sala de crónicos, más una sala de agudos pretendiendo hacer un abordaje de

comunidad terapéutica. Y vino a mi memoria justamente todo lo que dramatizamos con esta paciente, todo lo que apareció, el por qué en este momento yo hacía terapia familiar. En aquel intento en una institución pública, hacer comunidad terapéutica. Veíamos familias como uno de los abordajes. Y recordaba que, siempre nos quedaba la sensación de que lo que nosotros pretendíamos recrear en la comunidad terapéutica, era una suerte de idealización. Y que realmente, por una circunstancia equis en que yo me tuve que ir del hospital, ahí empecé a encarar el problema, definitivamente, con la familia, con el contexto de la familia nuclear y extendida, sin la internación. Empecé a entender una realidad desde el punto de vista sistémico, que no lo había podido detectar de ninguna forma a pesar de que pretendíamos en aquel hospital, en aquella institución pública, utilizar el sistema sistémico. Pero me di cuenta posteriormente de que el abordaje de la familia es el abordaje del contexto en totalidad, no el paciente y la familia. A partir de allí empecé a ver las cosas diferentes y pasaron 15 años y me encontré con un crónico y no lo pensé como un crónico y al no pensarlo como un crónico, como dice Selvini, pude hacer algo con él.

Dr. Isidoro Gurman: Yo estaba pensando que lo que estábamos haciendo, era definir los bordes o los perfiles por los cuales pasa la definición de un paciente, es decir, cuál es la historia de quien para nosotros como terapeutas, fue definiéndose como paciente. Mi fuerza como terapeuta viene desde el psicoanálisis de niños y los bordes de mi práctica estaban definidos por la más cruel ortodoxia kleiniana, en la cual me crié desde el año '63 hasta aproximadamente el '69. Digo esto porque era interesante, cómo uno se creaba una especie de objetología interna, que tenía la característica verdaderamente de una especie de grupo, uno trabajaba permanentemente con un grupo de objetos internos. Lo interesante era que paulatinamente, en algún momento lo había comentado con Frida, yo operaba al mejor estilo cirujano, técnicamente. Es decir, cortaba por el borde del niño, apartaba el resto y mi operación técnica quedaba allí. Por supuesto que al chico lo sacaban, lo ponían y evidentemente aquello que, uno lidiaba con un paciente adulto en el diván, en el chico era distinto porque las voces de los padres invadían el consultorio.

Una vez, hablando con A. Aberastury, le dije: ¿Qué hago?, y me dijo: El destino del psicoanalista del niño es ése. Es decir que a los chicos lo saquen en el mejor momento. Fue realmente la rebelión contra la cronicidad, tomando lo que decía Lebensohn, que decía que la eterna cronicidad de los bordes que delimita la tarea, lo que de alguna manera amplió el borde y el borde se amplió por irrupción y entró en crisis toda la práctica. En la medida en que tuve que empezar a escuchar voces que no estaba acostumbrado a escuchar.

Le comentaba a González y mientras hablaba con él, se me hizo presente una metáfora que Freud usa en *Construcciones en Psicoanálisis*, donde dice que es difícil para un analista intuir un esquema

gráfico espacial con el cual trate de mostrar qué es la historia para él, y que la única metáfora es a veces la metáfora de la contigüidad espacial. Y de pronto me di cuenta de que escuchando a personas sentadas, escuchaba ecos, voces e historias de tal manera que se me borraban esas personas y aparecían configuraciones fantásticas.

Fue a partir de aquí que la configuración fantástica se me recortó por los bordes de un grupo que de pronto se reunía y so pretexto de un chico empezaba a hablar.

Lic. Frida Riterman: Quería decir algo, Isidoro, con respecto a lo que estás mencionando. Yo pienso que en realidad, la terapia familiar que durante tanto tiempo se la definió como técnica simplemente, en realidad ha sido una revolución en la clínica porque nos ha obligado a replantearnos el concepto de clínica. Es decir, nosotros estábamos trabajando con un enfoque excesivamente especializado. La terapia familiar nos ha llevado a retomar el concepto de clínica, que originariamente la psicología tomó de la medicina. El concepto de clínico general, el médico de consulta, el médico de cabecera. Justamente esa situación en alguna medida también, nos llevó a los terapeutas a modificar el criterio de continencia del terapeuta. Yo creo que ésta, es una de las situaciones que a mí me costó más modificar en el pasaje que Isidoro viene señalando desde lo que ha sido un psicoanalista de niños, a un terapeuta de grupo familiar. La continencia del terapeuta es absolutamente distinta. En mi situación personal, lo que me ayudó mucho a hacer este pasaje, fue justamente la práctica hospitalaria que Adolfo señalaba hace un rato. Es decir, un terapeuta que ha ejercido la práctica hospitalaria se ha visto forzado por muchas situaciones a tener que ubicarse como terapeuta continente de una situación clínica propuesta de una manera completamente distinta, en la medida que una variable participante permanentemente es la precariedad. Eso quería decir.

Dr. Gastón Mazieres: Yo pensaba también que para la familia el modelo médico está presente y que ese modelo médico aparece, en la expectativa que tienen con respecto al terapeuta con el cual van a relacionarse. Es decir, el rol que la familia le designa al terapeuta está muy en relación con ese modelo. Quiere decir que la familia viene trayendo su propia escena, con el paciente designado, la protesta, las quejas, el rol del papá, la mamá, etc., las funciones definidas y con la expectativa desde el momento que decide ir a la terapia, con la expectativa de cuál va a ser el rol que va a asumir el terapeuta. Y pienso que esa es una expectativa tramposa para el terapeuta, que el terapeuta jamás debe asumir el rol que la familia le designa y que desde ahí comienza la primera modificación contextual que hace el terapeuta: el no asumir el contexto que la familia le quiere imponer.

Psic. Alberto González: Yo me voy a enganchar un poco en algo, que planteaba Frida y en parte los demás panelistas, en relación al

marco de la experiencia individual. Quizá por modalidades vinculadas a la práctica, mis problemas comenzaron más por la parte de pacientes en procesos psicoanalíticos o de psicoterapia psicoanalíticamente orientada dentro de los moldes tradicionales.

Coincidiendo con lo que planteaban algunos de ustedes, un poco la realidad clínica me impuso ciertos desafíos, que en un primer momento traté de reformular en términos de las categorías que yo tenía en ese momento, como ser resistencias o fallas técnicas inadvertidas a lo largo de un proceso. El hecho es que la realidad de los problemas familiares y de pareja fueron un poco al estilo de los personajes de Pirandello en busca de un autor!, cobrando presencia. Quizá a diferencia de otras experiencias no hubiera podido dejarlos entrar si no hubiera tenido un poco de ayuda. Y la ayuda por una cuestión de estilo personal vino por el lado de ciertos esquemas, quizá la influencia de Pichon-Rivière, y básicamente los trabajos de Liendo me sirvieron un poco como acompañante para meterme más en ese campo, digamos, y dejar que ese campo entrara sin que mi aparato cognitivo se desorganizara demasiado.

Es como pensar siempre un poco con el concepto del mapa y del territorio; o sea que meterme, por lo menos en mi experiencia personal, un poco ingenuamente en ese territorio familiar y conyugal, quizá hubiera sido exponerme a una especie de enfermedad profesional, por llamarlo de alguna manera. Y un poco los mapas me sirvieron para orientarme en aquel momento, y para ir perdiendo el temor a ese campo.

Estaba pensando que, una metáfora a veces bastante precisa para el papel de terapeuta de pareja, también a veces de familia, es el modelo del triángulo donde el terapeuta puede entrar fácilmente a recomponer un triángulo o a hacer el vértice excluido del triángulo, con todo lo que ello significa. Y probablemente no conocer las leyes que rigen esta dinámica y no tener este mapa de orientación sea perderse en ese territorio, justamente.

Dr. Adolfo Loketek: Yo estaba pensando qué lío éste de venir de lo individual; pensaba si los que vienen después no tendrán esta ventaja, lastre o vaya a saber qué. Supongo que enriquecimiento, verdad. Supongamos que yo recibo una familia ahora. ¿Y qué hago? ¿Qué es lo peculiar con lo cual yo me acerco a esta demanda de alguien, por lo general uno, que me consulta seguramente a partir de algún tipo de sufrimiento, para cambiar algo?

Creo que no se nos escapa que nuestro objetivo como terapeutas es siempre cambiar algo.

Primera cosa: creo en la interacción, creo y tengo que pensar que yo voy a priorizar a partir de ahora, que esto que alguien me cuenta que pasa tiene que ver con algún otro. Y este pensar que tiene que ver con algún otro, actual, histórico, etc., etc., hace que yo cite a éste y a algún otro, y es su contexto significativo. Pero no solamente lo pienso,

sino que también para lograr un cambio valedero tengo que intervenir sobre una relación.

Son creencias, lo digo desde esta perspectiva, y me aferro a ésta sabiendo que existen otro tipo de aproximaciones. Pero creo que esto, me valida en el hecho de acercarme a la familia y citar a la familia y empezar a observar qué pasa, cuando cito a una serie de personas unidas por una serie de lazos.

Me interesaría mucho, y creo que es un desafío, qué es lo peculiar que aporta la terapia familiar. Y creo que se planteó, no solamente como una técnica sino un cambio que pensamos que tiene que ser substancial.

Psic. Alberto González: Juntando lo que anteriormente se estaba formulando, un poco respetando la consigna que había propuesto Alfredo del pasaje por lo personal sin entrar en el racconto historiográfico de uno mismo. Estaba pensando justamente lo que significó para mí, en términos de cambio personal, descubrir en la práctica y en la teoría de la noción de interacción, por ejemplo, y empezar a ver las cosas en términos de que cualquier mensaje tenía que referirlo a un contexto relacional que incluía a dos o más personas.

Casualmente ayer cuando escuchaba lo que se historió, parte de la evolución de la terapia familiar en nuestro medio, pensaba en el salto que para mí significó conceptualmente, y creo que para otros también pasar del concepto de identificación proyectiva, por ejemplo, que de algún modo es un concepto de relación; o del concepto de inoculación al concepto de relación y de regla de la relación; donde uno deja de ver ya, o preocuparse tanto por lo individual.

Desde el punto de vista de la comprensión, de que no hay alguien que hace algo a alguien, sino que hay una regla que determina ese juego de papeles. Quería agregar eso.

Dr. Gastón Mazieres: Quiero decir que el campo relacional estaría entonces en el problema que trae el paciente, es decir el problema que trae el paciente visto en relación con los demás. Muy groseramente dicho, las posibilidades de cambio también vistas en las posibilidades de crear situaciones nuevas, donde se produzcan modificaciones de esas situaciones, rectificaciones de esas relaciones. Y algo más. Se me ocurre que lo relacional también, está puesto en el contexto terapéutico, en la relación que se establece entre el terapeuta y la familia, que para algunas escuelas, eso es importante. Es decir la familia deja de ser un campo para ser leído y se transforma la relación terapeuta y familia como un campo que es el determinante de los cambios, el determinante de los pronósticos, diríamos también, y es el que permite también ver las posibilidades de rigidez o flexibilidad. Ya no es la lectura de una interacción puesta ya sino que es una interacción en la cual está incluido el terapeuta. Nada más.

Dr. Fidel Lebensohn: Yo quería engancharme un poco con la idea

que acaba de decir Gastón, el concepto de relación. Estoy totalmente de acuerdo con Adolfo en el sentido de que por suerte los que vienen no van a tener ese prejuicio de poder ver las cosas como nos las enseñaron o como las quisimos aprender.

Lo que quería introducir, porque es una inquietud mía, es que en función de, indudablemente no hay otra posibilidad que incluirse en la relación familiar y crear esa inédita situación que es el terapeuta con la familia para crear un sistema completamente amplio y diferente; lo que quería introducir es el concepto de normalidad. En ese sentido no podemos tener; y ése es uno de los grandes cambios o rupturas epistemológicas que nos trae el pensamiento sistémico, no podemos tener estructuras que nos sustenten en este momento, un criterio absoluto de normalidad; no sabemos hacia dónde vamos, en el sentido de que la familia, si queremos verla sistémicamente, no es la familia que viene a la consulta y el terapeuta que sabe. Es decir una de las rupturas básicas que yo creo que se han operado, es desplazar toda una concepción cartesiana y de razonamiento aristotélico por una idea de flujo permanente; es decir que si nosotros en este momento queremos ver el proceso sistémico, tenemos que verlo a través de una relación de flujo permanente.

No podemos decir que hay un criterio de normalidad, que hay un punto hacia el cual vamos, yo creo que vamos a una idea indeterminada, porque en este momento una de las rupturas que ha permitido el esquema sistémico, es introducir ideas básicas de la física no relativista sino mucho más, la cuántica y la indeterminación, que en este momento nos lleva a una concepción y a un pensamiento totalmente diferentes, no individualista siquiera, sino a un concepto diferente de la ciencia de la conducta humana.

En ese sentido creo que es muy importante la idea de que el terapeuta se incluye, pierde la omnipotencia y empieza a colaborar en una situación de cambio.

Yo quería entonces que podamos hablar de esto. ¿Qué entendemos por cambio, qué es lo que pretendemos terapéuticamente?, es decir con una familia, ¿hacia dónde vamos? Eso por un lado lo dejo como inquietud y por otro lado el concepto de territorio y mapa que planteaba Alberto, creo que eso es también una clave en nuestro quehacer. Es decir si realmente queremos hacer terapia familiar tenemos que darnos cuenta de que podemos percibir parte de la totalidad y nunca la totalidad.

La totalidad se nos escapa, lo que podemos tener son referentes de un mapa cada vez más ampliado, más extenso y también esa es otra inquietud, y ahí vendría el quehacer terapéutico.

Cómo actuamos el mapa, cómo producimos el cambio, cómo marcamos las posibilidades de nuevas concepciones dentro de ese mapa para tratar el territorio, para captar el territorio, siempre pensando que se nos escapa de las manos la totalidad.

Dr. Isidoro Gurman: Yo pensaba que, siguiendo una propuesta de

Canevaro de: cómo pasan las cosas por uno como persona, ¿cómo están pasando las cosas por mí como persona en esta reunión familiar de terapeutas de familia? Pensaba mientras todos hablaban que si me hubiera quedado en mi institución madre, cuántos problemas me hubiera evitado.

En mi institución madre yo me llevo bien con mis hermanitos y allí hay como una especie de cálido clima de confort. Pero salí de mi institución madre y me conecté con personas, algunas de las cuales conozco, y otras que no conozco y me provocan tensiones, que las hubiera evitado si este encuentro de la familia no se hubiera dado. La propuesta de Canevaro, que me conoce, me estaba como diciendo ¡oj! no hables de lo que siempre hablas, enganchate con nosotros, y por supuesto si no me hubiera querido enganchar con ellos, no estaría acá.

Pero ese es mi problema, problema por el cual pasa todo sujeto, cuando sale de su institución madre, al afuera y se engancha con personas que no conoce. Todo casamiento es tenso, y entonces yo decía, ¿y yo? ¿qué hago en este casamiento? ; digo lo que dice Canevaro, digo lo que digo yo y mi institución madre, porque yo con Canevaro no me quiero pelear y con mi institución madre tampoco. Grave problema de un tipo que está en la familia, por un lado hay que respetar a la mamá y por otro lado... bien, Canevaro porque me interesa, porque me gusta escucharlo tiene lindas propuestas, y además porque me enriquezco. Pero esto da tensión, esto no es un problema de biología, esto es un problema de estar inmerso en la cultura.

La cultura tiene esta propuesta, uno sale de la mamá, conoce a gente que viene de otro lado, piensa de otra manera y con la cual tiene que entenderse. Entonces yo podría ahora pelearme, por ejemplo pelearme, y decir yo no pienso de ninguna manera como Frida y además como Canevaro tampoco y además me peleo y no vengo nunca más y chau. Y me voy con mi mamá. Entonces me divorcio y Canevaro me dice: no, Isidoro, no te enojas, vamos a ver cómo podemos hacer, vamos a ver cómo nos podemos entender. Y vamos a lo de Loketek, y él nos va a escuchar y yo le voy a decir: Loketek, mirá, mi mamá me dice que yo tengo que hablar de psicoanálisis; y Canevaro me va a decir por ejemplo: vos sos un irreductible dogmático crónico; y entonces Loketek me va a decir: hagamos un psicodrama, cosa que estamos haciendo, y lo propongo, porque pongo en escena la diferencia, entonces en este jueguito, le paso el micrófono a Loketek, por ejemplo, y le digo: ¿qué proponés?, porque yo y Canevaro estamos peleados porque mi mamá dice que yo tengo que decir tal cosa y Canevaro me dice que yo tengo que decir tal otra.

Dr. Adolfo Loketek: Este final no lo conocía.

Dr. Isidoro Gurman: Loketek quería una familia y yo se la traje.

Dr. Adolfo Loketek: Les voy a plantear más o menos en voz alta, lo que voy pensando cuando se me plantea una situación así. Yo

podría optar por decirle a Alfredo que se siente al lado de Isidoro, pensar, que el que me gusta más sea la mujer (ni se te ocurra porque me irrita, Isidoro), y hacer una cosa así como si esto fuera una entrevista de pareja, y yo fuera el terapeuta.

Pienso al mismo tiempo que eso es un desafío que no lo tenía preparado, con lo cual no sé si va a salir bien, y entonces al mismo tiempo pienso ¿cómo hacer? con esta situación de Isidoro, metido en tener que ser lo que la madre quiere que sea, o lo que él piensa que la madre quiere que sea, y metido a tener que ser lo que Alfredo o alguien acá quiere que sea.

¿Cómo sale de esta situación de entrampe, Isidoro? Sin lugar a dudas llamándome a mí. No para que yo le solucione nada; supongo simplemente como un modo de que esta situación de interacción, de escalada o de situación interna de Isidoro, se pueda resolver.

Pero quiero llevar esto a otro nivel. Qué es lo que pienso yo cuando viene alguien y me quiere consultar. Primera cosa. Este sub-sistema Isidoro-Alfredo está enfrentando un tipo de conducta equis que el mismo subsistema no puede contener, por eso se necesita un tercero. Tan simple como eso.

A conductas A me responden las conductas B habituales o en otro supuesto, se están entrevistando en una situación nueva posiblemente.

Es necesario formar lo que llamamos un supra-sistema, conformarlo y ¿para qué?, quizá para crear situaciones nuevas, o quizá para volver a las anteriores. Este es el desafío con el cual yo me encuentro cuando leo desde mi esquema, que no le quiero poner aditamento ninguno, por favor, yo creo que si terapia familiar también aporta algo, es tratar de cuestionar el encasillamiento individual. Creo que el encasillamiento de los científicos, de los terapeutas, es algo que no podemos evitar y estaremos siempre en lo mismo, ese es el desafío.

De cualquier manera es un suprasistema el que se va a conformar; yo pensaré cuál es la regla, cuál es la creencia que está siendo amenazada en este momento, ver cómo la están resolviendo ellos, y ver cómo puedo llevarlos yo a un tipo de regla alternativa, pero distinta de ese sistema. Ni que sea el sometimiento de Isidoro a esa madre, ni que sea el sometimiento de Isidoro a este contexto.

Esa es la propuesta. Es como yo he salido de esta situación.

Dr. Alfredo Canevaro (al público): Nos vamos a apartar unos breves minutos, ustedes y yo, para que participen más activamente acerca de lo que pensaron y sintieron en este intercambio entre un grupo de colegas, o grupo de pares como les decía antes, de distintas ideologías terapéuticas, con distintos abordajes técnicos, pero que estuvimos unidos en un momento determinado por lo que ahí pasó. Me gustaría que alguno de ustedes comente algo para después incluirnos con el resto del grupo, y terminar el panel.

Integrante del público: A mí me llamó poderosamente la atención que por un algo que no llamaría azar, te sacaran a vos que sos un

elemento muy importante, de tu parte así, pasiva, y te pusieran de golpe como un elemento activo.

Otra integrante: En realidad yo estaba absolutamente atenta en lo que estaba pasando y de repente vi al Dr. Gurman, aparentemente tenso, y su intervención me llevó a pensar que podría ser, que se produjera un fenómeno muy habitual como en una familia que ante un conflicto que no puede desarrollarse y solucionarse entre los dos miembros conflictuados, se buscara un chivo expiatorio, en el cual se proyecta la equivocada percepción o la fantasía inconsciente de uno o más de los miembros.

Lic. María R. Glasserman: La tentación que vamos a tener ya que somos eximios terapeutas familiares, es tender a interpretar todo lo que ha ocurrido acá.

Yo querría saber por ejemplo cómo trabajan, porque este es un panel sobre técnica, y me gustaría que respondan lo que pedimos, o lo que ofrecen ustedes, saber cómo trabajan estas seis personas que tenemos enfrente. Porque yo no lo sé.

Dr. Alfredo Canevaro: Quisimos hacer algo un poco distinto de lo tradicional, porque realmente se reclama que los paneles son aburridos, pero vamos a tratar de seguir una presentación más tradicional.

Dr. Fidel Lebensohn: Cuando Alfredo se levantó para hablar con el público, que es algo que de alguna forma pensamos que debíamos buscar, es decir comunicarnos con el público, en ese momento yo pensaba que lo que ocurrió acá, nos podría dar una cierta posibilidad de mostrar lo que pide María Rosa, en el sentido de que veamos a través de esa situación, cómo lo planteó Adolfo, que está mostrando como percibió, cómo sería en la consulta, cómo él actuaría, qué es lo que haría, etc. Quiere decir que definió un campo terapéutico.

Gastón creo que de alguna forma también lo ha hecho, y creo que puede servir, para decir muy brevemente, que yo pienso que en el problema de esta familia, el terapeuta es un accidente. En ese momento y ante la consulta indudablemente ellos quieren una solución, y yo me pregunto: ¿quieren realmente una solución o están pidiendo que no se los ayude a solucionar, sino que todo siga igual? Entonces una de las intervenciones que yo haría, sería con miras a romper quizá una estructura rígida que aparecería como una demanda simétrica de Isidoro hacia Alfredo, y de Alfredo hacia Isidoro, y a su vez pensando que quizá ellos tengan la solución. Que ellos como familia han intentado organizarse, auto-organizándose, pero no han podido dar un nuevo tipo de organización. Y al no poder dar un nuevo tipo de organización, piden ayuda; y el asunto es ¿cómo los acompañamos? ¿Cómo los acompaño yo técnicamente para que ellos, que saben seguro más que yo, pero que no quieren, puedan realmente fluir en esta organización potencial, inédita, que ellos saben y no pueden? Yo quizá, con una

pareja así, le plantearía que realmente lo está ayudando muchísimo Isidoro, que no lo agrede para nada, es decir, reestructuraría la actitud de Isidoro. Sería un elemento de reestructuración paradójica. De tal forma que ellos se den alguna oportunidad, que estoy seguro que la tienen, ante una situación en la cual yo como terapeuta les pueda decir, que realmente no pienso que Isidoro esté enojado y que tenga problemas con Alfredo, sino que al contrario, con todo este asunto de la mamá lo ayuda muchísimo a hacer a Alfredo activo, a estar permanentemente en una salida de lo que él quiere y no puede y que Isidoro está haciendo un sacrificio muy grande, para poder ayudarlo. Que en realidad yo no veo que acá haya agresión, no hay problema sino que realmente él está colaborando y ayudándolo.

Es sólo una técnica, lo que quiero decir es que cualquier técnica que podamos instrumentar, es, un imput al sistema, para que el sistema pueda empezar a fluir en un devenir, en un desarrollo, que hasta ese momento no se ha dado. Es decir, yo pienso que esta pareja está engranada redundantemente en reglas que ya no sirven. En un sistema de rotación sin traslación y que yo lo que pretendería es movilizarlos y salir de la rotación a la traslación. Es decir que realmente la cosa pueda cambiar, en ese sentido, pero pensando que realmente ellos, indudablemente desde hace mucho tiempo, están auto-organizándose para un cambio. Y que la posibilidad es que yo les ayude en ese fluir y esa posibilidad.

Lic. Frida Riterman: Yo pensaba que eso que vos decías que desde hace un tiempo están en rotación, reiterándose, también tiene que ver con algo que una persona del público señaló y es el mandato. Mi participación estaría dirigida no solamente a dejar fluir ese territorio de lo simétrico, según lo que dijo una participante, que yo llamaría: el territorio de lo transversal, sino que estaría muy atenta a lo que está pasando longitudinalmente. Hay momentos en que la sola interpretación de lo que está pasando en la interacción, permite que ella misma siga movilizándose en toda la red del sistema pero, de acuerdo a mi forma de trabajo, hay momentos que solamente una interpretación de lo longitudinal da la posibilidad de hacer esa modificación y salir de lo que se llamaba recién la rotación. En ese sentido, hemos hablado en otra oportunidad con Isidoro también, yo tengo la lectura muy atenta de lo que pasa a nivel del determinismo histórico del grupo y particularmente de los que interactúan porque en determinados momentos, es solamente interpretando el mandato que yo he podido llegar a producir una modificación en la interacción. Esa sería mi participación.

Dr. Gastón Mazieres: En última instancia la congelación de esta situación lleva a que tanto Isidoro como Alfredo, no puedan hacer un proceso de individuación, de desarrollo de crecimiento; es decir no pueden cumplir con el objetivo terapéutico.

Dr. Isidoro Gurman: Pensaba que a raíz de la interacción con el

público de pronto me sentí fenómeno con Alfredo y fenómeno acá, pero sintiendo por ejemplo que estaría mejor si esas preguntas no se hubieran hecho. Es decir que de pronto en este sistema, llamémoslo así, ingresaron otras voces y era como que interferían con el sistema. Ergo, qué papel cumplen estas otras voces dentro de este lugar, donde nosotros ahora tendríamos que cumplir con otro mandato por ejemplo, se contradiría el pedido de Alfredo.

Porque Alfredo dijo, por ejemplo: pongámonos a hablar del terapeuta como persona y no vengamos solamente con speech técnico, porque yo podría dar un speech técnico de cómo me defino desde mi técnica, pero resulta que si sigo hablando así corro el peligro de no satisfacer a quien me pidió que hable de otra manera. Y esto tiene historia, que de meterse aquí, podría provocar un efecto disruptivo. Digo esto porque ésta es mi manera de trabajar.

Dr. Adolfo Loketek: Yo no quiero hablar después de Isidoro. No es gracioso esto: ésta es mi manera de trabajar. Esto sería una especie de regla para nosotros. Esta es mi manera de trabajar, sería: yo no quiero hablar detrás de ti. Si hubieras traído la relación a la secuencia anterior, donde Isidoro me pasó el juego, me pasó el micrófono y yo, volviera a hablar, ahora, habiendo recortado aquello que para mí es substancial, diría: ahora trataría de no hablar si es que estuviera en un setting terapéutico y no acá ahora. Esta es mi manera de intervenir.

Dr. Gastón Mazieres: Yo explicando en cierta forma lo solicitado por María Rosa con respecto a la técnicas o a las técnicas o a la forma de trabajo, muy limitadamente diría que trato inicialmente de redefinir la propuesta que me trae la familia. La familia me trae la definición clara del problema que ellos tienen, que ellos traen. Establezco la primera redefinición en el contexto, es decir en la relación que establezco con ellos. No asumo el rol que ellos me designan.

Posteriormente trato de establecer una redefinición de la realidad de la familia, pero en relación con la óptica que pasa por mí. Creo tensión en las funciones del paciente designado en la relación del paciente con la familia; observo qué es lo que pasa en esta interrelación conmigo y en la relación con ellos. Observo los subsistemas, las relaciones, las jerarquías, etc. Y al fin de esto, entonces, planteo cuál es la realidad, el nuevo significado que tiene para mí esta propuesta que me hace la familia. Puede o no ser aceptado esto. Si no es aceptado esto, cuestiono entonces, antes de definir a esta familia como una familia rígida, cuestiono la observación mía, y trato de buscar otras redefiniciones. Si también son rechazadas, recién entonces podré aceptar que estoy en presencia de una familia rígida. Porque el sistema rígido primero me dice a mí, que entre ellos y yo, hay algo que no funciona, que se queda. Puede ser mi estilo, puede ser que me equivoqué pero lo voy a intentar previamente, antes de definir a la familia como una familia rígida. Y si la familia, acepta la propuesta de

esta nueva visión de la realidad de ellos, entonces sí trabajo con diferentes tipos de técnicas, dramáticas o lo que fuere, tratando de reestructurar, de crear nuevos contextos, de cuestionar funciones, de crear tensiones, de crear crisis, fundamentalmente porque pienso que a través del paciente identificado lo que la familia logró es evitar una crisis. Crear tensión en la familia y a partir de ahí lograr una reestructuración, situaciones relacionales diferentes, que permitan una mejor armonía o cambios en las reglas, etc.

Y al mismo tiempo comienzo a trabajar con cada uno de los miembros, en cuanto a las diferenciaciones, funciones, posibilidades individuales. Es un esquema muy general en el cual incorporo lo verbal y todas las técnicas, fundamentalmente las dramáticas. Es un deseo mío llegar a incorporar las técnicas dramáticas en el trabajo con la familia, porque hasta ahora, si bien trabajo dramáticamente con todas las parejas, pienso que en general, soy bastante corto en cuanto a ampliar las técnicas dramáticas en el trabajo con las familias. Hay muy pocos trabajos en general en la literatura mundial con respecto al trabajo psicodramático con familias. Fuera del cambio de roles, etc., fuera de eso hay muy poco material escrito con respecto a esto. Tal vez en el Congreso del año que viene haya algo más.

Psic. Alberto González: Yo quería agregar algo más en relación a la pregunta que le hice a Fidel: cuál era la pareja acá. Si era Alfredo-Isidoro o si era Isidoro-Adolfo. Un poco esta pregunta tendiendo a responder lo que preguntaba María Rosa de la forma de trabajo. Es una pregunta que nos descoloca, yo dejé todo el libreto en casa. Había traído otro libreto potencialmente, pero voy a tratar de acomodarme a una situación bastante desestructurante.

Lo que me llamó la atención es que, un miembro de la pareja —tomamos Alfredo-Isidoro como el nivel de análisis—, no hablaba. Es decir que yo nunca hablaría con dos personas en las cuales una de ellas no me ha formulado cuál es su problema. Lo primero que haría es construir una primera hipótesis de que quizá el problema de esa díada es que hay uno de los dos que define el problema, en este caso sería Isidoro, tomándolo como un mero papel que jugó dentro de una dinámica que en un momento nos incluyó a todos.

En segundo término trataría de ver qué les pasa a ellos, de alguna manera preguntaría sobre no solamente la pregunta clásica, qué les trae aquí, o qué cosa les preocupa, sino la definición del problema desde la relación de dos personas con un tercero que es el terapeuta.

Partiendo desde una hipótesis que últimamente estuve trabajando, que la manera que define el problema la pareja es parte del problema de la pareja. O sea que habría propiedades de la estructura relacional que se manifiestan a través de cómo la pareja define el problema. Si uno de los dos dijera que el problema es que se siente encerrado en una especie de mandato materno y su relación simétrica con su cónyuge, trataría de poder incluir al cónyuge que está en una relación asimétrica, justamente con respecto a la definición del problema. Cada vez

más me parece importante dedicarle un tiempo y un tipo de trabajo a cómo se define el problema desde la pareja, porque en la manera en que se opere en esa primera parte del proceso terapéutico, se van produciendo a veces en forma inadvertida cambios respecto de lo que vienen a consultar.

Sería interesante poder extenderse sobre qué modelos, técnicas, pero habíamos hecho una especie de regla entre nosotros de no exceder ese terreno. Una de las ideas más interesantes que yo he ido trabajando es la de cambio 1 y cambio 2; justamente. Donde los problemas de definición tanto de las reglas de definición o de definición de la relación y por lo tanto definición de qué tipo de relación se espera con el terapeuta va a ser justamente producto de niveles de procesos terapéuticos o de la estructura de la pareja, que tienen que ver más con problemas de cambio 2 que de cambio 1.

Juntando con lo que planteaba Gastón, en la redefinición del problema uno está ya intentando una nueva lectura que justamente la pareja o la familia por la propiedad autopropagante de los circuitos no puede hacerlo. En todo caso si hay tiempo después lo ampliamos.

Dr. Adolfo Loketek: Yo voy a hacer algunos comentarios respondiendo a la invitación de María Rosa que ya incluso antes había insinuado Gastón. Yo formo parte de un equipo de trabajo y entonces el tipo de intervenciones creo que hay que situarlas dentro del contexto y el recurso que uno tiene.

Creo que eso debe ser muy claro para el terapeuta, una cosa es trabajar en un medio institucional con una cámara de Gesell, con un teléfono, etc., etc.; otra cosa es trabajar en privado. Eso hace a los recursos del terapeuta que además hace a toda su formación previa, etc., etc. Me voy a referir a una experiencia que es una de las que más estamos desarrollando, y a dos aspectos de esa experiencia nada más, para diferenciar dos tipos de intervención, una que llamamos más energética y otra que sería como de apoyo.

Me hizo pensar mucho lo que trajo Gastón sobre el hecho de: inicialmente hacer intervenciones que uno podría plantearse como disruptivas con el sistema, redefiniciones, etc., etc. Obviamente en esto hay muchas aproximaciones. Por lo menos mi aproximación es que vamos acercándonos a intervenciones de tipo más suaves; llamamos "más suaves" a aquellas que son más sintónicas con el sistema, llámese a eso un tipo de confrontación, que hable uno con el otro, tipo de intervenciones sobre la comunicación, pequeñas redefiniciones de mensaje, etc. Pero lo más importante que me interesa resaltar, es que para nosotros también es muy importante que el tipo de intervención más energética es aquella que implica un recorte de una regla actual (estoy contiguo de que esta era una secuencia tipo me pareció muy acertada tu observación, yo sólo hacía oídos al mensaje de Isidoro, cosa absolutamente errónea en trabajo en parejas). Pero en el caso de que hubiera tenido esta secuencia buscada por mí en la relación actual e histórica no de la pareja solamente sino de las relaciones con sus familias de

origen la intervención que nosotros consideramos más enérgica, donde más se apoya el terapeuta, es aquella que puede hacer un recorte actual, alguna correlación histórica, pero de una manera que no sea solamente descriptiva sino provocativa. Provocativa es aquella que connota positivamente lo que ellos dicen como malo. Tan simple, buscando algún tipo de reacción paradójal. Esto muy rápidamente. Estas intervenciones que consideramos para ciertas situaciones, llámese situaciones psicóticas, ciertas paradojas pragmáticas de la pareja, situaciones de mucho entrampe, vamos a hacer un contraencierro al encierro de la pareja.

Dr. Fidel Lebensohn: Yo quisiera agregar algo con respecto a algún detalle de técnica; me satisface bastante el hecho de la coincidencia con Adolfo en el sentido de que en especial en terapia de pareja hemos estado trabajando prácticamente durante los últimos 4 años, tres o cuatro años, casi con un imput tipo que no sé si es exactamente el que plantea Adolfo que sería tomando un poco el modelo de la reestructuración. Cambiar el signo con que el sistema, la pareja viene, es decir, buscar siempre la posibilidad de encontrar esa regla, encontrar esa situación actual y trabajar con ese imput tipo. Por otro lado en nuestro quehacer terapéutico, quisiera definir también, que lo que nosotros pretendemos como decía un rato antes, es ampliar el mapa del territorio. Al ampliar el mapa del territorio, lo que nosotros pretendemos es permanentemente aumentar las diferencias. En ese sentido, tomando la idea básicamente de Bateson, en el sentido de aumentar las diferencias que nos va a permitir aumentar la información. Eso es básicamente lo que nosotros pretendemos.

No hay un imput único, sino que lo que pretendemos es a partir de diferentes estrategias que van dirigidas fundamentalmente, en terapia familiar y en terapia de pareja a aumentar la información, a partir del aumento de las diferencias, y reducir el campo de entropía relativa en que está el sistema cuando viene a consultar. Esta es una redundancia que produce una entropía relativa, ya que el sistema familiar es privilegiado porque se autoabastece, es decir tiene la capacidad de autoorganización. Entonces lo que pretendemos es aumentar las diferencias, aumentar la información a través de fomentar la comunicación en el sistema. O que se produzca esa situación inédita que nosotros pretendemos, en función de las hipótesis que hemos redactado con respecto al sistema. Lo que pretendemos fundamentalmente es eso, que el sistema en un momento determinado, pueda desencadenar el cambio que él ha autorregulado y está potencialmente en condiciones de desarrollar.

Dr. Isidoro Gurman: Para brevemente explicitar mi forma de trabajo, conjuntamente con el equipo con el que hace ya 10 años que venimos trabajando, quería decir que dentro de un marco conceptual psicoanalítico, trabajo con aquellos elementos, que hacen una técnica que tiene tres pasos: 1) recoger información, toda la posible, teniendo

en cuenta que esta información va a permitir un segundo paso; 2) el procesamiento de esta información tendiendo básicamente a mostrar que lo que allí está transcurriendo, son ecos, voces de una u otra historia que por no ser hablada, porque es una historia que transcurrió en otra ámbito, en las escaleras, en los pasillos, que tiene vieja historia y determina algo que podrá resolverse a través de una construcción que ponga en relevancia aquellos elementos presentes en la actualidad, generados desde otro contexto, contexto histórico de sentido que condensa en un conflicto actual. Aquello que el conflicto restitutivamente pone de un modo analógico con algo que por ser escamoteado y silenciado, y no hablado, es lo que de alguna manera determina esto que desgaja una historia y lo transforma en naturaleza. Puesto que cuando yo me peleo, pienso que es por la naturaleza de ambos, es transformar esto que es por naturaleza en historia el quehacer esencial de lo que nos proponemos en nuestra práctica en este momento. Nada más.

Dr. Alfredo Canevaro: Bueno, llegamos al cierre de este panel algo especial como lo había sugerido al comienzo. Pero no planificado como tal, porque fue una cosa que espontáneamente se dio.

Creo que pudimos ver una gama de situaciones muy variadas, como encontramos permanentemente en la terapia familiar: asimetría de poder, desestructuraciones, desafíos, provocaciones, actuaciones, contraactuaciones, etc., etc. Creo que lo importante es modificar situaciones rígidamente estereotipadas. Como hoy por ejemplo habría sido la tradición de los paneles leídos con una presentación más bien unilateral de cada uno de los participantes y que lo que generalmente induce es una sensación de falta de participación y de aburrimiento en el público. Haber incluido esta escena, haberlos incluido a todos, haber podido cambiar de roles o haber desestructurado lo rígidamente estereotipado es evidentemente un gran desafío y toca las cosas más profundas de cada uno, la persona, los recursos emocionales de cada uno de nosotros. Creo que eso es en esencia el trabajo del terapeuta de familia. Se suele decir que aquel que trabaja con las manos es un operario, aquel que une el trabajo de sus manos al de su mente es un artesano, y el que a las manos y a la mente une su corazón es un artista. Entonces probablemente hoy cada uno ha podido mostrar algo de lo que debe poner permanentemente en el trabajo tan intenso y comprometido con una familia y que es toda su persona sin posibilidad de disociaciones. En un encuentro terapéutico, esta disociación es lo que una familia no nos permite hacer y eso es lo que les tenemos que agradecer a cada una de las familias con las que trabajamos. Muchas gracias a todos.

INSTITUCIONES, ENTRENAMIENTOS Y ASISTENCIA

Dr. OCTAVIO FERNANDEZ MOUJAN; Dr. JUAN JOSE MORGAN;
Dra. LUCIANA SARTORIS; Dr. LUIS A. ALBORNOZ; Dra. ANA
GILLER; Dr. FRANCISCO ABBATE; Dr. MARIO TISMINETZKY.

Coordinador: Dr. ALEJANDRO SICARDI

Va a tomar la palabra el Dr. Francisco Abbate, Jefe de la Unidad de Psicopatología conyugal y familiar de la Cátedra de Psicología Médica, U.B.A., en el Hospital de Clínicas; Presidente y Miembro Fundador de la Sociedad Argentina de Psicología Médica del Matrimonio y la Familia; Psicoterapeuta familiar desde el año 1961.

Dr. Francisco Abbate: En la cátedra de Psicología médica sita en el Hospital de Clínicas José de San Martín, desde ya hace unos cuantos años hay inquietud y se fueron desarrollando temas sobre la psicopatología conyugal y familiar. Primero eran clases de psicosemiología que se incluía en los cursos de psicosemiología, después se hicieron en el año 1971 seminarios, supervisiones de casos, pero mezclados con otros casos dentro del área médico-psicológica. En 1974 ya se dictó un curso de Psicopatología conyugal y familiar, dirigido por mí; en ese caso en el Hospital, pero no en la cátedra, en el servicio de Psiquiatría Infantil de la cátedra de Pediatría. Y a partir del año siguiente, 1975 y 1976, se dictaron cursos más amplios y más organizados, hasta el año pasado inclusive. En el año 1976, además, se creó una Unidad de Psicopatología conyugal y familiar, que actualmente dirijo. Es decir, que un poco antes del año '76 ya había actividades teóricas vinculadas a este campo de la psicopatología conyugal y familiar y también asistenciales.

Yo me voy a referir a estas últimas en primer lugar. Como en todos lados es común, el equipo que formamos o la unidad que formamos, está constituida según la época del año por 10 ó 15 profesionales, médicos, psicólogos, asistentes sociales, a veces. En la unidad tenemos la inquietud de que haya, pero no siempre contamos con ellas. Hay en forma permanente en el Hospital, pero no en la Unidad. A veces intervienen también psicopedagogos, ginecólogos, andrólogos, clínicos, sexólogos, etc.

Cuando se atiende un grupo familiar, solemos utilizar una planilla en la cual se anotan los datos personales de cada integrante del grupo

familiar, aún los que no están presentes y agregamos dos datos que tienen cierto valor: los antecedentes psiquiátricos, que en la práctica se reducen a preguntarles, si han recibido psicoterapia y también si hay algún otro antecedente patológico, realmente importante, por ejemplo, una patología orgánica de mucha importancia.

Tratamos de que al llenar esta planilla sea de datos personales y de estos antecedentes, pero, invitándolos a que no se explenen, que no expliquen. Nos da mucho resultado que luego de tomar esos datos comiencen a hablar; en un segundo momento se les invita a que digan el motivo de la consulta. A éste le damos mucha jerarquía dado que como es muy conocido siempre suele ser muy útil para orientar y a veces obtener una colaboración más amplia de los pacientes. Hay que tener siempre el motivo por el cual consultaron, que a veces es discrepante, por ejemplo si se trata de un matrimonio en desarmonía.

En la primera entrevista además de llenar la planilla y de preguntar el motivo de la consulta, se hace un diagnóstico provisorio: el diagnóstico, en el sentido de la patología del grupo conyugal o familiar y la de cada uno de sus miembros. Ahí es común que se utilice una clasificación muy simple que yo formulé y que da resultados clínicos aunque es susceptible de mejorarse. Las perturbaciones psicopatológicas conyugales y familiares suelo clasificarlas en: las perturbaciones generales del grupo familiar o conyugal y las perturbaciones familiares y conyugales asociadas a la enfermedad manifiesta de uno de sus miembros. En el primer grupo están por ejemplo la desarmonía conyugal, la desarmonía familiar, trastornos sexuales conyugales, problemas vinculados a la esterilidad y a la adopción, la simbiosis patológica madre-hijo, situaciones de crisis familiares o conyugales, etc.

En el segundo grupo las perturbaciones que son de diversa índole, vinculadas a enfermos manifiestos: esquizofrenia, trastornos de conducta de adolescentes, depresiones, discapacitados, enfermos graves y con mal pronóstico de vida, etc. Ese agrupamiento o clasificación, nos lleva a un primer criterio.

Las perturbaciones generales pueden tener como tratamiento central la psicoterapia conyugal o familiar.

En el segundo grupo las perturbaciones asociadas a una enfermedad manifiesta, la psicoterapia conyugal o familiar puede ser complementaria, aunque a veces es indispensable.

Volviendo al modo de trabajo, hacemos la primera entrevista y se formula un diagnóstico provisorio, prácticamente en todos los casos y se propone hacer 4 ó 5 entrevistas más, o mejor dicho: 3 ó 4, porque incluyendo la primera son 4 ó 5, con fines exploratorios o bien combinados exploratorios y terapéuticos, pero poniendo énfasis en el aspecto exploratorio. Una vez elaboradas esas entrevistas se hacen los tests en todos los casos de matrimonio-familia y se formula un plan terapéutico en el cual además de la psicoterapia conjunta no se descartan las psicoterapias por separado. Tenemos cuidado de dar prioridad a la opinión del terapeuta individual. En este sentido, si en un grupo un paciente tiene a la vez un terapeuta individual, si ese

terapeuta desaconseja la psicoterapia conjunta, de un grupo que está bajo nuestro examen, nosotros no la hacemos. No es necesario que él esté de acuerdo con esa psicoterapia conjunta pero exigimos al paciente que su psicoterapeuta individual no se oponga, para poder admitirlo. Luego hacemos las derivaciones correspondientes a los clínicos, especialistas o a aquellas personas que asisten a la familia en otras áreas: abogados, asistentes sociales, psicopedagogos, ministros religiosos, etc. También tenemos en cuenta la prevención en el aspecto de que puede hacerse simultáneamente con la terapia durante el examen y el tratamiento del grupo familiar. Por ejemplo, si vemos un matrimonio en desarmonía, obviamente tenemos que ver la situación psíquica de los hijos o de otras personas convivientes.

Pasando ahora a un esbozo general del entrenamiento, quiero decir algunos criterios generales que tenemos en cuenta para la formación de aquellos que se interesan por la terapia familiar y conyugal.

En cuanto a la teoría, en el caso mío particular tengo una posición actual definida que puede ser susceptible de cambiar eventualmente en otras etapas con las nuevas experiencias y los nuevos intercambios científicos. Básicamente me baso en la teoría psicoanalítica pero como la mayor parte de los terapeutas familiares ponen énfasis en el enfoque psicoanalítico del grupo conyugal y familiar, entiendo que no es suficiente para comprender toda la dinámica familiar y para que sea el único instrumento de trabajo, como se ve por ejemplo en los libros de Flügel, que se nota que sólo con un enfoque psicoanalítico es insuficiente.

Yo suelo complementar los enfoques teóricos psicoanalíticos con el interaccionismo, la teoría de los sistemas, la teoría de la comunicación y también con la teoría de los roles y aún con la teoría de los grupos. Generalmente el objetivo es integrar todos los distintos conceptos en el caso clínico concreto.

Yo personalmente creo que estamos abriendo otros enfoques, generalmente esto es subjetivo y podría ser que la subrazón sea mayor a lo que uno mismo cree. Pero de todos modos conscientemente entiendo que es útil y provechoso el intercambio con otros terapeutas que tienen otros enfoques distintos. No es del todo suficiente el estudio teórico sobre otras orientaciones, pienso que es útil el intercambio de experiencias sobre todo viendo los casos clínicos con personas que hacen otros enfoques y también tratando de evaluar los resultados. Además usamos a veces otras técnicas que no tiene que ver con el psicoanálisis, como técnica de consejo basados en motivos psicológicos, técnicas del tipo de impacto múltiple, la de McGregor, etcétera.

Otro criterio en la formación es la importancia de un enfoque interdisciplinario. Entendemos que es necesario que el terapeuta familiar esté formado en un grado suficiente en otras disciplinas, para poder hacer un enfoque multidisciplinario en los individuos, que son los pacientes y del grupo conyugal y familiar. No se trata, de que el médico o psicólogo sea también antropólogo, sociólogo, economista,

teólogo, etc.; no es eso, sino que tenga los conocimientos suficientes, y a la vez que discrimine el campo específico médico-psicológico. Una cosa es que el profesional del área médico-psicológica tenga una formación interdisciplinaria y otra es que él salga de su propio campo; entiendo yo que es un error que trae confusiones, disminuciones de las funciones específicas terapéuticas e inclusive conflictos en los equipos.

En otro punto, casi el último, me refiero a los aspectos en la formación ética profesional. Entiendo que no es distinto eso de lo que sucede en todo profesional del área médico-psicológica. Sin embargo, es bastante más frecuente, a mi modo de ver, que haya problemas éticos que se presenten y que haya que entender cuando se trata de conflictos conyugales y familiares o problemas en general, conflictos en el sentido amplio de la palabra. De manera que, ponemos énfasis cuando se forman los profesionales en que presten atención a una formación ética profesional más profunda, en parte en tolerancia respecto a los colegas y sobre todo en lo que dije en entender los problemas éticos que surgen en el matrimonio y la familia, por ejemplo cuando vienen por un problema de adopción, un problema de separación conyugal, un problema de infidelidad, etc. Por otro lado también tiene implicaciones especiales en el matrimonio y la familia el secreto profesional, dado que podría tener trascendencia el problema conyugal en un plano jurídico.

Yo tengo por norma que cuando hay indicios que podría pasarse al plano legal, aclarar a los cónyuges que voy a guardar secreto profesional, inclusive en el caso que sea requerido un informe por un tribunal. Otro criterio, el último que quiero citarles es que prestamos importante atención a la prevención médica: sea simultáneamente con la asistencia, sea directa a los grupos comunitarios, sea como asesores en las entidades que se dedican a la asistencia conyugal y familiar.

El último punto, breve, que quiero decir, es éste: estoy convencido de que la formación en psicoterapia conyugal y familiar aumenta ampliamente las posibilidades psicoterapéuticas no sólo para asistir a matrimonios y familias sino aún para ejercer la psicoterapia individual y la psicoterapia grupal. Por ejemplo, en cuanto a comprender la dinámica más ampliamente y también para disminuir la resistencia cuando el mismo terapeuta tiene entrenamiento y puede pasar de una asistencia individual a la de un grupo familiar y viceversa. Muchas gracias.

Va a tomar la palabra el Dr. Albornoz, médico psiquiatra del staff de la Comunidad Terapéutica Psicoanalítica, psiquiatra y Miembro fundador de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, terapeuta individual y familiar.

Dr. Luis A. Albornoz: Evidentemente el panel este de Instituciones, entrenamiento y asistencia incluye puntos fundamentales, esenciales, que pienso que es difícil, dado el margen del tiempo, poder llegar a

trabajar con toda la intensidad necesaria que sería de mi gusto.

Hablando desde la perspectiva de las Sociedades de terapia familiar, una inquietud personal mía es qué tipo de instituciones, qué tipo de entrenamiento se brinda en estas instituciones para hacer el abordaje y tratamiento de la familia.

Esto es un problema importante por el cual se ha reunido este Congreso, para tratar de hacer el intercambio de la mayor y mejor forma posible. Esta reflexión viene a cuento de que evidentemente dentro de la actividad profesional que se desarrolla especialmente en la Capital y en provincias y ciudades importantes del país como Mendoza, Córdoba, Rosario, Paraná, Tucumán, están surgiendo, vuelvo a recalcar especialmente en la Capital, numerosos profesionales que han abordado el trabajo de la terapia familiar y han surgido instituciones para este tipo de trabajo y entrenamiento e investigación. Yo desde la perspectiva personal de mi experiencia, provengo de un entrenamiento que parte desde el tratamiento individual y que paulatinamente aparece el trabajo con la familia. Para mí aparecen el trabajo con la familia como un proceso natural de crecimiento de la experiencia psicológica y psiquiátrica; vale decir que el paso del trabajo del paciente único al concepto de la familia como unidad, es un descubrimiento paulatino.

Señalo esto porque lógicamente en las nuevas generaciones, se trata de buscar soluciones terapéuticas inmediatas, para ser útiles a la comunidad y para ser útiles a sí mismos, en la función de poder resolver, reparar situaciones personales y familiares. Esto tiene su pro y su contra; el pro es el beneficio que nosotros brindamos a la comunidad y el efecto contrario sería que la institución que forma terapeutas tenga la responsabilidad de entrenar de tal manera que este terapeuta haya paulatinamente a través de la terapia individual, preferentemente en Buenos Aires y de índole psicoanalítico, podido trabajar y elaborar sus problemas personales, para poder hacer el abordaje de la familia. Pienso que el abordaje intelectual sin mayor compromiso emocional, de la familia, deja un vacío que puede tornarse iatrogénico en el tratamiento. Esto apunta a que no es extraño en la historia de la medicina, casualmente nos llamamos terapeutas, y los terapeutas tienen la función de curar, de ayudar, vale decir, no es nuestro rol la investigación, en este campo, estamos hablando de la terapia familiar. Y como somos terapeutas familiares, nuestra misión es ayudar a la familia. Volviendo al problema anterior, la pregunta es: si las instituciones, el entrenamiento que brindan, está favoreciendo o brinda la posibilidad del desarrollo emocional del terapeuta y la superación de sus conflictos personales, para poder trabajar con familias. Estas reflexiones son de índole más general.

Particularmente la experiencia de trabajo en una Comunidad Terapéutica con pacientes graves y severos nos exige un compromiso emocional muy intenso. Ese compromiso hace que nosotros tengamos resueltos en gran parte los problemas familiares nuestros. La experiencia mía a lo largo de estos años es que a través de tratar familias yo he tratado mi propia familia de origen. Vale decir que esto está un poco

ligado a la idea que trae Whitaker, que la formación del terapeuta familiar tiene que estar relacionada con su mismo proceso terapéutico.

Si este proceso terapéutico se va cumpliendo y se va desarrollando, tenemos una posibilidad mayor de trabajar con las familias y sus ansiedades, especialmente con sus ansiedades psicóticas, las ansiedades desorganizantes, de otra manera corremos el grave peligro de caer en lo que dice Wynne, "en el cerco de goma", quedar incluidos, quedar anulados o defendernos intensamente a través de interpretaciones salvajes de la posibilidad del crecimiento emocional de la familia. Vuelvo a insistir: en una comunidad terapéutica de estructura multifamiliar en la cual todos los miembros van cumpliendo roles familiares diferentes que proyecta el paciente, va facilitando en el terapeuta un proceso de maduración y el proceso terapéutico del paciente. Esto es con respecto, muy esquemáticamente, a la experiencia que se puede realizar en una comunidad terapéutica de orientación psicoanalítica.

Esto está ligado a algo que escuché anteriormente que decía el doctor Fernández Mouján, qué tipo de instituciones son en las cuales trabajamos y qué ideología tiene la institución.

Evidentemente para la gente que comienza un entrenamiento y una asistencia a familias, es fundamental la ideología de la institución y lo que decía anteriormente, de qué manera esa institución favorece el desarrollo del terapeuta.

Terapia familiar, a mi criterio, no está separada de la terapia individual, uno puede ser en casos de pacientes graves un terapeuta individual que se está haciendo cargo de numerosos aspectos e introyectos familiares de un paciente grave. Vale decir que de alguna manera, está haciendo una terapia familiar con una persona, pero indudablemente eso es poco para que se realice un proceso terapéutico. Hay que integrar a la familia. Al integrar a la familia nosotros trabajamos, el terapeuta individual, en coterapia con el terapeuta familiar y a su vez, esto está enmarcado en un trabajo de equipo, y éste a su vez, está enmarcado en un contexto mayor que es la comunidad.

Y las múltiples informaciones que se dan sobre las interacciones y las proyecciones que deposita paulatinamente el paciente y que nosotros reintroyectamos no solamente a través de interpretaciones sino paulatinamente a través de un continente, que es el continente primero individual para contener las ansiedades psicóticas y el continente de la institución para contener las ansiedades psicóticas del paciente y de la familia.

Cuando nosotros logramos reintroyectar estos aspectos y además trabajar institucionalmente con todas las proyecciones constantes que nosotros como terapeutas traemos desde nuestra familia de origen, ese otro aspecto importante del trabajo del entrenamiento del terapeuta familiar y de la ideología de la institución. En estas palabras quiero resumir de alguna manera cómo un terapeuta individual pasa a ser un terapeuta familiar en una comunidad terapéutica y cómo su desarrollo emocional se va dando paulatinamente a lo largo del contacto con el

trabajo, con el paciente y con sus compañeros coterapeutas, colaboradores de equipo y con toda la comunidad en su totalidad que le va brindando información y discriminación constante entre la fantasía y la realidad, entre la proyección y la introyección y la regulación de ella que es uno de los aspectos básicos en los tratamientos graves. Nada más. Muchas gracias.

Va a hablar ahora el Dr. Fernández Mouján, médico psiquiatra y psicoanalista, Director del Centro Médico y Psicológico de Buenos Aires, ex miembro del staff del Servicio de Psiquiatría del Policlínico Lanús.

Dr. Octavio Fernández Mouján: ¿Cuál es el contexto donde creamos la formación de terapeutas de familias? Ese contexto necesita tener una relación lo más viva y que participe no solamente del problema de familia al cual uno se atiene sino también dónde la familia y en qué sociedad esa familia vive. ¿Qué pasa en su entorno, entre esa familia y ese médico? Es importante también crear equipos e instituciones también vivos, después voy a explicar qué estoy significando con esto, que permitan entonces una elaboración y un abordaje desde adentro de la terapia familiar.

La institución es también una institución viva, de carácter y de estructura familiar en parte dentro de la cual sus miembros viven sus crisis, y también elaboran las ansiedades y perturbaciones que una sociedad en cambios va provocando y desafiando. Una familia tiene una finalidad desde el punto de vista personal en la educación de sus hijos, de desafiar esos impactos sociales, y permitir una elaboración en una sola, la familia en sí misma, que permita entonces reconstruir su identidad y a partir de ahí el aprovechamiento y el crecimiento de cada uno de los miembros y de la pareja de los padres. Por eso es importante cuando formamos al terapeuta de familia darle un ámbito institucional no rígido, sino que también viva desde adentro vicisitudes de cambios estructurales, crisis vitales que permitan desde la institución ir entendiendo qué pasa desde adentro en esa familia. No seguir trabajando con prejuicios sino con juicios, que parten de una realidad que uno vive, participa, se equivoca, supera y transforma. Una institución entonces que tiene ideas claras, ideas abiertas y que se van transformando en el curso de la vida de esa institución. Esas ideas, esa ideología institucional, esa cosmovisión, permanentemente desafiante y transformante que al mismo tiempo interpela y es interpelada. Tiene algunas ideas que es importante para nosotros tener en cuenta, dado que venimos muy generalmente de una formación muy particular.

En primer lugar la práctica privada, tiende, porque tiende la sociedad en sí, a una práctica cada vez más pública, comunitaria e institucional. No es un capricho individual, la historia va hacia una socialización mayor. Esa práctica y no al revés, porque hemos venido muchos que hemos trabajado en instituciones, pretender moldear la práctica institucional a la manera del consultorio privado.

Otra segunda idea importante, es que la práctica clínica tiene que estar insertada en la cultura, la cual va a garantizar una actitud creativa y transformadora de esa cultura; así como las ideas y teorías que son aportes de otra cultura van a enriquecer nuestro trabajo clínico.

Esa cultura que al mismo tiempo es la que después nos va a permitir también este trabajo institucional como veremos después, nos va a permitir tener la misma actitud frente a una familia.

Otra idea es que el desarrollo teórico está cotejado permanentemente por esta realidad clínica, con este compromiso por una familia y con una sociedad. La visión del fenómeno humano, es una visión más amplia y totalizadora, no es solamente la visión de un psiquismo, de un aparato mental; es la visión de un hombre que crece en familia, en la sociedad y en instituciones. Es a eso a lo que tenemos que aprender a dar respuesta juntos como terapeutas.

De esta manera, las corrientes modernas de las cuales todos hemos surgido, como el psicoanálisis, o la psiquiatría dinámica, teoría de los sistemas, estructuralismo, fenomenología, conductismo, etc., entonces pueden ser conceptualizados, recontextualizados y extendidos.

Otra idea que marca este enfoque ideológico institucional, es que el marco institucional tiene que ser respetado en su identidad propia; la institución no es algo que se puede usar, es algo que hay que cuidar como una familia. Tiene una identidad propia, crece, muere y también entra en crisis y vuelve a transformarse.

Esta idea de los que hemos trabajado en instituciones públicas y trabajamos en instituciones privadas vemos el peligro permanente de esa deformación de la mentalidad de usar nuestras instituciones y que a veces también detectamos en la familia, como se usa la institución familiar y no se le detecta esa identidad propia, ese cuidado por la vida familiar, la vida institucional.

Otra idea: una práctica clínica que contemple una visión integrada dado que la acción es contextual, dado que la visión no pierde ningún detalle y va a ser utilizado para ese cambio y esa formación del terapeuta. Una visión asistencial que tenga en cuenta no sólo la asistencia de alguien que consulta, que tenga en cuenta la prevención y esto, los que trabajamos con familias lo sabemos muy bien. Cuando uno hace terapia familiar hace prevención; no solamente está asistiendo al miembro por el cual se consultó. Esto es otro hecho importante, otro cambio importante de mentalidad como terapeutas, en Buenos Aires, hoy. Estamos hablando que estamos acostumbrados a que los pacientes vengan a nuestro consultorio, no nos animamos a salir a buscar esos momentos de crisis fuera del consultorio, a los cuales tenemos que dar una respuesta para prevenir enfermedades futuras.

La OMS propone que la medicina y la psicología del año 2000 avancen si es que los terapeutas toman conciencia de hacer una medicina y psicología preventiva. Esta tarea además de prevención y asistencia tiene que estar ligada a la docencia. ¿Por qué? Porque en la docencia es donde uno al enseñar aprende y pone en cuestionamiento sus propias ideas. Es importante también la investigación. Es importan-

te poner todo esto en un marco de seriedad para ver que la eficacia de lo que hacemos es real, no es una pura ilusión, no es solamente el intento de aplicar teorías, que a veces vienen de otras culturas, sino es un intento de convalidar y de dar pasión a lo que uno está haciendo.

Es también ir desarrollando y tomar conciencia de la importancia de la administración médica. El trabajar en equipos, el trabajar en instituciones, sabemos que si no tenemos en cuenta este hecho, si no tenemos en cuenta nuestras pautas, cierta convivencia, ciertos aspectos legales dentro de una institución, las instituciones se convierten en verdaderos matriarcados donde realmente, vuelvo a decir, el defecto mayor es el uso de la institución. Insisto, la institución como la familia tiene identidad, tiene una vida propia que es importante que sus miembros respeten y se atengan a ella para crecer juntos cada uno en su propia identidad.

Es importante transmitir estas ideas el romper con la antinomia de una práctica privada con pacientes de muchos recursos versus pacientes de menos o pocos recursos.

Es importante que una institución se comprometa también a dar respuesta a una comunidad que solicita servicios para todos aquellos que tienen recursos y pocos recursos. Es importante cambiar nuestra mentalidad como terapeutas que venimos de una práctica liberal e insertarnos hacia dónde va la historia.

Todas estas ideas, que he esbozado algunas y que por honor al tiempo, las voy a interrumpir en este momento, van a esta cuestión.

Van a la cuestión de que para enseñar terapia familiar, creemos que es importante en qué contexto y desde dónde enseñamos. No basta informarnos realmente de lo que se hace y de lo que se lee.

Es importante vivir las crisis desde las instituciones, desde la familia y desde esta práctica vivenciar los hechos. Es importante que creamos un contexto para que nuestra formación no sea puramente teórica y de aplicación de teorías, sea una formación viva donde lo que estamos enseñando, lo que estamos practicando como terapeutas devenga de una experiencia, de algo que uno ha vivido y que uno ha podido comprobar desde adentro su eficiencia y su realidad.

Esto va a otra cosa, en la formación de terapeutas de familias es importante si uno está comprometido desde dentro de esta identidad familiar, desde dentro de esta realidad institucional, dentro de esta cultura que vive y se transforma. Es importante que el terapeuta de familia, como el terapeuta individual, como el terapeuta de grupo, o cualquier terapeuta, pero ponemos énfasis en la familia, porque la familia es un grupo y es también una institución, tiene también vida propia y es importante entonces, detectar qué es eso que particulariza a esta familia que tengo enfrente mío. No es cómo voy a aplicar lo que sé, sino cómo voy a entrar, vivir lo que pasa dentro de esta pareja, para que entonces con lo que sé, pero a partir de esta vivencia puedo empezar a tener juicios y poner en práctica una técnica terapéutica.

Otra idea que surge de este planteo es que cuando enfocamos la familia y la institución desde donde estamos practicando la terapia

familiar. Y cuando digo institución, no estoy diciendo institución que tiene un lugar físico, estoy diciendo la participación de asociaciones, desde donde yo garantizo que mis ideas no son mías solamente, desde donde yo puedo integrarme y compartir estas ideas que son como todas las ideas nunca acabadas y siempre en desarrollo. Pero antes tengo que garantizar que ese desarrollo no es individual y subjetivo, y la que tiene que garantizar es nuestra propia institución, nuestra propia sociedad y nuestros propios pacientes.

Aquí entra la idea que estamos frente a un proceso. Proceso que no podemos predeterminar absolutamente desde el comienzo, proceso en el cual uno podrá tener objetivos claros de qué es lo que realmente quiere. Es importante que esos conceptos y objetivos claros aparezcan desde un comienzo, pero también es importante tener en cuenta que lo que iniciamos en la terapia familiar es un proceso, es llevar la familia a esta situación básica de identidad familiar, llevar a la familia a recuperar eso que ha perdido por distintos factores, por defenderse frente a las ansiedades surgidas dentro de la familia, por defenderse frente a situaciones sociales que vienen de afuera, por defenderse de otra infinidad de motivos, que han fijado a la familia en una manera de funcionar. Lo mismo pasa con las instituciones, lo mismo pasa con nuestras ideas profesionales, que las cristalizamos y se convierten en defensivas. Cuando escuchamos una idea nueva, cuando escuchamos una familia que nos plantea crisis, no sabemos a veces qué responder y buscamos los libros, y buscamos a alguien que nos permita aplicar algo.

Un proceso es un acto creativo, es algo que entra en ciclos y cada ciclo entra en crisis y cada crisis es una transformación. Esto es fácil decirlo, no es tan fácil vivirlo. Es importante aceptar los momentos de crisis dentro de una institución, dentro de una nación, dentro de una familia y dentro de una persona. Esos momentos de crisis son momentos en los cuales uno se cuestiona y replantea, momentos de incertidumbre que todos tenemos cuando estamos frente a una familia.

A veces son los momentos más ricos, aquellos en los que uno tendría que callar y hablar, son los momentos donde uno tendría que preguntar, interrogarse, cuestionar, comentar lo que está pasando, y sin embargo quisiera tapar con ideas o prejuicios lo que está pasando en esa familia. Quisiera terminar con estas dos ideas: es rescatar esta idea de proceso, proceso que no es desde una familia que estamos viendo, proceso vivo que yo también vivo en la institución, proceso vivo, que también yo vivo desde mi persona, y como miembro y como ciudadano.

Ese proceso vivo es, y vivo quiere decir, algo que crece y está en permanente transformación, ese ámbito, esa identidad grupal, esa identidad familiar, esa identidad institucional, es un ámbito que favorece las elaboraciones de los conflictos que surgen desde sus miembros, conflictos desde los cuales es importante tener un ámbito y crear ese ámbito, que a veces la familia ha perdido y la pareja también, se han transformado en algo cerrado de uso mutuo. Es importante

recuperar ese espacio dentro de la familia, dentro de las parejas. Pero ojo, que esto no es teoría, tenemos que recuperar primero ese espacio en las instituciones, tenemos que crear ese espacio dentro de nuestra propia pareja, familia, y dentro de nuestra propia vida como ciudadanos. Es importante que lo que uno hace, lo que uno practica tenga algo que ver con lo que uno vive. Dentro de este marco creo que tiene que estar enmarcada la formación de terapeutas de familia.

Entonces sí pienso que todo lo que leamos, todo lo que recibamos de otros lugares, todo lo que hemos trasladado desde nuestra infancia y nuestra familia tiene una garantía de que eso en algún lugar va a ser elaborado a través de un valor, a través de un lugar del que nadie se puede apropiar porque ese lugar es un nosotros, es de todos. Eso es la familia en sí misma, eso es la institución en sí misma, eso es la identidad de la persona, eso soy yo. Ese yo, entonces, que necesitamos liberar de determinismos, es importante para poder transformar la formación de terapeutas de familia, y cualquier formación de terapeutas en un acto creativo. Creo que si no hay creación, no hay tampoco terapia. Muchas gracias.

Va a hablar ahora la Dra. Giller; es médica psiquiatra, Jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Piñero, y terapeuta de familia.

Dra. Ana Giller: Voy a contarles un poco la experiencia de nuestro servicio. Quizá nuestra experiencia, es una experiencia que se adapta un poco a todo lo que ha dicho Octavio. Nos costó mucho insertar un servicio de Psiquiatría en un hospital general de agudos, ser aceptados, encontrar nuestra propia identidad. Llevamos 3 años y medio; llegamos a un lugar que era un páramo y tuvimos la suerte que nos comprendieran y nos apoyaran.

Dentro de ese servicio, que es un servicio general, que tiene internación, que tiene consultas diarias en niños, adolescentes y adultos, hemos implantado un equipo de terapia familiar. Así como fue creciendo fueron creciendo las demás áreas, como dice Octavio, esa permisividad, que es un poco nuestra tónica de trabajo, logramos formar un equipo de familia. Luego me gustaría que contaran sus experiencias algunos de los miembros de ese equipo, que están aquí, desde su propia perspectiva.

Como les decía, ese equipo de familia utiliza distintas técnicas y se basa en distintas teorías. Pensamos que si alguien maneja bien lo sistémico, y es válido y puede hacer bien a determinadas familias, bienvenido lo sistémico. Si alguien trabaja desde lo estructural, bienvenido lo estructural. Esa es un poco la idiosincrasia de este equipo. Utilizan distintas técnicas, distintas teorías y se llevan bien, no se pelean, en estos 3 años y medio creo que fue un avance de maduración, de crecimiento.

Con respecto a la institución eso sería lo básico. Con respecto a la formación, el entrenamiento lo realizamos en lo sistémico y lo

interaccional a través de cámara de Gesell, tenemos seminarios, cursos, supervisiones. La derivación viene no sólo del hospital sino sobre todo de Sanidad Escolar, y otras instituciones. El servicio y el hospital están en una zona ecológica muy especial, y en un comienzo, pues ahora desaparecieron las villas, se trabajaba con gente de ese cordón ecológico. En este momento digamos a nivel municipal es el único servicio que trabaja dinámicamente, que posee un equipo de familia y la derivación se ha hecho de otras zonas de la ciudad. Las derivaciones sobre todo de la parte materno-infantil vienen con problemas de aprendizaje, chicos con trastornos de conducta, y dentro del equipo hay quienes trabajan con niños y gente que trabaja con toda la familia conjuntamente.

No sé que más les podría decir porque pensaba decir lo que ya dijo él. La exposición de Octavio ha sido brillante, qué más se puede agregar, coincido con lo que él piensa.

El servicio sigue en esta tónica y creo que no se puede trabajar en una institución si no se piensa de esta manera. Muchas gracias.

Va a hablar ahora el Dr. Morgan. Es profesor de Técnica y Dinámica de Grupos de la carrera de Psicología, Jefe del Servicio 8 del Hospital Borda y del Servicio de Psiquiatría del Hospital Británico y médico psiquiatra.

Dr. Juan José Morgan: Yo voy a hablar de la experiencia que hemos tenido en el Hospital Borda y cómo llegamos a familia. Mi acercamiento a la psicoterapia viene de bases analíticas e intentamos en el hospital hacer psicoanálisis de psicóticos. Dadas las dificultades que tuvimos con nuestra experiencia, nos obligó a ver otros factores de la enfermedad. Entonces apareció la madre; la culpa la tiene la madre, al ocuparnos de la madre nos tuvimos que ocupar del padre. Entonces nos dimos cuenta de que para entender la enfermedad de este señor esquizofrénico, teníamos que tomar en cuenta a la familia, la estructura de la familia. Dada nuestra experiencia analítica, nuestras primeras familias eran interpretativas. Un día tuvimos un señor que fue traído a la sala por una drogadicción y cuando empezamos a estudiar la familia nos encontramos con que había un padre que desde la guerra española estaba con un delirio. Entonces cuando le mostramos esto a la familia, el hijo dijo: "Claro, ¿por qué creen que yo estoy aquí?". Entonces descubrimos que para todos era esto conocido, esto nos hizo pensar que la interpretación de lo que pasaba en la familia podía ser útil para saber lo que pasaba si no para la familia en sí.

Otra vez, en otro servicio, un cuadro agudo parecía una esquizofrenia, estudiando la familia como hacemos de rutina, encontramos que esta familia que aparentemente tenía un hijo esquizofrénico por la sintomatología clínica, dijimos cómo puede ser una esquizofrenia si la familia aparentemente no tiene las características que nosotros habíamos observado en las familias de esquizofrénicos, que además habían sido descritos por Lidz. Y evidentemente no era una esquizofrenia, era

una encefalitis, que se curó de la encefalitis, pero que quedó un tipo de estado parkinsoniano que nos aseguró el diagnóstico.

Entonces con estos tres factores nos dedicamos a estudiar a familias. Con tres criterios: 1) como parte de la evaluación de la enfermedad, 2) como parte de estudiar la familia como continente. Ustedes saben que las técnicas actuales para socialización de los enfermos que nosotros tenemos, lo que queremos es un continente en la familia para que el individuo esté fuera, y pueda vivir fuera del hospital. Ustedes saben ya que las comunidades terapéuticas están un poco fuera de moda, porque si a un individuo le dan una comunidad terapéutica, el tipo se adapta a la comunidad y no sale más del hospital o cuando sale tiene las dificultades lógicas de su enfermedad. Entonces el objeto de nuestro estudio de familias, es ver la familia como continente y en aquellos casos que vemos que hay una posibilidad terapéutica utilizamos, no la interpretación que nos demostró que no nos era útil, sino la parte sistémica que ustedes conocen y que evidentemente desde el punto de vista terapéutico es más útil. En las salas, el estudio de las familias se hace en forma sistemática, con fines diagnósticos, como fin de evaluación de la familia como continente y cuando es posible, con fines terapéuticos. Lo importante de la familia, y eso creo que nos está atrayendo a nosotros desde el punto de vista clínico, es que ciertas enfermedades no se pueden curar fuera de la familia. Una de ellas es la esquizofrenia que les acabo de mencionar. Acuérdesse usted que en el año 50, R en su análisis directo curó 16 catatónicos pero dándoles una familia sustituta y actualmente yo creo que ninguna persona que trabaje con psicóticos puede pensar que hay una posibilidad de curación si no se toma la familia como parte del problema, ya sea para resolver el problema o para darle un continente a la familia que le permita al individuo vivir fuera. Estas situaciones que son tan importantes nos han traído evidentemente, como se ha dicho aquí antes, el concepto de la enfermedad.

Ya nadie acepta actualmente que la enfermedad es una patología debida al individuo únicamente. Eso nos ha cambiado totalmente, porque vemos que la mayoría de las enfermedades son situaciones en las que se lo coloca al individuo y cuya adaptación lo coloca en un estado de ilusión de alternativa, donde si quedarse le da mucha rabia, irse no puede. No sé si me explico. Pero además hay una cosa muy importante en este sentido. Todos ustedes conocen por experiencia, el débil mental que funciona bien en el campo en un ambiente protegido.

Yo creo que ninguna persona se atreve a tratar un psicótico o un niño si no toma en cuenta la familia. Por eso creo que no sólo debemos agradecer a la familia que nos ha mostrado una realidad que dada nuestra formación tratábamos de desconocer, sino que nos permite de alguna manera investigar mucho más todas las situaciones de interacción, las situaciones de cambio. Por ejemplo, cómo se puede cambiar un individuo con un análisis individual si el individuo no puede salir del sistema? El tipo colocado en un sistema evidentemente no puede cambiar el sistema; para poder cambiar el sistema uno tiene

que salir del sistema. Eso explica algunas de las terapias que duran tanto tiempo o que se postergan, se cambian cada cuatro años, cuando hay un conflicto entre el enfermo y el analista y entonces cambia de analista para curarse.

Por suerte actualmente estamos teniendo una patología dinámica mucho más clara. Entonces sabemos que en el caso de un señor con un problema neurótico la indicación precisa es un análisis ortodoxo porque es la dinámica que corresponde a la curación. Un señor que no reprime, que no disocia, no se le puede basar el conflicto en la represión; una persona narcisística donde el problema no está en la disociación sino en la ansiedad de la vulnerabilidad que tiene el individuo frente a cualquier rechazo, hasta que no se trabaja con distintas técnicas, con distintas situaciones, es imposible curarlo. Yo creo que la familia nos ha traído un cambio muy importante y que evidentemente debemos al psicoanálisis que nos ha dado una posibilidad de cambio; ya no es necesario el insight en ciertas patologías como las que acabo de describir, como pensábamos antes. Nada más. Gracias.

Va a hablar ahora la Dra. Sartoris, médica psiquiatra, Directora Nacional de Salud Mental y ex Directora del Hospital T. García.

Dra. Luciana Sartoris: Voy a caracterizar al Hospital T. García, para referirme luego al período que transcurre entre comienzos de 1979 y mediados de 1981.

Esta Institución que atiende la patología mental aguda de la población infanto-juvenil, poseía una fuerte concentración de recursos humanos y atendía a través de sus equipos de admisión integrados por médicos, psicólogos y asistentes sociales, quienes realizaban los diagnósticos y orientaban a sus pacientes según su patología y su situación socio-familiar hacia las distintas modalidades de atención. Así el servicio de internación recibía pacientes sin familia provenientes de las instituciones de minoridad, o pacientes provenientes de familias con graves problemas y/o con patología que requería hospitalización.

En el hospital de día se atendía patología o pacientes portadores de patología tanto o más severa pero con un grupo familiar continente y que asegurara la concurrencia diaria del paciente al hospital.

El equipo directivo estaba constituido en ese momento por el Dr. Skiadaressis, el Dr. Bernengo y yo, con el Dr. Mercer en la coordinación de docencia e investigación y el Dr. Kligmann en el servicio de internación. Este equipo hizo entre otras las siguientes observaciones: Gran parte de la demanda de atención provenía de familias desintegradas y familias que tenían dificultades para cumplir con las funciones de socialización primaria de sus hijos. Gran parte de la demanda de internación provenía de las instituciones de minoridad o sea de pacientes sin familia y estas instituciones a veces pretendían lo mismo que las familias desintegradas o con problemas para cumplir con sus funciones, depositar a sus hijos en el hospital. Denominamos a esos pacientes de minoridad como pacientes designados por la sociedad, en

tanto las instituciones no podían hacerse cargo de ellos como verdaderas familias sustitutas. Por otra parte la patología de los pacientes respondía en gran medida a problemas familiares; se trataba de niños carenciados cargados de frustraciones, de inseguridad, de desconfianza. Conjuntamente con esas observaciones, vimos que tanto las familias como las instituciones de minoridad y el hospital, tenían cierta similitud en lo que respecta a comunicación, que era defectuosa entre sus componentes. Así los servicios del hospital se desenvolvían en total aislamiento, lo que resultaba perjudicial tanto para los pacientes como para el personal. Los pacientes cuando eran derivados de un servicio a otro para su atención, cambiaban de equipo profesional, encontrándose muchas veces con que los distintos equipos de profesionales tenían formación diferente, como era también diferente la ideología de trabajo de los servicios. Los equipos de profesionales tenían predominantemente una orientación individual, que se basaba en el principio paciente diagnóstico - tratamiento. Las terapias grupales no se realizaban en el servicio de internación y en los consultorios externos solamente un par de equipos estaba a cargo de ellas.

Con respecto a terapias familiares, funcionaba un equipo en consultorios externos, pero a ese equipo eran derivados solamente determinados casos y en el servicio de internación, si bien se entrevistaban a algunos familiares de pacientes, no se realizaba terapia familiar.

En el hospital de día en cambio, estaban dadas condiciones que posibilitaban el proceso terapéutico del paciente, por la forma que estaba estructurado el servicio, por el clima que existía, por las técnicas que se estaban utilizando. Funcionaban pares terapéuticos a los que se asignaba los pacientes y se realizaba terapia familiar pero trabajando fundamentalmente con las madres; es decir que este servicio apuntaba a la reestructuración de la personalidad del paciente y de la dinámica familiar.

A partir de estas observaciones pensamos en que era necesario cambiar el enfoque individual por otro que fuese más abarcativo y que incluyese a las familias en el tratamiento. Es decir que la terapia familiar más que como técnica de abordaje de la patología del paciente, se incorporó como una técnica complementaria de las otras que se estaban realizando y concebimos el hospital como una institución que pudiera cubrir también las funciones que las familias de los pacientes no lograban cumplir. Es decir que fuese una institución correctiva también de las limitaciones de las familias con hijos en tratamiento. El hospital de día además de contener, de posibilitar el desarrollo de los padres, a fin de que pudieran hacerse cargo de las funciones de socialización primaria de sus hijos, y de que al momento del alta estuvieran capacitados para reintegrar a su miembro recuperado a sí mismo y a la comunidad. También pensamos que cada servicio debía, además de funcionar bien individualmente, estar debidamente articulado con los otros servicios, a fin de que la institución fuese un todo y que en ella convergieran todas las acciones en beneficio de los pacientes y de su familia. Con ese propósito programamos reuniones

con los profesionales de los diferentes servicios y se iniciaron acciones docentes en ese sentido. Se comenzaron las supervisiones en todos los servicios incluyendo en el servicio de enfermería y se dictaron cursos de terapia familiar para motivar a los profesionales y para dar un panorama teórico general.

Obviamente se produjeron ante estas propuestas, críticas, resistencia y reacciones que sin embargo, si no fueron superadas fueron disminuyendo a medida que se comenzó a trabajar en este sentido.

Nos encontramos así ante la posibilidad con el desarrollo de estas acciones de limitar las internaciones y de reemplazarlas por tratamientos ambulatorios que incluyeran a las familias, tanto en hospital de día o en consultorio externo como en áreas domiciliarias mediante equipos móviles.

Con respecto a los pacientes provenientes de minoridad se pensó también que podían utilizarse los equipos móviles para tratarlos en sus propios medios y al mismo tiempo hacer prevención. Sin embargo este propósito no se pudo lograr durante ese período.

Este aspecto que referí, que es parcial y relacionado exclusivamente con terapia familiar en el Hospital Tobar García, estaba incluido en un programa de acciones que tenía por objeto revertir la situación tradicional de los hospitales en los cuales el paciente debe adecuarse a la situación de la institución. Pretendimos que la institución tuviese un funcionamiento adecuado a las necesidades del paciente. Nada más. Gracias.

Va a hablar ahora el Dr. Tisminetzky, médico psiquiatra, Director del Centro de Salud Mental de La Matanza y del Instituto de Docencia y Asistencia Psicoterapéutica.

Dr. Mario Tisminetzky: Un poco como psiquiatra y psicoterapeuta sistémico y frente a la retroalimentación que recibo de la sala que se van todos, voy a tratar de apurarme para ver si por lo menos me pueden escuchar.

Quiero recoger algunos datos, algunas informaciones que dijeron los colegas en la mesa, que evidentemente debe ser una de las mayores ventajas de participar en los Congresos y en los paneles y ver cómo la asistencia psicoterapéutica se fue desarrollando más que todo en las instituciones. Y quizá a pesar de todo en los maltrechos hospitales oficiales o municipales, donde, así como el Dr. Morgan habló de los cambios que se fueron dando en la institución, o la Dra. Giller creo que también pasa por esta situación. Lo mismo estuvo pasando o pasa en el Centro de Salud Mental de La Matanza donde frente a una demanda cada vez más creciente el terapeuta está obligado a dar una respuesta a esa demanda. Es diferente quizá la asistencia privada donde es muy cómodo, bueno ahora esto está en crisis, citar y dar horas y recibir a los pacientes, que una institución a la que acude una población que circunda la institución a pedir asistencia.

Del Dr. Albornoz recojo que en la medida en que se actúa con la

familia el terapeuta familiar va realizando modificaciones en su propia familia. Del Dr. Fernández Mouján, todo lo que él dijo en cuanto a contexto y a ideología y cómo toda esa ideología de la institución va desarrollando toda una praxis en constante interjuego con el entorno en el cual, uno se desarrolla. Y a partir de ahí quiero contarles en dos minutos lo que hacemos en el Centro de Salud Mental de La Matanza y lo que se está empezando a desarrollar en una institución privada.

De paso quiero decirles que el Centro tiene una antigüedad de más o menos 25 años y que está situado en La Matanza y que a partir de un esquema psicoanalítico ortodoxo, tratamiento individual, pasó en otros momentos a tratamientos grupales y en este momento existen dos grupos de trabajo, un grupo con encuadre psicoanalítico grupal y el otro con encuadre sistémico familiar. El equipo de familia que en este momento está integrado por 15 profesionales está constituido por médicos, psicólogos, asistentes sociales, por sociólogos, etc., y por psicopedagogos. Surgió en el Centro como una necesidad frente a la demanda de una población que el Centro no podía cubrir en ese momento, que eran los chicos menores de 6 años, ya que los grupos funcionaban con una población infantil de 6 años en adelante. Teníamos el brote de casos agudos psicóticos que eran traídos por la policía de la zona, esposados, enchalecados, para que nosotros le diéramos certificados de internación y ahí empezaba el vía crucis de no saber a dónde mandarlos.

Otro tema era la necesidad de encontrar un encuadre científico que permitiera verdaderas terapias breves, en sentido de tiempo y operatividad teniendo en cuenta conceptos de salud y enfermedad. Todo eso llevó a constituir un equipo de terapia de familia en el cual comenzó la formación de profesionales con el encuadre sistémico. Luego de eso pudimos construir una cámara de visión unilateral que permitió una mejor formación de los profesionales y un mejor seguimiento de los tratamientos de las familias en la institución. Se hizo en 2 años.

Trabajamos con el sistema, encuadre sistémico, de la comunicación y tomando también el ciclo de vida. También tenemos formación de profesionales. Tenemos dos grupos de estudio con pediatras sobre la posibilidad de abordaje sistémico del pediatra al grupo familiar.

Toda esa estructura de desarrollo fue permitiendo establecer planes de investigación sistémica y así por ejemplo en el área de familia alcohólica en relación con la medicina folklórica y la migración tenemos un convenio con el CONICET con el cual estamos trabajando con familias alcohólicas. En el área de la prevención, también con el enfoque sistémico, tenemos un trabajo con jardines y guarderías y también con escuelas primarias, y con una escuela secundaria, para lograr que el maestro sea un agente de salud. En la escuela secundaria entramos a partir de un convenio con el Ministerio de Educación y la UNESCO en un plan que tienen ellos desarrollando por el uso indebido de drogas, alcohol y tabaco.

En el área de comunicación digital y analógica también estamos haciendo una investigación sobre las llamadas enfermedades psicosomáticas.

Hemos celebrado un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia referente a la habilitación de un hospital zonal, nos darán de 10 a 15 camas de internación donde tomaremos a los pacientes en situaciones de crisis, internarlos con sus familias y a partir de ahí, lograr el seguimiento en consultorios externos.

Nuestra línea de trabajo es sistémica. Nada más. Gracias.

Dr. Juan José Morgan: En Suiza hay un hospital psiquiátrico tan bueno, los pacientes son tan bien tratados que las faltas disminuyen terriblemente. Lo que sí se ve actualmente en el Hospital Borda es que llevaron una serie de enfermos a Colonia Federal, estaban en la cama, y con el cambio funcionaban mucho mejor, pero eso no quiere decir que luego, dados de alta, la adaptación social era mejor, para el enfermo el haber cambiado su medio donde trabajaban en una comunidad y eran valorizados, su conducta había cambiado dentro de la comunidad, se los obligaba a trabajar, se los valorizaba, eso no quiere decir que dados de alta, esa valorización no garantiza una vez que salga, persista, sobre todo en el caso del esquizofrénico.

El problema como se dijo acá es de socialización de ciertos tipos de enfermos.

¿Ahora a ustedes se les ocurre que a un individuo se le pueda socializar en un hospital?

M. Jones, en su famoso Institute, todos sus enfermos trabajaban afuera o casi todos, además el instituto estaba fuera del hospital psiquiátrico y se manejaba con tipos distintos del hospital. Por ejemplo si uno dice lo que piensa lo llaman loco.

Usted no puede establecer una comunidad terapéutica en un lugar donde la dirección es totalmente autocrática. Por eso yo pienso que si muchos enfermos por desgracia o por falta de conocimientos actuales, todavía nosotros no tenemos capacidad de mejorarlos o curarlos, sí tenemos la obligación de socializarlos por razones que la Dra. Sartoris conoce mucho mejor que yo, si no se nos acumulan los hospitales de enfermos que después ya ni quieren irse, han encontrado su familia como dijeron acá, que es el hospital psiquiátrico y ya no quieren irse.

Dra. Luciana Sartoris: Pienso que la comunidad terapéutica tiene indicaciones muy precisas y que a nivel privado puede beneficiar al sector de población que cuenta con los recursos para internaciones generalmente prolongadas.

Es muy difícil llevar a cabo en un hospital psiquiátrico, por la razón que diera el Dr. Morgan, tal vez sí una pequeña unidad, como la hubiera en el hospital Borda.

La orientación que da la OMS es la atención ambulatoria.

Dr. Mario Tisminetzky: Desde mi punto de vista, es un logro bastante importante la comunidad terapéutica. Dentro de la lectura sistémica es algo que no hace falta. La comunidad se la da la familia, el entorno.

WORKSHOPS

ALCANCES DE LA TERAPIA FAMILIAR EN EL ALCOHOLISMO

Indicaciones y contraindicaciones para la inclusión del paciente alcohólico en sesiones de terapia familiar.

Lic. RAQUEL GIORDANO DE GUILLIGAN*

Los lineamientos ofrecidos en esta presentación no dan una respuesta científica al tema "alcances de la terapia familiar en alcoholismo"; están basados en mi experiencia clínica, en las experiencias de otros colegas, en los informes sobre los casos clínicos y en la observación regular que durante quince años efectué de la recuperación de familiares de alcohólicos, a través de las reuniones multifamiliares que brinda Al-Anon, asociación paralela a la de Alcohólicos Anónimos.

El alcoholismo es una enfermedad que afecta al hombre en su integridad, a su familia, e implica al sistema social más amplio. El profesional se encuentra frente a un cuadro sumamente complejo y con una enorme cantidad de datos sobre el problema, provenientes de distintos abordajes. Esto es así porque la enfermedad cabalga sobre factores biológicos, psicológicos y sociales.

Hablar de los alcances de la terapia familiar en alcoholismo, significa tener en cuenta cuatro criterios básicos:

I: Evolución de la enfermedad según las fases de la alcohol-dependencia enunciadas por el Dr. Jellineck.

El conocimiento de estas etapas es fundamental como criterio diagnóstico para la inclusión o no del paciente alcohólico en las sesiones de terapia familiar.

II: Desarrollo de la enfermedad emocional en el grupo familiar.

La familia que tiene un miembro alcohólico queda detenida en algún punto de su crecimiento y comienza a repetir sistemáticamente una problemática central: que el alcohólico deje la bebida. Alguno de los familiares aparece como el más involucrado en este desafío esperanzado, que significa para él, la presunción de que algún día va a obtener el control de la bebida que ingiere el alcohólico. Desarrolla gradualmente una dependencia cada vez mayor con la adicción; es la doble adicción o adicción a la adicción del otro. Es la pérdida de la sobriedad emocional en el familiar más afectado. Se establece así a nivel familiar la dependencia con la enfermedad, quedando todo el grupo sobre-involucrado por el alcoholismo.

* Estrada 721 - (1640) Martínez, Prov. de Buenos Aires.

La terapia familiar debe sólo ocuparse de modificar en lo posible el patrón de relaciones patológicas rígidamente incorporado al sistema; la estructura del mismo que posibilita esa forma recurrente de relación interpersonal y en un nivel contextual, la historia familiar y los valores socio-culturales que subyacen.

La terapia familiar no debe ocuparse de los problemas del alcoholismo; intentar modificar la sintomatología alcohólica sería formar parte del sistema que consulta, cometiendo el mismo error que los familiares del alcohólico: creer que se puede con el alcoholismo.

III: Conceptos básicos y modelos utilizados en Terapia Familiar Sistémica en el tratamiento de familias de alcohólicos.

El alcohólico y su familia ofrecen por sus características un prototipo particular que permite apreciar lo enriquecedor que resulta para el terapeuta y el paciente la posibilidad de articular tres modelos o construcciones intermedias provenientes de la Teoría General de los Sistemas y de la Cibernética. Estas son: el modelo interaccional, el estructural sistémico y el contextual.

Cada uno de estos tres niveles de análisis se co-implican y se relacionan con las distintas fases de la enfermedad y del ciclo vital familiar. La experiencia así lo demuestra.

IV: Alcances de la Terapia Familiar en Alcoholismo.

En función de los criterios enunciados anteriormente, el abordaje terapéutico incluye en el análisis del problema las siguientes variables:

a - En qué etapa de su ciclo vital se encuentra la familia que consulta.

b - En qué fase de la evolución de la enfermedad se encuentra el paciente designado.

c - Detectar dentro del grupo familiar cuál es el miembro más afectado por el problema.

d - Qué hechos ocurrieron últimamente con especial referencia al motivo de consulta.

La estrategia y alcance de la terapia están en relación directa con los conceptos enunciados en el punto IV.

SUMMARY

Based on the 15 year personal observation of the author on the family recuperation in Al-Anon groups, and her own clinical experiences as well as those of other professionals, she establishes the following strategy of therapeutical treatment of the sick member and the whole family.

1) By means of Dr. Jellineck's classification an approximate differential diagnosis should be made to decide the convenience of introducing the alcoholic to the therapeutical family sessions.

2) To detect, within the family group, the member most affected by the problem. Who has become an addict to the addiction.

3) To find out at which stage the family vital cycle is at that moment.

4) The possibility of accomplishing the different intermediate patterns of systemic approach: interactional, structural or contextual; according to 1), 2) and 3) above.

This strategy is important because alcoholism presents multiple factors which make of it and the families involved a special prototype for analysis.

UN ASPECTO DEL ENTRENAMIENTO DE TERAPEUTAS FAMILIARES: LA INSTRUMENTACION DEL GENOGRAMA.

Lic. MARIA ROSA GLASSERMAN* y Lic. JUANA M. DROEVEN**

Este taller se centró alrededor del entrenamiento de terapeutas familiares, poniendo particular énfasis en ciertas dificultades que se presentan en la tarea clínica vinculadas a conflictos no resueltos del terapeuta con su familia de origen.

Se subrayó la importancia del genograma del terapeuta con la descripción de sus vínculos familiares (transferencia relacional dominante).

Se realizó una síntesis teórica y luego se pasó a un trabajo vivencial.

Se interrogó a los participantes sobre dificultades clínicas repetidas en su tarea y se eligió una.

Un terapeuta planteó que repetidamente se enojaba frente a situaciones de pareja en que la mujer sufría, se quejaba reprochando que ambos no la ayudaban. También su dificultad aparecía cuando no podía resolver la situación que se le planteaba.

La metodología que se siguió en este caso fue:

- a) Dramatización del caso clínico y su dificultad.
- b) Escultura de la familia de origen del terapeuta en dos momentos vitales elegidos por él.
- c) Interrogatorio sobre su genograma tendiente a desentrañar creencias y mito.
- d) Análisis de la situación y conclusiones.

a) En la dramatización de la pareja frente al reclamo y sufrimiento de la mujer, llamaba la atención que cuando el marido intentaba ayudarla, el terapeuta se sobrecargaba haciéndose cargo de la situación, bloqueando la solidaridad del marido. Se hacía cargo del sufrimiento hasta que por bronca, salía de la habitación.

b) Las situaciones elegidas por el terapeuta de su historia fueron semejantes. 1) Su madre enferma sufriendo muriendo, la hermana sufriendo y llorando, él en el medio de todas las miradas incluso la del padre, quien le reprochaba al terapeuta, tener demasiada fe en los médicos y poca en Dios. 2) La otra situación elegida era una en la que el padre trabajaba, la madre lloraba y le reprochaba "sos malo, por vos llora tu hermana, le pegaste". La hermana llora y él se siente culpable por la situación.

c) Cuando le preguntamos por su familia de origen apareció un personaje mitológico, su abuelo, pastor de rebaños que en sus momentos libres estudiaba hasta que logró mucha cultura y poder. Se llamaba como él y él se llamaba, a su vez, como un rey al que se le adjudicaba

* Guatemala 4320, (1425) Buenos Aires.

** Bulnes 1865, 6º, "A", (1425) Buenos Aires.

mucho poder, "el salvador". Todos los primogénitos de la línea materna llevan ese nombre.

d) Análisis y conclusiones. Es notable la situación isomórfica entre lo clínico y lo personal. Siempre en una triada de la que inculpa de algo y con alguien que sufre *debía* ser "el salvador". Esa situación cuando no es posible lo lleva a situaciones de culpa y bronca volviéndolo inoperante en esos momentos en el campo terapéutico.

Quisiéramos que quede claro que el conocer estas situaciones y reconocerlas no implica necesariamente cambio, sino que es un alerta que permite salir del campo para evitar entrapamientos.

Para esto es útil y recomendable trabajar en cámara, en dupla, con alguien con relación clara e íntima para usar esta herramienta.

SUMMARY

This workshop will deal with the use of the trainee's genogram (a space organization of the genealogical tree, in at least 3 generations) when he is facing clinical situations in which he is blocked and this is not due to lack of theoretical knowledge or techniques of approach, but because certain binds or interactions make the therapist move back to similar ones in his family history or to his present situation, thus causing his ineffectiveness.

Method

This will be explored through clinical situations posed by some of the members.

It will be done through dramatic techniques, sculpture, genogram, considering our theoretical systemic model.

ABORDAJE DE LA FAMILIA CON UN "PACIENTE ORGANICO CRONICO"

Dra. ANALIA KORNBLIT*, Dra. SILVIA WASERTREGUER** y
Lic. JAIME SZWARSTEIN***

Se partió del comentario de los coordinadores acerca de cómo llegaron a elaborar la metodología de trabajo propuesta para la atención familiar de este tipo de pacientes.

Se presentaron a continuación las dos vertientes del modelo propuesto:

a) el trabajo en el área de lo *cognitivo* vinculado a la enfermedad, que busca que surjan y aclaren las distorsiones en la información que el grupo familiar maneja acerca de la enfermedad. Estas distorsiones están ligadas a las *creencias*, vehiculizadas a través de los mitos populares y familiares acerca de la enfermedad.

b) el trabajo en el área de la *dinámica familiar* ante el impacto de la enfermedad crónica. Bajo esta óptica se postula que el comportamiento sintomático "orgánico" debe ser descifrado en términos de lo que está pasando al nivel de las relaciones entre los miembros de la familia, concebida como un sistema. El modelo apunta a la elaboración de técnicas específicas para cada familia, tendientes a lograr una mayor autonomía del paciente en cuanto al manejo de su enfermedad, graduada según la edad. Se presentó la caracterización de S. Minuchin sobre este tipo de familias y el abordaje específico de los autores en términos de la complementariedad rígida como estructura relacional de la pareja parental. Dado que a nuestro juicio en estas familias la oscilación principal se centra en torno a la complementariedad, proponemos una especie de "remodelamiento" del vínculo complementario para llevarlo al contexto colaborativo. Esto incluye tres esferas de acción simultánea:

a) a nivel de la pareja parental: uso de una técnica de simetrización momentánea.

b) a nivel de la pareja padre (o madre) — P.I.: promoción de la alternancia "one-down" - "one-up" entre ambos.

c) a nivel del subsistema filial: prescripciones que engloben a sus miembros en un contexto diferenciador con respecto al subsistema parental.

El grupo trabajó con estas propuestas manifestando inquietudes y transmitiendo sus propias experiencias, lográndose un clima de "contexto colaborativo" a partir de la complementariedad coordinadores-escuchas.

* Moldes 1243, (1426) Buenos Aires.

** Rawson 3753, (1636) Buenos Aires.

*** Aráoz 2471, 1º, 4, (1425) Buenos Aires.

SUMMARY

In this paper, a clinical-psychological approach to families with a member in a chronic condition, is described.

The main purpose is to act on the emotional factors that the disease produces in the family as a system and that interfere in the therapeutic success, at the medical level.

To operate in two areas is proposed:

a) *Cognitive*, trying to know and make clear any distorted information the family have on the disease, with special emphasis on non-critical beliefs. To make conscious these primitive myths constitutes a valuable tool leading to their questioning and eventual correction, and consequently improving the family behavior related to the control of the disease.

b) *Family dynamics*. Chronic diseases facilitate the broadening of the pre-existing dependency links. Furthermore, if the organic disease constitutes a sort of limit not seen in psychiatric disorders, the load on the patient of other conflicts can be understood as the role played by the "identified patient" as mentally ill. The individual "marked" with an organic disease is an adequate target to receive multiples deposits from unsolved family system conflicts, expressed through many dysfunctional interactions. The model of work above mentioned aims to specific techniques for each family to achieve a better autonomy of the patient and emphasizes the necessity for this type of families, as G. Bateson proposed, "to reach the bottom".

TRES NIVELES DE ABORDAJE DEL GRUPO FAMILIAR

Dr. ALFREDO CANEVARO*, Lic. ALICIA ARBISER** y Lic. SILVIA QUAGLIA***

El workshop consistió en la presentación de un video cassette correspondiente a una consulta realizada con el Dr. Canevaro. Su intervención fue solicitada por los resultados poco significativos de la psicoterapia individual de una niña autista al cabo de dos años y medio de tratamiento.

En la consulta estaban presentes además, la Jefa del Servicio, el terapeuta individual de la paciente designada y la familia nuclear.

El material clínico se presentó a través del genograma de las familias de origen y nuclear, se extrajeron algunas hipótesis.

En esta presentación se explicitaron las características de las familias según su modo de agrupamiento y el estilo de relación.

La hipótesis central consistió en correlacionar el síntoma del autismo de la P.D. con el encierro de la madre, proveniente de una familia dispersiva-centrífuga, rechazada por la familia de origen de su marido, de características cohesivo-centrípetas.

En el transcurso de la proyección se fueron explicitando algunas de las maniobras terapéuticas: excluir a la P.D. y su terapeuta y a los hijos menores; más tarde a la hija mayor, quedando en la consulta la pareja enfrentada con la problemática conyugal e individual.

Una vez concluida la proyección, los participantes se incluyeron activamente a través de interrogantes formulados sobre el modelo propuesto.

Se explicitó el motivo de destriangular a los hijos a los fines de recortar los subsistemas y abordar frontalmente la problemática conyugal y de éstos con las respectivas familias de origen.

Partiendo de la premisa del beneficio que traería modificar el contexto no sólo para la P.D. sino para toda la familia nuclear, se respondió al cuestionamiento de la exclusión de los niños.

La patología múltiple de la familia nuclear (cólicos renales del padre, autismo de la P.D. y trastornos escolares de la hija mayor) se señalaron como indicadores de la interferencia de la familia de origen del padre, que no facilitaba el recorte de este grupo nuclear.

La proyección sirvió de ejemplo para mostrar el triple modelo de abordaje que propone el Dr. Canevaro para la Terapia Familiar.

El workshop se cerró con la información actualizada del seguimiento de la familia realizado por la Institución que solicitó la consulta. Los cambios registrados fueron evaluados como positivos.

SUMMARY

The objective of this paper is to revalue clinical research in family therapy and to offer a model for the therapeutic approach to dysfunctional families that takes into account the context formed by the articulation of the families of origin of both spouses.

As introduction the author gives an outline of the origin and the different contributions of several psychoanalysts to the family therapy. In this historic cross-section, he points several concepts: 1) the unit of research and treatment passes gradually from the individual to the family group, 2) a new scientific paradigm, the necessity for changing the context in order to change the individual, 3) an interrelated, circular causality replaces an unidirectional causality. He points out clearly certain concatenated characteristics of family therapy: 1) its historical profile as a clinical science, 2) its nature as a scientific discipline information, 3) the necessity of emphasizing and guaranteeing the scientific nature of clinical research in family therapy and of the evaluation of its results.

The author gives the outline of a model for clinical research and therapeutic approach to dysfunctional families in a trigenational context. He defines the family context, taking into account the family unit, its different models of grouping and the style of relationship it configures. He develops two types of groups: the cohesive-centripetal family (CCP family) and the dispersive-centrifugal family (DCF family) and emphasizes the difference between several authors approaches and his saying that the real and virtual structural field which, as a figure-back-ground phenomenon, must always be present in the therapist. That is the union between two families of origin will be the backdrop before which a new family is going to perform and will mark its style, be it normal or pathological. These two families of origin will always exist in the configuration, even when only one representative forms this virtual field that must be investigated. He outlines three possibilities: a) Both families possess cohesive-centripetal characteristics (CCP + CCP); b) one family is cohesive-centripetal and the other dispersive-centrifugal (CCP + DCF); c) both are dispersive-centrifugal (DCF + DCF). He describes three levels of therapeutic approach which delimit the area specific to the family defining the context in which the individual grows and acquires his identity. The first level or the individual-intrapersonal level; the second level or the relational-interpersonal level and the third level or group systemic level. Finally the author develops the articulation of the different levels in the therapeutic process of the family group and points that the global therapeutic strategy should be approached after diagnosing the contextual situation determined by the configuration formed by the conjunction of both families of origin. He describes the three cases.

* 11 de Setiembre 1760, 19 "D", (1428) Buenos Aires.

** Junín 1431, 7° "B", (1113) Buenos Aires.

*** Rojas 141, 5° "20", (1405) Buenos Aires.

INTERSEXUALIDAD. UN DESAFIO PARA LA ESTRUCTURA FAMILIAR

Dr. ROBERTO LOSSO* y Lic. SILVIA MORICI**

El objeto del workshop fue el de comentar casos que presentaban alteraciones congénitas, correspondientes a los llamados estados intersexuales o intersexos (niños que presentan genitales ambiguos debido a la existencia de perturbaciones y/o defectos enzimáticos en la síntesis hormonal) y la repercusión que produce el nacimiento de un niño con estas características en el núcleo familiar.

Encontramos diferentes estructuras familiares que corresponden a dos subgrupos dentro de los estados intersexuales. El primero, el de aquellos niños que presentan una franca ambigüedad en sus genitales externos, que incluso crea dudas en el momento del nacimiento con respecto a la asignación del sexo. El segundo, aquellos que, si bien presentan caracteres intersexuales, su aspecto externo responde más o menos definitivamente a uno de los sexos.

En el primer grupo encontramos estructuras de personalidad más patológicas, con mecanismos de defensa más primitivos (escisión, negación y mecanismos maníacos). En ellos la indefinición sexual los lleva a un conflicto de identidad sexual, y por lo tanto a una *angustia confusional*. Las familias son frágiles, se tiene de ellas la sensación que se pueden desestructurar fácilmente y apelan a mecanismos maníacos, generando una estructura pobre y estereotipada. Los roles parentales de contención son débiles y el lugar vacío que dejan los padres a menudo es ocupado por el mismo paciente quien se adultiza precozmente. La familia comparte una situación muy dolorosa con predominio de angustia confusional que puede llevar a depresiones extremas y en algunos casos incluso al suicidio de alguno de sus miembros.

Dentro del grupo familiar es frecuente que el padre asuma esta depresión, en función de que la visión de la ambigüedad de los genitales de su hijo lo remite a la fantasía de la "castración consumada". En cambio, en la madre entran en juego predominantemente fantasías de completud, bisexualidad y negación de la castración. Es por esto que es ella quien se hace cargo habitualmente de los aspectos maníacos.

En el segundo grupo las familias se ubican generalmente dentro de una nosografía neurótica con una estructura yoica y mecanismos más preservados, en razón de que existe una asignación de sexo precoz.

Se encuentra, en todos los casos, lo que hemos llamado un *vacío identificador* entre padres e hijo. El hijo pide desesperadamente parecerse a alguno de sus padres, cosa que no logra, y ellos no pueden ofrecerle como modelos identificatorios al hijo, ya que ven en él a un extraño. Esto lleva a los chicos a un profundo sentimiento de soledad

* Laprida 1916, 5° "11", (1425) Buenos Aires.

** Gorostiaga 1731, (1926) Buenos Aires.

por no poder hallar un lugar en el mundo de los hombres o el de las mujeres.

Hemos estudiado los destinos de los deseos parentales de elección de sexo. Todo padre o madre fantasea con elegir el sexo de su hijo: en los intersexuados la alteración anatómica otorga una base de realidad para que esta fantasía se cumpla, a diferencia de los casos de perversión en que se trata de familias más patológicas, donde esta elección de sexo se hace a pesar de que el hijo tenga un sexo anatómico definido.

Es importante diferenciar ambas estructuras familiares. En las dos los padres envían mensajes confusionantes a los hijos, pero en el caso del perverso existe previamente una familia con un grado de patología marcada, mientras que en los intersexuales es la ambigüedad genital del hijo la provocadora de confusión en los padres.

SUMMARY

The birth of a child with ambiguous sexual characteristics (cases of intersexuality), represents a *challenge* to the previous balance of the family group. We differentiate two groups: the first one, in which there is an outstanding ambiguity of the external genitalia, and therefore, doubts with regard to the sex of the newborn are common. In the second one, that sexual identity, at birth, is more certain (less ambiguity).

We have been able to establish: 1st; the existence of an identificatory "emptiness", as much at parents as at the child; 2nd, from that, the presence of a *confusional anxiety* generating confusion in the group and of confusing messages from the parents to the child, in front of which they react, in the first group, with splitting, denial and specially maniac defences (which hide the underlying depression). In the 2nd group, defences are more "neurotic"; 3rd., a particular distribution of roles in the family group, assuming each of its members, different defensive styles; 4th, fathers and mothers react diversely: the first ones, by reactivating their castration anxiety, concretized in their "failed son". The mothers, finding a base for their phantasies of non-castration and bisexuality.

ADOPCION Y SUS DIFICULTADES. OBSERVACIONES PARA LA PREVENCIÓN

Dr. CARLOS MARIA DIAZ USANDIVARAS*

I - Hipótesis. II - Conceptos Sistémicos sobre Familia Funcional. III - Desarrollo del Proceso en la Familia Estéril, Disfuncional. IV - Desarrollo del Proceso en la Familia Estéril, Funcional. V - El Contexto Social.

I - Hipótesis

1) El enfoque más común de: los Adoptantes, las Instituciones que colaboran, los Organismos que legislan, ordenan y controlan, así como la mayoría de los esfuerzos profesionales que hemos intentado para asesorar, prevenir, curar y ayudar en este problema, parten en su mayor parte de explicaciones de la epistemología Lineal convencional, tipo "causa-efecto", y de los fenómenos propios de la Psicología Individual.

2) Esta concepción es insuficiente e inadecuada para comprender los problemas propios del Sistema Familiar, explicables sólo por una epistemología circular, y que además posee características, reglas y leyes propias, distintas a la suma de las psicologías individuales de sus integrantes.

3) Esta concepción lineal e individual tiende a favorecer un proceso de "Falsa Adopción", centrada en la idea de la "protección del Menor Abandonado", que es más un proceso de Tutela que una verdadera Adopción.

4) la Verdadera Adopción es un proceso de formación e integración de un Nuevo Sistema Familiar que puede ser pensado como tal si es una Alternativa Novedosa en el repertorio de Respuestas del sistema, un Salto de Nivel o Cambio 2 en vez de una tentativa de solución tipo "repuesto" o "prótesis", en el Mismo Nivel —Cambio 1— que constituya "más de lo Mismo".

5) Cuando dentro del "contexto de una familia" se produce una falsa adopción, una "Tutela", se produce una incongruencia de características paradójales inevitablemente patógena para el sistema.

6) La Patología del niño adoptado debe ser entendida como parte de un Sistema Familiar Disfuncional.

7) Así como la incongruencia entre el CONTEXTO FAMILIAR y sus ACTITUDES MANIFIESTAS —Tutela— puede ser patógena; la incongruencia entre el CONTEXTO SOCIAL de características filantrópicas, de concepciones lineales e individuales, y LA FAMILIA que trata de "Adoptar" a un niño, resulta causante de disfuncionalidad.

8) Proteger a la Familia es proteger al niño, en cambio, proteger al niño no ayuda a la familia y, consecuentemente, se vuelve contra él, porque se alteran las jerarquías del sistema familiar y se crea un proceso doble-vincular por la incongruencia de equiparar la "clase" —familia— con el "miembro" —niño—.

II - Conceptos Sistémicos sobre Familia Funcional

- 1) Homeostasis - Reglas - Contrato - Cambios.
- 2) Constantes y variables - Sistema de creencias - Mitos familiares, El ciclo de la Vida Familiar - Relaciones Extrafamiliares - Las Familias de Origen.
- 3) Morfogénesis y Morfostasis.
- 4) Estructuras y Jerarquías.
- 5) Alianzas.

III - Desarrollo del Proceso en la Familia Estéril-Disfuncional

1) La desconfirmación por la esterilidad: el problema - El querer ser Madre-Padre - La identidad Complementaria.

2) El adoptado como cambio 1 o "más de lo mismo" o "donde la solución es el problema". Al Adoptado como "Prótesis". La Adopción como "Reparación maniaca". La Colusión.

3) La identificación del Adoptado como paciente. Las coaliciones intergeneracionales. El protector protegido. La ruptura de la Alianza Parental. La constitución de la situación de "Tutela". Las Atribuciones. El cuerpo extraño. La Adopción Filantrópica. El Mito Familiar de la Adopción. El juego interminable.

IV - Desarrollo del Proceso en la Familia Estéril-Funcional

1) Ante la desconfirmación por no poder ser Madre-Padre salir del campo, buscar la solución desde afuera. Cambiar las reglas. Adopción como cambio 2.

2) La estructuración del Adoptado en una Familia Adoptiva. Las estructuras. Límites intergeneracionales. Las Alianzas parentales.

V - Desarrollo del Proceso Social

1) El abandono, la esterilidad y la Adopción, como problemas del Sistema Familiar y no como problemas individuales.

2) La PROTECCIÓN DEL MENOR como forma de encarar el problema como Tutela y no como Adopción.

3) La CAUSALIDAD LINEAL en vez de CIRCULAR.

4) TUTELA como problema INDIVIDUAL Vs. ADOPCIÓN como fenómeno propio del SISTEMA FAMILIAR.

5) Legislación y organización social, instituciones, etc. con enfoques lineales no sistémicos que privilegian al niño y a la Adopción

* Aguado 2205, (1646) San Fernando, Prov. de Buenos Aires.

Filantropica, actuando como dueños del niño, en coalición con éste, en contra de los padres adoptantes. (Coalición interestructural).

SUMMARY

I - Hypothesis

1 - The parents that adopt, the institution which collaborate, the organisms that legislate and the Professionals efforts that we had intended to advise, to prevent, cure and help in this problem they based in the conventional, lineal, epistemology (causes-effect) and in the Individual Psychology.

2 - This concept doesn't reach to understand the Family System's phenomena, only explained by a Circular Epistemology and it is more and different to the summing up of the individual psychologies of its components.

3 - This conception favours a false Adoption process, ocused in the Protection of the minor that is abandoned which is more a "guardian ship" process than a real adoption.

4 - The real adoption is the formation and integration of a new family system, a novelty alternative between the answers of the system, skipping a level, change 2 - instead of a solution as a repair or a prothesis, at the same level, change 1 - that constitutes "more of the same".

5 - When, inside a Family context, there is a false adoption, a "guardian ship process", there is an incongruency and makes a pathological paradox in the system.

6 - The adopted child's pathology must be understood as a part of a Disfunctional Family System.

7 - Also the incongruency between the Social Context, of filantropic Characteristics, and the Family that tries to "adopt" a child is a disfunctionality cause.

8 - To protect the family is to protect the child, instead, if we protect only the child it is not help to the family, and, consequently, it goes against them, because the hierarchies of the family system change and create a double bind process because of the incongruency of leveling the "class" —the family, with the "member"— the child.

II - Systemic Concepts About Functional Family

1 - Homeostasis - Rules - Contract - Changes.

2 - Constants and Changeables - Belief Systems - Family Myths - The Family Life Cycle - Not Familiar Relations - The Origin Families.

3 - Morphogenesis y Morphostasis.

4 - Structures and Hierarchies - Intergenerational Boundaries.

5 - Joinings.

III - Development of the Process in the Disfunctional Sterile Family

1 - The problem: To want to be mother or father - The complementary identity - The disconfirmation about the sterility.

2 - The adopted as change 1 or "more than the same" or "were the solution is the problem". The adopted as "prothesis". The adoption as a maniac reparation. The colution.

3 - The identification of the adopted as a patient. The intergenerational coalitions. The "protector protected". The rupture of the parental joint. The philanthropic adoption. The family myth of the adoption. The everlasting game.

IV - Development of the Process in the Functional Sterile Family

1 - In front of "the problem" (III-1) leave the field and look for a solution outside to change the rules. Adoption as change 2.

2 - The structuration of the adopted in an adoptive family.

V - Development of the Pathological Social Process

1 - The abandoned, the sterility and the adoption as a family system problem and not as an individual problem.

2 - The minor protection as a way to front the problem as a guardian ship an not as an adoption.

3 - The lineal causality instead of circular causality.

4 - Guardian ship as an individual problem Vs adoption as a family system phenomena.

5 - Legislation and social organization, institutions, etc. with lineal not systemics, focuses, that privileged the child and the philanthropic adoption - acting as owners of the child, in colition with him against the adoptive parents.

PROPUESTA DE UN ESQUEMA PSICOANALÍTICO PARA EL ABORDAJE DE UNA TERAPIA FAMILIAR

Dr. ISIDORO GURMAN* y Lic. ESTELA S. DE GURMAN*

Se tratará de explicitar aquellos conceptos del esquema referencial freudiano sobre los que nos apoyamos, para abordar clínicamente a la familia.

Se trabajará en dos momentos: 1) exposición y debate sobre aquellos puntos de la teoría que nos parecen relevantes; 2) lectura y trabajo sobre material clínico ilustrativo.

Nota: Sugerimos a los participantes la lectura de los siguientes trabajos de Freud: Psicoterapia de la histeria, Cap. III; Tótem y tabú; Moisés y la religión monoteísta; La novela familiar del neurótico; Psicología de las masas y análisis del Yo; Análisis de la fobia de un niño de 5 años (Caso Juanito).

SUMMARY

We will attempt to make explicit those concepts of the Freudian relational schema we rely upon in order to get a clinical approach to the family.

The workshop will consist of two parts:

1) Exposition and discussion about those points of the theory which are considered to be relevant;

2) Reading and working on illustrative clinical material.

Note: We suggest that the participants read the following works by Freud:

- The Psychotherapy of Hysteria (ch. 3)
- Totem and Taboo
- Moses and Monotheism
- The Familiar Romance of the Neurotic
- Mass Psychology and Ego-Analysis
- Analysis of Phobia in a Five-Year-Old Boy (Little Hans Case).

TERAPIA FAMILIAR - ENFOQUE VIRGINIA SATIR

Lic. NORMA BERDICHEVSKY* y Lic. EDIT GROSS**

Luego de exponer una breve reseña de la autora (que fue la primera directora de entrenamiento en el instituto de Salem y que actualmente es conferencista y consultora en terapia familiar y relaciones interpersonales, etc.), pasamos a definir maduración y crecimiento, ya que Satir no da importancia a la "enfermedad" sino a las relaciones interpersonales que inhiben el crecimiento y desarrollo.

Se definió maduración como una secuencia de experiencias de aprendizaje dentro de una familia, que capacita para efectuar elecciones y decisiones basadas en percepciones adecuadas sobre sí mismo, los demás y el contexto.

Se definió Homeostasis Familiar como un proceso a través del cual la familia equilibra las fuerzas que existen dentro de sí misma para lograr unidad y orden funcional, es por eso que toma en cuenta los conceptos de autoestima, comunicación, reglas, sistema abierto y cerrado.

De acuerdo al funcionamiento de estos elementos, la comunicación ayuda al crecimiento o inhibe el desarrollo si es indirecta, confusa e incongruente.

Se desarrolló el tema de los roles básicos en una familia disfuncional: acusador, aplacador, superrazonador e irrelevante. En forma práctica se realizó un ejercicio con cuatro integrantes que alternaron en distintos roles simulando una familia. Luego la experiencia fue comentada.

Otros ejercicio vivencial de comunicación fue el de "estar en contacto" a diferentes distancias y posturas corporales, luego fue comentado.

Se relacionó la experiencia con los conceptos de diferenciación y simbiosis.

Finalizó el workshop con un intercambio de ideas y comentarios sobre las experiencias realizadas.

SUMMARY

At the beginning a brief summary of the author (who was the first director of training in the Esalem Institute and who is nowadays a lecturer and a consultant in Family Therapy and Interpersonal relationship etc.) was done.

We define maturation and growth as Satir doesn't give importance to sickness but to interpersonal relationship that inhibit growth and development.

Maturation was defined as the sequences of learning experiences in

* Rosario 552, 12, "C", (1424) Buenos Aires.

** Gorostiaga 1731, (1426) Buenos Aires

* Viamonte 2660, 7º, "A", (1056) Buenos Aires.

a family that permit the elections and decisions based on the adequate perceptions on ourselves, the others and the context.

Familiar homeostasis was defined as a process through which the family equilibrates the forces that exist inside itself to reach unity and functional order. That's why the author considers the concepts of self-confidence-communication, rules, opened and closed system.

According to the functioning of these elements, communication helps for growth or inhibits development if it is indirect, confusing or incongruent.

The subjects of Basic Roles in a disfunctional family were exposed: accuser, appeaser, reasoner, irrelevant. In a practical way exercises with four integrants who alternated different roles of a simulated family were done. Later this experience was commented.

Another exercise about vivential communication was the one of "Being in Contact" in different distances and postural ways.

The experience was related with the concepts of differentiation and Symbiosis.

The workshop ended with an exchange of ideas and comments on the experiences done.

ACERCA DE LA PREDICCIÓN EN LA TERAPIA FAMILIAR

Lic. ESTRELLA JOSELEVICH* y Lic. HUGO HIRSCH**

En este trabajo pretendemos mostrar que la formulación de predicciones constituye una constante del trabajo terapéutico, como así también de qué manera la realización conciente y sistemática de esta tarea mejora la calidad del proceso terapéutico y —a mediano plazo— la calidad del terapeuta como tal. Esta tarea nos estimula en la búsqueda de alternativas en la estrategia clínica.

Hacemos un acercamiento teórico a la naturaleza de la predicción en el terreno de la terapia familiar, su valor, interés, utilidad, limitaciones, contraindicaciones.

A continuación tratamos de mostrar el uso clínico de las predicciones a partir de algunos ejemplos extraídos de nuestra práctica clínica.

SUMMARY

In this paper, we intend to show that the formulation of predictions is a constant of the therapeutical work, as well as showing how the conscious and systematic performing of this task improves the quality of the therapeutical process and —in the middle term— the quality of the therapist as such. This task encourages us to look for alternatives in the clinical strategy.

We make a theoretical approach to the nature of prediction in the field of family therapy, its value, interest, usefulness, limitations, contraindications.

Subsequently, we attempt to show the clinical use of predictions through some examples got from our clinical practice.

* Obligado 2357, (1428) Buenos Aires.

** Av. Libertador 5881, 1° "D", (1428) Buenos Aires.

SOBRE LA ATENCION DE FAMILIAS EN CRISIS POR ENFERMEDAD CORONARIA Y EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO

Dr. LUIS JAIT* y Lic. SILVIA GALAY**

Desde una perspectiva teórica comunicacional, interpersonal y sistémica, nos acercamos a una familia en crisis, por la irrupción de un síntoma coronario.

La crisis, en tanto irruptiva, es un fenómeno inesperado, irreversible; de aquí en adelante: "Ya no soy el que era" "Ya no es como antes"

En un intento de establecer un isomorfismo entre crisis coronaria-crisis familiar, nos encontramos con que ambos sistemas encuentran áreas bloqueadas; y en ambos, son necesarias respuestas vicariantes que den cuenta de la pérdida de la función.

La familia en tanto estructura social: con límites, jerarquías y funciones, sus intercambios entre sí y con el afuera, en el devenir del tiempo se ha consolidado en una organización regida por reglas, que la crisis actual cuestiona, tanto en lo que refiere al "modelo de vida" como a la posibilidad de dar cuenta de la nueva situación.

La patología orgánica es siempre una presencia más o menos "esperable". La específicamente coronaria, conlleva una presunción de ocurrencia con características particulares:

A - Temer a la muerte: de muy difícil control.

B - Una etiopatogenia y una terapéutica ligada a factores emocionales. (Las reacciones vagotónicas y simpaticotónicas constituyen la esencia misma de los componentes físicos de los síndromes afectivos.)

C - Antecedentes históricos referidos al síntoma en familia.

D - Las reacciones vasomotoras: empalidecer, rubor, son respuestas en situaciones inhibitorias ante la imposibilidad de una respuesta motriz funcional.

E - Este síntoma tiene gran poder de convocatoria por lo ya mencionado.

Desde nuestra lectura, intentaremos hacer un desarrollo que tenga en cuenta: Familia-Sistema-Tratamiento Cardiológico y que incluya una propuesta de intervención terapéutica.

Relación: Familia - Paciente - Sistema

1 - Se instaura una nueva relación entre *esfuerzo y demandas*; la irrupción del síntoma requiere una nueva claridad relacional. En tanto

el paciente se encuentra en el acmé de su propia producción, con roles que implican alto nivel de compromiso: económico-social, jerárquico, afectivo, (cabeza de familia), el síntoma constituye una amenaza de pérdida de la estructura familiar.

Las otras variables a tener en cuenta son:

2 - Los factores de riesgo: tabaquismo, stress, alimentación, hábitos de vida, etc., obviamente definidos por la prescripción médica, que mutuamente se incluye con el punto 1 de nuevos esfuerzos y nuevas demandas. Será el eje organizador de nuestra búsqueda de información y de nuestras intervenciones.

Diseñar una hipótesis de abordaje a estas familias implica una lectura minuciosa de la estructura:

A - Paciente identificado - víctima - polo débil.

B - Familia - intermediaria entre A y C.

C - Médico tratante - polo valorizado y necesitado como omnipotente.

Nuestra inserción frente a esta estructura:

A - La posibilidad de operar a nivel de interconsulta.

B - La actuación directa, a través de la atención de la familia y el paciente.

En todo desempeño, un eje referencial siempre presente, es el estado clínico del paciente y las indicaciones referentes a tratamiento y factores de riesgo prescriptas.

Modelo Propuesto

Hipótesis: el bloqueo coronario, en tanto bloqueo disfuncional del sistema circulatorio, es un input al sistema familiar, que genera una respuesta isomórfica. En ambos sistemas son necesarios canales supletorios que den cuenta de la pérdida de función; en función de esto hablamos de familias "cardiopáticas".

Modelo teórico: En un intento de conceptualizar la conducta sintomática en términos comunicacionales, hablamos del síntoma coronario como *unidad de mensaje no verbal*: el paciente identificado evidencia estados y los demás manifiestan actividades.

Intervenciones:

a - *cuestionario*: elaborado "ad-hoc" que pretende por un lado, procurarnos información sobre: estructura de la familia, en sus pautas relacionales históricas (familias de origen), actuales; sus relaciones con el síntoma y sus expectativas; con la posibilidad de abstraer el patrón relacional con que tienden a estructurarse durante las crisis.

Por el otro lado, la confección individual del cuestionario pretende posibilitar una instancia autorreflexiva y discriminada acerca de la situación.

b - *intervenciones de campo*: deberán dar cuenta de dos situaciones:

— La gravedad del síntoma, evaluada lógicamente por el cardiólogo.

— Factores de riesgo de cada familia.

* Laprida 1088, 6° "A", (1425) Buenos Aires.

** Cnel. Díaz 2521, 8° "B", (1425) Buenos Aires.

SUMMARY

We approach a family in crisis due to the irruption of a coronary symptom, from a communicational, interpersonal and systematic perspective.

Being irruptive, the crisis is an unexpected, irreversible phenomenon. From now on: "I am no longer who I used to be". "It's no longer what it used to be".

This work does not intend to establish an etio-pathogenesis. We do try to approach an understanding of the family and its symptoms, establishing an isomorphism between coronary-crisis and family crisis and we find that in both systems there are blocked areas and both need suppletory responses to account for the loss of a function.

The family, as a social structure, with limits, hierarchies and functions, with interchanges among its members as well as with the outside world, has become, in time, an organization governed by rules which are questioned in the present crisis, in what regards the "life model", as well as the possibility of accounting for the new situation.

Operative Proposal

Our intervention starts, once the cardiological diagnosis has been given, when a certain level of insufficiency has been indicated to the patient and a plus of sufficiency to his wife.

The crisis has given in; he is no longer completely supported by the medical structure as the one deciding and executing things. This structure will have to be assimilated by the family. There will be nursing functions to be performed by the wife; the daily vigilant watching will be in charge of others, including the patient himself, who will replace doctors.

There is a transferring of roles which will affect all family relations from now on. A new code, learnt from doctors, will start to function as from this crisis. The information given by the medical group is taken in by the family group, which will try to assimilate it to their usual rules of behavior. Here we have to obtain information directly from the doctor in charge, as the information given by the doctor is usually not the same as the one heard by the patient and his family, when they are displaced by desperation. The information given must be adequated to the possibilities each family shows; it must be progressive and without counterindications or gaps.

The way these new demands, including information, are recorded, has to do with the family's relational resources and the perception of the present structure in function of its history.

CONSIDERACIONES ACERCA DEL ROL DE LA MUJER EN LA FAMILIA

Coordinadora: Lic. MARIA CRISTINA VILA DE GERLIC*

Sintetizadora: Lic. NOEMI MENADEBA DE CHEBAR**

La coordinadora comienza presentando cómo se fue delineando su pensamiento respecto a los roles del hombre y de la mujer en la familia, a partir de su trabajo clínico en Psicología de la Mujer. Plantea que considerar el rol de la mujer en la familia, implica necesariamente considerar el hombre en la misma y que esto se hará en el workshop. Aclara que la terminología que utilizará se referirá a hombre y mujer, por cuanto los términos masculino y femenino llevan implícitos estereotipos culturales. Propone al grupo, partir de la propia experiencia de vida, en la familia respectiva y en el vínculo con la madre, a fin de integrar estas vivencias y reflexiones con el trabajo conceptual que se realizará después. Entrega a los participantes un ejercicio con consignas escritas que éstos responderán por escrito y anónimamente. Comenta sus propias vivencias en las sucesivas oportunidades en que ella lo realizó. Con interés y atención; así también con muestras de cierta movilización todos se ponen a la tarea.. Terminado el ejercicio se intercambian las vivencias de los participantes. El trabajo es considerado por el grupo como muy interesante en tanto en general se revalorizan aspectos de la relación con la madre: se encuentran más aspectos comunes entre el que escribe y su madre de lo que pensaban. Se recalca también sentimientos de ternura y placer al realizar el ejercicio.

A continuación la coordinadora presenta el concepto de mundo en cambio y el hecho de que mujeres y hombres están ejerciendo roles transicionales. Expone luego una reseña acerca del pensamiento teórico referido al grupo familiar en las décadas del 50, 60, 70 y 80.

Propone para investigar en el trabajo clínico con las familias cinco áreas fundamentales. Estas áreas son:

- a) Provisión económica
- b) Cuidado de los hijos
- c) Tareas domésticas
- d) Apoyo interpersonal
- e) Toma de decisiones

Someramente se señalan las características generales en cuanto a la concepción de la familia en las distintas épocas hasta llegar a la década de 1980 en donde aparece generalmente para cada miembro de la pareja la necesidad de incorporar en segundo rol y trabajar dentro de la familia considerando la sincronización de los roles dobles para el hombre y la mujer. Los dos roles tienen que ver con un mayor

* Beruti 3032, 6°, "16", (1425) Buenos Aires.

** Canning 3278, 8°, (1425) Buenos Aires.

acercamiento del hombre a la familia y con la inclusión de la mujer en la vida laboral. Se hace referencia también a familias distintas de las nucleares; ejemplo: familias constituídas por padres separados, vueltos a casar; hijos adoptivos, etc.

Se toman en cuenta cuáles son las consecuencias de los roles transicionales en la familia nuclear. Para ello se esclarece el término de parejas simétricas: las que pueden funcionar con dependencia y autonomía. Los conceptos teóricos finales conciernen a las consecuencias interpersonales, en la propia familia, la familia de origen, y los intrapsíquicos (por el hecho de vivir con roles transicionales). Se invita a los presentes a reflexionar sobre la importancia de los valores del terapeuta en esta temática. Se ilustra esto con casos clínicos abordados por la coordinadora y por los miembros del grupo.

SUMMARY

The work is started by using an experiential method with the inclusion of one own's family. Afterwards, the general characteristics of the conception of family are revised. This is done in the different epochs up to the decade of 1980 when, for each member of the couple, a second role appears. (This second role for the woman is the one of work outside her home, and for the man, it is a different insertion in the family).

The marriage and family therapist's task would take into account the synchronization of those dual roles, called transitional roles.

The concept of symetric couple is established as: the one in which the woman and the man can function alternating dependance an independance in their dual roles.

The consequences are pointed out: the interpersonal one in one own's family and in one's family of origin; and the intrapsychic consequences just for the fact of living these transitional roles.

The importance of the therapist's values are considered in relation to this topic. The coordinator and members of the group illustrate the subject with clinical cases.

HACIA UNA REDEFINICION DE LA FEMINEIDAD

Dra. ROSA I. BECERRA DE BONFANTI¹, Arq. SARA COHEN DE MELILLO², Lic. LILIAN FISCHER DE ARROYO³, Lic. MARIA CRISTINA FLOREZ MONROY⁴, Lic. DIANA LIJALAD DE BRUZZO IRAOLA⁵ y Prof. JUANA LOIZAGA⁶

Area: La mujer y la familia. A quienes va dirigido: A los asistentes del Congreso, hombres y mujeres, interesados en reflexionar sobre estos temas.

Metodología de trabajo y contenido: Presentamos video tapes y se dramatizaron situaciones representativas de la mujer en la familia. Este material se discutió en pequeños grupos, y se realizó un debate posterior con la participación de todos los asistentes y las autoras.

De este modo nos propusimos reflexionar acerca de aquello que es propio y característico de la mujer en su vinculación con el hombre y la familia actual, e intentamos redefinir aspectos preponderantes de la femineidad relacionados con la sexualidad, la pareja, la maternidad, el trabajo y la creatividad.

SUMMARY

This workshop dealt about woman and family, and it was oriented to the assistants, men and women, concerned on this matters.

Some films were showed and representative situations about women within family were acted. All this material was set forth to discussion among assistants and authors.

Therefore our purposal was to think about the peculiarity of women's binds with men and today's family, and we attempted to redefine certain important questions about feminality as sexuality, couple, work and creativeness.

1 Gorostiaga 1731, (1426) Buenos Aires.

2 Cerviño 3931, (1425) Buenos Aires.

3 Andonaegui 2961, (1431), Buenos Aires.

4 Arenales 1954, 1º, (1124) Buenos Aires.

5 Gorostiaga 1731, (1426) Buenos Aires.

6 Soldado de la Independencia 1086, (1426) Buenos Aires.

ABORDAJE DE LA CRISIS FAMILIAR ANTE EL EMBARAZO E INTEGRACION DE UN NUEVO MIEMBRO DE LA FAMILIA (ESTRATEGIAS DESDE UN EQUIPO DE PSICOPREVENCIÓN)

Coordinadora: Lic. HILDA SCHUPACK*

Sintetizadora: Lic. BEATRIZ DAVIDSON**

Se trabajó en forma de grupo operativo. Se mostró la forma de trabajo de un equipo de psicoprevención para la maternidad-paternidad.

Un equipo constituido por obstetra, un neonatólogo, una obstétrica y una psicóloga con la intención de abordar las distintas áreas que afectan a una pareja que espera un hijo. Partimos de la hipótesis de que la llegada de un nuevo integrante a la pareja o a la familia con hijos produce una serie de cambios ante los cuales deben estar preparados cada uno de los integrantes en forma individual y como pareja, para que la situación sea una crisis abordable y no una catástrofe que produzca sucesos dramáticos en la madre, en el padre o en el vínculo.

Tratar de evitar intensas depresiones post-parto o rupturas de la pareja en forma manifiesta, como separaciones reales o en forma más velada como separaciones afectivas, intentando que cada uno pueda asumir y disfrutar su rol, el de madre, el de padre sin rivalidades entre ellos, y manteniendo el vínculo erótico.

Se abordaron los temas que habitualmente se tratan en los grupos de información a cargo de los profesionales médicos y de la obstetra y en los grupos de orientación a cargo de la psicóloga.

Así como en las clases informativas se tiene un temario, en las reuniones de las parejas con la psicóloga se trabaja con temas libres y sin orden determinado pero con la coordinación atenta a interpretar los temas como expresión de las ansiedades y defensas relacionadas con el embarazo, parto, puerperio, lactancia y crianza en general, desde un abordaje grupal pero también comprendidos desde la historia personal de cada pareja.

Se realiza una lectura psicoanalítica pero no se verbaliza la transferencia, se hacen señalamientos y también se da información si es necesaria.

También en el workshop se respondieron preguntas de los participantes en cuanto a actitudes del equipo ante situaciones especiales como malformaciones, cáncer en el embarazo y madres solas.

Por último se mostró material gráfico que se administra a las parejas para detectar actitudes y posibilidades ante el parto, lactancia y el vínculo de la pareja.

SUMMARY

It was shown the way working of a team for psychoprevention for maternity-paternity formed by an obstetrician, a neonatologist a female obstetrician and a female psychologist.

The hypothesis for team working is based in that the arriving of a new integrant to a couple or a family, introduces a serie of changes on different areas, in front of which is convinient to be prepared.

It is intended to help each of both members of the couple assuming and enjoying his/her role, the one of being a father and the one of being mother without rivalities between them.

In order to do that information classes in charge of medicine majoring professionals and groups are formed with the future parents in charge of the psychologist of the team, where characteristic anxieties an defended of this moment are worked out, considering the personal history of each one.

It is used too, graphic matherial that is given to the patients for detecting possibilities in front of the delivery lactation and couple bond.

* Mario Bravo 457, 9º, "B", (1175) Buenos Aires.

** Angel Gallardo 563, 8º, (1405) Buenos Aires.

LAS ETAPAS DE LA VIDA FAMILIAR

Lic. ROSALIA BIKEL*

La familia es un sistema organizado cuyos miembros, unidos por relaciones de alianza y consanguinidad, sustentan un modo peculiar y compartido de leer y ordenar la realidad, para lo cual utilizan información de adentro y de afuera del sistema y la experiencia actual e histórica de sus miembros. Los acuerdos relacionales (reglas) son las conductas adecuadas para mantenerlo y perpetuarlo.

Como sistema de relaciones abierto, la familia está expuesta, por una parte, a una interacción permanente con otros sistemas y, por otra, a las exigencias provenientes de su propio desarrollo.

Así como el parámetro contextual influye y nos informa sobre la posibilidad de una familia de incorporar información proveniente del entorno, el parámetro temporal nos proporciona elementos para acceder a la forma como el sistema se adapta a los cambios provenientes de su propia evolución.

Del adecuado interjuego entre la tendencia a la estabilidad y de la tendencia al cambio, dependerá la posibilidad de una familia de acceder al "crecimiento", entendido éste como "crecimiento sistémico", observable en la complejización de las relaciones, en el incremento de la división en subsistemas y sub-subsistemas y en la diferenciación de funciones, tanto como "crecimiento individual" de los miembros del sistema, observable éste en el desarrollo, por parte de cada individuo, de nuevas relaciones dentro del sistema y fuera de él, que le permiten el desenvolvimiento de una mayor cantidad de áreas vitales.

En todo proceso de crecimiento familiar, y más precisamente en el cambio de una etapa a otra, lo que debe renegociarse es tanto el sistema de creencias compartido como las reglas que lo mantienen, unidos ambos términos en un proceso de retroalimentación continua.

Existen tres tipos de vínculos posibles en una familia: de alianza, paternofiliales y fraternos, que se juegan en la convivencia cotidiana a través de un intercambio constante de palabras, de objetos, de afectos.

El proceso de transformación de las reglas de una familia es constante y permanente, si bien hay ciertos momentos críticos, que marcan cambios muy notorios. Si los cambios que se producen en el sistema conducen a una transición gradual desde la totalidad a la sumatividad, se dice que el sistema sufre una "segregación progresiva". La tendencia tiene que ver con el crecimiento y se manifiesta en el incremento de la división en subsistemas de diferenciación de funciones. El proceso inverso, en el que hay un cambio hacia la totalidad, se denomina "sistematización progresiva". Consiste en el fortalecimiento de relaciones pre-existentes entre las partes, el desarrollo entre partes

previamente no relacionadas, la gradual adición de partes y relaciones a un sistema o alguna combinación de estos cambios.

Estos dos procesos ocurren simultáneamente y continúan indefinidamente para que el sistema siga existiendo como tal, aunque no siempre actúan en la misma proporción.

El momento de transición de una etapa a otra es un momento de crisis, en el cual los miembros de la familia tienen la clara percepción de que las reglas con que se venían manejando ya no sirven y que aún no han surgido de ellos, otras nuevas que las reemplacen.

A partir de las nuevas propuestas relacionales comenzará el camino hacia la sistematización progresiva de esas reglas, que resultarán satisfactorias y funcionales si no entran en contradicción con el sistema de creencias compartido por la familia. Del interjuego dialéctico entre la generación de nuevas reglas y la flexibilidad del sistema de creencias, dependerá el destino de funcionalidad de esa familia.

SUMMARY

The family is an organized system whose members, bound by relations of alliance and consanguinity, maintain a peculiar way of reading and ordering the reality shared by all of them, for which they use information from inside and outside the system and from their present and historical experience.

The possibility for a family to attain 'growth' — this being understood as 'systematic growth' as well as 'individual growth' of the members of the system, will depend on the adequate interplay between the tendencies towards the stability and the change.

The transformation process of the family rules is constant and permanent, though there are some critical moments which indicate very noticeable changes.

The fate of the functionality of that family will depend on the dialectic interplay between the generation of new rules and the flexibility of the system of beliefs.

* Cerviño 3926, 10º "A", (1425) Buenos Aires.

SOBRE EL ANALISIS FAMILIAR

Dr. RAFAEL SKIADARESSIS*

Hemos desarrollado, en base a lo que proponemos denominar "Análisis Familiar", una concepción de la estructura familiar. Para ello nos apoyamos en dos vertientes teóricas:

a) la Antropología Estructural según las ideas de Claude Levy-Strauss

b) el Psicoanálisis según las concepciones de Sigmund Freud y Jacques Lacan.

No podemos dejar de destacar que entre los puntos a) y b) antes mencionados, se sitúa el aporte de la Lingüística en la figura de Charles S. Pierce, Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson y otros.

Destacamos la Prohibición del Incesto como elemento princeps en lo que constituye para el ser humano el pasaje de la Naturaleza a la Cultura, produciendo en el medio social el hecho que los hombres intercambien mujeres y que en el seno de la familia la mujer intercambie falo por niño.

Así en el medio familiar la estructura permitirá tres tipos de relaciones: a) de consanguinidad, b) de filiación y c) de alianza; teniendo en cuenta para ello la inclusión de un cuarto término, es decir la función del avunculus (tío materno).

Pensamos de esta forma que la Ley que regula el funcionamiento de la estructura familiar hace que los miembros de la familia se posicionen ante ella, lo que determinaría la configuración de familias neuróticas, perversas o psicóticas.

SUMMARY

We have developed a concept of family structure based on the "family analysis" considering two theoretical concepts:

a) The Structural Anthropology according to Claude Levy-Strauss ideas;

b) The Psychoanalysis according to the Sigmund Freud and Jacques Lacan concepts.

We can't help emphasizing between a) and b) the important contribution of Linguistics in the person of Charles S. Pierce, Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson et al.

We want to emphasize the incest prohibition as a main element in the human being passage from the nature to the culture, producing into the society the fact that men interchange women and into the family the woman interchanges phallus by child.

Into the family group the structure will admit three types of

relations: a) of consanguinity; b) of filiation and c) of alliance; including a fourth one: the avunculus function.

We think that the rule of action that regulates the functioning of the family structure makes that the members of the family embrace a position in front of it, determining the configuration of neurotic, perverse or psychotic families.

*Neuquén 2638, (1406) Buenos Aires.

TERAPIA FAMILIAR CON ADOLESCENTES

Presentación de un caso (familia simulada con colaboración de los asistentes) tratado con el modelo de Terapia Breve del M.R.I. de PALO ALTO (California)

Lic. DORA ABADI*, Lic. SUSANA B. DE BREYTER**, Dra. ANA GILLER*** y Lic. NORMA ROSSO****.

Algunos Fundamentos Básicos de este Enfoque

Es una terapia estratégica, orientada hacia el síntoma.

Se considera al síntoma o problema que los pacientes traen a la consulta como dificultades situacionales entre personas o problemas de interacción.

Todas las transiciones dentro del ciclo vital de una familia son potencialmente fuente de "dificultades", las que mal manejadas podrán convertirse en "problemas" o "síntomas". Esto dará lugar a intentos de solución no exitosos, los que, al repetirse formarán un "círculo vicioso", donde, las soluciones intentadas terminarán convirtiéndose en el *verdadero problema*.

Para resolver esto se requiere un patrón de comportamiento, capaz de romper ese "círculo vicioso" de conductas *perpetuadoras* del problema.

Se utilizan, para esto, intervenciones estratégicas, que a veces parecen ilógicas pero que están destinadas a promover cambios en el sistema.

Por pequeña que parezca la modificación, ésta podrá llevar al sistema familiar a lograr cambios mayores y contribuir así a la formación de un "círculo beneficioso" que irá intensificándose del mismo modo que antes lo hiciera el "círculo vicioso".

Para planificar las intervenciones estratégicas, el Terapeuta tiene muy en cuenta, lo que los autores denominan "*Lenguaje del paciente*" y que incluye sus creencias, valores, modos de comportarse, etc.

Caso

Familia compuesta por: abuelo materno, 70 años. Madre, 47 años. Hija adolescente, 16 años.

El motivo de consulta: son las peleas continuas con la hija adolescente, a la que, tanto el abuelo, como la madre, acusan de rebeldía, desobediencia, falta de respeto por sus mayores, etc., etc.

En el momento de la consulta se dan simultáneamente 3 situaciones vitales muy complejas: 1) reciente viudez del abuelo, quien a raíz

de esto vino a vivir a la Capital a casa de su hija y su nieta (la nieta había sido criada por estos abuelos, lejos de su madre, con la que fue enviada a vivir, hace muy poco al morir su abuela).

2) La adolescencia de la joven, conflictiva naturalmente como etapa vital y agravada por la muerte de su abuela-madre, como también por el traslado a la Capital con la consiguiente pérdida de sus grupos de pertenencia anteriores y además, la nueva relación con su madre.

3) Las dificultades de la madre para aceptar la evidencia del crecimiento de su hija, de golpe, además de la pérdida de su propia madre y la nueva convivencia con su padre, viudo, anciano y su hija adolescente.

Todos los intentos que hicieron, tanto el abuelo como la madre por solucionar esta rebeldía adolescente (premios, castigos, sobornos, amenazas) lograron convertir una dificultad propia de una etapa de transición en un verdadero problema perpetuado a partir de las "soluciones intentadas" y convertido así en el *síntoma* por el cual consultan "Peleas constantes con la adolescente".

Surge desde la primera entrevista que el "lenguaje" de esta familia es el "negativismo" y que, los conflictos son básicamente verbales. Teniendo esto en cuenta el Terapeuta supone que responderán con el mismo negativismo a sus prescripciones y decide utilizar la estrategia denominada "Prescripción del Síntoma".

A cada miembro le pedirá que siga peleando como hasta ahora, pues por el momento no están capacitados para otro tipo de interacción entre ellos.

Esta intervención es muy impactante, pues permite a los miembros de la familia por primera vez experimentar una sensación de *poder* al elegir *no pelear*; además derrotan tanto al Terapeuta como al otro miembro de la familia simultáneamente al rehusarse a pelear.

Los miembros de la familia terminan uniéndose entre ellos para oponerse a seguir las prescripciones del Terapeuta pues, no desean "seguir peleando" y así deciden dar por terminado el tratamiento, porque ya no lo necesitan ya que ahora no pelean casi nunca.

Se hicieron varias entrevistas de seguimiento donde se vio que las modificaciones continuaban.

SUMMARY

For some families who are destroying themselves by fighting, the Psychotherapist must find the Technique to stop fighting.

In this case we think that it would be a sufficient goal simply to change the combative behavior that was destroying the family.

The employ of the "Symptom prescription" intervention, was so useful in this case, because when we work with a family system in which the predominant problem is verbal conflict, the system usually communicates in the language of "*negativism*".

Knowing that the Therapist asked the family members to do

* La Pampa 1730, (1428) Buenos Aires.

** J. E. Uriburu 1227, (1114) Buenos Aires.

*** Vte. López 2251, (1128) Buenos Aires.

**** Arenales 2176, (1124) Buenos Aires.

homework assignments that will be useful to them if they do them, but, even more useful if they do not; that is if the members "negate" the Therapist request as they do each other's.

Each family member is told: "Go ahead and allow yourself to get sucked into the fights".

This intervention is particularly powerful because it permits the family members for the first time to experience being powerful by choosing *not to fight*, and, the opportunity to defeat both, a family member and the therapist simultaneously by refusing to fight is almost irresistible.

TERAPIA FAMILIAR CON NIÑOS

Lic. CELIA Z. DE GALPERIN*

Durante el desarrollo del workshop se hizo una breve exposición teórica previa acerca de los indicadores de funcionalidad y disfuncionalidad del grupo familiar con niños pequeños y la importancia y utilidad de su detección diagnóstica en la elaboración de la estrategia y trabajo terapéuticos.

Luego se presentó un caso clínico; se trabajó con una familia simulada para el trabajo e intercambio grupal.

Se realizó una síntesis final.

SUMMARY

During the development of the workshop a previous brief theoretical exposition was made about the indicators of the functional and dysfunctional characters of the family group having young children and the importance and usefulness of their diagnostic detection in the working up of the therapeutic strategy and work.

Then a clinical case was presented or work with a simulated family was carried out for the group work and interchange.

A final synthesis was made.

* Lafinur 2932, 8º, "A", (1425) Buenos Aires.

GRUPO DE FAMILIARES MUJERES EN UNA COMUNIDAD TERAPÉUTICA

Lic. SUSANA BARILARI*, Dra. ROSALINDA GUSBERTI** y
Dra. LYDIA RAVASCHINO***.

Terapeutas del equipo que coordina el Dr. David Libedinsky, de la Comunidad Terapéutica de la Clínica Psiquiátrica que dirige el Dr. Jorge García Badaracco.

El objetivo de este trabajo es mostrar una experiencia clínica que se lleva a cabo en una Comunidad Terapéutica, que trabaja fundamentalmente con pacientes psicóticos o gravemente perturbados y sus familias.

En esta Comunidad Terapéutica, la familia está permanentemente incluida en los diversos espacios terapéuticos que se implementan, acompañando así el proceso terapéutico del paciente designado. "De otra manera, los tratamientos se estancan, surgen situaciones incontralables y los pacientes aparecen como incurables." (Dr. Jorge García Badaracco)

Contamos con grupos multifamiliares donde se reúnen pacientes y familiares en distintos momentos del proceso terapéutico; es decir son grupos abiertos, lo que da lugar a que haya familias y pacientes que al tener más tiempo de inclusión en la Institución, pueden continentar mejor a otras recién integradas y por lo tanto con gran monto de angustia, ansiedad e inexperiencia. Debido a la diversidad de temas que surgen, y a las urgencias impostergables en muchos momentos, detectamos que algunos integrantes de estos grupos, quedaban sin espacio ni tiempo para participar más comprometidamente. Ante los reclamos imperiosos de estos familiares, especialmente madres, que cargadas de ansiedad, retenían a los terapeutas en los pasillos reclamando soluciones mágicas; las terapeutas mujeres del equipo, desde nuestra identidad femenina, identificándonos con esta función de madres, hijas, esposas, etc., muy necesitadas de ser oídas, pensamos en la posibilidad de crear para ellas, un lugar complementario al ya existente para trabajar exclusivamente con las familiares mujeres de este grupo.

La propuesta de trabajo fue pensada con los siguientes ítems:

1. Desgaste que produce el acompañamiento a pacientes gravemente perturbados.
2. Culpa por enfermarlos.
3. Culpa por querer abandonarlos.
4. Postergaciones de sí mismo y la creciente agresividad que esto genera.
5. Las propias carencias personales.
6. Cómo esto se pone en evidencia, a través del tratamiento del paciente designado.

* C. de la Paz 1314, 6° "B", (1426) Buenos Aires.

** Pereyra Lucena 2582, (1425) Buenos Aires.

*** Juncal 1945, 1°, "A", (1116) Buenos Aires.

7. Lo doloroso de todo este proceso.

Desde el trabajo grupal, surgió un nuevo ítem, que fue el poder hablar de su propia vida sin la presencia del paciente designado, que generalmente requiere todo para él. Las integrantes de este grupo son madres, hijas, hermanas, abuelas, tías, esposas, etc. No les era fácil discriminarse de la patología del familiar internado y poder hablar y pensar desde ellas y en ellas.

El grupo de mujeres, representó para las integrantes a las madres, hijas o hermanas que no tuvieron, o que sí tuvieron y no pudieron compartir con ellas sus necesidades básicas y que a través de esta experiencia aprendían a hacerlo. Con distinto material clínico, mostramos este proceso.

Las terapeutas autoras de esta experiencia, nos sorprendimos en las evaluaciones posteriores a la labor terapéutica, intercambiando experiencias y vivencias personales que eran emergentes del clima logrado en la reunión precedente. Esto nos brindó a nosotras mismas alivio, comprensión y acompañamiento, equivalente al que pudimos brindar a quienes requerían de nosotras lo que no pudieron tener en sus propias familias.

SUMMARY

In the "Therapeutical Community" in which we work with psychotic or deeply perturbed patients, we include the families so that they can accompany these patients on their processes.

These groups formed by the patients and their families are what is called "spaces" where they all meet at various stages in the process of evolution of the treatments.

These "multifamily groups" are conducted by a team made up of several therapist both male and female.

The female therapists suggest the creation of a new "space" to get the female members of these families together.

The objective of this project was to work on the following items:

1. The deterioration produced by living with a patient who is seriously ill.
2. The feeling of guilt for making them ill.
3. The feeling of guilt for wanting to get rid of them.
4. The permanent neglect of the relatives' needs and the increasing aggressiveness which this generates towards the patient.
5. What they feel they lack.
6. And how these feelings come up in the treatment of the patient.
7. The suffering caused by the process.

These groups were formed by the mothers, sisters, aunts, daughters, grandmothers, wives and former wives of the patients.

By means of team work, these women were able to start talking

about themselves, their needs and what they lacked. They had the possibility to share experiences, in an atmosphere of certain intimacy, with other mothers and sisters, thus enabling them to recreate bonds which were lost or did not exist.

This relationship established with a new "mother or sister" makes it possible now for them to continue their emotional development and to acquire a much deeper understanding of the difficulties in their own families.

TRATAMIENTO ESPECIFICO DE LA SEXUALIDAD EN EL MARCO DE LAS TERAPIAS DE PAREJA

Lic. LAURA S. CALDIZ* y Dr. LEON ROBERTO GINDIN*

Las aproximaciones tradicionales al tratamiento de las disfunciones sexuales consideraban a éstas como respondiendo a causas individuales. Si se descartaban las causas orgánicas, quedaban sólo sustentadas por las intrapsíquicas. Esto responde a una visión psicopatológica para la cual el contexto en que la disfunción se desarrollaba era descartado por no pertinente.

A medida que nuestro trabajo se fue desarrollando, vimos que este criterio era insostenible ya que las características de las disfunciones sexuales de origen psicológico son: su aparición circunstancial, su selectividad (alguien puede presentar síntomas con una persona y no con otras), la ansiedad anticipatoria ante una nueva compañía, problemas en la relación de pareja. También situaciones de duelo, pérdida en el campo laboral, jubilación, etc., pueden traer aparejados trastornos en la sexualidad.

Esto indica claramente la inscripción de las disfunciones sexuales de origen psicológico dentro de un contexto relacional, e implica tomar como patológicas ciertas modalidades de relación y no sólo a las personas intervinientes. Cada problema sexual es también a veces un problema de relación donde el síntoma aparece como una adaptación a un sistema de interacción.

Por lo tanto el abordaje terapéutico de las disfunciones sexuales supone el agrandar el campo de observación y pasar de la situación individual a la pareja y a veces a sistemas más amplios, con la finalidad de incluir el contexto en que la disfunción aparece.

Es sabido que las disfunciones sexuales abarcan a por lo menos el 50% de las parejas. A medida que la disfunción sexual aparece en la terapia familiar o de pareja, el terapeuta se ve plantado frente a una disyuntiva: ¿Puedo o no resolver yo solo este problema?

La sexualidad se comporta psicofisiológicamente. A veces no basta la mera comprensión o interpretación del síntoma en la diada. Es absolutamente necesario el conocimiento de la psicofisiología de la respuesta sexual y sus inadecuaciones para poder operar terapéuticamente en forma adecuada.

Por lo tanto el profesional que atienda las disfunciones sexuales debe estar específicamente formado y poder responder a los requerimientos que la patología sexual exige en cada caso. Es necesario entonces, un trabajo específico con un terapeuta sexual en adecuada comunión con el terapeuta familiar.

Nos proponemos en este workshop revisar:

- a) Sexualidad masculina.
- b) Sexualidad femenina.

* Darregueira 2247, 1º, "B", (1425) Buenos Aires.

- c) Mitos de la sexualidad.
- d) Sistemas sexuales de interacción de la pareja.
- e) Las terapias sexuales como una respuesta específica.
- f) El campo de las terapias sexuales en la terapia de pareja y familia.

SUMMARY

The traditional approaches to the treatment of sexual disfunctions used to consider them as obeying to individual causes, physiological or intrapsychic ones. This fact is due to a psychopathological point of view, discarding as no pertinent the context in which the disfunction develops.

In our clinical work we have observed that this criterion was untenable since the characteristics of the sexual disfunctions with psychological etiology are: circumstantial apparition, selectiveness (symptoms may appear in relation with some people and not with others), anxiety at a new partner, problems within the couple. Also situations of mourning, laboral problems, retirement, etc. may carry on sexual problems.

All this indicates clearly that sexual disfunctions of psychological origin are enrolled into a relational context, considering pathological certain kinds of relation and not only the individuals. Each sexual concern is often also a relational problem where the symptom appears as an adaptation to an interactional system.

Consequently, the therapeutical approach to sexual disfunctions implies to enlarge the observation field and to pass from the individual situation to the couple and sometimes to wider systems in order to include the context in which the disfunction appears.

We wish to revise in this workshop the following:

- Male sexuality.
- Female sexuality.
- Myths about sex.
- Sexual interactional systems in the couple.
- The sex therapies as a specific answer.
- The field of sex therapies within the therapy of couples and families.
- Sexuality in our social context.

APROXIMACION AL ENFOQUE SISTEMICO EN TERAPIA FAMILIAR

Dr. ALBERTO VAZQUEZ* y Lic. ZULEMA STORANI DE ORLANDO**

Directores del Instituto Familiar Sistémico (IFASI), Buenos Aires

Objetivo: Lograr una aproximación teórica de los fundamentos sistémicos, cibernéticos, comunicacionales e interaccionales del enfoque propuesto como marco de referencia para abordar las disfunciones familiares.

Metodología: Con técnicas de role-playing de familias estructuradas e inestructuradas, se mostraron diferentes situaciones que fueron utilizadas para dar los fundamentos teóricos propuestos.

Dirigido a: Profesionales de la salud mental.

SUMMARY

OBJECT: To attain a theoretic approximation to the systemic, cybernetic, communicative and interactional grounds of the approach proposed as a frame of reference to deal with family disfunctions.

METHODOLOGY: By means of role playing techniques of structured and unstructured families, different situations used for giving the proposed theoretic grounds are shown.

DESIGNED FOR: Mental Health Practitioners.

* Bulnes 2515, 9º, "D", (1425) Buenos Aires.

** Beruti 3865, P.B., (1425) Buenos Aires.

EL ROL DEL AUXILIAR TERAPEUTICO

ELISABETH RAPELA DE SERIGOS*

El objetivo de este trabajo es de hacer conocer un tipo de intervención terapéutica cuya característica es el rol del así llamado "auxiliar terapéutico".

Tomando la familia como un sistema abierto, capaz de gobernarse y con posibilidades de autorregulación, el auxiliar funciona como un agente externo que se incluye en el sistema familiar, como un elemento que provee nuevas técnicas que pueden resultar útiles para destruir círculos homeostáticos y crear posibilidades de cambio.

El auxiliar forma parte de un equipo terapéutico que es generalmente quien recibe la consulta y con quien se discuten las estrategias. El A. T. tiene un encuadre limitado, un horario y honorarios, variables según el caso, el lugar de trabajo es la casa de la familia, tiene un objetivo claro que cumplir que queda explicitado desde el comienzo.

Toma un "rol sustitutivo provisorio" donde hay alguna función que es inoperante o cuando hay una hipertrofia de un rol en detrimento de otro. Esto lo hace desde el sistema, donde se inserta, en el llamado por Ph. Caille "modelo fenomenológico", en su habitat.

En este amplio y flexible encuadre, facilitador de posibilidades ilimitadas de creación personal, juega un papel importante el clima emocional del que participa el auxiliar.

Se *hace-con* en vez de *hacer-hacer*, se acompaña en la experiencia, funciona a nivel analógico y verbal; muestra, enseña. Este aprendizaje es capitalizado por la familia y trae consigo una apertura al cambio y facilita la adquisición de nuevos modelos de conducta.

Las familias consultantes, están en crisis, desbordadas y han solicitado al equipo algún tipo de ayuda de emergencia. Estas crisis familiares están caracterizadas por la ruptura del equilibrio y las familias están dispuestas a aceptar nuevas creencias o nuevas percepciones del mundo.

Se da un proceso marcado por tres tiempos, una etapa de iniciación donde lo fundamental es el "joining" y la entrada en el sistema. Se establece un contrato y se explora la interacción, alianzas, subsistemas y se pasa a la segunda etapa donde se focaliza la dificultad, la acción es mayor, salimos a la calle, nos reunimos con los hermanos, amigos, hacemos tareas, bloqueamos y facilitamos díadas o tríadas, contenemos situaciones de angustia o de violencia.

La tercera etapa, de "despegue" es la de la salida del sistema y está ligada al cambio que la familia ha conseguido, y es aquí, desde una situación personal, donde es el A. T. más que la familia quien se siente emocionalmente triste por la separación.

Se ha trabajado con: suicidios, crisis depresivas y fóbicas, psicosis

tratadas sin internación, casos en que las familias se resisten a las psicoterapias convencionales o que no pueden salir de su casas. Familias con adolescentes con problemas de conducta, enfermedades somáticas que obligan al paciente a estar en cama, situaciones terminales y finalmente, familias en crisis naturales o accidentales donde se crea un círculo estereotipado homeostático.

Los seguimientos son anuales, desde hace ocho años, siguiendo las familias consultantes, hasta la fecha, asintomáticas.

SUMMARY

The objective of this paper is to describe a type of therapeutic intervention characterized by the role of the "therapeutic aide".

The aide approaches the family as an open system, capable of self-government and with possibilities for self-regulation. Functioning as an external agent who introduces himself into the family system, the aide functions as an element that provides new techniques which may be useful for the destruction of homeostatic circuits and may create possibilities for change.

The therapeutic aide is part of a therapeutic team which generally receives the consultation and with which strategies are discussed. The aide has a specific setting, schedule and fees which vary according to the case. His place of work is the family's home. There is a definite objective to be attained which is explicitated from the beginning.

He takes an a "provisional substitutive role" where there is an inoperative function or where there is a hypertrophied role in detriment of another. He does so from the system into which he inserts himself, that is, from what Ph. Caille calls the "phenomenological model" in ist habitat.

In this wide and flexible setting which allows for unlimited possibilities for personal creativity, the emotional climate in which the aide participates plays an important part. He *operates-with* instead of *operating-on*, he accompanies experientially, he functions at both verbal and analogical levels; he shows, he teaches. The family capitalizes on this learning which ushers in an opening toward change and facilitates the acquisition of new models of behavior.

The families who consult are in crisis, out of control, and have asked the team for some kind of emergency help. These family crises are characterized by a break-down in the equilibrium and the families are willing to accept new beliefs or new ways of perceiving the world.

This therapeutic process is marked by three periods: a period of initiation where the main task in "joining" and entering the system. A contract is established and the therapeutic aide explores the interaction, alliances, and subsystems. It is in the second phase that the difficulty is focalized and action is more intense: we go out of the house; we get together with brothers, sisters and friends; we perform tasks; we block and/or facilitate dyads and triads; we contain situa-

* Las Heras 3836, 13º, (1425) Buenos Aires.

tions of anguish or violence. The third step or "separation" is that of leaving the system and is connected with the change the family has achieved. In this sense, it is the therapeutic aide in his personal situation who feels emotionally sad about the separation.

We have worked with suicide cases, depressive and phobic crises, psychoses treated without hospitalization, cases in which the families are resistant to conventional psychotherapies or cannot leave their homes, families with adolescents with behavior problems, bed-ridden patients with somatic illnesses, terminal cases and finally, families in natural or accidental crises where a stereotyped homeostatic circuit has been created.

Follow-ups have been practiced yearly for the last eight years with the consulting families which are, up to now, asymptomatic.



Institución Psicoterapéutica

- Residencia terapéutica intermedia
- Clínica psiquiátrica
- Comunidad del tiempo (Hospital de Día)
- Talleres terapéuticos
- Centro institucional

Directores:

Dr. Felipe Díaz Usandivaras
Dra. Mirta Irene Méndez Puig

Soler 5961 - 1425 Capital Federal - Tel.: 771-8114/8108

PLANIFICACION FAMILIAR DERECHO DE TODOS

compacta

"Sostener la necesidad de profundizar en todos sus aspectos la temática de la planificación familiar difundiendo los principios y postulados de la PATERNIDAD RESPONSABLE como un derecho humano fundamental".

Objetivos de la A.A.P.F.
Art. 3º de los Estatutos Sociales

- Consultorio médico de Planificación Familiar (anticoncepción)
- Consultorio de Orientación para Adolescentes
- Capacitación en Planificación Familiar y Educación Sexual
- Asistencia técnica a escuelas para programas de Educación Sexual
- Venta de material educativo

INFORMES



ASOCIACION ARGENTINA
DE
PROTECCION FAMILIAR

HORARIO DE ATENCION
Diariamente de 13 a 18 horas

Agüero 1566
1425 - Capital Federal

821-6155
821-4990



CENTRO DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA MEDICO
PSICOLOGICA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DRA. TELMA RECA

Directora: Dra. Evelina S. de Costa

- TRATAMIENTOS: Psicoterapia individual, grupal, familiar y de pareja; psicopedagógicos. Orientación Vocacional.
- DOCENCIA: Cursos de Post-grado destinado a Médicos, Psicólogos y Psicopedagogos.
- SEMINARIOS BREVES.

11 de Setiembre 986 - (1426) Capital Federal

Tel. 772-1166/773-8152

C E R F

CENTRO PARA EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES FAMILIARES

Directores: Psicólogo Alberto G. González - Psicóloga Olga Benzadon de González

DOCENCIA - ESCUELA PARA TERAPEUTAS FAMILIARES - 1983-1985

Está diseñada para ampliar el rango de operaciones terapéuticas posibles para la práctica clínica familiar. Los alumnos trabajan una vez por semana en grupos de 8 a 10 personas. La coordinación del grupo está a cargo de los directores del C.E.R.F. y colaboradores. El programa está estructurado alrededor de la supervisión en vivo (Cámara Gesell). Las entrevistas con los grupos familiares son observados por los colegas del grupo de entrenamiento, por lo tanto cada uno tiene la experiencia directa de trabajar y la observación. Esto brinda un amplio rango de situaciones. Las entrevistas son videogradas y revisadas en una reunión de Supervisión al comienzo de cada jornada. Se desarrolla el aspecto teórico según la teoría General de los Sistemas y de la Comunicación.

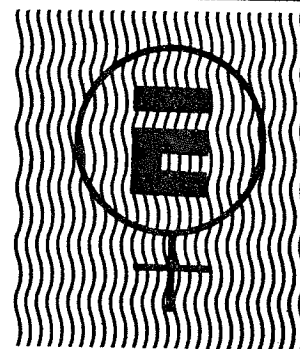
Consta de: Area Clínica, Area Teórica, Desarrollo de Recursos Técnicos, Planeamiento y Evaluación.

ACTIVIDADES A REALIZARSE:

SEPTIEMBRE: Seminario sobre "Reglas y Organización Familiar". Prof. G. Klimovsky y Psic. A. G. González.

OCTUBRE: Seminario sobre "Bateson y la Teoría de la Comunicación. Prof. G. Klimovsky, Psic. A. González, Prof. Delia Prada.

INFORMES SOBRE CURSOS Y SEMINARIOS EN: Soler 3765, 4º J, Nro. 18 - Tel. 802-0333 y 824-1188, días lunes, martes, jueves y viernes de 15.30 a 19 horas.



eliam Equipo para la investigación y asistencia de la mujer

Profesionales especializados en la atención psicológica de las siguientes áreas:

- Disfunciones sexuales en la mujer.
- Información sexual para adolescentes mujeres.
- Mujeres con afecciones ginecológicas, mamarias, histerectomías.
- Grupos de Autoayuda - Autohelp.

Directora: Lic. María Cristina Vila de Gerlic

INFORMES: TEL. 83-2498/1581/2557/2538/7999

I.D.A.P.

Instituto de docencia y asistencia psicoterapéutica

Directores: Dr. J. Mario Tisminetzky - Lic. Silvia Schlemenson de Oms

Escuela de formación de terapeutas familiares para médicos, psicólogos, psicopedagogos y asistentes sociales.

Director: Dr. J. Mario Tisminetzky

Secretaría: Av. de Mayo 1035 - Ramos Mejía - 658-0928

Lunes a viernes de 16 a 20 horas.

EQUIPOS DE VIDEO

INSTALACIONES DE CIRCUITOS CERRADOS DE TV

GRABACIONES – PROYECCIONES – COMPAGINACION

ALQUILER DE EQUIPOS PARA CONGRESOS

SERVICIO TECNICO Y VENTA DE
EQUIPOS DE VIDEOCASSETTE

TECNI SERV

Ciudad de la Paz 2506, 1º, Of. 3
Tel. 784-0123

MENSAJERIA TELEFONICA

SIS-TEL

ANTENDEMOS LLAMADOS TELEFONICOS
exclusivo a profesionales.

Durante todo el año.

Damos la seguridad de que el trato del profesional
con el paciente queda perfectamente canalizado
a través de nuestras **secretarias permanentes**
capacitadas para la coordinación de horarios
de consulta, transmisión de llamadas o
mensajes personales, profesionales, etc.

Visítenos en

AUSTRIA 2033 - 1º D (Y JUNCAL) (1425) CAP. FEDERAL
TEL. 83-2557/2498/1581/2538/7999

CENTRO

de

D ocencia
I nvestigación y
A sistencia
P sicológica

Directores:

Dr. Roberto P. Montanelli
Dr. Carlos María Dfáz Usandivaras

PSICOPATOLOGIA DE ADULTOS

PSICOPATOLOGIA INFANTO JUVENIL

PSICOPEDAGOGIA Y CLINICA DEL APRENDIZAJE

TERAPIA FAMILIAR Y MARITAL

DOCENCIA – INVESTIGACION

ACASSUSO 907 – SAN ISIDRO – T.E. 743-8645 – Bs. As.

VI ENCUESTRO ARGENTINO DE PSICOLOGIA PROFUNDA

TEMA CENTRAL

EL PROCESO TERAPEUTICO

21 y 22 de Octubre de 1983

Sede del Encuentro: S.A.D.E., Uruguay 1371, Capital

1. EL PROCESO TERAPEUTICO Y EL CONTEXTO HISTORICO SOCIAL.
2. PROCESO PSICOANALITICO Y PROCESO PSICOTERAPEUTICO.
3. PROCESO TERAPEUTICO EN EL MARCO INSTITUCIONAL.
4. FACTORES ESENCIALES Y CONTINGENTES EN EL PROCESO TERAPEUTICO.
5. LA PALABRA Y EL CUERPO EN EL PROCESO TERAPEUTICO.
6. LA PERSONALIZACION EN EL PROCESO TERAPEUTICO.
7. TEMAS LIBRES.

Aranceles hasta el 31-8-83: Titulares, \$a 100. Adherentes, \$a 70.

Miembros y candidatos del Círculo, \$a 50.

CIRCULO DE PSICOLOGIA PROFUNDA DE BUENOS AIRES

Adherido a la Federación Internacional de Círculos de Psicología Profunda

Informes e inscripción: Pasteur 282, (1028) Capital Federal, Tel.: 47-4526,
de 13 a 16 hs.

LA SEXUALIDAD ES ALGO QUE TODOS TENEMOS, NECESITAMOS Y MERECEMOS. EN TODO MOMENTO. EN TODAS LAS EDADES.



centro de
educación
terapia e
investigación
en sexualidad

- Tratamiento de las disfunciones sexuales.
- Educación sexual para adultos y adolescentes.
- Especialización para profesionales.

Directores:

Lic. Laura S. CALDIZ
Dr. León R. GINDIN

Solicite entrevista personal o información postal.

Darregueira 2247 - Depto. "B" TEL. 773-7391
(1425) Buenos Aires, Argentina.

ARTES GRAFICAS

ELIAS PORTER S.R.L.

Charlone 1809
Plaza 1202 - (1427) Capital Federal
(Altura Alvarez Thomas al 1800)
Tel. 552-3621

- ◆ FOLLETOS MEDICOS
- ◆ PROGRAMAS PARA CONGRESOS CIENTIFICOS
- ◆ REVISTAS Y PROPAGANDA MEDICA
- ◆ DIPLOMAS Y POSTERS - REUNIONES CIENTIFICAS
- ◆ LIBROS, etc.

CENTRO DE ESTUDIOS GRUPALES

Director: Dr. J. J. MORGAN

**ESCUELA DE PSICOLOGIA SOCIAL
Y TECNICAS GRUPALES**

- ENFOQUE SISTEMICO.
- LAS CLASES DE 1er. AÑO COMIENZAN EL 10/8/83.
- SOLICITAR ENTREVISTA PARA LA INSCRIPCION, QUE SE REALIZA EN:
RODRIGUEZ PEÑA 660, 4to. PISO
TEL.: 40-1141 - 83-1168 - 774-5940 - 825-0750



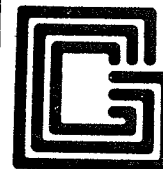
COORDINACION PEDAGOGICA

Delly Beller
Alejandra Eidelberg
Nusha Teller

PRACTICA, FORMACION E INVESTIGACION

Secretaría: 15,30 a 19 hs.
Teléfono: 771-3179

Luis María Campos 1145
1426 Buenos Aires



**ASOCIACION ARGENTINA DE PSICOLOGIA
Y PSICOTERAPIA DE GRUPO**

Fundada el 20 de septiembre de 1954

Asociación dedicada a la investigación y docencia en temas referidos a Grupos ofrece a la comunidad:

- Curso para la formación de Terapeutas de Grupo, Familia y Pareja. Duración: 4 años. Exclusivo para médicos y psicólogos.
- Curso de formación de Coordinadores de Grupo no Terapéuticos. Duración: 2 años. Para profesionales con formación terciaria.
- Seminarios de extensión sobre: Pareja, Familia y Grupos Terapéuticos. Duración: 2 años. Para profesionales de la especialidad.
- Supervisión y Asesoramiento Institucional, Laboratorios y Jornadas sobre Dinámica Grupal, a cargo de un equipo especializado.
- Supervisión de Grupos Terapéuticos de Niños y Orientación para Padres, a cargo de la Sub-Comisión Area Grupo de Niños.

GORRITI 4257 - TEL. 86-7959

Secretaría de 8 a 17 horas

salud mental

Comunidad Terapéutica
Clínica de Día - Internación
Psicoterapia grupal-
individual - Familiar

Director: Dr. Jorge Garca Badaracco
Sub-Director: Dr. Norberto Proverbio

CLINICA PSIQUIATRICA

ditem

DOCENCIA - INVESTIGACION
Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES MENTALES

O'HIGGINS 2328 - BUENOS AIRES - TEL. 781-1306/7825/0557

ASOCIACION ARGENTINA DE PSIQUIATRIA INFANTIL Y PROFESIONES AFINES

MIEMBRO TITULAR DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE PSIQUIATRIA
INFANTIL - ADOLESCENCIA Y PROFESIONES AFINES.

ORGANIZA EL

IV CONGRESO ARGENTINO Y III JORNADAS CORDOBESAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL

EN LA CIUDAD DE CORDOBA
DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE DE 1983

SECRETARIA VEMA
CALLAO 1178, 6° PISO - Tel. 44-0769 / 41-0205

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DE LA PAREJA CON INCLUSION DE TECNICAS PSICODRAMATICAS

Dr. ROBERTO LOSSO* y Lic. ANA PACKCIARZ DE LOSSO*

La psicoterapia psicoanalítica de parejas es encarada a partir de las ideas de Freud acerca de la invariable presencia del *otro* como modelo, objeto, auxiliar u oponente, y su afirmación de que "la psicología individual es al mismo tiempo psicología social". La pareja constituye un prototipo de la presencia real y concreta de ese *otro*, modelo, objeto, auxiliar u oponente.

Las personas se unen en parejas por diversos motivos, destacándose entre otros (desde el punto de vista del psicoanálisis): 1) Un intento de resolver la situación edípica (o dicho de otro modo de pasar de la endogamia a la exogamia, o de la sexualidad infantil a la adulta); 2) Llenar necesidades de compañía, amor y protección; 3) Lograr la ilusión de "completud" con "la otra mitad"; 4) Reafirmación recíproca (confirmación) de la respectiva identidad sexual.

Estos son los aspectos "progresivos", pero también los hay "regresivos": 1) Así como es salida del Edipo, también la pareja es entrada en el mismo: el objeto queda "teñido" con características incestuosas; 2) Tiende a recrear asimismo la pareja madre-hijo, con todas sus necesidades regresivas.

Cada uno de los individuos aporta a la pareja sus propias fantasías inconscientes, o situaciones dramáticas, que corresponden a lo que Pichon-Rivière ha llamado *grupo interno*, cuyo drama se desarrolla en la "cancha interna" (Pichon), o sea en el mundo interno del individuo.

Los "grupos internos" de ambos miembros de la pareja se entrelazan inextricablemente en una complicada trama interaccional dando lugar a la constitución de un *grupo pareja*, al que cada individuo aporta su propia dimensión dramática o *dramática de pareja*, que se desarrolla en la "cancha interna" de la pareja. Es como un "collage" resultante de la interacción de escenas infantiles de ambos miembros, mecanismos transferenciales y compulsión repetitiva mediante.

En los casos en que hay un *predominio* de estos aspectos transferenciales regresivos y repetitivos, estereotipados, dichas dramáticas adquieren una particular *rigidez* que las lleva a un "equilibrio" patológico más o menos estable, constituyendo una *colusión* (Laing).

Cada uno funciona aquí como *yo auxiliar* de la estructura defensiva del otro, o dicho de otro modo cada uno reafirma al otro en su "falso self".

Desde el punto de vista *técnico*, empleamos las técnicas del psicodrama creados por Moreno, pero considerándolas como un instrumento sumamente útil para la comprensión psicoanalítica. A partir de

*Laprida 1916, 5°, "11", (1425) Buenos Aires.

aquí hemos desarrollado el concepto de *concepción dramática de la psicoterapia*: toda labor psicoterapéutica con o sin uso de técnicas psicodramáticas, se desarrolla en un campo dramático.

El tratamiento de la pareja es efectuado por una pareja de terapeutas de diferente sexo. Hemos definido esta relación como *tetracorporal y multipersonal*, en el sentido que en el interjuego dramático emergente del campo terapéutico, hay "personajes" (fantasmáticos) permanentemente incluidos, presentes, que interactúan desde el grupo interno de la pareja.

A lo largo del tratamiento, van surgiendo situaciones dramáticas, que se plasman en escenas, algunas de las cuales son *dramatizadas*, escenas que, como el contenido manifiesto de un sueño, remiten a *otra escena*, inconsciente, latente, que corresponde a las dramáticas centrales de la pareja, expresión de las situaciones colusivas. La develación de estas *dramáticas colusivas centrales inconscientes*, que constituyen el *inconsciente de la pareja*, es el objetivo de la terapia psicoanalítica-psicodramática de la pareja.

SUMMARY

The psychoanalytic psychotherapy of couples is considered from Freud's point of view about the invariable presence of the *other* as "a model, a helper or an opponent", and his claim that "individual psychology... is at the same time social psychology as well". The couple constitutes a prototype of the real and concrete presence of that "other".

People join in couples with the purpose of resolving their oedipal conflicts, passing from endogamy to exogamy, fulfilling in that way their needs of love and protection, achieving the illusion of "completeness" and reciprocally confirming their sexual identity. But also there are "regressive aspects", oedipal and narcissistic.

Each member brings its own "internal group", and dramatics, which interacts with the "internal group" and dramatics of the other. They both constitute a *couple-group*, in which a *couple-dramatics* develops, resulting from the summing-up of the individual dramatics.

When there is a predominance of the regressive and repetitive aspects, these dramatics acquire a particular rigidity, constituting a *collusion* (Laing).

From the technical point of view, we use the techniques developed by Moreno, but considering them as a useful instrument for the psychoanalytic understanding based in our "*dramatic conception of psychotherapy*".

The treatment is carried out by a heterosexual couple of therapists. The relationship between a couple of patients and a couple of therapists is defined as "*tetracorporal and multipersonal*".

The couple's dramatics is expressed through *scenes*, some of which

are *dramatized*. These scenes remit to *other scenes* (latent, unconscious): the couple's *central, collusive unconscious dramatics*, constituting the couple's unconscious. The search and understanding of those scenes is the aim of the psychoanalytic-psychodramatic psychotherapy of couples.

DINAMICA DE LOS GRUPOS INSTITUCIONALES

Coordinador: Dr. CARLOS JORGE ELINGER *

El Dr. Elinger planteó el tema a través de un ejemplo institucional y desde allí poder conceptualizar los elementos teóricos deducibles de las dinámicas Institucionales. Dividiendo en instituciones Autoritarias, Democráticas y Lesser Faire, las vicisitudes que los integrantes pueden vivenciar en función de éstas. Características de la depositación de Ansiedades Psicóticas, mecanismos de las mismas en función de los roles institucionales.

El rumor institucional, elementos del mismo.

Diferencias y similitudes entre los pequeños y grandes grupos, factores potenciales de integración y desintegración de los mismos.

La ambigüedad institucional; importancia de la misma.

Elementos para la comprensión y posible coordinación de estos fenómenos.

A continuación el grupo participa activamente planteando ejemplos institucionales que fueron discutidos, buscando integrar los mismos con los conceptos teóricos expuestos.

SUMMARY

Dr. Elinger posed the subject through an institutional example so as to conceptualize by means of it the theoretical elements deducible from the institutional dynamics making a division into authoritarian, democratic and laissez faire institutions according to the vicissitudes that their members may experience in terms of them. Characteristics of the deposition of psychotic anxieties, their mechanisms in terms of the institutional roles.

The institutional rumour, its elements.

Differences and similitudes between small and large groups, potential factors of their integration and desintegration.

The institutional ambiguity, its importance.

Elements for the understanding and possible coordination of these phenomena.

Immediately after the group participated actively posing institutional examples that were discussed, trying to integrate them with the theoretical concepts previously stated.

TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA. MODELO DEL CENTRO PER LO STUDIO DELLA FAMIGLIA DE MILAN.

Lic. SARA B. JUTORAN* y Dra. SUSANA FRONDIZI DE BULLRICH**

El workshop se centró en el análisis y elaboración de un caso concreto de acuerdo con el modelo del Grupo de Milán.

Se trabajó en base a los presupuestos teóricos de este modelo, y la puesta en práctica de los mismos a través del trabajo grupal.

El trabajo se organizó de acuerdo a la siguiente distribución: Una primera parte de comunicación teórica, una segunda parte descriptiva y una tercera, donde se trabajó sobre el feedback del grupo de asistentes.

Este workshop estuvo dirigido a profesionales médicos y psicólogos.

SUMMARY

The workshop's activity was oriented to analyze and discuss a specific case according to the theoretical principles of the Group of Milan and the practicing of the groupal work.

The job was organized in three different parts as follows:

first stage: theoretical communication

second stage: descriptive

third stage: inclusion of the assistant's feed-back.

This workshop has been intended to be useful for physicians and psychologists.

* Zabala 1881, 19°, (1425) Buenos Aires.

** Santa Fe 1449, 5°, (1060) Buenos Aires.

* Gorriti 4257, (1414) Buenos Aires.

MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACION EN FAMILIA

Lic. NIDIA CARRANZA OVIEDO DE BAROCELA*

Sintetizador: Lic. NORBERTO IANNI

Las dos técnicas psicoterapéuticas presentadas para tratar familias y parejas tienen su eje central en la regulación de la comunicación.

La propuesta de ambos modelos es de que el cambio terapéutico se consigue mediante la modificación de la comunicación entre los miembros de la unidad terapéutica.

Esta modificación no se refiere a la exhuberancia de la comunicación, sino por el contrario a la moderación y regulación de la misma.

Los mensajes que se van a emitir deben ser seleccionados. Las reglas básicas de la comunicación deben ser formuladas y la discusión constructiva debe ser aprendida.

El workshop tuvo la siguiente configuración:

Módulo I. Se proporcionaron datos significativos obtenidos en recientes investigaciones sobre la comunicación en las familias y en las parejas. También se dio información sobre comunicación verbal y analógica.

Módulo II. Se presentaron dos técnicas para tratamientos de familia y pareja.

— Técnica de Richard Stuart (USA 1980) pertenece a la teoría del "Intercambio Social Comunicacional".

— Técnica de Sven Walhroos (USA 1978) desarrollada dentro del marco referencial del "Aprendizaje Social".

Módulo III. Se utilizó la técnica de Roleplaying con el público asistente. Se dramatizaron situaciones propuestas por los participantes para ejemplificar ambas técnicas y se realizaron ejercicios para el entrenamiento de la comunicación reglada.

Los módulos I y II fueron ejemplificados con videograbaciones sobre las técnicas.

El módulo III fue monitoreado y grabado para ser utilizado en la discusión de cierre, la cual se centró en la discusión de las técnicas desarrolladas.

Ambas técnicas están apoyadas en el concepto de que los miembros de una familia establecen códigos internos de comunicación que no son conscientes y que rigen la interacción. Las reglas no se explicitan pero regulan la relación.

El trabajo sobre la comunicación propone un modelo de esclareci-

miento sobre las reglas que determinan la interacción y permiten su regulación y reformulación. El mayor énfasis fue puesto en los aspectos no verbales de los mensajes.

Otro aspecto destacado fue que cada miembro de la pareja lleva al matrimonio un modelo de comunicación que era funcional en su familia de origen pero que difícilmente vuelven a ser funcionales en la vida en común.

Ambas técnicas proponen modelos de discusión y de comunicación regladas para modificar la interacción y obtener modelos de comunicación más funcionales.

SUMMARY

Information was given to the participants divided in three groups:

Information type I: research findings on family and couple communication.

Information type II: Richard Stuart's technique based on social learning theory. Here the therapeutic goal is communication change.

Information type III: Sven Walhroos's technique of family and couple communication improvement, used as the only therapeutic approach.

Rules of the useful communication were given.

Each information type was showed through VTR some therapeutic models.

Participants were asked to realize some experiences with the received information, so as to improve the learning.

* Anchorena 1726, PB, "B", (1425) Buenos Aires.

MODELO PARA UNA TAREA PSICOPROFILACTICA CON PAREJAS Y FAMILIAS

Lic. NORMA BENDERSKY DE IURCOVICH*

Este trabajo como tarea Psicoprofiláctica, se asienta en el concepto, que el conocimiento de los episodios a vivir y las alternativas posibles, permiten una mejor resolución de los mismos.

Las crisis por las que atraviesa toda pareja y toda familia, no son patología, sino falta de resolución de las mismas.

Mitos y Tabúes que influyen en la conducta de la pareja y la familia:

La virginidad en la mujer, como condición para acceder al matrimonio.

El machismo; poder otorgado al hombre de ser el iniciador, conocedor absoluto y por lo tanto responsable de la gratificación sexual de la mujer.

Restricciones sobre la sexualidad, que pasan a menudo inmutables de madres a hijos sin tener la posibilidad de encontrar otra manera constructora y reparadora, que corrija las dificultades anteriores u ofrezca otras alternativas.

La tercera edad, considerada como una etapa en la que la actividad sexual debe cesar por impotencia o falta de deseo.

Este mito transmitido de generación en generación ha creado en la gente mayor una suerte de jubilación no sólo en lo laboral, sino en la vida misma.

En relación a la sexualidad, sabemos que el lenguaje sexual es amplísimo, sin embargo la mayoría de los seres conocen maneras de vincularse sexualmente, limitando así todo un caudal de goce del que la propia naturaleza los ha hecho acreedores.

El sexo es limitado sólo a los genitales.

La sociedad ha aprendido a mutilar sus sentidos y a circunscribir parcialmente determinadas áreas o zonas para provocar respuestas específicas.

Muchas disfunciones sexuales son provocadas por una total falta de información de la pareja sobre sus propios cuerpos y posibilidades.

¿Cuántos adolescentes han aprendido que el deseo sexual o la excitación son procesos y sensaciones naturales que tienen que ver con salud y crecimiento, y no con un pecado digno de ser sometido al castigo y a la humillación?

¿Cuántos jóvenes no se iniciaron sexualmente con mujeres mayores mercaderes del sexo donde el amor y la comprensión necesarios para cualquier aprendizaje estuvieron ausentes?

Nuestra sociedad nos enfrenta con una permanente ambivalencia,

por un lado una moral que prohíbe films, libros, espectáculos, etc., a la vez que impone conductas rígidas y disciplina; por otro lado la publicidad bombardea con un alud de estímulos eróticos. Hasta para vender un auto se recurre publicitariamente a la imagen erotizada de una mujer, cuando no en actitud provocativa.

Así se confunde libertad e independencia, con libertinaje e insubordinación.

Roles femenino y masculino en nuestra sociedad:

El rol que el hombre ocupó en la sociedad a través de miles de años le ha sucedido a la mujer en escasas generaciones.

La mujer que trabaja fuera de la casa se ve exigida, por tener que asumir un doble full time, estar menos retribuida que el hombre económicamente, y además tener que supeditarse a la prioridad del varón, sobre todo en cargos privilegiados.

Planificación Familiar:

Hoy no podemos eludir más la necesidad de planificar la familia teniendo en cuenta sus principios morales, condiciones económicas y psicológicas de la pareja.

Esto permite que el hijo ingrese a la vida de los padres como un ser plenamente deseado.

Propuesta:

Facilitar masivamente información y orientación adecuadas en cada una de las etapas del proceso evolutivo familiar. Anticipando los cambios y procesos que indefectiblemente vivirá con el devenir del tiempo toda pareja y familia.

Tratar que el hombre logre convivir con su sexualidad de manera digna y respetada. Que aprenda que genitalidad y procreación es sólo una parte del comportamiento sexual. Que nuestros instintos son dignos y dignificantes.

Que no es necesario sustituir placer por deber, cultura por naturaleza, ni instinto por moral, pues no son antagónicos, sino por el contrario a través de su conciliación el hombre encontrará el equilibrio necesario para la vida.

SUMMARY

This paper puts forth a proposal, the psychoprophylaxis of the married couple and the family, on the premise that a better knowledge of future experiences and their possible alternatives will permit a more adequate outcome.

Certain myths and taboos are discussed which determine behavior, such as a woman's virginity as a requisite for marriage.

Male chauvinism, as the role attributed to man as the initiator, the expert and, therefore, responsible for a woman's sexual gratification.

Restrictions on sexual information, which are handed down unaltered from one generation to the next and consequently do not

* Santa Fe 1854, 2º, (1123) Buenos Aires.

allow for new alternatives capable of modifying the previous difficulties.

Old age seen as a stage in which sexual activity must cease because of impotence or absence of desire, which brings about in elderly people a sort of retirement from their own life.

Owing to lack of adequate sexual information in children and adolescents, natural and gratifying growth processes and man's capacity for enjoyment become a sin deserving punishment.

Frequently, young men have their first sexual experience with prostitutes so that love and understanding necessary in any learning process are absent.

The changes undergone by the woman's role in present-day society has not been recongnized yet and in the occupational field woman get lower salaries and have fewer chances than men.

Family Planning: it is crucial to form a family in a society as demanding as ours. When a married couple knows the necessary means to plan for a family in accordance with their needs and possibilities—religious, economic, social, etc.—their child starts his life as a wanted child and not as a burden to be put up with.

Conflicts do not give rise to pathological behaviour, but the failure to find an adequate solution for them does.

Know ledge prevents conflict from becoming antrenched in a couple or a family. It encourages learning through the feedback from new sources of information and undestanding, and brings the couple closer to the conflict in order to find a way of coping with it together. It allows each spouse to assume his, or her, own role with responsibility and respect and greater discrimination and autonomy, and prevents the establishment of a confusional tie between husband and wife, and between the couple and the rest of the family and the external environment.

Massive diffusion of information and education adequate to each developmental stage, anticipating the changes that each couple and each family will undergo in the course of their growth.

To help men to enjoy their sexuality in a dignified and respected way, not by substituting duty for pleasure, culture for nature, morality for instinct, since these are not antagonic pairs; rather by reconciling them men will be able to find the necessary balance for a harmonious and gratifying life.

COMPRESION DESDE EL PSICOANALISIS (RELACIONES OBJETALES). ABORDAJE DESDE LA TEORIA DE LOS SISTEMAS DE LA TERAPIA DE PAREJA.

Lic. VIVIAN LOEW* y Lic. GUILLERMO FIGUEIRA**

Hasta hace poco tiempo se visualizó al Psicoanálisis y la Teoría de los Sistemas como antagónicos, y esto no ha beneficiado a ninguna de las dos.

El Psicoanálisis lleva a una comprensión detallada de los significados, proveyendo información acerca de lo histórico y dejó de lado el papel de los procesos relacionales que funcionan constantemente como para que un problema se conserve como tal.

La Teoría de los Sistemas puede rápidamente clarificar qué sucede entre dos personas, pero pierde detalles de lo intrapersonal de cada uno de ellos.

Del Psicoanálisis tomaremos la teoría de las relaciones objetales. Intentando reducirlas a lo más simple: en la infancia, las relaciones que tiene el niño con sus seres significativos, modelan sus futuras relaciones, sobre todo en cuanto a deseos, expectativas y temores.

De aquí podemos decir que cada uno va a tener predisposiciones para, y que se podría trazar un mapa proveniente de generalizaciones de sus experiencias tempranas con su familia.

Esta familia puntúa la experiencia del niño y la transforma en secuencias significativas. Estas incluyen explicaciones acerca de la causa de las cosas, lo que es apropiado, qué sentimiento se debe esperar de los demás, qué respuestas, convicciones en determinadas circunstancias, qué y cómo transmitir corporalmente, etc. Deja dentro de cada uno un mapa que va llevando a la acción frente a un entorno. Este mapa se convierte en predominantemente inconciente, pero es la guía que va llevando a la conducta.

Este mapa organiza la experiencia. Es función primordialmente del hemisferio no dominante. Se visualiza con mayor claridad durante momentos de stress y juego, debido a que estos son los momentos donde lo acostumbrado y lo nuevo entran en juego. Este mapa sirve a cada uno para navegar en entornos complejos, provee protección contra la invasión de información, un criterio acerca de qué es lo relevante y qué lo secundario. Provee de significados que permiten una orientación rápida y rápida respuesta, reduciendo lo nuevo a familiar. Organiza y limita lo que puede ser aprendido.

Este mapa funciona como un sólido sistema de creencias, comparables a la creencia de que la tierra era chata hasta que Colón se arriesgó a navegar sobre el borde, y encontró que no era chata. Y esto desafió las creencias. Y una de las maneras en las que el terapeuta puede

* Av. del Libertador 662, 4°, "12", (1001) Buenos Aires.

** Suipacha 211, 24, "G", (1008) Buenos Aires.

ayudar es sirviendo como guía en experimentar en la vida. Desde lugares nuevos se ven mejor los viejos.

De acuerdo a esto el terapeuta deberá:

- 1) comprender el mapa (relaciones objetales)
- 2) ubicar lugares nuevos, desde la TGS, desde donde podrán cuestionar y/o cambiar algunas piezas del mapa que necesitan para encontrar armonía en la pareja.

¿Qué busca el Terapeuta para ubicar el mapa?

— Utiliza empatía para comprender el sistema de pensamiento de cada uno. A través de ella el terapeuta se une al baile y puede introducir, desde él, variaciones en la coreografía.

— Estilo comunicacional de cada uno con el terapeuta y de ellos entre sí.

— Toma en cuenta cuánto pueden negociar y cuál es el clima de las negociaciones.

— En qué etapa de la vida está cada uno. Qué congruencias e incongruencias hay. En qué están asimétricos.

— Trata de hacerse alguna idea acerca de las familias de origen de cada uno, y, a partir de ellas, qué espera cada uno del otro.

— Investiga cuán dispuesto está cada uno a probar cosas nuevas.

— Cuánto puede comprenderse, cuánto diferenciarse.

— Cuán cerca del límite de frustración está cada uno.

— Qué moldes recurrentes tienen, sobre todo aquéllos en los que quedan atrapados.

— Cómo y qué hace cada uno para desencadenar lo peor en el otro.

— Cuánto pueden distinguir responsabilidad de reproche y culpa.

— ¿Cómo se encuentran los lugares nuevos? Un modo es a través del "juego": balance óptimo entre lo conocido y la novedad. Si la novedad es excesiva produce angustia; si es poca, nada se modifica.

Juegos

— Cada uno repite, sin parodia, lo que el otro dijo. El otro puede ir corrigiendo hasta que el primero pesque la onda y la transmita tal cual.

— Si entran fácilmente en peleas, cada uno puede usar sólo UNA palabra, y todo lo no verbal que quieran. Se les pide que peleen con esa sola palabra.

— Cada uno da el contenido de sí mismo pero en el estilo del otro (querulante, acusador, despreocupado, etc.)

— Esculturalización. Reedición de una estatua cotidiana de cada uno, hecha por cada uno por separado. Estado deseado de la relación, hecha por cada uno. Cada uno puede hablar, desde la posición colocada, si le es o no confortable cómo lo instaló el otro. Si no lo es, que se vaya colocando cómodo, respetando la estructura general del que diagramó la escena. Al que diagramó, sobre la base de los cambios

que hizo el otro, se le pide una nueva reacomodación y así hasta que lleguen a un estado de comodidad. El terapeuta puede sugerir, ya que están mutuamente enganchados en una serie posible y no ven otras.

— Imaginar cada uno por separado cómo habrá sido el casamiento de los padres. Hacerlo por escrito. Luego identificar ítems en común y diferentes con la pareja de ellos.

— Distintos tipos de tareas, inventadas de acuerdo a lo que muestren.

SUMMARY

Psychoanalysis leads to an understanding of meanings, providing personal historical depth, slighting the effects of the relational process in problem maintenance. General systems theory can clarify what happens between members of a family, losing intrapersonal meaning.

From psychoanalysis we take Object relation theory: early childhood relations shape adult relations with respect to wishes, expectations and fears. This leads to a map or model of relations, a special way in which each one punctuates his experience.

This map, which organizes experience, can best be visualized during play experiences.

Therapist will have to 1) understand the map (object-relations), 2) change some pieces of the map in order to harmonize with the other member of the couple.

Different plays are provided in the workshop so as to understand and change each member's map.

UN MODELO DE ENTRENAMIENTO EN TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA. USO DE TECNICAS DRAMATICAS, VIDEOGRABACION, ETC..

Dr. GASTON MAZIERES* y Dra. MARIA CRISTINA RAVAZZOLA DE MAZIERES*

Sintetizadora: Lic. SILVIA CRESCINI

En el campo de la psicoterapia familiar en nuestro medio, es posible el acceso a la información de las teorías y sus técnicas correspondientes, debido a la incrementación de la difusión bibliográfica de los últimos cinco años y a la responsabilidad docente asumida por diversas instituciones.

Nosotros queremos enfatizar la importancia de participar en grupos que pongan en práctica pautas de entrenamiento experiencial según los modelos con los que se trabaja. Pensamos que un profesional responsable debe exponer su persona, sus conocimientos y su trabajo, en distintos niveles que deben ir desde los más próximos (auto-observarse, auto-evaluarse) hasta los más amplios y distantes (que los colegas, pares, y aún los profesionales de mayor experiencia lo observen, lo cuestionen, le hagan aportes).

Nuestra propuesta específica, producto de nuestra práctica con nosotros mismos en una síntesis de todo lo previamente aprendido, es la de trabajar el rol de terapeuta familiar utilizando el bagaje técnico del psicodrama en la ejercitación de lo que conceptualizamos como las áreas centrales de manejo técnico del modelo sistémico con el que mayor afinidad tenemos (predominantemente estructural, con aspectos del modelo experiencial y aportes de la sistematización de las ideas de crisis, tensión y cambio de la escuela de Roma). Desde este modo de pensar definimos la función del terapeuta de familia como la del artesano que se introduce en una estructura de relaciones continuadas y significativas entre sus miembros, armando con ellos un nuevo sistema; desde allí contribuye a operar modificaciones cuestionando el síntoma (con técnicas al servicio de redefiniciones como focalización, puesta en acto, contraprovocación, etc.), cuestionando la realidad de la familia (con construcciones cognitivas, poniendo énfasis en las fuerzas positivas, etc.), y cuestionando la organización de la estructura familiar (creando fronteras, desbalanceando, etc.); para luego retirarse.

Para lograr el desarrollo vivencial gradual del rol a estructurar, se proponen ejercitaciones dramáticas de rol-playing, de imágenes simbólicas, de simulación de familias, etc. Estas experiencias, al tener lugar en un campo de trabajo menos comprometido que el del contacto directo con la familia consultante, permitirán la exploración de los recursos

técnicos, como así también la movilización y ajuste de las emociones, dando lugar a la emergencia de conductas creativas en el entrenando, que enriquecen sus posibilidades de una adecuada relación con la familia, a partir de una mejor autoevaluación.

Para la ejemplificación en el workshop, pensando que era una experiencia aislada y sin continuidad, se eligieron algunos ejercicios tendientes a promover un claro recorte de la función del terapeuta, a través de una propuesta práctica, con intensa participación de los asistentes.

Se planteó un primer ejercicio de autopresentación, realizada mediante una autoevaluación con exposición central (hot seat), funcionando el resto del grupo como contexto de observación, para medir la coherencia entre el lenguaje gestual-corporal y el lenguaje verbal, utilizando la videograbación del mismo para analizar el registro.

Luego se realizó un ejercicio de dramatización del sistema terapéutico donde se trabajó una situación propuesta por una persona del grupo quien examinó su inserción en la misma manejándose los conceptos de espacio y movimiento para dar cuenta de la estructura familia-terapeuta, funcionando nuevamente el grupo como contexto.

Por último se simuló una familia, actuando uno de los participantes de terapeuta en el "rol vacío" mientras un grupo funcionaba de colaboradores "fuera de cámara". Con este ejercicio se pudo medir la tensión a la que se somete el terapeuta dentro del campo y la funcionalidad del equipo de colaboradores al servicio de una mayor eficacia en la intervención terapéutica.

SUMMARY

The authors begin by defining the Family Therapist's function as the one performed by an artisan that enters within a structure with lasting and substantial relationships among its members, building up together with them a new system so as to, from that new system help them to change, redefining the symptom, the family structure and the family reality using several techniques, and, after that process, be able to quit and stay away from the family.

In order to train that Family Therapist's rol, that needs to be an intensive personal training, the authors suggest, as they have experienced in their own trainings, some psychodrammatic role-playing drillings (symbolic images, simulated families, sitting on hot seat, etc) that allow the exploration of techniques, and a growing accuracy in self evaluation.

During the workshop (the authors had chosen adequate drilling for a nonlasting experience with non-selected people) they performed the following tasks:

- 1 - a self presentation, with self exposition on a "hot seat".
- 2 - a sculpture of the therapeutic system.
- 3 - a simulated family with a member of the workshop playing the

* Dorrego 2381, (1425) Buenos Aires.

"empty rol" while a group of participants acted as co-workers outside the "one-way-mirror", less emotionally involved and therefore taking a more objective view of what happens.

This short experience about training exercises had the following outcome: the evidence of the increasing tensions that threaten the therapist while exposed to dysfunctional families and the strong advantages of sharing the work with a trusting team.

ANOREXIA NERVIOSA

Dr. JUAN JOSE MORGAN* y Dr. JOSE ROQUE BOZZO**

El objeto de este workshop fue presentar un ensayo de utilizar una explicación psicodinámica sobre la dependencia y el cuerpo en la anorexia nerviosa, para aplicarla en el abordaje terapéutico.

Temario:

- 1) Historia del conocimiento de esta enfermedad y su caracterización.
- 2) Explicaciones psicológicas y tratamientos intentados.
- 3) Ensayo de explicación psicodinámica.
- 4) La dinámica del grupo familiar.
- 5) Objetivos terapéuticos respecto del individuo y del grupo familiar.

La presentación se ilustró con relatos de nuestra casuística y la representación de un caso aportado por un asistente con el método de la escultura familiar.

Resumen:

Se revisa el concepto de anorexia nerviosa en su perspectiva clínica, dinámica e interaccional. En la familia de estos pacientes la madre establece una relación simbiótica con su hijo, que le sirve para llenar su propio sentimiento de vacuidad. Ella permite a su esposo ocuparse de asuntos "no humanos", tales como trabajo, dinero, etc. y justifica de este modo su necesidad de autosuficiencia.

La paciente debe aceptar un cuerpo femenino como parte de sí misma y encarar la separación de su propio cuerpo del objeto materno, lo que su yo requiere a toda costa. Durante esta fase transitoria de depresión puberal el yo organiza un desesperado sistema defensivo, dividiéndose en dos partes, esperando alejar dos grandes catástrofes psicológicas: un estado permanente de depresión o una regresión a la esquizofrenia.

La dinámica familiar es el ambiente que se usará para facilitar la separación de la madre, de la que depende la falta de autonomía y/o que impide el adecuado aprendizaje de roles sociales.

Los autores proponen una aproximación terapéutica que involucre a la familia en varias instancias, ya sea por medio de reuniones conjuntas o no. Esta estrategia tiende a transformar la relación simbiótica con la madre en una relación grupal familiar. También indicamos terapia individual en el contexto del proceso familiar.

SUMMARY

The concept of anorexia nervosa in its clinical, dynamic, and interactional perspective is reviewed. In the family of these patients, the mother establishes a symbiotic relationship with her offspring,

* Santa Fe 911, 2º, (1059) Buenos Aires.

** Conde 1078, (1426) Buenos Aires.

which serves to fill her own sense of emptiness. She leaves her spouse free to seek non-humane attachments, work, money, etc., justifying in this way her own sense of self sufficiency.

The patient that has to accept a feminine body as part of herself. The separations of her own body from the maternal object which her ego wishes to separate itself at all cost. During this transitory phase of pubertal depression, the ego organizes a desperate defense system splitting itself in two parts, in the hope of averting two major psychic catastrophe: a permanent state of depression and regression to schizophrenia. The family dynamics is the environment that has to be used to help the separation from the mother, which is responsible for the lack of ego autonomy which prevents sufficient learning of social roles.

The authors propose a therapeutic approach which involves the family in many instances in terms of conjoint interviews or not.

This strategy terms to transform this symbiotic relation with her mother into a group family relationship. We also indicate individual therapy but in the context of family process.

CECAF

*Centro de Capacitación en
el Trabajo con Familias*

Director: Lic. Daniel Fränkel
Coordinadora: Lic. Psicología Social
Lydia Rapoport

Dto. Docencia e Investigación:

Cursos a profesionales que trabajan con familias.

Metodología sistémica aplicada al conocimiento de las
funciones familiares y de sus redes sociales

Dto. de Prevención:

Grupos operativos con parejas

Asesoramiento y orientación de la pareja.

Cosquín 256 - (1408) Bs. Aires Tel. 641-0752 y 659-8892

APLICACION DE LA TERAPIA FAMILIAR EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Dra. ANNY SPEIER*, Dra. ESNEA AULETTA y Lic. RUBEN VADAGNEL*****

**C.E.A.M.: Centro de Estudios y Asistencia Médico-Psicológica de la
Niñez y la Adolescencia**

Se expone un enfoque psicoterapéutico de tipo elaborativo-dinámico-interaccional.

La terapia familiar enfoca a la familia como una estructura cuyas partes son interdependientes.

Tres conceptos son esenciales en este enfoque.

1) El resultado de las relaciones personales es algo más que la suma de las personalidades en juego.

2) El concepto de retroalimentación y de sus efectos acumulativos y de modificación progresiva entre los individuos interactuantes.

3) Influencia de la interacción actual en la modificación de la conducta, que fundamenta la terapia centrada en ésta.

Procesos de la estructura familiar. La familia es una estructura en evolución constante, a través de procesos de complementariedad y diferenciación por los que se integra el crecimiento individual y los objetivos de la familia.

Los procesos de la comunicación. Constituyen la trama de la interacción en su nivel verbal y analógico y definen el significado y el valor relacional.

Los enfoques psicoterapéuticos. Se perfilan aquí tendencias distintas según el énfasis puesto más en la relación o en la estructura. La línea divisoria parece marcarse en el concepto del cambio, y de cómo producirlo. Beels y Herber dividen a los terapeutas en "reactores" o "conductores", según eliciten el cambio, desde adentro, con técnicas elaborativas o, desde afuera, con técnicas directivas.

Un enfoque dinámico - elaborativo - interaccional. Concebimos el cambio como producto de una elaboración interna y recíproca a la vez. El desarrollo se cumple en un marco de relación interpersonal como transformación y reestructura continua que tiende a la realización del potencial en nuevas estructuras. Siempre se trata de una nueva creación y ésta es el factor de cambio a través de vivencia actual en la entrevista interaccional.

El proceso y el manejo psicoterapéutico. Integramos en un contex-

* Sucre 1333, 4° "A", (1478) Buenos Aires.

** Copérnico 2393, 7°, (1425) Buenos Aires.

*** Blanco Encalada 2327, 6°, "C", (1428) Buenos Aires.

to psicoterapéutico lo elaborativo-vivencial con lo interaccional. Centramos la terapia en: 1) La elaboración conjunta de la interacción actual y de sus consecuencias transaccionales recíprocas en la conducta de cada uno de los miembros interactuantes. 2) En la elaboración de las motivaciones de la conducta, aún en su nivel intrapsíquico, pero siempre en su función interdependiente. 3) En la toma de conciencia de sus efectos acumulativos recíprocos y sobre la estructura.

La relación terapéutica. El terapeuta debe establecer una relación múltiple con cada uno de los miembros de la familia, con la familia como conjunto, con la imagen de la familia y con el significado de la interacción disfuncional. Una vivencia emocional positiva compartida, en la cual el terapeuta se convierte en un modelo de relación tácitamente incorporado, favorece el crecimiento afectivo de la familia.

El manejo terapéutico. El terapeuta estimula, por un lado, el proceso de elaboración espontánea interaccional, interviene, por el otro, con señalamientos e interpretaciones. Estas se dirigen siempre a la interacción (complementaria y simétrica) y a sus implicancias motivacionales interdependientes. Promueve la clarificación en la comunicación de los mensajes contradictorios y analógicos, y de doble vínculo; el crecimiento y la diferenciación; y el descubrimiento y desarrollo de las fuerzas positivas de la familia.

Casuística: Se exponen cuatro casos que ejemplifican distintas modalidades de terapia introductoria y de objetivos limitados o prolongados con elaboración a nivel verbal interaccional y utilización de técnicas gráficas, dramáticas y de juego y "sesión comida", en casos específicos.

SUMMARY

A psychotherapeutical approach of the elaborative - dynamic - interactional sort is set forth.

Family - therapy views family as a structure whose components are interdependent. Within this approach, three concepts are essential:

1) The result of personal relationships as something beyond the sum of the personalities involved.

2) The concept of feedback, its accumulative effects and the progressive modification among the interacting individuals.

3) The influence of the actual interaction on the behaviour modification, upon which the therapy centered on the latter is grounded.

The process and the psychotherapeutical handling. The change is conceived as the product of an elaboration both internal and reciprocal. The development takes place within a frame of interpersonal relationship, as a continuous transformation and re-structuration tending to the carrying out of the potential towards new structures. It is always a new creation, being this the change factor through the actual life —experience of the interactional interview.

The elaborative, life-experienced and interactional aspects are integrated in one psychotherapeutical context.

The therapy is centered upon the joint elaboration of the actual interaction, its motivations and the accumulative process, within a positive therapeutical relationship which favors the affective growth of the family. The therapist stimulates the interactional process and intervenes by clearing up interaction and communication. Different family - therapy techniques are illustrated through four clinical cases.

DE LA TERAPIA INDIVIDUAL A LA TERAPIA DE CONTEXTO

Dr. CARLOS MARIA DIAZ USANDIVARAS* y Lic. MARTA WUDKA
DE MAGUD**

El trabajo consiste en un videotape que contiene las secuencias más significativas de un proceso terapéutico completo desde la primera hasta la última sesión, realizado por una terapeuta en formación que efectúa, con éste, su primer tratamiento en Terapia Familiar Sistémica, bajo supervisión en cámara de visión unilateral.

El motivo de la consulta es una escalada de episodios fóbico-obsesivos, de ansiedad y pánico a la muerte, que sufre N., maestra, de 28 años, casada con J.L., técnico, de 31 años. La familia incluye, además, dos hijas, L. y S., de 6 y 4 años, y a A., madre de J.L., viuda, en cuya casa J.L. tiene su taller. Como la del matrimonio está un poco alejada, N. pasa casi todo el día en casa de A., quien, ante la incapacidad de aquélla, se ha hecho prácticamente cargo de sus nietos. N. está en terapia individual de tipo psicoanalítico a dos sesiones semanales, pero, ante su desesperación, comienza, simultáneamente, otro tratamiento similar. No obstante, pese a sus 4 sesiones semanales, consulta, con urgencia, un día domingo, ante una de sus crisis de ansiedad.

Se destaca en el material, cómo al descartar las hipótesis que ellos proponen, que sobreidentifican a N. como enferma, e involucrar a la familia, especialmente al vínculo de J.L., con su madre, surge, ante lo inesperado de la propuesta, una ruptura en la homeostasis del sistema y un principio de cambio, que se va acentuando progresivamente mediante prescripciones de características paradójicas.

Con respecto a la terapeuta, se observan, en el material, sus limitaciones y dificultades iniciales, acentuadas por su experiencia y hábito de trabajo previo, de tipo psicoanalítico; caracterizados por tendencia a la pasividad, rechazo a las intervenciones directivas, etc.; como la lucha inicial por el manejo del poder en el sistema terapeuta-familia, que se logra gracias al apoyo de la supervisión en vivo, en los momentos críticos del proceso.

Se da por terminada la terapia al cabo de 15 sesiones, en un lapso de ocho meses aproximadamente, con remisión o mejoría, casi absoluta de la sintomatología que causara la consulta, con recuperación total de la capacidad vital, funcional y laboral de N., la paciente identificada y modificaciones fundamentales en la relación matrimonial, así como en la estructura de la familia y en sus reglas de funcionamiento.

Con respecto a la terapeuta: a lo largo del proceso se observa el

desarrollo progresivo de sus capacidades, de su creatividad y de su independencia de la supervisión.

Ambas, terapeuta y paciente identificada, han hecho un corrimiento exitoso, de la terapia individual a la terapia de contexto.

SUMMARY

It is a videotape with the most important sequences of a Complete Therapeutic Process, done by a beginner in Family Therapy with direct supervision in a one way mirror room.

N. a teacher of 28 years old, consults about serious anxiety and obsessive symptoms, such as scared of death. She is married to J.L. 31 years old a technical mechanic. The Family includes two children L. and S. of 6 and 4 and A. who is J.L.'s mother, a widow, in whose house J.L. has his work shop.

As the couple's house is far away, M. spends all day in A's house, who looks after the grand children.

N. has a psychoanalytical therapy without any benefits.

The therapists had discarded the hypothesis that the family shows, in which N. is overidentified as the ill person, like her mother, and involves all the family, specially the relation between J.L. and his mother.

This unexpected hypothesis, breaks up the homeostatic cycle and a change begins, continuing pushed by paradoxical prescriptions.

We can also see the therapist work with his initial difficulties: passivity, repels the directives interventions, etc., like the initial struggle for the power in the therapeutic - family system, that is obtained by the support of the direct supervision in the critical moments of the process.

After 15 sessions, in 8 months, the therapy was finished with great improvement in the identified patient's symptoms, changes in the marital relationship, in the family structure and in its functional rules.

The therapist developed her capacity, her creativity and independence of the supervision.

Both, the therapist and the identified patient, had made a successful change, from Individual Therapy to Contextual Therapy.

* Aguado 2205, (1646) San Fernando, Prov. de Buenos Aires.

** Urquiza 2719, (1638) V. López, Prov. de Buenos Aires.

TERAPIA FAMILIAR COMBINADA CON OTRAS TECNICAS INDIVIDUALES

Lic. NIDIA CARRANZA OVIEDO DE BAROCOLA*

Area: Enfermedad orgánica y familia.

Objetivo: Promover el uso de otras técnicas que pueden asociarse a la terapia familiar con la finalidad de producir una rápida distensión sintomática.

Metodología: Trabajo de laboratorio con los participantes; demostración del uso del instrumental y protocolos; ejemplificación de casos con videotape.

Tema: Terapias cognitivas. Cognitivas comportamentales. Entrenamiento en Biofeedback. Entrenamiento con técnicas "Problem Solving" y "assertivity training". Desensitización sistemática.

Estas técnicas terapéuticas no se definen como terapéuticas para la familia, sino como técnicas de autocrecimiento, autocontrol y aprendizaje.

SUMMARY

Area: "Organic Disease and Family"

Object: To promote the use of other techniques that may be associated with the family therapy with the purpose of producing a rapid symptomatic distension.

Methodology: Laboratory work with the participants. Demonstration of the use of instrumental and protocols. Illustration of cases with Videotape.

Subject: Cognitive therapies. Behavioral cognitive therapies. Training in Biofeedback. Training with 'Problem-Solving' techniques and 'Assertivity Training'. Systematic dessensitization.

These techniques are not defined as therapeutic for the family, but as self-growth, self-control and learning techniques.

The video and technical equipment and the tapes will be provided by the author.

UN CUENTO NARRADO COMO UN OBJETO TRANSICIONAL ACTIVADO.

Dr. JULIO CORREA*

La narración de cuentos provee a los padres de una oportunidad de dramatizar y transmitir mensajes sobre contenidos emocionales particulares a sus hijos. El niño podrá entender esta forma de comunicación como un acercamiento del adulto a su lenguaje y a sus necesidades emocionales, con quien comparte la alegría que le provoca el cuento. Por otro lado, el cuento se ofrece como un modelo parental de organización emocional, a través de dos aspectos: 1) Una estructura formal o modo de narración del cuento, por la que el niño comienza un verdadero aprendizaje en su expresividad emocional, y 2) La transmisión de un contenido que tiene que ver con una situación emocional que interesa al niño.

Los cuentos cumplirán pues, a saber, dos funciones: 1) Acompañante en la fantasía; 2) Organizadora a nivel emocional. Si bien el cuento es un objeto cultural introducido por los adultos en la vida del niño, durante un período posterior a la fase en que se genera el objeto transicional (O. T.), puede analogarse a este último, en tanto se conforma intrínsecamente por material imaginario que ayuda al niño a sobrellevar la ansiedad de separación, y promueve en él dependencia afectiva al establecer una adicción por determinados temas o relatos. La estructura misma del cuento integra una dialéctica entre lo real y lo imaginario, zona combinada de experiencias que compone asimismo al O. T. Fundamentalmente, una diferencia básica con el O. T. reside que en su conformación ilusoria no depende del niño tanto como del progenitor narrador que lo construye activamente.

En este trabajo investigamos si en la estructura propia del cuento existe una función similar a la que desempeña el padre narrador, estableciendo un puente comunicacional entre la fantasía del niño y la del padre. Para ello estudiamos cuentos para niños de carácter maravilloso, que según hemos establecido previamente expresan fantasías básicas de la relación parento-filial, acerca de la ansiedad de separación. A fin de caracterizar una función semejante a la del progenitor narrador en el material de cuentos estudiado, ésta se definió como "objeto transicional activado" (O. T. A.), que denomina al producto imaginario resultante de la enseñanza emocional y acompañamiento en la fantasía, inducido por el progenitor a través de la narración de cuentos. Ello pudo demostrarse en los cuentos analizados. Tanto "la Bestia" del cuento de hadas "La Bella y la Bestia", como la abuelita del cuento moderno "La abuelita en el manzano", de Mira Lobe, equivalen a la representación ilusoria de la figura parental ausente, que acompañan en la fantasía al protagonista, y lo organizan emocional-

* Julián Alvarez 2383, 2º, "E", (1425) Buenos Aires.

* Anchorena 1726, P.B., "A", (1425) Buenos Aires.

mente, permitiéndole evolucionar desde el aislamiento hacia la concreción de un vínculo. Se postula que el hada podría representar a la recreación ilusoria de las facultades emocionales enseñadas por el progenitor a través de la narración.

El empleo de cuentos como recurso en la Terapia Familiar, puede ser útil para la elaboración de la ansiedad de separación que se moviliza intensamente, por ejemplo, en la familia del paciente oncológico, al emplear un camino de comunicación olvidado aunque vigente en la organización emocional primitiva de la familia.

SUMMARY

An hypothesis of the narrated story as an "activated transitional object" is proposed, as it needs from an active participation of the parents in the imaginary construction of a transitional space, build up sharing the children's language of phantasy. Narration is offered to children as a parental model of emotional organization: children may learn how to express emotionally guided by the way of narration, as well as to treat with specific emotional problems given in the recreated plot. With the aim of studying if the story structure itself includes a parental story-teller figure, we studied a fairy tale ("Beast and Beauty"), and a modern story for children ("Granny in the apple tree" by Mira Lobe). In both tales, Beast/fairy and Granny respectively, as imaginary counterparts of absent parental figures, accomplish a role in the emotional organization of the hero, leading to make him evolve from isolation to new object relationships.

It is postulated that faries may represent the illusory recreation of the emotional faculties of the parent displayed during narration.

Stories may be employed in particular Family Therapy approaches, making use of a forgotten pathway already present in the family's primitive emotional organization.

ENFOQUES BASICOS DE PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL: TERAPIA MARITAL Y SEXUAL

Dr. CLAUDIO AGUE*

1) La psicoterapia comportamental actual implica dos enfoques fundamentales:

a. La focalización en el intento de obtener comportamientos "normales" y gratificantes, más que en el de eliminar aquellos "enfermos" o indeseados;

b. La acción terapéutica se centra en las necesidades específicas del (de los) cliente(s), a través de un programa "hecho a medida" para suplirlas;

2) Independientemente del tipo de problema(s) presentado(s), estas metas se consiguen:

a. negociando los objetivos del tratamiento a través de un contrato específico;

b. estableciendo una lista de metas comportamentales limitadas, pero claramente definibles, que constituyen acercamientos progresivos a la meta terapéutica final, asegurándose que el cliente entienda y participe activamente en las distintas etapas;

c. ejecución de los distintos comportamientos de sesión en sesión;

d. trabajo conjunto con el terapeuta examinando progresivamente los resultados (o dificultades) obtenidas, identificando los obstáculos "claves" que impiden un cambio comportamental efectivo;

e. cambios actitudinales que refuerzan y/o motivan los cambios comportamentales deseados;

f. si no se obtienen progresos comportamentales, negociando nuevas metas o interrumpiendo el tratamiento.

SUMMARY

1. Present psychotherapy implies two fundamental approaches: a. focussing on the attempt to obtain "normal" and gratifying behaviors rather than on eliminating the "sick" or undesirable ones; b. therapeutic action is centered on the specific needs of the client(s), through a program "tailored" to meet them.

2. Independently of the type of problem(s) presented, these goals are reached by: a. negotiating the objectives of the treatment with a specific contract; b. establishing a list of limited but clearly definable behavioral goals, which constitute progressive approximations to the final therapeutic goal, making sure that the client understands and actively participates in the different steps; c. practicing the different behaviors from session to session; d. co-operation with the therapist to

* Fco. de Vittoria 2350, (1425) Buenos Aires.

examine progressively the results (or impediments), identifying the "key" obstacles that impede an effective behavioral change; e. changes of attitude that reinforce and/or motivate the desired behavioral changes; f. negotiating new goals or suspending the treatment if behavioral progress is not obtained.

LA CONTRA O ANTI-INTELIGENCIA EN LA TERAPIA FAMILIAR

Dr. EDUARDO J. PADILLA*

D. Wechsler define la inteligencia como "la capacidad agregada, o global del individuo para actuar con propósito, para pensar racionalmente y habérselas de manera efectiva con el medio ambiente".

En nuestro trabajo con familias nos hemos encontrado en dos situaciones en las que el nivel de inteligencia del grupo nos ha llamado particularmente la atención.

La primera en una familia en la que los miembros discurrían en un nivel de abstracción inusual y con un gran despliegue de vocabulario, escuchando luego las intervenciones del terapeuta familiar (TF) con un conmiserativo silencio, haciéndole sentir que sus aportes eran simplezas o perogrulladas de quien le faltaba más vuelo de inteligencia para llegar a sus alturas: en suma, un estudiante secundario en medio de un grupo de oxfordianos. Costó trabajo descubrir que tras la actitud de "ya lo sabemos" el grupo tampoco entendía nada de lo que hablaban. Aquí el paciente designado (PD) tuvo un brote esquizofrénico en su adolescencia.

En segundo lugar, en el polo opuesto, nos encontramos con una familia en que el nivel general de inteligencia aparecía como llamativamente pobre. El TF trataba de adecuar su vocabulario al magro del grupo para ser lo más simple y coloquial posible. Pero sus intervenciones eran escuchadas con aire de desconcierto para finalmente concluir que eran "cosas rebuscadas" ("no hay que pensar tanto") que nada tenían que ver con la sencilla realidad cotidiana de la familia. El grupo se aburría ostensiblemente y las conversaciones giraban alrededor de temas baladíes en una dispersión permanente. Todos, excepto el padre, tenían o habían tenido notorias dificultades en sus estudios. Este, generalmente asistía con regocijo a la esterilización del TF. La PD se comportaba como una niña de pocas luces en vez de como la adulta joven que era. Al comenzar su tratamiento presentaba síntomas histéricos y psicóticos de tipo paranoide y su C.I. estaba en el límite inferior de la normalidad, índice que mejoró para situarse en el nivel promedio en un re-test tomado al año de iniciado su tratamiento.

En ambos casos notamos un uso peculiar de la inteligencia, que en vez de estar al servicio de la vida, —esto es a unir, sintetizar, adquirir conocimientos, conservarlos, elaborarlos— había sido puesta al servicio de una "anti-vida", para impedir la adquisición de nuevos conocimientos que conllevaran a un crecimiento verdadero.

A este uso de la inteligencia como una fuerza poderosa, encubierta y constante, la llamamos "anti-inteligencia" o "contra-inteligencia", término este último utilizado por I. Luzuriaga para describir un

* Sevilla 2922, (1425) Buenos Aires.

fenómeno similar en sus pacientes individuales, antecedente que nos ha hecho inclinar por el uso preferencial de éste.

Al decir de M. Mannoni, aquí "la inteligencia se ha estructurado de tal modo que, en vez de ser interrogación sobre la vida y la muerte, se ha convertido ella misma en esa muerte. Se obtiene allí la respuesta de un sujeto que se desea castrado para no tener que interrogarse sobre nada".

Frente a estos ataques a las funciones cognoscitivas, el TF deberá buscar una estrategia adecuada para lograr que el grupo tome conciencia de la utilización de estos mecanismos contra-inteligentes, los motivos por los que son utilizados del enorme monto de energía que insumen para la destrucción y la forma en que puede ser reencauzado para una vida mejor.

En este "workshop" se trabaja con familias simuladas de características como las descriptas.

SUMMARY

We have been struck by the way certain families neutralise the use of intelligence. In Family Therapy this has been specially noticed in two opposite kinds of groups: those who seem so extremely intelligent that the therapist feels an uneasy sensation of "nothing worth while saying", and those who seem so dull that most of his interventions are disqualified as ununderstandable or "far fetched".

In both cases we have felt subjected to the use of a continuous, powerful and unconscious force against intelligence, i. e., against growth and life itself.

ACERCA DEL CASO SCHREBER. CONSIDERACIONES SOBRE SU PROGRAMACION DESDE LA PERSPECTIVA FAMILIAR

Dra. ELSA LABOS* y Lic. AIDA TARRAB**

En este trabajo se trata de desarrollar una teoría hipotética de la *dinámica vincular parento-filial* presente durante la formación psicopatológica del cuadro psicótico de Daniel P. Schreber.

Desde la vertiente psicoanalítica y la T. de la Comunicación se hacen aportes para la reconstrucción de la dinámica de los vínculos infantiles. Se muestra el mapa generacional de Daniel Schreber y se posibilita así un acercamiento a la comprensión de la patología individual desde una vertiente histórico-generacional. El trabajo sigue el lineamiento dinámico de las posibles configuraciones edípicas de los dos Schreber (padre e hijo) y las distintas organizaciones de fantasías inconscientes vinculares que probablemente se dieron dentro del campo comunicativo vincular. El estudio está basado en la búsqueda de indicios y señales dentro de los discursos del padre y del hijo (tal como aparecen en el libro *Guía para la educación*, de Daniel Gotlieb Moritz Schreber y las *Memorias* de Daniel P. Schreber) y de otros textos.

Se discuten las posibles vicisitudes de la interacción parental. Se infiere con respecto a los padres de Daniel P. Schreber la existencia de una relación complementaria marital rígida y concordante, con vaciamiento de la función afectiva materna. Esto significará para el pequeño Daniel Schreber un "splitting" sensorial temprano, una modalidad de identificación determinada y una cosificación de la relación vincular que lo llevará a fracturar en él toda la vertiente afectiva de su propia demanda. Desarrollará prematuramente funciones yoicas coercitivas y sofocará las libidinales creándose un Super-yo precoz, sádico, que lo inducirá a sentir el "placer" por el dolor y la obediencia. Así también este vaciamiento de la función materna va a surgir en la construcción delirante que hizo Schreber posteriormente en su creencia de haberse convertido en mujer y ser una madre fecunda.

Se exponen todos los aspectos que están en juego en la interacción y se explica el concepto de "procesamiento vincular". Se muestra cómo los procesos primarios de integración del Self corporal son dependientes de la funcionalidad de los objetos externos. Y cómo cuando fallan en su estructuración todo el *aparato sensorio-perceptual-motor* queda distorsionado sobre la base de la patología del proceso proyectivo-introyectivo, y la simbolización es utilizada por el proceso primario.

La "*dinámica vincular*" parento-filial es considerada como "una organización de fantasías vinculares multipersonales". Esta hipótesis es de suma importancia no sólo porque establece una nueva teoría de la

* Villanueva 1365, 1° (1426) Buenos Aires.

** Arcos 1641, 10°, "A", (1426) Buenos Aires.

psicosis sino también por las consecuencias que tiene para la teoría de la Técnica y para la Prevención.

Por último surge el interrogante sobre si es el psicótico manifiesto una estructura irreductible o es más bien un estado que mediante múltiples combinaciones procede de un ámbito "psicotizante" derivado de las interacciones de los aspectos psicóticos de las propias figuras parentales, las que no necesariamente se expresan en psicosis clínicas.

SUMMARY

This paper aims at developing a hypothetical theory of the *parent-child bond dynamics* present during the psychopathologic formation of Daniel P. Schreber's psychotic symptoms.

Contributions towards the reconstruction of the dynamics of the child bonds are made from the psychoanalytical perspective and from the theory of communication. Daniel Schreber's generational map is shown, making thus possible an approach to the understanding of the individual pathology from a historical-generational perspective. The paper follows the dynamic lineaments of the possible oedipal configurations of both Schreber (father and son), and the different organizations of the unconscious bond-related fantasies which probably happened inside the communicative field related to the bond.

The *parent-child bond dynamics* is considered as being an "organization of multipersonal bond-related fantasies." This hypothesis not only sets up a new theory of psychosis but also has important consequences for the theory of the technique, and in the field of prevention.

TIEMPO PARA VIVIR

Lic. ESTERA GORANSKY*

* Santa Fe 435 Oeste, (5400) San Juan.

MODELO DE RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA VINCULAR COMO EJE DE LA TERAPEUTICA FAMILIAR, INSTRUMENTADO POR EL SERVICIO SOCIAL

Lic. AMELIA BURLO MENDOZA* y Lic. MARTA VILLEGAS**

* Las Heras 2371, 9º, "F", (1425) Buenos Aires.

** Olazábal 5520, 1º, "B", (1431) Buenos Aires.

PRIMERA ESCUELA PRIVADA DE PSICOLOGIA SOCIAL

Fundada por el Dr. Enrique Pichon-Rivière

Taller para la FORMACION DE PSICOTERAPEUTAS

Coordinación: Lic. José Töpf.

Temario: Teoría Psicoanalítica: Freud - M. Klein - Fairbairn - Winnicott.

Desarrollos teórico-técnicos de E. Pichon-Rivière: La Teoría de la Enfermedad Unica.

Duración: 3 años.

Dos niveles:

- a) Profesionales que se inician en Psicoterapia y estudiantes avanzados.
- b) Psicoterapeutas en ejercicio.

Informes: Carlos Calvo y 24 de noviembre - Tel. 93-1907 - 10 a 20 horas.

SEMINARIOS



**centro médico
psicológico
buenos aires**

Director:

Dr. Octavio Fernández Mouján

Secr. de Asistencia:

Dr. Sergio Bruzzo Iraola

Secr. de Prevención:

Lic. Alicia Beramendi

Secr. de Docencia:

Dra. Ana Goldberg

Departamentos Asistenciales: ADULTOS, LA MUJER, PSIQUIATRIA SOCIAL (Comunidad Terapéutica Diurna, Psiquiatría Clínica, Tercera Edad), GRUPOS, FAMILIA Y PAREJA, INFANTO-JUVENIL, MEDICINA INTEGRAL y PSICOPEDAGOGIA.

- Terapias individuales, de pareja, familiares, grupales, psicopedagogía.
- Talleres de Reflexión, orientación vocacional, etc.
- Escuela de Formación de Post-Grado en Salud Mental, Seminarios, etc.

ORO 2242 — (1425) BUENOS AIRES — Tel. 773-8289 y 772-8851

EMPRESAS Y FAMILIA, INTERVENCION EN UN CAMPO TRANSICIONAL

Lic. CARLOS E. SREBROW*

Algunas familias desarrollan una estrategia muy especial para el abordaje y el manejo de la realidad externa, como así también para el desenvolvimiento de su dramática interna: levantan un escenario, implementan un proceso, definen un espacio, un tiempo, crean un producto, una marca; hacen una Empresa.

Dada su dimensión, estructuración e historia conforman una familia con distintos grados de realidad. Puede estar presente en su totalidad (una, dos o tres generaciones), en forma parcial o fuertemente evocada de forma tal que todas las relaciones internas y contextuales quedan teñidas por los rasgos típicos del grupo primario.

Esta producción familiar, este espacio intermediador entre realidad interna y el mundo, podemos visualizarlo como un espacio u objeto transicional, tal como lo ha definido Winnicott. En él se produce el encuentro entre el sistema familiar y el organizacional dando por resultado una totalidad compleja. Algunas veces este mecanismo tiene éxito, otras no. ¿En qué términos debe ser medido? ¿En lo individual, en lo familiar, en lo organizacional? En todos los casos, este campo, entre la fantasía y la realidad y en donde lo subjetivo y objetivo conviven con mayor proximidad, permite el desarrollo de una urdimbre confusa y enmarañada, donde los participantes traman sus respectivos proyectos personales, familiares y empresarios en un juego de permanente pulsión entre la discriminación y la indiscriminación, con distintas dosis de placer, de dolor, y hasta de trampa diabólica.

La empresa como área transicional alimenta la "ilusión familiar" de convivencia armónica entre su realidad interna y la realidad externa con sus exigencias de eficacia y resultados concretos. Esta "ilusión" puede generar situaciones creativas, atrapantes o muchas veces autodestructivas.

Esta visión de la organización descentra la mira psicosocial de las relaciones interpersonales hacia la particular relación de cada integrante con los objetos, los objetivos y con la organización misma como objeto total. De esta forma queda planteado al mismo tiempo el grado en que

* Antezana 218, (1414) Buenos Aires.

cada uno y el grupo puede acompañar el crecimiento, abandonando relaciones con objetos obsoletos, y transfiriendo catexia a los nuevos sin alienarlos.

El conflicto y la resistencia al cambio estarían asentados justamente en este espacio intermedio, en los objetos que lo pueblan y en la dificultad de transferir e incluir otros.

Intervenir organizacionalmente en este tipo de empresa es transformarse uno también en una herramienta familiar transicional, ubicado entre la racionalidad administrativa, técnica, económica y la comprensión psicosocial.

Al manipular y transformar conjuntamente con los integrantes los objetos organizacionales estamos modificando cualitativamente la totalidad y afectando su racionalidad. Dicha racionalidad no se brinda fácilmente al análisis y es fundamental tener en cuenta que toda desmistificación es más rápida que la lenta labor de remitificar.

El abordaje de estas organizaciones es posible mediante el Análisis Organizacional, herramienta multidisciplinaria producto de la convergencia de distintas vertientes; la administración, la tecnología y las ciencias del comportamiento. Su desarrollo data de las últimas décadas y surge como respuesta a la limitación de cada disciplina para enfrentar el conflicto y el cambio planificado.

SUMMARY

Some families develop a very special strategy for the approach to and handling of external reality, as well as for the unfolding of their internal dynamics: they build up a setting, implement a process, define a space, a time, they create a product, a trademark; they build a BUSINESS CONCERN.

This mediating space between internal reality and external world can be visualized as a transitional space, as defined by Winnicott. An indistinct and entangled plot takes place in it. Participants weave their own personal, family and business projects in a wavering movement between discrimination and indiscriminability.

This notion of the organization as a transitional space crowded by transitional objects turns the psychosocial scrutiny off center towards the particular relationship of each member with objects and with the organization as a total object.

To operate organizationally on this type of business concern is to become a transitional instrument placed between organizational and family rationality.

By means of Organizational Analysis, a product of the convergency of different disciplines (management, technology and the sciences of human behaviour), a planned approach to conflict and change is possible.

RESIDENCIA TERAPEUTICA INTERMEDIA: RELATO DE UNA EXPERIENCIA CLINICA EN UNA INSTITUCION ABIERTA ESTRUCTURADA COMO FAMILIA TERAPEUTICA.

Dr. FELIPE DIAZ USANDIVARAS* y equipo de trabajo

La institución está planteada en cuatro áreas autónomas, edilicia y conceptualmente. Estas son: Centro Institucional, Clínica Psiquiátrica, Comunidad del Tiempo (Hospital de día comunitario) y *Residencia Terapéutica Intermedia*.

La denominamos *Témpora, Institución Psicoterapéutica*.

Nos proponemos considerar:

1. Un modelo de organización familiar, con normatividad afectiva con asunción de roles parentales. Una transmisión de la autoridad, vertical en el sentido parental, y horizontal en el sentido de los pares.

2. Que el paciente se encuentre en el nivel evolutivo en el que necesite maduración intra-familiar. Es decir en un nivel previo a la inserción "Social". En este sentido decimos que es en un nivel previo a la Comunicación Terapéutica, que denominamos Familia Terapéutica. Dicho de otra forma el objetivo sería replicar la casa de familia y no la comunidad social.

3. Brindar un continente transitorio (teniendo en cuenta lo incontenible que es en sí misma la locura) donde el éxito terapéutico está ligado a la celebración de la partida del hijo.

4. Como con toda familia, consideramos la existencia de un sistema con una estructura inconsciente.

Descripción: La Residencia Terapéutica Intermedia está destinada al tratamiento de pacientes recuperables. Estos viven en un *clima* que consideramos esencial para que se geste y transcurra el proceso terapéutico.

Los pacientes, que llamamos Residentes, tienen autonomía total y llave del lugar, viviendo en un ámbito que cuenta con una organización familiar y se propone como espacio para el crecimiento adecuado que no fue posibilitado por la familia de origen (genuina).

La denominamos *Residencia*: Porque es el lugar donde se vive. Allí reside y se aloja el residente. *Lo reiteramos: En ella nadie se interna, se aloja.*

Terapéutica: Porque en su *clima* transcurre el proceso terapéutico y buscamos que todo en ella refuerce este proceso, siendo conscientes de que no todo es terapéutico, pero que es válido buscar que lo sea.

Intermedia: Porque es un lugar transitorio, que intermedia el tiempo y el espacio necesario, mientras se instituye la imago familiar y el proceso permanente de discriminación y organización permite salir de la confusión.⁴

Media, en el logro de la identidad, en el incremento de los capitales

* Soler 5951/61, (1425) Buenos Aires.

yoicos y la modificación del carácter y las conductas al proponer nuevos modelos en un ámbito continente. Intermedia desde el proceso agudo a la curación, desde la incapacidad hacia la proximidad de un desarrollo socio-económico propio.

Intermedia entre Terapeutas, Institución, Familia y Paciente Designado para que éste deje de serlo, al tiempo que la familia toda se va haciendo cargo de sus conflictos.

El diseño: Replicar la casa de Familia.

Ubicada en Palermo viejo, con capacidad para 22 residentes, gimnasio, talleres de terapia ocupacional, libre expresión, plástica, musicoterapia, expresión corporal, formación corporal y áreas de recreación. Consultorios, Administración, Coordinación y Dirección.

1. *De la Admisión:* Adolescentes y adultos de ambos sexos, curables (nos identificamos con la curabilidad de las psicosis). No admitimos: Gerontes, débiles, lesionados, defectuados, psicópatas y adictos. Deben tener terapia familiar e individual.

2. *Autonomía:* Los residentes poseen autonomía total o deben poder tenerla en poco tiempo. La puerta de la Residencia está abierta y los residentes tienen llave de la institución.

3. *Reglamento:* No hay un reglamento escrito. Las reglas se transmiten oralmente como en toda familia. Estas se elaboran y se ajustan desde el grupo de convivencia, actividad obligatoria para el residente, y desde el consejo de dirección que funciona como un consejo de familia.

4. *Comunicación:* Abierta permanentemente y cuidada por todos por su importancia.

5. *Información:* Acceso a toda la información que inquiete.

6. *Organización:* Hay un sentido vertical desde los asesores, directores, coordinadores, médico administrador, asistente terapéutico, padrinos. Y en un sentido horizontal que tiene que ver con los pares y la hermandad que circula por los residentes, talleristas, acompañantes, y auxiliares terapéuticos, etc.

7. *Festejos:* Cumpleaños, fiestas religiosas, fin de año. Y todo acontecimiento significativo para cualquier residente.

8. *La llave:* En reuniones organizadas a tal fin y con el ceremonial que se justifica se le entrega la llave de la institución al residente que ya tiene autonomía total.

Objetivos:

1) Posibilidad de replantear el tiempo del desprendimiento familiar como proceso evolutivo previo a la inserción social y laboral.

2) Organizar el tiempo de paciente.

3) Organizar la actividad del paciente.

4) Discriminar desde la admisión los riesgos de la cronicidad y plantear toda actividad para la re-habilitación, que no la consideramos ligada a la cronicidad.

5) Integrarse en el proceso psicoterapéutico.

6) Catalizar el afecto terapéutico de los pares.

7) Lograr conciencia de enfermedad.

8) Ambito de elaboración interaccional con pares.

Indicaciones:

1) Descompensación psicótica no aguda.

2) Post internación inmediata.

3) Pacientes borderline.

4) Ruptura y/o ausencia temporaria o definitiva de medio familiar.

5) Pacientes con residencia en el interior.

6) Medio familiar no continente.

7) Integrar, complementar o posibilitar la terapia familiar.

8) Alternativa temporaria durante la psicoterapia.

9) Pacientes identificados como tales en medios sociales reducidos.

SUMMARY

It is an experience report about a middle-way House. It is actually located in the same building of an Institution with other areas such as the Psychiatric Clinic itself, the Community of Time, Institutional Center and this House called Intermediate Therapeutical Residence.

We consider the cure process is made through certain characteristics:

1) A family structure with laws supported by affects.

2) We try to reproduce the family house instead of the social community. Because we think the family evolution is precious. That's why we call this work-model a Therapeutical Family.

3) We provide a meanwhile-place where the cure comes by hand with the celebration of the son's leaving.

4) Like in any ordinary family we have as a fact an unconscious structure. The patients whom we call Residents are completely free and they have the front door key.

Objectives:

1) Organize the residents life time.

2) Organize their activity.

3) Help a Social and Work re-habilitation.

4) Arrive to a self illness conscience.

5) Provide a support to the therapy process.

CAMBIOS DE UNA INSTITUCION DERIVADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE FAMILIAR SISTEMICO

Dra. EVELINA S. DE COSTA*; Dra. SUSANA B. DE PROCUPET*;
Dr. JUAN ENRIQUE KUSNIR*; Dr. MIGUEL J. MIHANOVICH*;
Lic. OFELIA ELIAS*

La Institución C.E.A.M., es la continuadora de la obra y el esfuerzo de Telma Reca, iniciado en 1934, para llevar al terreno práctico sus convicciones y criterios teóricos. En C.E.A.M. han quedado integradas y desarrolladas todas las tareas de docencia, investigación y asistencia, del Departamento de Psicología y Psicopatología de la Niñez y Adolescencia dependiente de la Universidad de Buenos Aires.

C.E.A.M., que en sus quince años de vida, ha admitido y sigue admitiendo cambios, procura mantener una suerte de homeostasis y transformación continuas, siempre y cuando ello implique el permanecer fieles a ciertos principios y valores humanísticos y científicos.

Tanto por el enfoque nuestro, como por la circunstancia de la especialidad en niños y adolescentes, la inserción del abordaje terapéutico familiar sistémico se nos da como facilitado. La consideración de lo familiar y el espacio terapéutico dedicado a los padres ha sido una constante en la Institución. Nunca hemos atendido un niño, sin atender las necesidades de los padres referidos a: la fundamentación y clarificación del cuadro, su orientación, la modificación de criterios y actitudes educativas, eventualmente el tratamiento parental y el asesoramiento pedagógico.

¿Por qué lo sistémico ahora como otra alternativa? Porque conocedores del Grupo Palo Alto, de sus experiencias y resultados, algunos de los integrantes del equipo se plantearon viajar e incursionar en "vivo y en directo" en sus cursos de capacitación. Y porque después del rechazo inicial de técnicas vividas como agresivas o manipuladoras, rechazo de lo nuevo, en suma, resistencia al cambio, se fue dando la profundización, el estudio de la teoría: "una nueva lección circular de todo el proceso familiar", "la familia aquí y ahora", ante nosotros, sin mediatizarla. La observación de fenómenos clínicamente comprobables, de procesos más complejos y completos de la interacción familiar, de la comunicación y sus características de retroalimentación de la teoría general de los sistemas y sus praxis en nuestra área específica, serían entre otras, las reflexiones llevadas a cabo por el equipo.

Resonancias en la Institución

El interés creciente de algunos profesionales que a través de seminarios o grupos de estudio, dentro y fuera de la Institución, buscan un conocimiento más acabado del enfoque. Interés en viajar y conocer otros grupos.

* Integrantes de un equipo del CEAM. 11 de setiembre 1980/88, (1426) Bs. As.

Surgen también aspectos tensionales a resolver, referidos a los encuadres institucionales de la tarea, a conflictos de lealtades que se actualizan, el miedo y resistencia al cambio, a las dificultades organizativas, etc. En suma, el juego de las homeostasis institucional: lo morfoestático versus lo morfogenético.

Dentro de la ideología institucional se va logrando la aceptación de la terapia familiar con su propio espacio. La creación y visualización del equipo con tareas asistenciales y de investigación, en la búsqueda del propio estilo, afín al estilo institucional.

Esto mismo confluye hacia la concreción de seminarios, reuniones y ateneos internos referidos a los aspectos teóricos, a la experiencia concreta y a su integración con la modalidad institucional. Se originan también cambios en la derivación al equipo, desde los casos graves para ser vistos con una "técnica nueva y mágica" a la derivación directa como forma regular del diagnóstico.

Dentro de estos cambios que van ocurriendo, se incluye el proceso de definir la tarea que implica varios niveles: la integración acabada del equipo con su adecuado entrenamiento, el establecimiento de sus pautas de funcionamiento, la determinación de las formas de recepción de las familias para su tratamiento incluyendo las distintas modalidades de derivación, las relaciones o articulaciones con los terapeutas de algunos de los miembros de la familia, etc. Implica también precisar las metas posibles, el encuadre (tiempo, frecuencia, número de entrevistas, roles) es decir, definir la teoría de la técnica y la técnica misma.

Una Institución con quince años de trayectoria ha consolidado muchos logros, una experiencia definida en su modalidad de trabajo, un estilo en el diagnóstico y tratamiento, producto de un enfoque y una larga experiencia clínica; una Institución que ha crecido y logrado cambios, tanto en lo asistencial como docente. Esta Institución, debe plantearse si ante la nueva experiencia debe tender hacia una reacomodación que en lo asistencial deje de operar desde el "paciente referido" a la familia en su totalidad con enfoque sistémico y diagnóstico terapéutico.

Con un criterio de circularidad pensamos que desde la Institución se retroalimentará al equipo de la experiencia que a su vez hace una devolución a la Institución. Esta dará sus respuestas y se irán señalando las líneas de acción más conducentes al logro de una funcionalidad lo más óptima posible.

Intercambios de Ideas y Experiencias en el Seminario del Congreso

El seminario se enriqueció con los aportes de dos instituciones: de un Hospital Regional de Salud Mental, de Neuquén y de una Institución privada con internación, en la Ciudad de Paraná. Tanto en uno como en otro caso se verificaron cambios con la introducción de la T.F.S. que de alguna manera se proyectaban al total de la Institución.

Cambio y mismidad llevada a una institución que tiene un largo proceso ("ciclo vital"), recorrido con pautas, reglas establecidas, etc. Puede implicar una crisis en el proceso de esa institución; puede

incorporar el cambio modificando parcialidades o no lo logrará y sectores de esa institución se apartarán para constituir otros nuevos sin el total peso de los anteriores objetivos o metas.

SUMMARY

Since 1934 dates the work of Telma Reca a psychiatric pionner in Argentine, whose theoretic criteria keeps on the going at C.E.A.M., an Institution over fifteen years now on the private field. Integration and development of new ideas and investigation are always welcomed if certain humanistic and scientific principles and values, are kept unmodified by them.

The social and family context of children and adolescents have always been taken into consideration in our therapeutic approaches. This seems to facilitate the experience of the group as regard this new model of therapy. This paper analyzes the possible changes which must be taken into consideration in the application of this new model in our Institution implying a proper experience and evaluation of all the variables that facilitates or on the contrary perturbs the work whether of the Institution or the group in its experience.

A psychotherapeutical approach of the elaborative - dynamic - interactional sort is set forth.

Family-therapy views family as a structure whose components are interdependent. Within this approach, three concepts are essential:

1. The result of personal relationships as something beyond the sum of the personalities involved.

2. The concept of feedback, its accumulative effects and the progressive modification among the interacting individuals.

3. The influence of the actual interaction on the behaviour modification, upon which the therapy centered on the latter is grounded.

The process and the psychotherapeutical handling. The change is conceived as the product of an elaboration both internal and reciprocal. The development takes place within a frame of interpersonal relationship, as a continuous transformation and re-structuration tending to the carrying out of the potential towards new structures. It is always a new creation, being this the change factor through the actual life —experience of the interactional interview.

The elaborative, life —experienced and interactional aspects are integrated in one psychotherapeutical context.

The therapy is centered upon the joint elaboration of the actual interaction, its motivations and the accumulative process, within a positive therapeutical relationship which favors the affective growth of the family. The therapist stimulates the interactional process and intervenes by clearing up interaction and communication. Different family-therapy techniques are illustrated through four clinical cases.

PSICOLOGIA DE LA VIDA COTIDIANA EN EL GRUPO FAMILIAR

Dr. MARCOS BERSTEIN*

Desarrollaremos siete categorías de análisis:

- 1) **AMBITOS:** a) Psicosocial: estudiamos a cada integrante del grupo familiar, la visión que tiene de los demás, y en cuánto coincide con la realidad. b) socio-dinámico: investigamos la interrelación entre los integrantes, roles, liderazgos, sistemas de poder, etc. c) Institucional: estudiamos las relaciones del grupo con las instituciones: laborales, educativas, recreativas, religiones, etc. d) Comunitario: indagamos las relaciones del grupo con la comunidad.

- 2) **PREHISTORIA:** La unidad mínima de análisis abarca tres generaciones: hijos, padres y abuelos. Un ejemplo: los nombres que cada hijo lleva, y que los marcan a veces con un destino, por el monto de espectativas depositadas.

- 3) **ECONOMIA:** Investigamos cómo se la maneja en el grupo, y cómo esto determina modos de interacción. Un ejemplo: el hombre somete económicamente a la mujer, y ésta se rebela rechazándolo en el requerimiento sexual.

- 4) **CEREMONIALES:** Por ejemplo, los que se realizan a la hora de las comidas: horarios, ubicación en la mesa, etc.

- 5) **EVOLUCION DEL GRUPO FAMILIAR DESDE LA PAREJA:** Estudiamos algunas motivaciones inconscientes por las que formaron pareja: a) para poder salir del grupo familiar de origen: se adosa al grupo del cónyuge. b) para poder quedarse en el grupo familiar de origen: se adosa al cónyuge al grupo propio. c) para sacar al otro del grupo familiar de origen: es por envidia al grupo que tiene el cónyuge, que es más afectivo que el propio.

- 6) **DUELO CENTRAL NO ELABORADO:** Investigamos:

- A) Duelo parental familiar: por la pérdida de grupos familiares de origen.

- B) Duelo conyugal familiar: por la pérdida de la intimidad de la pareja, al nacer los hijos.

Estudiamos aquí algunas de las motivaciones inconscientes para tener hijos, y el "abuelado": a) para salir del grupo familiar de origen: necesita tener un hijo para demostrar que ya es "grande". Acá toman el poder los padres del otro cónyuge. b) para quedarse en el grupo familiar de origen: necesita recibir a través de lo que sus padres le dan a su hijo, lo que no recibió siendo hijo. Toman el poder los padres de este conyuge. c) para sacar al otro del grupo familiar de origen: necesita un hijo para que el cónyuge tenga que cuidarlo y no vaya tanto al grupo de origen.

- C) duelos de los hijos: por las sucesivas pérdidas: claustro uterino, pecho, mamadera, chupete, etc.

* Pueyrredón 1937, 6º, (1119) Buenos Aires.

A, B y C confluyen formando el duelo central no elaborado.

D) Duelo actual o desencadenante: por situaciones de pérdidas actuales: muerte, separación, hijos que se van (por estudio, casamiento, etc.), jubilación, menopausia, etc.

Hay que trabajar con el duelo actual, pero este nos remite siempre al duelo central.

7) *VECTORES DEL CONO INVERTIDO*: A) Afiliación y pertenencia: grado de identificación entre sí y con la tarea. B) Cooperación: capacidad de ayudarse entre sí y al terapeuta. C) Pertinencia: capacidad de centrarse en la tarea. D) Comunicación: Distinguimos tres niveles:

a) Oral: es el más regresivo. Hay quejas y demandas constantes y recíprocas. (Nivel narcicista: se exige que el otro satisfaga todos los deseos.)

b) Anal: menos regresivo. Períodos de expulsividad y retentividad. Agresiones y arrepentimientos. Culpa e intentos de reparación.

c) Genital: el más evolucionado. Puede cada uno ponerse en el lugar del otro.

En la comunicación investigamos también los cortocircuitos, los malentendidos, y los secretos familiares (que todos saben pero nadie dice).

E) Aprendizaje: de los roles básicos: esposo-esposa, padre-madre, hijo-hermano, etc.

F) Telé: estudiamos los sentimientos actuales de atracción o rechazo, que remiten a personajes arcaicos del mundo interno. Todo encuentro en un reencuentro.

Si falla Pertinencia es porque no hay buena Cooperación; y eso significa que algo anda mal en Afiliación-Pertenencia.

Si Telé está mal, eso remite que algo anda mal en Aprendizaje, lo cual significa que está fallando la Comunicación.

Conclusión

Todas estas categorías de análisis que hemos desarrollado constituyen un esquema de orientación básica para leer e interpretar las conductas de los integrantes del grupo familiar. Constituyen un esquema que, incorporado al ECRO (Esquema Conceptual, Referencial y Operativo) del agente corrector, puede ayudarlo a sistematizar y a planificar cada momento del proceso terapéutico.

Este esquema no constituye algo rígido y estereotipado, sino que en su aplicación se realizan los cambios y adaptaciones necesarios para cada caso. Creo, sin embargo, que como guía o como modelo, es válido.

Es una posibilidad de abordaje que planteo como modelo de pensamiento, como un punto a partir del cual se pueden desarrollar múltiples posibilidades.

Resumen

En este trabajo hacemos un enfoque de la psicología de la vida cotidiana en el grupo familiar. Consideramos que es de fundamental importancia para la comprensión y abordaje de los fenómenos de interacción dentro de la familia.

Se desarrollan aquí diferentes categorías de análisis: 1) Ambitos o niveles. 2) La prehistoria. 3) La economía. 4) Los ceremoniales. 5) La evolución del grupo familiar desde la pareja. 6) El duelo central no elaborado. 7) Los vectores del cono invertido.

Realizamos en este trabajo una descripción fenoménica de conductas y situaciones de la vida cotidiana en el grupo familiar; analizamos también los psicodinamismos y las motivaciones inconscientes que subyacen a dichas conductas manifiestas.

SUMMARY

In this report we make an approach to the psychology of daily life in the family group. We consider it highly important to the comprehension and approach to the phenomena of interaction inside the family group.

We find different categories of analysis: 1) Environment or levels. 2) The background. 3) The financial position. 4) The ceremonials. 5) The evolution of the family group since the constitution of the couple. 6) The non elaborated central loss. 7) The vectors of the inverted cone.

In this report we make a phenomenological description of the behaviours and situations of every day in the family group; we also analyze the psychodynamics and the unconscious motivations which underlie such manifest behaviours.

TRATAMIENTO DEL GRUPO FAMILIAR CON PSICOSIS

Dr. LUIS A. ALBORNOZ¹; Dr. SAVERIO A. GUZZO²; Dr. NORBERTO MASCARO³; Lic. MARIA E. MITRE⁴; Dr. JORGE ALONSO⁵.

Tomamos como marco general el modelo ideológico del Dr. Jorge García Badaracco. Estas familias presentan diversos grados de simbiosis y alianzas patológicas entre sus miembros, con ruptura de límites intergeneracionales; sus roles inconscientes, están estructurados sobre fantasías primitivas; actuando en términos de ecuación simbólica, este tipo de interacción, mantiene una homeostasis que distorsiona el intento de individuación. (Desarrollo del aparato psicológico individual), agravando la indiferenciación YO/NO YO. El uso de la comunicación como control del otro, favorece el origen de identificaciones primarias patológicas, estructuras autónomas con respecto a un YO débil (falta de desarrollo yoico genuinos e inmadurez del aparato psicológico) apareciendo síntomas en sus miembros de diferentes grados y formas. El terapeuta creará un clima de confianza, "aliándose" a los aspectos simbióticos patológicos; pero saliendo de los mismos al aportar elementos físicos y emocionales de realidad, contención, apoyo dando posibilidad de pensar, usará el señalamiento e interpretación individual y grupal, trabajará en relación a las figuras familiares paternas reales o virtuales de cada generación. Modificará el sistema familiar, facilitando un redesarrollo de las potencialidades sanas dando identificaciones positivas en contacto con la realidad en la resolución de sus problemas o conflictos, el grupo encontrará una persona que los guíe y enfrente a sus miedos. (Estructura ésta que los atrapa y los identifica). Los mecanismos primitivos omnipotentes de disociación, negación, favorecen actuaciones severas al ser integrados a la estructura sana del aparato psicológico, durante este proceso terapéutico, se tendrá suma prudencia. (Suicidios, enfermedades psicosomáticas, etc.).

SUMMARY

We take into account the general ideological model of Dr. Jorge García Badaracco. These families present different degrees of symbiosis and pathologic alliances among their members, with breaking of the intergenerational limits; their subconscious roles are build on primitive fantasies; acting in terms of symbolic equation, this type of interaction maintains an homeostatics which distorts the intent of individua-

lization (Development of the individual psychological apparatus), aggravating the indifferentiation EGO/NO EGO. The use of communication as a control over the other, helps to the origination of primary pathological identifications, autonomous structures with reference to a weak EGO (lack of genuine EGO - development and immaturity of the psychological apparatus), appearing symptoms of different degrees and forms in their members. The therapist will create a psychological atmosphere, forming an alliance structurally with the symbiotic pathological aspects; but transforming them when adding emotional and physical elements of reality, continence, support, giving the opportunity of thinking, he will use the pointing, and the interpretation for an individual and for a group, working in relation to the real or virtual paternal familiar figures of each generation. He will also modify the family system, through paradoxical prescriptions facilitating a redevelopment of the same potentialities, giving positive identifications in contact with reality, in the resolution of their problems or conflicts, the group will find a person who will guide them and will face their fears (this structure overtakes and identifies them). The omnipotent primitive mechanisms of dissociation and negation, favor severe ac-tuations when they are integrated to the same structure of the individual psychological apparatus; during this therapeutic process, the possibility of suicide, psychosomatic illnesses and abandonment of the treatment, will be controlled.

1 Arcos 1737, P.B., "A", (1426) Buenos Aires.

2 Ciudad de la Paz 3057, (1429) Buenos Aires.

3 Tapiales 1413, (1638) Vicente López, Prov. de Bs. Aires.

4 Gelly y Obes 2249, 2º, (1425) Buenos Aires.

5 Arcos 1737, P.B., "A", (1426) Buenos Aires.

PROPUESTA DE UN SISTEMA VINCULAR PARA EL TRATAMIENTO DE NIÑOS CARENCIADOS

Lic. MIRYAN BERRA¹; Lic. MARIA ESTER B. DE MARTINEZ²;
Lic. MARIA CRISTINA ADRIANO³; Lic. MONICA M. L. M. DE
UBERTO⁴.

Comienza con el marco teórico compuesto por la introducción del trabajo y una definición de "familia" de las autoras con el análisis detallado de la misma.

Luego se toma a los niños privados de un medio familiar normal y a continuación se describe la metodología de trabajo del equipo técnico para el tratamiento de los mismos y de su familia, para luego arribar a las conclusiones.

Finalmente se describe un caso típico.

SUMMARY

It begins with the Theoretical Framework composed of the Introduction to the paper and the authors' Definition of "family" with the detailed analysis of it.

Then it deals with children deprived of a normal family environment and afterwards it proceeds to describe the work methodology used by the technical team for the treatment of these children and their family, to reach then the Conclusions.

Finally a typical case is described.

1 Rivadavia 3118, 7°, C, (1203) Buenos Aires.

2 Charcas 2748, 5°, "A", (1425) Buenos Aires.

3 S. de Bustamante 1952, 9°, "52", (1425) Buenos Aires.

4 Müller 2289, (1431) Buenos Aires.

EL COMPLEJO DE EDIPO A LA LUZ DE LA EXPERIENCIA CLINICA EN EL TRATAMIENTO FAMILIAR CON PACIENTES PSICOTICOS

Dr. JORGE GARCIA BADARACCO*

A través del proceso terapéutico con pacientes psicóticos aportaremos algunas observaciones sobre la naturaleza del Complejo de Edipo, así como de los factores que interfieren o perturban su elaboración.

La labor terapéutica muestra que la dificultad del esquizofrénico de realizar un crecimiento psicosexual hasta alcanzar una organización genital definitiva no depende solamente de su propia patología, sino en gran medida de actitudes de los padres. Consideramos que la noción de "vínculo", tal como la define Pichon Rivière, resulta útil para entender la patología del Complejo de Edipo, lo cual sería en este sentido una "patología vincular". La estructuración de un Complejo de Edipo patológico no sería atribuible exclusivamente al sujeto en términos de satisfacción o frustración de la pulsión instintiva, sino que habría que considerar otros factores implicados en la relación con sus propios progenitores, tales como la relación de pareja de los padres, los deseos inconscientes de cada uno de los mismos, conductas seductoras, dificultades emocionales y aspectos carenciales de todo tipo que puedan condicionar una patología vincular que va a interferir necesariamente en la elaboración y resolución de los diferentes aspectos de la conflictiva edípica. De esta manera, las dificultades de los padres no sólo mantienen con su conducta las "esperanzas" señaladas por Freud sino que tienden a potencializarlas.

A la luz de esta forma de centrar la problemática entendemos la función de la familia como contexto real del crecimiento psicológico de los individuos que funciona al estilo de un objeto transicional estructurante de su personalidad. El crecimiento de los hijos se realiza en un contexto que requiere de los padres estar capacitados para desempeñar las funciones paterna y materna como modelos de identificación necesarios para hacer posible el crecimiento normal de los hijos. Las carencias de recursos yoicos en los hijos y la carencia sistemática de experiencias enriquecedoras en el desarrollo yoico de las personas permite comprender mejor la configuración de las variadas formas de enfermedad mental.

Tanto en el psicoanálisis individual como en la psicoterapia familiar podemos ver que la patología remite a la existencia de un conflicto, pero tenemos que incluir la noción de carencia de recursos para poder elaborar el conflicto.

Textualmente dice Freud que las relaciones de los distintos componentes de la constelación edípica sucumbe a la amenaza de castración pero deja abierto un espacio alegando que aún no queda terminado el

* Libertad 1370, 13°, "B", (1016) Buenos Aires.

problema. Nosotros pensamos que cuando el padre y la madre tienen internalizada la prohibición al incesto como una pauta cultural sana, como un superyó no prohibidor ni castrador de deseos reprimidos, sino de un superyó constructivo y protector de deseos reprimidos que evita situaciones caóticas y/o psicóticas, el renunciamiento a ciertos deseos primitivos no sería una castración, sino más bien una protección frente a estos impulsos primitivos. En la medida en que estas fantasías pueden ser vividas en forma lúdica y son acompañadas por los mismos padres sirven de elementos estructurantes de la personalidad.

SUMMARY

Therapeutic work shows that the difficulty of the schizophrenic patient consisting in a psycho-sexual growing till reaching a definitive genital organization does not depend only on his own pathology, but in great measure on the parents attitudes which do not help to separation because they unconsciously maintain the pathologic symbiosis through seductive behavior.

Under this point of view, the organization of a pathologic Oedipus Complex could not be exclusively attributed to the satisfaction or frustration of the instinctive drive but also to a "vincular pathology".

In this sense we understand the family as a real environment for the psychological growth of individuals.

Freud says that the Oedipus Complex succumbs to the castration menace. We think that when the parents consider the incest prohibition as a healthy cultural pattern, as a constructive and protective Super Ego, the rejection to this wishes would not be a castration but a protection facing this primitive impulses. In these conditions, the "repressed wishes" do not become neither disorganizing factors nor they provoke catastrophic, chaotic or psychotic situations.

As much as these fantasies may be experienced in a playful interchange and accompanied by the parents, they are useful as structural elements of the personality.

TERAPIA DE PAREJA - SERVICIO DE PSICOPATOLOGIA - EQUIPO DE FAMILIA - HOSPITAL PARMENIO PIÑERO

Dr. OSCAR TABER* y Lic. MARIA ELENA LEFEVRE**

Se conceptualizarán el sentido de la pareja como grupo teniendo en cuenta su significación y sus redes de comunicación. Se abordará a la pareja como grupo sistémico desde 2 enfoques.

- a) El Psicodinámico
- b) El Interaccional

Se mostrará las diferencias fundamentales entre ambos enfoques marcando en el primero el valor del juego intrapsíquico y en el segundo la interacción manifiesta como eje fundamental del cambio.

1) Se insistirá en el enfoque interaccional en terapia de pareja, su origen común y sus posteriores diferenciaciones.

2) Se tratará con ejemplo de comprender el porqué de la aparición de los síntomas, su sentido, su significación y el mensaje que lleva implícito.

Para complementar esto último, se presentarán dos entrevistas distintas con la misma pareja, para comprender cómo se modifica la interacción y por lo tanto aparece el cambio a través de la actuación terapéutica.

SUMMARY

The sense of the couple will be conceptualized as a group considering its significance and its communication nets. The couple will be considered as a systemic group from two approaches:

- a) The psychodynamic and
- b) The interactional one.

The fundamental differences between both approaches will be shown by stressing in the first the value of the intrapsychic play and in the second the manifest interaction as fundamental axis of the change.

1) The interactional approach in couple therapy, its common origin and its posterior differentiations will be insisted upon.

2) By means of an example, there will be an attempt to understand the reason for the appearance of symptoms, its sense, its significance and the message that it implicitly conveys.

To complement this later, two different interviews with the same couple will be presented, in order to understand how the interaction is modified and therefore the change appears through the therapeutic action.

* Billinghurst 2386, 3º, "B", (1425) Buenos Aires.

** Juramento 3361, 1º, A, (1430) Buenos Aires.

ABORDAJE DEL GRUPO FAMILIAR EN SITUACIONES DE DIVORCIO

Lic. MARIA ELENA GANDOLLA DE CZERTOK*; Lic. HAYDEE M. C. DE TORONCHIK**

La clínica del Grupo Familiar en situaciones de divorcio requiere la elaboración de un plan de tratamiento adecuado a las características de cada familia en particular.

El divorcio supone una serie de cambios y por consiguiente la elaboración de duelos. Para la pareja, es la aceptación y el reconocimiento de un punto final en el proyecto imaginario común que los unía, y para los hijos es una pérdida cuyos efectos se irán aliviando o potenciando en la medida que los padres puedan hacer ese duelo, sin negar, minimizar o rechazar las reacciones, las preguntas y los planteos del niño. En cada caso, planificamos el diagnóstico o tratamiento desde una visión abarcativa de los distintos contextos en que transcurre la vida del niño.

Inicialmente, en entrevistas con ambos padres, o con cada uno de ellos por separado recabamos información sobre la historia sintomática, evolutiva y familiar. Nos interiorizamos sobre las modalidades de la separación, las modificaciones previas, concomitantes o posteriores que se produjeron en la organización de la familia. Preguntamos sobre la evolución personal posterior a la separación de los cónyuges, y el modo en que se siguen ejerciendo las funciones paternas, maternas, sus desajustes, las carencias y las modalidades de enlace con las dificultades del niño y con la historia de las familias de origen de los padres.

Evaluamos las tendencias culpabilizantes y el monto de agresión aparente y oculto entre los padres, en la inteligencia que cuando la hostilidad es intensa se incrementan las tendencias a la actuación y con frecuencia el pedido de consulta encubre estos fines y es una actuación en sí misma.

Objetivos terapéuticos: a) que los padres puedan entenderse ante las vicisitudes de la relación conyugal a fin de mantener vigente el complejo marco parental que se ha de ir estructurando alrededor de los hijos ("los tuyos y los míos..."), tanto en la relación personal directa como a través de las palabras y modos en que el padre o la madre es evocado, nombrado o redefinido a través de los recuerdos penosos o felices compartidos. Investigamos el conflicto de lealtades entre el padre presente y el ausente y los trastornos en los procesos de identificación.

Frecuentemente se niega valor a la relación anterior, sea por coincidir con el sentimiento residual del padre divorciado, sea por un acuerdo inconsciente con la nueva pareja tendiente a evitar la emergencia de molestos recuerdos o positivas evocaciones.

* Cnel. Díaz 1510, 9º, (1425) Buenos Aires.

** Mansilla 3338, P.B., "C", (1425) Buenos Aires.

b) Enfatizamos la elaboración de los duelos que implican la situación de divorcio. Cada uno espera del otro coincidencias con el propio modo de sentir, con los propios tiempos. Se atribuyen al niño la imposibilidad de comprender el sentimiento de los adultos. Se le adjudican clichés y se le plantean exigencias contradictorias de comportamiento. O es muy chico, no entiende aún ciertas cosas de la vida por lo que debe seguir como si nada hubiera cambiado, o bien ya es grande y debe colaborar adaptándose automáticamente a todo.

c) Reubicar los sucesos reales e imaginarios en una historia que tenga coherencia discriminando en el relato las distorsiones y los secretos mostrando a los padres los riesgos de fomentar tanto la ignorancia y/o el olvido que hacen insostenible cualquier diálogo auténtico, como el adoctrinamiento rencoroso.

d) La aceptación de un período peculiar nuevo en que va a delinarse una estructura transaccional normativa susceptible de cambios que regulen la educación de los hijos.

Modalidad del abordaje clínico: Se realizan entrevistas individuales, grupales padre-hijos, madre-hijos y subsistema de hermanos, conforme con las problemáticas espacio-temporales del sistema.

SUMMARY

Clinical practice with the family group in situations of divorce requires the development of a treatment plan which is adequate to the characteristics of each particular family.

Divorce implies a series of changes and therefore the working-through of mournings. For the couple, it is the acceptance and recognition of an end point in the shared imaginary project which united them, and for the children it is a loss whose effects will become greater or lesser depending on the parents' resolution of that mourning, without negating, minimizing or rejecting the child's reactions, questions and questioning.

In each case, we plan the diagnosis or treatment with a wide visions of the different contexts in which the child's life goes on. Initially, in interviews with both parents. or with each of them separately, we gather information on the symptomatic, developmental and family history. We learn about the nature of the separations, previous, concomitant or later modifications taking place in the family organization. We ask about the personal development of the spouses following the separation and about the way in which they continue to exercise their maternal or paternal functions. their maladjustments, deficiencies and the way they fit in with the child's difficulties and with the parents' families of origin.

We evaluate the guilt-giving tendencies and the amount of apparent and hidden aggressions between the parents, in the knowledge that when hostility is intense the tendencies to acting-out are increased, and that frequently the request for a consultation covers these ends and is in itself an acting-out.

Therapeutic objectives: a) that the parents' may understand each other in spite of the vicissitudes of the marital relationship in order to keep up the complex parental framework which must be structured around the children ('yours and mine'), in the direct personal relationship as well as through words and ways in which the father or mother is referred to, named or redefined through the painful or happy memories they share.

We investigate the conflict of loyalties between the absent and the present parent and the disorders in identification processes. Frequently, the former relationship is denied its value, either because this coincides with the residual feeling in the divorced parent or because of an unconscious agreement with the new partner tending to avoid the emergence of bothersome memories or positive references.

b) We emphasize the working-through of the mourning that the divorce situation implies. Each one expects the other to coincide with his way of feeling, with his own tempos. They attribute the impossibility of understanding the adults' feelings to the child. The attribute clichés to him and make contradictory demands of behavior. He is either too small, he does not yet understand certain things in life, for which reason he must go on as if nothing had changed, or he is big now and must cooperate by adapting automatically to everything.

c) Relocate real and imaginary events in a coherent history, discriminating the distortions and secrets in the narrative, showing the parents the risks of encouraging ignorance and/or forgetfulness which make any authentic dialogue unviable, like a resentful indoctrination.

d) The acceptance of a certain new period in which a normative compromise structure, susceptible to changes, to regulate the children's up-bringing, is going to be outlined.

Clinical approach: individual, group, father-child, mother-child, and sibling subsystem interviews are held, according to the space-time problems of the system.

ORGANIZACION EMPRESARIAL Y ESTRUCTURA FAMILIAR INCONSCIENTE

Lic. MARIA DEL CARMEN DIZ*; Lic. EDUARDO MANDELBAUM**

Transferencia y Multifamilia

El poder estructurante de los fenómenos transferenciales se reveló en las experiencias terapéuticas de pacientes y familias en el ámbito de la Comunidad Terapéutica Psicoanalítica. Jorge García Badaracco denominó multifamiliar al campo psicológico que organizan las personas que integran la vida comunitaria. Esto comprende no sólo a los pacientes sino también a sus familias. Las investigaciones posteriores mostraron que asimismo los terapeutas organizaban su tarea a través de percepciones "multifamiliares". Esto significaba en términos generales que las personas tienden a recrear con otras que a veces apenas conocen, vínculos que implican sentimientos profundos de búsqueda de amor, seguridad, protección, para controlar la emergencia de sentimientos terroríficos, violentos, o de intensa pérdida o angustia. Al estudiar el desarrollo de estas vinculaciones en los distintos estamentos de la comunidad se notaba la emergencia de aspectos del pasado individual, recreado en las interacciones comunitarias. El concepto de multifamilia alude a que los depositarios de tales proyecciones transferenciales son múltiples, y múltiples entonces las posibilidades de elaboración terapéutica.

Transferencia Institucional

Este concepto fue definido a partir de la experiencia clínica con pacientes que parecían esperar todo de "la sala", "la comunidad", o "el Hospital", pareciendo que se transferían esperanzas y temores, más sobre la idea de la Institución que sobre personas concretas. Se asimila este concepto al de la transferencia que alguien hace sobre su propia estructura familiar, además de sus personajes significativos.

Ideas Convergentes

Se citan los descubrimientos de Elliot Jacques acerca de las instituciones y las ansiedades psicóticas individuales.

Los fenómenos descriptos por Stanton y Schwartz acerca de la alteración de la patología de pacientes internados ante la presencia de conflictos en el equipo tratante.

Los trabajos de Maxwell Jones acerca de las técnicas de confrontación entre terapeutas para evitar la actuación de los conflictos sobre los pacientes. Estos fenómenos son el resultado de la organización del Hospital o la institución como si fueran una multifamilia primitiva

* Solís 343, 2º, "B", (1078) Buenos Aires.

** Uriburu 1001, (1642) San Isidro, Prov. de Bs. Aires.

inconciente. Uno de nosotros propone la idea de "insight" institucional para referirse a una función reflexiva y comprehensiva que debe desarrollar una institución psiquiátrica para evitar caer en las contra-identificaciones patológicas que transforman el accionar terapéutico en una multifamilia enfermante.

Nuestra Experiencia

Siguiendo estas ideas acerca de la comprensión del papel estructurante de la familia internalizada pensamos que se podría investigar y operar en instituciones no-psiquiátricas y con personas no-psicóticas. Tomado el trabajo con instituciones empresariales desde este enfoque, pudimos comprender dinámismos conflictivos operantes e introducir modificaciones que ayudaran a un mejor funcionamiento. Diseñamos un encuadre de trabajo apoyados en la experiencia de terapia multifamiliar, para aquellos pacientes que querían tener acceso a este modo de comprender su inserción en una estructura laboral. Las reuniones se realizan mensualmente durante 3 horas, en la consigna de intercambiar vivencias, experiencias, problemática y soluciones, referidas a los desempeños laborales, en la organización que fuera y en el rol que en ellas les tocara desempeñar. El análisis de las empresas tomadas como organizaciones familiares inconcientes permitían comprender qué aspectos de la dramática individual o interpersonal, se jugaba en cada ocasión. Durante cuatro años se visualizaron tres planos de abordaje para diferentes desempeños. Desde lo personal, un individuo planteaba sus dificultades concretas. El análisis de las mismas ayudaba a un desarrollo personal en relación con el desempeño laboral.

Otro plano es el de planteos grupales-institucionales cuyo análisis permitía la adopción de estrategias institucionales desde el núcleo del grupo que plantea el problema.

Y un tercer plano evaluativo demostraba que el trabajo grupal producía en su continuidad un conocimiento no-sistemático de tipo incorporativo, que facilitó a los miembros del grupo una mayor respuesta adoptativa a nuevos conflictos institucionales en forma espontánea y creativa. Se refieren ejemplos clínicos sobre la interacción entre la historia y la patología individual y la trama laboral institucional.

Un punto a destacar es cómo se veía con sorprendente frecuencia cómo estaba influida la toma de decisiones por razones inconcientes atribuibles a estas organizaciones familiares latentes. Se ejemplifica clínicamente esto último.

SUMMARY

Based on the multi-familiar psychological field concept developed by García Badaracco and the transference ideas of the psychoanalytical theory, the institutional transference concept discovered in the clinical-institutional experience of the authors is reconsidered.

In this line of thoughts, the contributions of Elliot Jacques, Stauton and Schwartz and Maxwell Jones are mentioned with reference to the study of the relations among people who live together in institutions where they project aspects of their unconscious life.

Based on the hypothesis that these works evidence the structuring force of the unconscious family life in the behaviour of people in their actual institutional interactions, the authors describe a group work method applied to managers who have met during five years, discussing about their companies and conflicts, in the same way as the multifamiliar groups assemble in the therapeutic community. Definite clinical aspects of this task are described, together with an explanation of how the group elucidation of the unconscious family dynamics, operating in different companies, allowed for modifying operations in a positive sense for the personal and labor development of the people involved in this group experience.

CONSIDERACIONES TEORICO-TECNICAS SOBRE LA FAMILIA CON ADOLESCENTES

Lic. RODOLFO URRIBARRI*

Se desarrollará una introducción sobre las funciones y roles familiares, del enfoque evolutivo del grupo, y acerca de la asimetría.

Seguidamente caracterizaré el proceso adolescente, como una etapa que atañe a toda la estructura familiar y que plantea una de las más difíciles crisis a resolver.

Se examinarán los psicodinamismos actuantes y la relaciones cruzadas que se establecen entre el joven y sus padres y hermanos, así como entre el endo y el exogrupo, y la familia ampliada. También se considerarán las fantasías en torno de la separación-individuación y el destino familiar.

Luego se centrará en aspectos técnicos y finalmente consideraciones clínicas sobre la psicoterapia con familias con adolescentes, pudiendo llegar a trabajarse algún material clínico que presente organizadamente algún participante.

SUMMARY

An introduction on the family functions and roles, on the evolution approach of the group and on its asymmetry is to be developed.

Immediately after I will characterize the adolescence process, as a stage concerning the whole family structure and posing one of the crisis most difficult to solve.

The acting psychodynamisms and the cross relationships established among the young person and his parents and siblings, as well as among the endo and exogroup and the extended family will be examined. The phantasies about the separation-individuation and the family fate will be also considered.

Then the paper will be centred on technical aspects and finally on clinical considerations about the psychotherapy with families having adolescents, being possible to take into consideration any clinical material introduced in an organized way by any participant.

* Las Heras 3027, 10°, "A", (1425) Buenos Aires.

FAMILIAS ADOPTANTES: UN PECULIAR MODO DE VIVIR EN FAMILIA

Lic. EVA GIBERTI*

El supuesto básico de este trabajo es la teoría psicoanalítica, y su posición con respecto a la constitución del aparato psíquico y las defensas que éste utiliza para insertarse en un mundo socializado.

Parto de tesis anteriormente defendidas: la presencia de la desmentida y lo siniestro en la dinámica familiar de los adoptantes-adoptivos e incorporo como nueva subtesis la presencia de las pulsiones del adoptivo que funcionarían como "desordenantes" en estas familias, analizando los esfuerzos del Yo de los adultos para organizarlas en una estructura socializada de acuerdo con los cánones que ellos evalúan como "normales". Sostengo, como tesis central que las adoptantes son familias "distintas" si se las compara con las no-adoptantes; distinción que resulta de la presencia de la desmentida, lo siniestro, las representaciones y fantasías del niño y la presencia de "los otros" (los progenitores del chico) de modo fantástico (real a veces). Estas familias se caracterizarían por una singular (propia) manera de oponerse al "desorden" que el niño incorpora (así como la esterilidad de los cónyuges) insistiendo en los valores de un tipo de familia que ellos idealizan como "ordenadora" —normal denunciando de este modo su ideología acerca de la "bondad" de las otras familias ligadas por el vínculo de sangre; bondad asociada con lo previsible y conocido a través de la herencia y donde todo lo que ocurre aparece como socialmente "normal". Ideología que constituye un obstáculo epistemológico: bondad igual a equilibrio, orden, etc. De allí su imperativo categórico de esforzarse en "ser-como-los-otros" negando la propia identidad que los diferencia sin que ello implique anormalidad o psicopatología, necesariamente.

El hijo adoptivo no solamente cuenta con sus propios cromosomas, su mundo fantástico sino con sus pulsiones que tienen sus raíces somáticas en "otros"; lo cual haría impredecible una parte de su conducta (según lo presienten los padres) y hace que la pulsión sea altamente inabordable aunque objeto y meta puedan adquirirse en la vida familiar. La imposibilidad de *predecir* —la pulsión no está en un futuro hipotético sino en un presente desconocido— y la posibilidad de *prever* que obliga a incluir la lógica de la probabilidad en el trato con el chico constituyen elementos inquietantes para la familia que pretende ser "ordenada", sin advertir que existe un "desorden" que reclama nuevos "ordenadores" diferentes de los que utiliza la familia "clásica" (uno de esos ordenadores es la existencia de mujeres que se deshacen de sus hijos). Los adoptantes intentan renunciar al derecho de ser diferentes y de moverse en una familia cuyos meridianos tienen características propias.

* Montevideo 1306, (1018) Buenos Aires.

SUMMARY

The *basic assumption of this paper* is the psychoanalytic theory and its position as regards the constitution of the psychical system and the defenses it makes use of to insert itself in a socialized world.

I set out from previously defended theses: the presence of the denial and the sinister in the family dynamics of the adopting-adopted, and I add as a sub-thesis the presence of the adopted child's pulsions that would act as "disorderers" within such families, analysing the efforts made by the ego of the adults to organize them into a socialized structure in accordance with the canons they believe to be "normal". I maintain, as a *central thesis*, that adopting families are "different" when compared to non-adopting ones. Such a difference is the result of the presence of the denial, the sinister, the child's representations and fantasies and the presence of "the others" (the child's parents) in a fantastic way, which is sometimes real. These families would be characterized by a particular (inherent) way of opposing the "disorder" the child introduce, (as well as the sterility of the married couple), by insisting on the values of a type of family that they idealize as being "ordering"-normal, thus proclaiming their ideology concerning the "goodness" of the other families who are linked by blood bonds; a goodness associated with what is known and predictable through heredity and where everything that happens appears as socially "normal".

Such a belief becomes an epistemological obstacle: goodness is equal to equilibrium, order, etc. Thus its categorical imperative of trying very hard to "be-like-the-others", denying the inherent identity that makes them different without its necessarily implying any abnormality or psychopathology.

The adopted child has not only his own chromosomes and his fantastic world but also his pulsions that have their somatic roots in "others". This would make part of this behaviour unpredictable (as the parent forebode it) and gets the pulsion to become highly inaccessible, even though the goal and aim might be acquired through family life. The impossibility of *predicting* the pulsion is not in a hypothetical future but in an unknown present— and the possibility of *foresight* that forces the inclusion of the logic of probability when dealing with the child are disquieting elements for the family that endeavours to be "ordered"; without noticing that there exists a "disorder" that calls for new "orderers" which are different from those used by the "classical" family. (One of such orderers is the existence of women who abandon their children).

Adopting people attempt to give up their right to be different and to act inside a family whose meridians have their own characteristics.

PATRIARCADO, FAMILIA NUCLEAR, Y LA CONSTITUCION DE LA SUBJETIVIDAD FEMENINA

Lic. GLORIA BONDER* y Lic. MABEL BURIN*

Dada las características del Seminario, la reunión estuvo centrada en la *transmisión de información conceptual* sobre el tema propuesto a cargo de las coordinadoras y en su posterior discusión. Los conceptos vertidos tomaron como eje principal la noción de *patriarcado* como marco global de determinación de las diferencias jerárquicas de los sexos en la cultura occidental. El enfoque utilizado partió de la concepción materialista-histórica del patriarcado haciendo referencia a su estructura y dinámica en un eje diacrónico y sincrónico. Se puso un énfasis especial en el análisis de la dialéctica producción-reproducción y sus correlaciones con las asignaciones socio-culturales de las mujeres y los hombres a cada uno de estos ámbitos de la organización social. Asimismo, se analizó la producción ideológica y simbólica emergente de la estructura patriarcal, particularmente en su discurso acerca de las mujeres (equivalencia mujer = madre, supuestos naturalistas, esencialistas y biólogos en la identificación de la identidad femenina). Se insistió en la pertinencia de incluir este determinante para la comprensión de la organización familiar, y particularmente para analizar las relaciones entre los sexos y entre las generaciones en la familia.

Se trabajó sobre el concepto de *familia nuclear* definiéndola y acotándola como una particular organización de los vínculos entre los sexos y entre las generaciones que surge como producto histórico a partir de un determinado momento socio-económico del desarrollo de la cultura occidental: la Revolución Industrial. Se trabajó sobre la posición de la mujer en este contexto familiar, posición caracterizada por su adscripción al ámbito doméstico y al rol reproductor, con la modalidad de la delegación exclusiva de esos roles la mujer = madre biológica de cada familia particular.

Esta posición determina el privilegio para la mujer del desarrollo de funciones yóicas necesarias para el cumplimiento de esa asignación, y su contrapartida, o sea la inhibición de otras funciones.

En un orden más general, se postula que la *posición asignada a la Mujer en familia nuclear es un determinante estructural de la organización de su aparato psíquico, tanto en el proceso mismo de su constitución en la niña (por el proceso de identificaciones) como en la mujer adulta por la reproducción de las prácticas que imponen el aparato psíquico, modos de organización de las pulsiones, de las identificaciones y de las funciones yóicas atingentes al ámbito doméstico y al rol maternal.*

Se discutieron algunas teorías científicas que al pretender dar cuenta de la psicología y psicopatología de la mujer, omiten y

* Bulnes 2591, P.B., (1425) Buenos Aires.

distorsionan hechos relevantes observables en la práctica clínica de las pacientes mujeres y con familias. Estas distorsiones se centran en: omisión de la multideterminación de la posición de la mujer, particularmente de los aspectos de orden sociocultural que limitan su inserción en la cultura, y asimismo distorsiones de las particularidades del funcionamiento psíquico de la mujer en función de identificarlo al desarrollo psíquico del hombre y/o a sostener la equivalencia mujer = madre.

El grupo aportó ejemplos clínicos y problematización acerca de los marcos referenciales disponibles hasta el momento para comprender la problemática femenina y la posición de la mujer en la familia, especialmente en la comprensión de la sexualidad femenina (autoerotismo y sus destinos, narcisismo, elección de objeto heterosexual y desimplicación del deseo erótico y el deseo del hijo).

El grupo coincidió en la necesidad de continuar profundizando en esta temática a los fines de lograr una mejor articulación e integración de las distintas determinaciones, y asimismo de crear mediaciones teóricas y técnicas para ser utilizadas en la práctica psicoterápica de mujeres y de familias.

SUMMARY

The expressed concepts followed, as the principal axis, the notion of *patriarchate* as the global framework for the determination of the different hierarchies of both sexes in western culture. The viewpoint which was used started from the materialistic-historical conception of patriarchy, making reference to its structure and dynamics in a diachronic and synchronic axis. A special emphasis was put into the analysis of the production-reproduction dialectic and its correlative with the social-cultural assignments of women and men to each of these fields of social organization. Likewise, the ideological and symbolical production which emerges from the patriarchal structure was analyzed, specially in its discourse about women (equivalence woman:mother, naturalist assumptions, essentialist and biologist assumptions in the identification of women's identity). It was insisted on the relevance of including this determinant for the comprehension of family organization, and specially to analyze the relations between sexes and between generations within the family.

We have worked upon the concept of *nuclear family*, defining and outlining it as a particular organization of the bonds between sexes and between generations that emerges as an historical product, starting from a particular social-economic moment in the development of western culture: the Industrial Revolution. We have worked on women's position in this familiar context, a position which has been characterized by its appointment to the domestic field and to the reproductive role, with the modality of the exclusive delegation of these roles, to the biological woman:mother of each particular family.

This position determines the privilege for women of the develop-

ment of yoical functions necessary to carry out this assignment, and its counterpart, which means, the inhibition of other functions.

In a more general order, we have postulated that the *position assigned to Women in nuclear family is a structural determinant of the organization of their psychical system, in the process itself of the constitution in the child (through the process of identification) as well as in the adult women through the reproduction of the practices that impose forms of organization of the drives, of the identifications and the yoical functions referring to the domestic field and to the maternal role, for the psychical system.*

MODELO DE ABORDAJE TERAPEUTICO EN FAMILIAS CON NIÑOS PEQUEÑOS

Lic. FANNY COHEN* y Dr. OCTAVIO GARCIA FAURE**

Nuestro objetivo en este trabajo es mostrar la metodología actual con la cual abordamos el tratamiento de familias con niños pequeños. A este modelo hemos llegado incorporando a nuestra comprensión psicoanalítica inicial, los elementos de la teoría de la comunicación necesarios para el trabajo con familias.

Todo este trabajo está hecho en co-terapia y ambos hemos comenzado siendo terapeutas de niños, que paulatinamente fuimos acercándonos al trabajo terapéutico con familias.

Nuestro objetivo es mostrar, por un lado, cómo se incluye la caja de juegos en la sesión familiar, y por otro, mostrar cómo a partir de la comprensión psicoanalítica del material y de la observación de la interacción, se realizan intervenciones tendientes a modificar la trama relacional de la familia.

Ilustraremos estos conceptos con el material clínico de cuatro familias.

La dinámica de este seminario consistirá en una exposición inicial y una discusión posterior sobre el material clínico presentado, enfocada hacia el análisis del modelo.

SUMMARY

This paper aims at showing the current methodology by means of which we approach the treatment of families with young children. We reached this model by incorporating our original psychoanalytical understanding with the elements of the communication theory necessary to work with families.

All this work has been done in co-therapy; both of us have begun as child therapists, and then we have gradually approached the therapeutic work with families.

Our object is, on the one hand, to show how to include the play box in the family session, and, on the other hand, to show how interventions which tend to modify the relational family fabric are carried out starting from the psychoanalytical understanding of the material and the interaction's observation.

We will illustrate these concepts by using clinical material from four families.

The dynamics of this workshop will consist of an introductory exposition and a subsequent discussion about the clinical material presented, focused on a model analysis.

* Laprida 2044, 7º, (1425) Buenos Aires.

** Sevilla 2924, (1425) Buenos Aires.

TERAPIA FAMILIAR Y PSICOANALISIS INDIVIDUAL: INTEGRACION DE RECURSOS TERAPEUTICOS

Lic. EDUARDO MANDELBAUM*

La integración de Recursos Terapéuticos aparece como una necesidad referida al tratamiento de pacientes psicóticos y de sus grupos familiares al organizarse la primera Comunidad Terapéutica Psicoanalítica, al promediar la década del '60. Los logros obtenidos con este enfoque alentaron la elaboración de hipótesis a verificar en el campo clínico, acerca de la posibilidad de enriquecer y movilizar aspectos del psicoanálisis de pacientes no-psicóticos integrando recursos terapéuticos que implican la operación directa sobre la patología vincular, tales como el tratamiento de la familia o la pareja, interactuando con el análisis individual.

El concepto de "integración de recursos terapéuticos" acepta cuatro vertientes para su análisis. La primera se refiere a que tal integración supone el encuentro y articulación de distintos cuerpos teóricos y conceptuales, pensados a veces desde campos experienciales muy distintos. Un ejemplo sería la articulación de las hipótesis sobre funcionamiento intrapsíquico y su articulación con lo observable en sistemas familiares.

Un segundo nivel de análisis debe tomar en cuenta la articulación de diferentes técnicas concretas, con diferentes encuadres y diferentes modalidades operativas.

Una tercera consideración será la de la interacción de los agentes concretos que deberá asumir la forma de trabajo en equipo que reflejará necesariamente aspectos del paciente y su familia, como se señaló en otros trabajos.

El cuarto nivel de análisis considera la particular integración que el paciente realiza en su mundo interno a partir de la simultaneidad de sus experiencias terapéuticas. El presente trabajo es el resultado de las observaciones realizadas por un solo terapeuta en su desempeño como analista familiar e individual.

Se describe la hipótesis de la cura analítica como cura de una relación vincular; la estructurada transferencialmente con el analista y a partir de esta comprensión se describen dos tipos de transferencia en la terapia familiar; la que ocurre con el analista y la que ya viene estructurada entre los miembros de la familia. La labor terapéutica consistirá en crear las condiciones necesarias para que personas involucradas en tramas patológicas puedan surgir de sus investiduras transferenciales recíprocas y aparecer a sus ojos y a los de los demás, como son en realidad. Se describe el clima particular de sesiones que ocurren "insights" que facilitan el "reconocimiento" de los objetos. Se refiere la utilidad de tales experiencias para el análisis individual de identifica-

* Uriburu 1001, (1642) San Isidro, Prov. de Buenos Aires.

ciones primarias y secundarias de características patológicas que pueden así modificarse en un tiempo menor que el requerido por el tratamiento convencional. Se añaden ejemplos clínicos.

Se ejemplifica además la posibilidad de reducir por medio de estas técnicas, el efecto negativo de altos montantes de transferencia negativo hostil, que puedan llevar al bloqueo o la interrupción del tratamiento.

Otra posibilidad que se abre y concurre al proceso terapéutico, es la de que el paciente pueda vivenciar cómo aquello que percibe en su tratamiento individual se despliega dramáticamente en sus vínculos actuales y transformar estas vivencias en mero material para su elaboración. La relación entre los materiales que se ofrecen para ser analizados en los distintos encuadres simultáneos tienen entre sí un efecto potenciante a través de una interacción dialéctica.

Otro aspecto resultante de la integración de recursos terapéuticos es la de permitir confrontar escenas y fantasías infantiles acerca de los vínculos con los objetos originales a la luz de sus interacciones en la terapia familiar.

También es sumamente positiva la posibilidad de "descubrir" a través de interacciones terapéuticas con la familia actual que muchos recuerdos y modelos traumáticos de la infancia puedan ser esclarecidos como resultados de encadenamientos de "malos entendidos" sucesivos que no permitieron por ejemplo la percepción adecuada de los afectos positivos puestos en juego.

La interacción de recursos parece asimismo ser muy útil en pacientes vinculados en forma simbiótica profunda, que presentan fantasías de muerte o desintegración asociadas a experiencias de crecimiento de modo tal que temen y sabotean permanentemente sus progresos terapéuticos. Se ejemplifica clínicamente.

El análisis minucioso de las interacciones entre las experiencias analíticas e individual presenta un riquísimo campo a explorar sobre las formas tempranas de organización del psiquismo y las leyes y condiciones necesarias para producir modificaciones terapéuticas, tanto en el paciente analizado como en su grupo familiar.

SUMMARY

The thought of integrating therapeutic resources appears as a real need in the treatment of psychotic patients and their families, in the organization of the psychoanalytic therapeutic community, in the 60's. From the personal observation and successful treatment, the author explains his findings in the analytical treatment of non-psychotic individuals and families.

Consideration of the integration of resources is divided into four levels: a) Interacting theories that have to be integrated; b) Definite techniques and framings; c) Interaction of the therapeutic team; d) Integration of the patient's inner world and experience.

The similarities and differences between individual and family

treatments, taking into consideration the theory of transference with the therapist and among the members of the family, are explained.

Part of the therapeutic objectives is to create the necessary conditions so that members of the group with pathologic traits could divert themselves from their reciprocal transference bonds and be seen by the rest of the group as they really are.

The value of the integration of the therapeutic resources can be demonstrated by the following examples: working through primary and secondary pathogenetic identification, decreasing the intensity of hostile transference, that threaten the continuation of the treatment, express in the family environment the insight and feeling experienced during the individual therapy, through the dialectic interaction of different types of analytical material.

Another aspect is the confrontation, during family therapy, of old scenes and objectal fantasies in the internal child world, discovered through individual analysis.

The usefulness of the "integrated technique" is also demonstrated in cases of deep symbiotical binds to actual meaningful objects.

The integration of resources presents a rich material to explore the early ways of psyche organization and the norms and necessary conditions to produce therapeutic modifications in the analyzed patient as well as in his family group.

TRASTORNOS DE SUEÑO EN LA PRIMERA INFANCIA. SU RELACION CON LOS CONFLICTOS DE LA PAREJA.

Lic. HAYDEE M. C. DE TORONCHIK*

Características coincidentes

— En los niños: Dificultades para iniciar el sueño, rechazo de la cuna, despertares nocturnos; primogénitos de parejas jóvenes; sin trastornos orgánicos ni otros síntomas psicológicos.

— En los padres: Pasaban por situaciones de crisis como parejas y como individuos; parecían niños y, de hecho, algunos reeditaban síntomas padecidos en ciertos momentos de la infancia. Las madres evidenciaban ambivalencia, sentimientos contradictorios e imposibilidad de separarse de sus hijos; los padres, sentimiento de exclusión de la relación madre-hijo y de pareja. Problemas —en la mayoría de los casos, leves— en las relaciones sexuales. Antes del nacimiento del niño, estas parejas no presentaban problemas evidentes.

Tipo de trabajo realizado

La técnica utilizada fue la de entrevistas con los padres y —en cinco casos— con el grupo familiar, cuyo objetivo se resume en:

1. Discriminar al bebé y a la pareja de proyecciones de figuras arcaicas.
 2. Esclarecer el contrato matrimonio anterior. Duelo.
 3. Proyectar un nuevo contrato (sexual, social, etc.) adecuado a la nueva situación.
 4. Revisar la figura del hijo. Ambivalencia y odio.
 5. Reordenar la vida del bebé según idiosincracia.
- (Se ejemplifica a través de uno de los casos.)

Conclusiones

Los casos estudiados no representaban fracasos absolutos sino crisis de crecimiento cuya elaboración excedía la capacidad de sus miembros: evidenciaba ciertas fallas que, junto a la ruptura de un especial contrato matrimonial, producía una situación emocional de alto nivel de ansiedad donde el bebé no podía reposar.

El lugar del terapeuta.

SUMMARY

The work was performed with twelve children not older than 18 months.

* Mansilla 3338, P.B., "C", (1425) Buenos Aires.

Coinciding characteristics:

— In the children: Difficulties for beginning to sleep; cradle rejection; nocturnal awakening; first-born children of young couples; free from organic disorders or other psychological symptoms.

— In the parents: they were experiencing a situation of crisis both as couples and as individuals. The mothers evidenced: ambivalence, and impossibility of getting separated from their children. The fathers showed: a sentiment of exclusion from the mother-child relationship as well as from the couple. Minor problems in the sexual relations. The couples had no problems before the child's birth.

Type of work performed:

The technique used was that of interviews with the parents and, in five cases, with the family group

Conclusions:

The cases studied did not represent absolute failures but developmental crises, the working up of which exceeded their members' capacity. They evidenced certain faults which together with the breach of a special matrimonial contract, resulted in an emotional situation with a high degree of anxiety, where the baby was unable to sleep.

LOS MALENTENDIDOS EN LAS RELACIONES DE PAREJA

Psic. LUIS JURI*

* Entre Ríos 286, 8º, (2000) Rosario, Prov. de Santa Fe.

COMUNICACIONES LIBRES

TERAPIA FAMILIAR. SERVICIO DE PSICOPATOLOGIA EN UN HOSPITAL GENERAL (HOSPITAL PARMENIO PIÑERO).

Lic. JORGE POSE*; Lic. CELIA MARGIOTTA*; Lic. MONICA JARAK*

El propósito del trabajo es transmitir la experiencia e informar sobre la modalidad de trabajo de nuestro equipo de terapia familiar en el Hospital Piñero.

A estos fines se describe el contexto particular en el que este equipo se inscribe: un servicio de psicopatología, con internación y consultorios externos, que funciona en un hospital general.

Se detallan las características del hospital y del servicio, describiendo los equipos que lo componen, nuestra interrelación con ellos y las fuentes de derivación, así como los distintos tipos de trabajo de familia que recibimos. Focalizando en el modelo de atención:

Criterios de admisión.

Duración de los tratamientos.

Frecuencia de las sesiones.

Otras características de la tarea asistencial.

Posteriormente se describen las distintas dificultades y resistencias a las que se enfrenta un equipo de estas características, tanto en el ámbito institucional como en el funcionamiento interno.

Se desarrollan las características del equipo en sí:

Coterapias.

Tarea asistencial.

Formación.

Supervisión de casos en el equipo.

Supervisión externa.

Uso de la Cámara de Gesell, etc.

Finalmente se describe la constitución del equipo y el lugar que en él ocupan los distintos aportes representados por las escuelas y formaciones profesionales de las que provienen nuestros integrantes.

SUMMARY

The purpose of this paper is to convey the experience and to report on the models of working of our family therapy team at the Hospital Parmenio Piñero.

* Hospital Piñero, Servicio de Psicopatología, Varela 1303, (1406) Buenos Aires.

The paper gives a description of the particular context in which this team is inscribed: a psychopathology service in a general hospital.

It specifies the characteristics of both the hospital and the service, describing the teams which integrate it, the interrelationship with them, and the sources of referral.

Model of care:

- admission criteria
- treatment duration
- session frequency.

It also describes the difficulties and resistance a team like this must face, both in the institutional sphere and in the internal operation.

PSICOPROFILAXIS QUIRURGICA Y FAMILIA

Lic. MARIA MARTA DUCOS*

Situación familiar del paciente quirúrgico.

El niño: su ubicación en el grupo familiar.

Los padres, hermanos, familia grande, ansiedades.

El adulto: situación de abandono temporario de su vida habitual.

Pareja, hijos, padres, delegación de roles, ansiedades.

Los gerontes, expectativas de vida del paciente y de su familia frente a la gravedad y riesgo real.

Inclusión de los familiares en el proceso de psicoprofilaxis.

La familia, el terapeuta y el grupo médico asistencial.

SUMMARY

— The child: His/her status in the family group.

Parents. Siblings. Large Family. Anxieties.

— The adult: Situation of temporary abandonment of his/her customary life.

Partner. Children. Parents. Role delegation. Anxieties.

— The aged: Life expectations of the patient and his/her family in the face of serious illness and real risk.

Inclusion of the family in the process of psychoprophylaxis.

The Family, the Therapist and the Medical Staff.

APROXIMACION A LA DINAMICA FAMILIAR E INDIVIDUAL DE PACIENTES CON TRASTORNOS EN LA ADQUISICION DEL LENGUAJE

Dra. SUSANA ROMERO* y Psic. MARTHA SIERRA MARTINEZ

Formando parte de un grupo de investigación (Centro Neuropsicológico de Montevideo) dedicado a la investigación de los trastornos del lenguaje en los adultos y en los niños.

Nuestro subgrupo de psicología intenta abordar o tratar de entender qué lugar ocupan los aspectos emocionales en los diferentes trastornos del lenguaje.

En este trabajo nos centramos en aquello que tiene que ver con la adquisición del lenguaje en el niño.

La finalidad de esta investigación con este sub-grupo, es la de intentar entender cómo los trastornos afectivos pueden incidir en la afección.

Tomando a De Waelhens "El acceso a la palabra es explicable en términos hegelianos como el paso que lleva desde el elemento de la mediatidad al de la mediación. Se trata pues de renunciar a la inmediatez del objeto e ingresar en la mediación revelándose ésta última como inseparable a la constitución de un simbolismo. Nombrar un objeto es renunciar a la presencia de dicho objeto. El acceso al lenguaje es un proceso por el cual el niño se separa en primer término del primer objeto (su madre), y en segundo lugar acepta la negatividad, la ausencia. Esta renuncia a la mediatez es sustituida por la palabra o por otro signo que la sustituya. Este complejo proceso, está sobredeterminado a múltiples relaciones donde juegan un papel preponderante las figuras parentales".

Partimos en nuestra investigación de que el niño puede llegar a ser fácilmente el depositario masivo de los conflictos intrafamiliares y por lo tanto nuestra investigación privilegió en las entrevistas el abordaje a la familia, situación ésta que nos posibilitó un mejor entendimiento de la conflictiva individual.

Como dice el Dr. C. Mendilaharsu en su trabajo sobre patología del lenguaje en el niño, que se trata de un disturbio que ha dado lugar a múltiples controversias tanto en torno al diagnóstico como a la etiología.

Habiendo autores que lo consideran como un disturbio funcional sin substracto anatómico en el que podría incidir una serie de factores entre los que estarían los disturbios afectivos.

En su concepto hay dos hipótesis etiológicas: la primera en la que habrían alteraciones estructurales determinadas por lesiones precoces de diversa naturaleza, y en segundo lugar los casos familiares (genéticos).

* San José 807, Dto. 1101, Montevideo, Uruguay.

Se muestra a través de un material clínico cómo desde una comprensión psicoanalítica se pueden detectar sin duda elementos determinantes del mantenimiento del síntoma.

Creemos que el material muestra claramente cómo este niño nace de un deseo y queda inmerso en un discurso familiar que lo determina.

Creemos que este caso nos enfrenta a las complejas relaciones entre el nivel psíquico y el orgánico, punto en el cual convergen diversas disciplinas, que a pesar de sus esfuerzos aún no han logrado una adecuada articulación de los conocimientos que permitan una comprensión más acabada del mismo.

SUMMARY

We belong to the interdisciplinary group (Center of Neurology of Montevideo, Uruguay), dedicated to the study and research of disturbances of language, in adults (Aphasics) as well as in children (Dysphasics). Our sub-group of dynamic psychology attempts to approach the incidence of emotional disturbances both at individual and at family level, in the different alterations specific to both fields.

In this paper we refer to some aspects of our research in the Dysphasias. Our questions connected with this research are whether the disturbances of the emotional area, at individual as well as at the level of the family group, are a consequence of organic factors or whether they interact with these, and if so, in what ways they influence the maintenance of this symptom.

CEFYP: UN CENTRO DE FORMACION PARA TERAPEUTAS FAMILIARES

Dr. ADOLFO LOKETEK* y Lic. ROSALIA BIKEL*

El auge de la terapia familiar en los últimos años está unido evidentemente con la necesidad de acceder a una comprensión del hombre que trascienda los mecanismos y motivaciones intrapsíquicos de sus conductas y que abarque las situaciones vitales que lo contextúan. Desde este punto de vista, la familia, sistema natural matriz de las relaciones interpersonales, ha sido privilegiada como objeto de estudio, comprensión e investigación de las conductas y de la psicopatología humana.

Fue en esta creencia, que CEFYP nació como institución docente y asistencial. A partir de nuestro modo de leer los fenómenos familiares en una línea actual e histórica, pretendíamos desarrollar un modelo clínico eficaz en las consultas por situaciones disfuncionales, a la vez que aplicar un modelo docente que fuera congruente tanto con la teoría como con el método clínico propuesto.

En este momento tenemos claro que nuestra comprensión de la familia y nuestro abordaje de una familia disfuncional, que privilegia cierto tipo de intervenciones terapéuticas, requiere un terapeuta con características especiales. Para ello implementamos el modelo docente que vamos a describir, con docentes con características también específicas y con una organización institucional que lo mantiene.

A partir de esta organización docente institucional, esperamos que un profesional de la salud mental que se acerca a CEFYP, no sea sólo un alumno de un curso, sino que participe de un Centro de formación, para mantener el cual necesitamos una retroalimentación constante. Para ello contamos con:

- Cursos regulares de entrenamiento de dos años de duración.
- Cursos de post-gradó para continuar la formación clínica.
- Cursos especiales de entrenamiento para profesionales del interior del país.
- Cursos especiales para asistentes sociales y psicopedagogos.
- Cursos, seminarios y jornadas sobre temas específicos.
- Seminarios intensivos.
- Ateneos clínicos.
- Supervisiones, supervisiones en vivo, observación en horarios extradocentes.
- Acceso al material bibliográfico y de video-tapes.

De todas nuestras actividades, seleccionamos aquí para exponer el curso regular de entrenamiento de dos años de duración, porque entendemos que es paradigmático de nuestra manera de encarar la formación.

Este curso se desarrolla en clases semanales de cinco horas de

* Serrano 1141, (1414) Buenos Aires.

duración: 2.15 horas teóricas y 2.15 horas clínicas, con un intervalo de 30 minutos entre ambas, lo cual hace un total de aproximadamente 200 horas teóricas y 200 horas clínicas, a lo largo de los dos años.

Básicamente, la parte teórica está estructurada alrededor de un programa temático bibliográfico y una manera especial de transmitirlo. Si bien nos manejamos con bibliografía conocida sobre los temas, lo peculiar de nuestro esquema docente está puesto en la forma, en el cómo de la transmisión.

El tema de las intervenciones terapéuticas es analizado en la parte teórica y es aplicado en la práctica clínica; es en este campo que se concretizan los conocimientos y se validan las teorías. Además, los alumnos pueden tomar supervisiones con el cuerpo de supervisores de la institución, durante todo el período de su formación, de acuerdo a reglas que rigen para esta tarea.

Indicadores importantes que nos permiten suponer que nos hemos aproximado a nuestro objetivo en la formación de un terapeuta familiar, son las construcciones lingüísticas que éste utiliza para transmitir su comprensión de una situación terapéutica. Como por ejemplo:

En la descripción: Cada vez que A dice..., B dice... y C se muestra...

Describiendo el sistema terapéutico: Cuando A planteó su..., B sugirió... y yo me acerqué a A para...

Describiendo su intervención terapéutica: Me dirigí a A señalándole su... y sabiendo que B iba a recibir mi intervención de tal manera y C de tal otra.

O bien:

Me dirigí a A señalándole su... y no sabía qué pasaba en ese momento con B y C. Sabía que era importante en ese momento no saber nada de B y C.

Imaginando la próxima sesión: Espero que en la próxima sesión A, B y C, no se enganchen o entrapen en... (las reglas conocidas).

SUMMARY

The boom of the family therapy in recent years has been obviously merged with the necessity of attaining an understanding of man that goes beyond the intrapsychical mechanisms and motivations of his behaviour and that covers the vital situations which surround him. From this viewpoint, the family, natural matrix system of interpersonal relations, has been favoured as the object of study, understanding and research of the human behavior and psychopathology.

On account of this, CEFYP came into being as an institution of teaching and assistance.

Starting from our way of viewing the family phenomena in a present and historical line, we sought to develop a clinical model effective in the consultations for dysfunctional situations and at the same time we sought to apply a teaching model consistent with the theory as well as with the clinical method proposed.

FAMILIA DEL OBESO

Dr. RUBEN ZUKERFELD* y Dr. ALBERTO CORMILLOT*

1. Introducción

La obesidad es una enfermedad que implica la compleja combinación de tres factores:

1.1.) Alteraciones del balance energético que sobre una base orgánica predispuesta culminan con la acumulación de grasa denominada *gordura*. Su grado es variable y su repercusión familiar es, en principio, función directa de factores socioculturales que varían desde su valoración como signo de opulencia hasta un profundo sentido peyorativo de fealdad y vergüenza.

1.2.) Alteraciones de la conducta sobre una personalidad previa o no que concluyen en la aparición de conductas *adictivas* a la comida. Esta alteración suele quedar articulada dentro de una red familiar de comunicaciones confusas donde la identificación de los deseos individuales y la discriminación de los roles es dificultosa.

1.3.) Alteraciones de la *imagen corporal* asociadas a pasividad, inhibiciones y trastornos de la identidad. Es en relación con esta alteración donde más específicamente puede develarse patología familiar en función de la valoración particular del cuerpo como representante y objeto de determinados ideales.

2. Familia del Obeso

Esquemáticamente pueden describirse tres tipos:

2.1.) *La familia "obesa"*: Descriptivamente la mayoría de sus integrantes son obesos. Existen aquí pautas alimentarias inadecuadas pero sólidamente arraigadas y ausencia de conflicto salvo cuando uno de sus integrantes intenta adelgazar.

2.2.) *La familia "obesogénica"*: Esta situación suele ser la más necesitada de terapia familiar en la medida que existe un único integrante obeso que puede convertirse en el depositario de determinada patología grupal. Esta suele ser denunciada en el mismo proceso de adelgazamiento a través de situaciones doble-vinculares muy características.

2.3.) *La familia "perturbada"*: Si el caso anterior es típico para el adolescente o el adulto joven obeso, existen otros donde lo primario es claramente la obesidad de uno de los integrantes del núcleo familiar y la patología resultante es consecuencia de esta presencia incomprensida y perturbadora. Es decir, que aquí no debiera hablarse de una "génesis" familiar en el desarrollo sintomático.

En una investigación que realizamos en 1976 en 30 familias de adolescentes obesos se observó que la vinculación con el tratamiento

* Cuba 3684, (1429) Capital.

"seudocolaboradora" coincidió con las relaciones insatisfactorias estables y con la mayoría de la distribución obesogénica, mientras que la vinculación "colaboradora" correspondió totalmente a la relación satisfactoria y a la distribución denominada obesa. Debe observarse que en la literatura se ha señalado que la primera caracterización es propia de estructuras donde se han dado episodios de despersonalización, fuertes crisis de identidad y desarrollos esquizofrénicos. Sin embargo, *ninguno de los pacientes obesos correspondientes a estas familias presentó síntomas que fueran diagnosticados como psicóticos.*

3. Abordaje Terapéutico

Son grandes las dificultades de incluir a la familia del obeso dentro de un proceso terapéutico. No cabe duda que existen distintas necesidades desde las imprescindibles en el caso de un niño o un adolescente hasta las no tan necesarias cuando existe un mínimo de vínculos satisfactorios. Pero de todas formas existe un primer nivel informativo mínimo que se implementa a través de *entrevistas familiares explorativas* y *grupos multifamiliares*. En las primeras se trata de hacer participar al núcleo de convivencia dentro de un proceso que es algo más que el adelgazamiento tratando de hacer un diagnóstico presuntivo de la vinculación familiar con la institución y el tratamiento. Paralelamente se propone a la familia participar de ciclos mensuales multifamiliares.

Es desde aquí que se produce la derivación a *terapia familiar* en tres momentos típicos: a) Familia seudocolaboradora "en acción", es decir saboteos y contradicciones permanentes. b) Crisis de reengorde característicamente homeostáticos donde se percibe influencia familiar. c) Estructuras narcicistas donde la confusión y aglomeración perturban significativamente la evolución terapéutica. No desarrollaremos aquí el abordaje de la familia "perturbada" que suele tener buena evolución en *grupos de autoayuda* semejantes a los de ALANON en alcoholismo.

4. Conclusiones

Como síntesis de lo descripto pensamos que en el tratamiento de la obesidad el abordaje familiar es útil, siempre que se haga un diagnóstico adecuado y se planifique una estrategia de alternativas variadas dentro de un abordaje múltiple.

SUMMARY

Obesity is an illness which consists in three kinds of disturbances: a) a physical disturbance called fatness; b) behavior disturbances with addictive symptoms; c) body image alterations.

The family structure participates to a greater or lesser extent in all three characteristics.

There are 3 kinds of families of the obese: a) the "obese" family in which all the members suffer from obesity; b) the "obesogenic" family

in which only one member of the family suffers from the family pathology; c) the "disturbed" family in which the pathology comes as a consequence of the obesity of one of the members.

A study was carried out with 30 families of obese adolescents and it was observed that the "obesogenic" families showed stable-unsatisfactory binds in Jackson's terms, and a pseudo-helpful attitude. Besides they established double-binds in the treatment. None of the obese patients had a psychotic crisis.

The treatment is carried out at 3 levels:

a) Exploratory family interviews and multi-familial groups to give information and clarify underline conflicts.

b) Programmed family therapy, specially indicated in narcissistic patterns, treatment blackmailing or habitual relapse crisis.

c) Self-help groups in "disturbed" families.

TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA: UN MODELO DE ABORDAJE CON ESPECIAL REFERENCIA AL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

Dra. NORMA FUCCI*; Psic. ELENA K. DE LEBENSOHN*; Dr. MARIO RAUL LITMANOVICH*; Dr. CARLOS MAHUAD*.

Este trabajo intenta un acercamiento a nuestra experiencia como equipo terapéutico que opera liderado por un supervisor. Característica de nuestro equipo consolidado a través de un aprendizaje previo conjunto y nuestra labor grupal intensiva a través de cuatro años.

Se describen las características fundamentales de nuestro estilo de trabajo basadas en la epistemología sistémica estratégica considerando la producción de cambios inesperados y no trabajando en función de un concepto predeterminado de normalidad.

Se describen las técnicas a través de las cuales intentamos provocar dicho cambio como: la prescripción de apertura, modo fundamental de enfrentar la resistencia del sistema familiar, la captación de la paradoja central del sistema, la utilización del terapeuta como inductor paradójico.

Se describen las modalidades de los mensajes emitidos por el supervisor. Ejemplificación de nuestro modelo de trabajo con un ejemplo clínico.

SUMMARY

This paper attempts an approach to our experience as a therapeutic team which operates under the leadership of a supervisor. A characteristic of our team which was consolidated through previous learning experience in common and through our intensive group work throughout four years.

We describe the basic characteristics of our style of work, based on the strategic systemic epistemology, taking into account the production of unexpected changes rather than working in function of a predetermined concept of normality.

We describe the techniques which we attempt to provoke this change, such as: the opening prescription; the basic manner of handling the resistance of the family system; the discovery of the system's central paradox; the utilization of the therapist as a paradoxical inductor.

We describe the nature of the messages emitted by the supervisor. Illustration of our model of work with a clinical example.

* Integrantes del Centro de Estudio de Terapia Familiar (C.E.TE.FA.). Director: Dr. FIDEL LEBENSOHN. Tucumán 1060, P.B., "A", (200) Rosario, Prov. de Santa Fe.

REFLEXIONES ACERCA DE LA SELECCION DE LOS MIEMBROS PARA LA TERAPIA FAMILIAR

Dra. LAURA GRINBERG DE OTTADO*; Psic. ALICIA BETRIA DE PALOU**; Dra. RINA PALENQUE DE SEINELDIN***.

Se plantean consideraciones teóricas y estrategias terapéuticas para el trabajo con familias cuyo subsistema conyugal atraviesa una crisis, enfrentando la posibilidad de su disolución, o habiéndose ya disuelto.

Dentro del material estudiado se ejemplifica con casos que están en proceso de disolución, analizando dos modalidades:

a) cuando se manifiestan severas dificultades para la convivencia, a la vez que se plantean amenazas de separación

b) cuando ya se ha iniciado formalmente el proceso de separación.

En los casos donde el subsistema parental ya se ha disuelto se observan las siguientes:

1) cuando continúan interaccionando como subsistema parental único.

2) cuando uno o ambos padres forman parte de otro sistema conyugal o familiar.

La diferencia que existe entre ambas situaciones es que en la primera el subsistema parental convive con el subsistema filial, no ocurriendo esto cuando la separación ya se ha producido.

Se analizan distintas situaciones que se presentan en la práctica de la Terapia Familiar en las que el terapeuta debe decidir con cuáles miembros de la familia va a operar, cuando no es conveniente la aplicación directa de principios generales a estos sistemas particulares, ya que los mismos enfrentan una fractura en el subsistema parental, y necesitan encontrar nuevas reglas que les permitan superar la crisis y reestablecer la homeostasis en la nueva estructura.

Frente a fracasos terapéuticos en familiares que, habiendo ya hecho un tratamiento previo, solicitaban nuevamente ayuda por el mismo problema, su estudio llevó a la conclusión de que la modalidad de abordaje que habían empleado los terapeutas anteriores, no sólo dificultaba su solución, sino que se constituía muchas veces en una situación iatrogénica.

Estos casos, habían sido tratados de acuerdo a principios compartidos aceptados por la mayoría de los terapeutas familiares, y que se refieren a que la entrevista con toda la familia presente, permite considerar una mayor cantidad de indicadores para reconstruir la espiral de interacción, y posibilita contar con más alternativas para efectuar intervenciones.

De la casuística se desprende que el tratamiento con toda la familia

presente, puede resultar inadecuado, especialmente cuando el subsistema conyugal está en crisis, ya se ha disuelto, o cuando uno o ambos de los cónyuges ha constituido otra familia, existiendo una mayor contraindicación cuando el paciente identificado hijo no convive con el progenitor que ha formado la nueva familia.

La búsqueda de una mayor precisión en los criterios para seleccionar los miembros con los cuales trabajar, y que son necesarios para modificar los circuitos de interacción se basa en la conclusión de que se puede operar sin el miembro que no convive con el niño, pues si bien él puede haber estado presente cuando comenzó el problema, el hecho de que persista después del cambio de la estructura, indica, que el sistema lo utiliza como una modalidad disfuncional autónoma de adaptación.

En este caso puede operarse entonces sólo con los miembros más implicados en las reglas que mantienen los circuitos de la interacción.

SUMMARY

Theoretical considerations and therapeutic strategies for the care of families undergoing a crisis in their marital sub-system facing the possibility of the disintegration or already disintegrated are presented.

Facing the therapeutic failures in families which having been treated beforehand requested new help on account of the same problem, the study led to the conclusion that the method of approach that had been used not only made the solution of the problem more difficult, but also frequently brought about a iatrogenous situation.

The treatment that had been used with all the family present turned out inadequate for these systems that face the fracture of one of their sub-systems. There is a major contraindication when the identified patient, the son, does not live with the progenitor who has formed a new family.

The search of a greater precision in the criteria for the selection of the members to work with and who are necessary for the modification of the interaction circuits, is based on the conclusion that one may operate without the member who does not cohabit. Even though he may have been present when the problem started, the fact that the situation persists after the change of the structure, indicates that the system uses him as an autonomic disfunctional modality of adaptation.

Operative criteria for the study of different situations within the subject discussed are mentioned.

* Ituzaingó 640, (2000) Rosario, Pcia. de Santa Fe.

** Paraguay 950, (2000) Rosario, Pcia. de Santa Fe.

*** Ituzaingó 640, (2000) Rosario, Pcia. de Santa Fe.

PSICOPROFILAXIS DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO DES- DE EL ENFOQUE SISTEMICO

Psic. SUSANA FERDKIN*

La familia, como sistema humano en interacción permanente, atraviesa a lo largo de su ciclo vital, por distintas etapas, transiciones, momentos críticos de cambio durante los cuales debe reorganizarse y encontrar reglas de funcionamiento adecuadas para facilitar el pasaje de una etapa a la siguiente.

La llegada de un hijo representa un cambio muy importante e involucra a todo el sistema familiar: creará abuelos, tíos, etc. y una compleja red de relaciones se pondrá en movimiento desde el momento de la concepción. Por su parte, los futuros padres deberán reorganizarse para recibir a un nuevo miembro, y esto implica acomodar reglas, revisar funciones y encarar una nueva área de relación: la de los hijos.

Fueron precisamente estos fenómenos de organización y estructuración de los sistemas familiares, frente a las crisis propias de sus ciclos vitales, los objetivos de una experiencia que se realizó en la ciudad de Mendoza en el año 1981.

Para este propósito, fue necesario plantear una metodología adecuada que ubicara al embarazo dentro del contexto familiar, como una situación de pasaje de un estadio del ciclo vital al siguiente. Circunstancia que compromete el equilibrio hasta entonces logrado por el sistema, en virtud de tener que incorporar a un nuevo miembro, y por lo tanto alcanzar una organización tal, que le permita seguir siendo el mismo y modificar a la vez algunos aspectos funcionales.

Esta experiencia, tomó la forma de un curso de alrededor de dos meses de duración, con una frecuencia semanal y debía concurrir la pareja. Previamente a los encuentros grupales, se realizaron por los menos dos entrevistas a cada pareja en particular. La propuesta incluía dos encuentros posteriores al parto, a modo de seguimiento, para realizar una evaluación de la situación presente y por supuesto, de nuestro trabajo. Se trató de una tarea privada con un grupo piloto de seis parejas entre los dieciocho y treinta y tres años de edad, todas primigestas. El aspecto de información fue cubierto por un médico obstetra y una médica neonatóloga, la gimnasia prenatal fue dirigida por una partera y el equipo psicológico, trabajó en las organizaciones familiares de las parejas.

El objetivo de la experiencia, fue la prevención de posibles disfunciones ante los fenómenos de organización y desorganización que caracteriza a los cambios evolutivos.

Las parejas en cuestión, fueron abordadas principalmente a través de tres áreas: a) económica, b) social y c) parental. Áreas que fueron

privilegiadas por considerarlas las más comprometidas con el cambio, de acuerdo con las características del grupo.

La evaluación posterior al parto, resultó altamente positiva y significó sobre todo, un importante estímulo para seguir trabajando en prevención familiar.

SUMMARY

Family, as a human system in a permanent interaction, goes through different phases of its vital cycle. There are critical moments of change, transitions, during which the system must reorganize and find operative rules, to facilitate the passage from one stage to another.

When a child arrives to a family, there is an important change that engages the whole system: they will originate grandparents, uncles, aunts, etc.. It will mobilize a complex relational network. Meanwhile, the future parents will reorganize their lives in order to receive the new member. That means to adapt old rules, review functions and aim a new relationship area: the parental one.

These were the objectives of an experience which took place in Mendoza City. For this purpose, it was necessary to plan a competent method that could place pregnancy in its natural context the family.

The major goal of that experience was to prevent family disfunctions through its evolutive changes, in such way that system can use previous and operative patterns and at the same time can find a new organization that include the new member.

* Belgrano 1362, P.B., (8300) Neuquén.

INDICACION Y CONTRAINDICACION DE TERAPIA DE PAREJA

Lic. STELLA MARIS MOLINA*

La indicación de terapia familiar o de pareja depende de los criterios del entrevistador acerca de la necesidad o la pertinencia de abordar un sistema intersubjetivo. Se intentará sistematizarlos pensando la experiencia terapéutica.

Caso A: donde se indicó Terapia de Pareja.

Caso B: donde se indicó Psicoanálisis Individual.

Se plantean algunos interrogantes: ¿Es posible aplicar los mismos criterios para indicar TP que para indicar TF? Se propone TP cuando en la problemática esté en juego la constitución de la alianza y sus consecuencias actuales; tratamiento individual cuando la problemática excede el área de la pareja y abarca lo laboral, social, comunicacional; TF cuando se hallan comprometidos los hijos a nivel de la sintomatología y no meramente como portavoces.

¿El momento en que se indica TP puede tener que ver con su fecundidad?

El concepto de proceso terapéutico permite preguntarse acerca de cuál es el momento más pertinente para abordar la problemática de una pareja.

¿Cómo se entiende en TP el problema de las relaciones entre los individuos y el sistema? Existen disfunciones sistémicas y existen conflictos personales. Un sistema como la familia o la pareja es funcional cuando al mismo tiempo que mantiene su existencia como unidad, permite el desarrollo de sus miembros. Un individuo puede denunciar la crisis por la que pasa el grupo o bien puede utilizar al grupo como escenario para desplegar sus conflictos personales.

No se pretende proponer parámetros absolutos ni criterios rígidos sino poder elegir mejor entre alternativas terapéuticas en función de:

— El tipo de demanda y el lugar en que la pareja o los miembros individualmente ubican al terapeuta. Es decir, si se detecta el pedido de tratamiento y deseo de cambio en la relación.

— Los tipos de conflictos y de síntomas. Es necesario discriminar cuáles pertenecen al sistema pareja y cuáles a sus integrantes. Si la pareja tiene hijos se constatará en qué medida presentan sintomatología involucrada en el conflicto de los padres o si son portavoces. En ambos casos denuncian, pero el compromiso psicopatológico y el abordaje terapéutico son diferentes.

— Establecer si la determinación del síntoma o del conflicto es elaborable predominantemente a nivel de la relación intersubjetiva y de la estructura del sistema, o bien, la determinación del síntoma o del conflicto remite predominantemente a estructuras históricamente anteriores al vínculo y elaborables a nivel de la transferencia en el análisis individual. El fantasma está estructurado sobre los deseos relacionados

con el Complejo de Edipo, que determinan si la elección de objeto será del tipo narcisista o por aposición. Además existen factores reguladores de esta elección que la permiten y restringen al mismo tiempo. Uno, es la prohibición del incesto (lo prohibido) que lleva a la búsqueda de un objeto exogámico. El otro, es el código de significaciones inconscientes que se aprehenden en la familia de origen para el cumplimiento del deseo y las restricciones para sortear el tabú del incesto (lo prescripto). La elaboración terapéutica se orientaría hacia uno u otro de la elección de objeto, eslabón entre los deseos edípicos y la consolidación de una alianza matrimonial, según la importancia de las sobredeterminaciones del conflicto actual.

SUMMARY

We attempt to systematize criteria as to the pertinence of approaching an intersubjective system therapeutically by reflecting on:

Case A: where Couple Therapy (CT) was prescribed.

Case B: where Individual Psychoanalysis was prescribed.

Some questions are posed: Is it possible to apply the same criteria for prescribing CT as for prescribing Family Therapy (FT)? CT is proposed when the constitution of the marriage and its present consequences are involved in the problem; individual treatment when the problem goes beyond the area of the couple and includes the social, work, etc., areas. FT when the children are affected at symptomatic level and not just as spokesmen.

Can the moment in which CT is recommended have to do with its fruitfulness?

We recur to the concept of therapeutic process.

How do we understand the problem of the relations between the individual and the system in FT? Systemic dysfunctions and personal conflicts exist. A system is functional when it maintains its existence and permits the development of its members. An individual may denounce the crisis of a group or may utilize the group as a stage on which to display personal conflicts.

We intend to choose among therapeutic alternatives basing our choice on:

—The type of demand and the place in which the couple or the members situate the therapist.

—Types of conflicts and symptoms. Discriminate which belong to the family system, which to the couple and to its members.

—Determine whether the conflict may be worked—through predominantly on the level of the intersubjective relation and of the structure of the system or whether it refers predominantly to structures historically previous to the union, to be worked—through on the level of the transference in psychoanalysis. The therapeutic working—through would be oriented toward one side or the other of the object choice, a link between oedipal desires and the consolidation of the marital alliance, according to the importance of the over-determinations of the present conflict.

* Laprida 1898, 16°, "M", (1425) Buenos Aires.

¿PAREJA ADULTA EN: "CRISIS DE ADOLESCENCIA"?

Psic. NIEVES LABRUCHERIE MERCON*

Pareja que se presenta a la consulta, por desavenencias que van en aumento, sin motivación precisa. Dicha pareja está constituída desde hace 15 años, y tienen dos hijas de 14 y 12 años.

Realizamos cuatro entrevistas diagnósticas que nos permiten a su vez, programar una estrategia de trabajo y un pronóstico sobre la base de sus posibilidades de aprendizaje.

Lo que llama más la atención en estas primeras etapas, son sus conductas estereotipadas, rígidas, donde todo lo que hacen y dicen está predeterminado y planificado.

De dichas entrevistas surgen como aspectos más significativos los siguientes:

- a) las hijas funcionan como figuras superyoicas muy fuertes;
- b) la "Santa Madre Iglesia" y el Padre Jeremías, su representante, digitan la vida familiar y la distorsionan;
- c) actitud de los miembros de la pareja: huídas, depresiones, grupos de pertenencia extra familiares, muy absorbentes, rebeldías, celotipias, controles mutuos excesivos.

Todos estos síntomas comienzan a surgir, a punto de partida de un cúmulo de duelos no elaborados que se suceden en el correr de cuatro o cinco años (pérdidas de los padres de ella, hysterectomía, ruptura de una situación de estrecha dependencia del miembro masculino de la pareja, con su madre y su hermano, que ha funcionado como padre).

Estos duelos, no elaborados y no compartidos, los remite a duelos anteriores, tampoco no elaborados, y que también se reactualizan con la irrupción de la pubertad de las hijas y sus 15 años de matrimonio.

La consecuencia de todo ello es que la comunicación falta o está distorsionada. Los conflictos se dan entre los roles y entre el adentro y el afuera. Las ansiedades predominantes son las depresivas y persecutorias. El aprendizaje es lento pero con buenas posibilidades.

Entiendo que por las características racionalizadoras y verborrágicas de la pareja, sería necesario la inclusión de técnicas expresivas que permitieran una movilización a otros niveles, y así incluyo técnicas dramáticas y collages. Es a través de este material que puedo visualizar los siguientes aspectos: conflictos entre crecer y permanecer en la infancia, vivido como un rompecabezas. Incertidumbre en relación al futuro, miedo al compromiso, miedo al rechazo. Desconfianza en el otro y en sí mismos; sensación de desvalimiento. Pocas posibilidades de reparación ante el error y las pérdidas. Enfrentamientos ideológicos entre la pareja y cada uno consigo mismo. Planteos ambivalentes en lo sexual. Fugas.

Como se observa en lo antedicho, corresponderían estas caracte

rísticas a una típica crisis de adolescencia, que se manifiesta no sólo en cada uno de los miembros, sino en la pareja como tal.

En estos momentos el proceso continúa, han habido importantes modificaciones en ellos, especialmente en la comunicación, que se ha hecho más fluida y espontánea.

Igualmente, se me plantean las siguientes interrogantes de futuro: ¿será necesaria la inclusión de las hijas en el proceso? ¿En qué momento y cómo? ¿Será preciso la indicación de terapia individual para cada uno de ellos?

SUMMARY

A clinical case is presented: the couple comes to consult owing to increasing discord. Married 15 years ago, they have two daughters of 14 and 12 years of age, respectively. After four diagnostic interviews, the following aspects appear to be the most significative ones:

- a) The daughters act as very strong super-egotistic figures.
- b) The "Holy Mother Church" and Father Jeremías, its representative, manipulate the family life distorting it.
- c) Couple members' attitude: flights, depressions, highly-absorbing extra-familial belonging groups, rebelliousness, jealousy, excessive mutual controls.

A series of non-elaborated mournings followed one another in the course of 4 to 5 years: loss of her parents; hysterectomy; rupture of a closely dependent relationship between the male partner and his mother and brother.

Because of the rationalistic and verbose traits of the couple, I decided to include dramatic techniques and collage.

It was through this material that the typical aspects of a crisis of adolescence (struggles between growing into adulthood and staying at childhood; uncertainty related to the future; fear of involvement and rejection; lack of self-confidence and of confidence in the other partner; ambivalences in sexual matters, and so on) appeared manifestly in each one of the partners and in the couple as well.

* Libertador 1676, Dto. 1101, Montevideo, Uruguay.

FANTASMAS QUE INCIDEN E INTERFIEREN EN LA DINAMICA FAMILIAR

Psic. RINA FRUGONE DE VALETA*; Psic. MARTHA SIERRA MARTINEZ**; Psic. NIEVES LABRUCHERIE MERCON***.

Se intenta mostrar en este trabajo, las distintas vicisitudes del proceso terapéutico de algunos grupos familiares, en los cuales se ha centrado el motivo de consulta en uno de los hijos.

En las entrevistas previas, realizadas antes de establecer el contrato, se ve cómo éstos son depositarios masivos de una problemática; que hay una realidad que se remite a los conflictos de las parejas parentales con sus propias familias de origen.

Jerarquizamos las entrevistas diagnósticas para ver qué posibilidades tienen como grupo y cada uno de ellos, y poder visualizar qué conflictiva es depositada en el niño. En estas entrevistas hacemos hincapié en el tipo de comunicación que se establece en el grupo familiar, cómo se encuentran distribuidos los roles, cómo se manejan los conflictos y qué tipo de ansiedades se ponen en juego, tratando de esta manera de poder evaluar qué posibilidades de aprendizaje tiene ese grupo, cuáles las dificultades de realizar un cambio y plantearnos las distintas estrategias terapéuticas a seguir en el transcurso del tratamiento.

Estas primeras entrevistas diagnósticas son, para nosotros, sumamente valiosas, en la medida que las tomamos como los primeros emergentes que marcarán la dinámica grupal. Creemos también que éste es el momento donde se encuentran los terapeutas con sus propias posibilidades y limitaciones que lleva a éstos a un análisis profundo de sus propias fantasías, de sus propios conflictos como miembros también de una familia, especialmente, porque aún en nuestro medio, muchas de las veces, el terapeuta se aproxima a esta disciplina en un doble esfuerzo de comprensión en tanto no ha transitado por dicha experiencia, aunque esta situación está paliada por la propia formación del terapeuta familiar, que necesariamente hace su aprendizaje a través de una experiencia grupal que le permite revivir en ese grupo, sus propios conflictos con su grupo primario.

Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta y ser muy cuidadosos con ellos, es que en la mayoría de los casos, los pacientes son derivados por otro profesional a una psicoterapia individual, lo que refuerza en los padres, la depositación, aumentando los mecanismos de negación como forma de no asumir el compromiso que la terapia significa. De ahí que muchas veces tengamos que hacer un abordaje

individual y ser muy cautelosos en el pasaje a una terapia del grupo familiar.

En suma: este niño estaría sosteniendo las situaciones familiares no resueltas de cada uno de los integrantes del grupo, que ocultarían fantasmas difíciles de develar, y que se proyectarían en el o los hijos, como vínculos patológicos establecidos anteriormente con sus progenitores.

Destacamos también, la atención que debemos tener con los posibles fantasmas que puedan incluirse por parte de los terapeutas; procedentes no sólo de vínculos familiares anteriores, sino de sus esquemas referenciales, y sus inserciones institucionales.

SUMMARY

What is intended to be done is to prove the different troubles in the therapeutic process of some family groups in which advice about one of the children is centered.

In previous interviews made before establishing the contract one realizes they are massive depositaries which really derive from their own parents and their family before them.

This child would be putting up with unsolved family situations of each one of the members of the group.

These situation (problems) would hide ghosts difficult to clear up and which would project themselves in the person involved or his children as pathological ties previously established by their own parents.

We would also like to draw your attention to the fact that there might be possible ghosts that can be included by therapists themselves.

Coming not only from previous family bonds but from referring outlines and their institutional insertions.

* Av. J. Suárez 3055, Montevideo, Uruguay.

** San José 807, Dto. 1101, Montevideo, Uruguay.

*** Libertador 1676, Dto. 1101, Montevideo, Uruguay.

PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LA FAMILIA

Lic. MARIA ISABEL REY DE LAMBERTI*

El proyecto se realizó teniendo en cuenta la experiencia en un Centro de Salud dependiente de la Municipalidad de San Fernando, cuya área de influencia es un barrio suburbano-periférico.

En el primer momento fuimos insertándonos y conociendo los recursos y necesidades. Luego preparamos el plan y actualmente, ya presentado en la Secretaría de Bienestar Social, hemos comenzado a aplicarlo.

La tarea encarada es preventiva y asistencial, la cual consideramos ámbito del psicólogo. Dirigida a la *familia*, como unidad grupal de la sociedad, donde el hombre transcurre su proceso vital, constituyendo subgrupos funcionales, dinámicamente imbrincados.

Partiendo del subgrupo *pareja*, hombre y mujer transcurren una situación de noviazgo y posteriormente de matrimonio. La acción preventiva se puede realizar a través de instituciones (p. ej. eclesiásticas) colaborando en la información y formación de las mismas.

Cuando la pareja se plantea la posibilidad de ser padres, se produce una situación intermedia que llamaremos *búsqueda de la paternidad*, nuestra acción en consultas de Esterilidad (asistencial) se aborda con el médico; de Adopción con las instituciones existentes. Para la Regulación de la Reproducción, grupos operativos y en el caso de las gestantes los Cursos de Psicoprofilaxis interviniendo el Hospital.

Si bien el tercer subgrupo *padres* generalmente llega para - su asistencia vemos posible, en el momento oportuno, agruparlos por edades de sus hijos. Se les ofrece grupos de formación e información de "Con hijos hasta 5 años" "...hasta 10 años" y "...adolescentes".

Hace unos años que se lleva a cabo la tarea médico-escolar. Lo cual entrelaza a todos los Centros y Escuelas del Partido. Esto posibilita que el psicólogo se inserte en el mismo operativo. Por ello, en la situación *Hijos* nos llegan a consulta los niños derivados por escuela y médico, como también los que son traídos por los padres y los adolescentes y adultos que vienen por sí mismos. Preventivamente podemos actuar sobre los miembros de las instituciones en las cuales se agrupan (maestros, sacerdotes, entrenadores, etc.). Más directamente pueden darse charlas informativas en las instituciones o en el Centro y formar grupos operativos sobre temas específicos.

Por último el subgrupo *Abuelos*, quienes consultan personalmente, muchas veces por estar a cargo de sus nietos, otras son derivados por el médico y también es la familia o la institución quien puede asistir a consulta.

Encarar el trabajo preventivamente significa ayudar al hombre a un

buen-estar-en-la-ancianidad. Y para la familia y la sociedad aprovechar de ese miembro de sí misma.

Para todos los subgrupos se planifica la asistencia de la forma conocida. Generalmente se redefine la consulta individual como familiar. Se trabajó esta redefinición, luego si es necesario se realizan tratamientos individuales, grupales o familiares.

Esta tarea preventiva y asistencial remite a un problema conocido que es el equipo interdisciplinario. La formación de éste es un proceso arduo en tiempo y esfuerzo personal. De todos modos necesario. Estar convencido que un solo profesional no va a dar la "solución al complejo problema de la familia-en-sociedad, es el comienzo, luego el aprender a compartir la tarea haciéndose cargo del propio puesto y el respeto del puesto del otro.

SUMMARY

The project was carried out taking into account the experience in a Health Centre dependent on the Municipality of San Fernando, being the area under its influence a peripheral suburban neighbourhood.

The task undertaken is connected with prevention and assistance; we consider it to be within the scope of the psychologist. It is directed towards the *FAMILY* as a group unity of the Society, where man develops his vital process, making up dynamically imbricated functional subgroups.

Starting from the subgroup *COUPLE*, the subgroup *PARENTS* is reached through the *PURSUIT OF PARENTHOOD* to end with the subgroup *GRANDPARENTS*.

For every subgroup the assistance is planned in the ordinary way.

Generally the individual consultation is redefined as a family one. Then, if it is necessary, individual, group or family treatments are carried out.

Informative talks are given in the centres; besides, operative groups are made up.

This task of prevention and assistance refers to a well known problem, that is to say the interdisciplinary team.

* Brasil 605, (1643) Beccar, Prov. de Buenos Aires.

ANOREXIA NERVIOSA, UNA COMUNICACION CLINICA

Lic. WANDA SANTI*

El trabajo se apoya teóricamente en ideas de Bowen, Minuchin y Palazzoli. Explicita el modo de trabajo de su autora.

Luego de una o dos entrevistas diagnósticas con todo el grupo familiar, se cita sólo a los padres para la tercera. En ésta se le comunica que por el momento se trabajará con ellos solos, para que puedan a través de la convivencia cotidiana ser quienes modifiquen la situación que les preocupa.

Esto resulta útil por varias razones:

a) Los padres pasan de una posición pasiva, incompetente e impotente, a otra activa, dirigida y sistematizada, con aval de un experto con el que establecen un pacto de colaboración.

b) Automáticamente quedan demarcadas las fronteras generacionales.

c) Los padres triangulan con otro tercero, el terapeuta.

d) Se hace alianza con el área libre de conflicto de los padres, para trabajar incrementando una de las funciones de todo sistema, la transformación.

Desarrolla brevemente definición del Síndrome y Sistema Familiar Anoréctico.

Caso clínico: Consiste en presentación de resumen de las dos primeras de diez entrevistas que tuvo en total el tratamiento.

Padre: 36 años. Abogado.

Madre: 35 años. Ama de casa. Ceramista.

JESSICA: 12 años. 7° grado.

Dolores: 10 años. 5° grado.

Elmer: 6 años. 1° grado.

Peso en marzo 81: 38 kgs.

Primer visita al pediatra: Sep. 81. Altura 1,45 - Peso 33 kgs.

Primer entrevista familiar: Noviembre 81. Altura 1,45 - Peso 28,100 kgs.

Motivo de la consulta: Evitar la internación y detener el descenso de peso, y que el pediatra había puesto como tope los 28 kgs.

Temas de la primera entrevista: Evolución y detalles del síntoma. Antecedentes de una consulta al psiquiatra por manías religiosas e intensos temores al infierno con llantos constantes, al punto de impedirle continuar con los preceptos de la Iglesia que su padre impone a la familia.

Relatos de dietas (ineficaces) de la madre y manejos de las comidas que hace Jessica.

* Juncal 2605, 7°, "C", (1425) Buenos Aires.

Se hicieron dos intervenciones, la primera cuando arreciaban los comentarios sobre la religión y comida, y la segunda, al cierre.

1ra. Intervención: "Veo que Jessica ha demostrado ser capaz de llevar los temas que preocupan particularmente a Mamá y Papá hasta sus extremos. Hace un año, con la religión que tanto le interesa a Ud. (al padre) a tal punto de no poder cumplir con los preceptos. Y ahora con la comida que es capaz de controlar tan exitosamente para no engordar como Ud. (a la madre)."

2da. Intervención: "Yo voy a reunirme a trabajar solamente con Uds. dos (señalando a los padres) en las próximas entrevistas. Vos Jessica seguramente estarás internada, ya que sólo te faltan 100 gramos para ese momento. Veo que has decidido salir de tu casa, de ésta manera, para no seguirte tentando de reemplazar a tu mamá."

La primera intervención apunta a cambiar a Jessica de paciente débil a fuerte con poder. Superando a ambos padres.

La segunda delimita subsistemas. Connota positivamente el síntoma y lo prescribe. Además plantea un desafío a la madre a que retome su lugar de tal.

Segunda Entrevista: Vienen los padres solos, cuentan que Jessica se fue indignada de la 1ra. entrevista y lloró dos horas. En ese día dijo que no comería, la madre entonces se fue a su cuarto, a lo que Jessica responde buscándola y comiendo "normalmente" en su presencia. Esto les alegró porque siguió comiendo lo suficiente como para no volver a perder peso. Siguen discutiendo luego entre ellos, porque la madre no se ocupa (según el padre) adecuadamente de la casa, ya que va al taller. Hace tres meses que no tienen relaciones sexuales, con lo cual no cierran su puerta, ya que sólo lo hacen cuando van a tenerlas. La madre pide ayuda para la pareja.

Intervención: "La situación de la pareja de Uds. es preocupante, pero no ha sido el motivo que los trajo. Si están mal y desean separarse lo podrán hacer más adelante, es más, yo podría ayudarles a que lo hagan, pero no ahora. Mi interés en este momento es pactar con Uds. para que colaboren conmigo y puedan modificar situaciones familiares a través de la convivencia, para lo cual voy a pedirles que hagan una serie de cosas. Sé que es una tarea muy difícil que tendrán que hacer, pero será un sacrificio más que harán por su hija".

Los puntos de la tarea:

1) Absoluto secreto de las entrevistas.

2) Una salida secreta de ambos.

3) Cerrar todas las noches la puerta de su cuarto.

4) Tomar notas de las reacciones de todos, frente a cambios.

Se comentan los detalles de esta entrevista, a qué apunta cada parte de la intervención.

Hay luego un resumen del resto del tratamiento. Se incluye una entrevista de seguimiento tres meses después. Los resultados siguen siendo satisfactorios.

SUMMARY

A case of anorexia nervosa in a 12 years old girl is presented. Consultation was sought to avoid hospitalization and to stop the rapid weight loss.

Ten interviews with a systemic approach were done. This presentation includes a summary of the first two with the therapist's intervention, and the elaboration of each part of the interventions. Comments on the family's reactions to these interviews are also presented.

In addition, the other eight interviews and one follow-up interviews after three months are summarized. Treatment succeeded and its goals were accomplished.

The symptom received a positive connotation and was prescribed in an indirect but explicit way. All five members of the family attended only the first interview. For the others, only the parents were present. The author, who usually works with the parents and leaves the children at home, even the symptomatic one, explains her model, in the line of Murray Bowen and Mara Selvini-Palazzoli. In the report, this model, the rationale for its election, and the expected results, are explained.

REFLEXIONES SOBRE EL LUGAR DE LA MUJER EN LA FAMILIA

Lic. ANA MARIA DASKAL*

El lugar de la mujer en la familia no es producto de una "naturaleza" femenina, sino que está *multideterminado* por factores biológicos, psicológicos, económicos, históricos, sociales. Lo mismo ocurre con el rol materno, que no es un producto del "instinto" que toda mujer "sana" posee. La historia de la organización social nos aporta datos importantes para pensar en esto. El lugar de la mujer en la familia, como así también el del hombre, se transformó radicalmente, por ejemplo, a partir del surgimiento de la sociedad industrial. La mujer perdió su lugar social como productora y pasó a desempeñar un rol exclusivamente dentro del hogar y con los hijos. Este trabajo no fue ni es considerado como tal sino como producto de la "naturaleza" femenina. *Esto implica la negación de que la mujer, en su trabajo doméstico y maternal, cumple una función social, tendiente a mantener y perpetuar una cierta forma de organización familiar, al servicio de un determinado funcionamiento de la sociedad.* La división tan tajante entre dos mundos: el doméstico y el público-social, empobreció a hombres y mujeres. Los hombres han sentido y sienten sobre ellos el peso de las exigencias y presiones del mundo social y de la responsabilidad del mantenimiento económico del hogar. Las mujeres se viven a sí mismas como meras satisfactoras de las necesidades de otros, saben del encierro, de la soledad y de la falta de sentido de su propia vida más allá de la maternidad. En la actualidad, el trabajo fuera del hogar, en muchos casos, se ha venido a sumar, como una tarea más, a las actividades tradicionales de las mujeres, acentuándose de esta manera los sentimientos de culpa, de exigencia, de insatisfacción.

Sostengo aquí que un cambio del lugar de la mujer en la sociedad no pasa *necesariamente* por su salida del hogar, sino también por un proceso de transformación *dentro de él* que la abarque, así como a su marido y a sus hijos. Este proceso implica concientizar valores y prejuicios en torno a temas tales como:

- a) pautas de crianza con los hijos y sus diferencias para varones y niñas;
- b) la distribución de la autoridad en la familia;
- c) los roles paterno y materno; expectativas;
- d) los roles de esposa y esposo;
- e) la organización y administración de la economía y de los bienes familiares;
- f) la organización de las tareas domésticas, etc.

Considero que los terapeutas, en tanto estamos en contacto, o bien con familias, o bien con niños, mujeres y/u hombres individualmente

* Superf 2149, (1430) Buenos Aires.

también debemos repensar estas temáticas, ya que, desde nuestro rol, podemos contribuir tanto a la persistencia como a la transformación creativa de los valores implícitos en la vida cotidiana. Sólo una actitud reflexiva y crítica sobre ellos nos permitirá hacer diagnósticos, elaborar estrategias, pensar causalidades, de una manera menos prejuiciosa y por lo tanto más científica.

SUMMARY

The place of women within the family is not a product of female "nature", since it is multidetermined by biological, psychological, economic, historical and social factors. The same happens with maternity, which is not a product of an "instinct" with which every woman is born. In housekeeping and mothering women are fulfilling a social role, tending to keep in some way a familiar organization, which satisfies a determined function of the society. The confinement to maternity and household makes women live themselves as simply fulfilling others persons' needs. Nowadays, working outside the home, in many cases, increases the demands, the feelings of both guilt and dissatisfaction.

I state here that a shift of the women's place in society must necessarily include a transformation within the household that contains them, as well as their husbands and children. This process—that we as therapists must also go through—, implies the awareness of certain values, prejudice, and beliefs which are deeply rooted in every day life.

FAMILIA. UNA NOVELA ... FAMILIAR

Lic. ESTELA STILMAN DE GURMAN*

En este trabajo se trata de mostrar algunos aspectos del interjuego fantaseoso estudiado por Freud en *La novela familiar del neurótico*, y que se hallarían en la base de la constitución de cualquier familia.

Se trata en otros términos de la problemática que gira en torno a la idealización infantil de los padres, al proceso de desidealización, y a los procesos de investidura narcisista que pone en juego la idea del hijo.

Se desarrollará el tema ilustrándolo con un material clínico.

SUMMARY

This paper attempts to show some aspects of the phantasmatic interplay studied by Freud in "Family Romances", and which may be found in the basis of the constitution of any family.

It deals with questions that involve infantile idealization of the parents, the process of disidealization, and the processes of narcissistic cathexis which the idea of the child puts into play.

The subject is illustrated with clinical material.

* Viamonte 2660, 3º, "C", (1056) Buenos Aires.

DIFERENTES REFLEXIONES SOBRE LA DIADA INSTITUCION - FAMILIA

Lic. SARA SINAY DE OLSTEIN*

Area correspondiente: Prevención y orientación.

En tres años de trabajo en una Institución educacional, como psicóloga, pude establecer las relaciones que por analogía fueron surgiendo en una estructura que frente a situaciones de cambio, rigidiza sus defensas. En la imposibilidad de elaboración se actúa aquello que se oculta por falta de valor simbólico.

Vemos que la "renuncia", es una constante que expresa: resistencia al cambio, a la pérdida, al duelo adecuado que posibilita el pasaje de una situación a otra. Semejante sintomatología se da en áreas de expresión diferentes (institución-familia) compulsando en la repetición, en tanto no hay función padre.

Esta interpretación psicoanalítica del proceso, ofrece a las diferentes lecturas con sus marcos referenciales, una forma de abordaje complementario.

SUMMARY

As a psychologist throughout three years work in an educational institution, it was possible to establish the emerging relationships in a structure which, faced with change situations, stiffened its defense mechanisms. When elaboration is impossible whatever is kept hidden due to lack of symbolic value, is acted. "Resignation" is a constant which expounds resistance against change, and loss, and an adequate mourning, otherwise enabling access from one situation to another.

Such symptomatology appears in different areas of expression (institution-families), compulsory in the repetition, as long as the paternal function is inexistent.

This psychoanalytical interpretation of the process offers complementary approaches to the different readings and to their referential frames.

TECNICAS DE INTERVENCION EN EL PROCESO TERAPEUTICO

Lic. SILVIA CRESCINI* y Lic. MARIA E. PANIZO**

Partimos de considerar a la familia normal funcional como un sistema en crecimiento que posibilita dos procesos simultáneos, a saber:

Sistematización (inclusión de miembros - nacimientos cuidado de los hijos)

Segregación (salida de los mismos - escolaridad - adolescencia)

Una familia normal funcional es la que puede rever sus reglas de interacción de acuerdo con los cambios evolutivos y de contexto. La organización funcional está centralizada por el subsistema parental con límites claros y flexibles entre los subsistemas, lo que posibilita el cumplimiento óptimo de su función básica (desarrollo y crecimiento de sus miembros).

Enfatizamos como funcional, además, a la familia nuclear separada claramente de las familias de origen y con un adecuado intercambio con ellas.

La familia se torna disfuncional cuando no se cumplen las premisas anteriores. Puede aparecer detenida en su momento evolutivo y eso hace que funcione con viejos clichés frente a situaciones nuevas volviéndose inoperante para resolverlas.

El motivo de consulta encierra simultáneamente la tendencia al cambio que los libere del sufrimiento como la resistencia al mismo.

Por último, una familia disfuncional se encuentra indiscriminada de sus familias de origen y tiende a repetir los modelos relacionales previos que no satisfacen, a su vez, las demandas actuales.

Modelo de Trabajo

El caso a presentar fue trabajado en dupla, es decir, un terapeuta en el campo y otro detrás de la Cámara de Gesell, comunicados por un teléfono interno.

La función del terapeuta observador es:

- 1) facilitar la lectura de las múltiples interacciones en juego (verbales, lúdicas, gráficas, corporales).
- 2) el rescate del terapeuta de posibles involuciones con la familia.
- 3) elaboración de intervenciones en forma conjunta.

Desarrollo del Caso

Padre: Benjamín 27 años.

Madre: Mónica 25 años.

Yanina 7 años

Gabriel 3 años.

* Godoy Cruz 2931, 3º, "C", (1425) Buenos Aires.

** Famatina 3978, (1437) Buenos Aires.

* Gascón 697, 10º, "4", (1181) Buenos Aires.

Motivo de consulta: Crisis asmáticas de Yanina - Problemas de conducta de Gabriel.

La terapia fue indicada por el pediatra, acercándose a la institución a través de la abuela materna.

Yanina había tenido un tratamiento durante un año, solventado por el abuelo materno, hasta que éste se niega a seguir pagando, con lo que recrudece el asma, sumándosele el problema de conducta de Gabriel.

Se casaron muy jóvenes (18 y 16 años) a raíz del embarazo de Yanina.

El contrato terapéutico se estableció en función del problema de los chicos y recortamos el sistema alrededor de la familia nuclear. Durante la primera etapa trabajamos alrededor del síntoma y de la pauta interactiva en la que estaba incluido, es decir, que tenían estructurado su funcionamiento alrededor de nebulizadores y corticoides.

El síntoma, la colocaba a Yanina en un lugar central, obligando a los padres en su función.

Las intervenciones de esta primera etapa fueron connotaciones positivas del esfuerzo de cada uno, recomendándoles además el seguimiento por escrito de las alternativas de la enfermedad de Yanina y las dificultades de Gabriel.

En la segunda etapa, citamos a los padres solos para seguir con el tema de los niños, pero comenzaron a surgir las dificultades conyugales, que nos corrieron del motivo de consulta, produciéndose entonces, un incremento de ambos síntomas.

En la 13a. entrevista establecemos un recontrato centrado nuevamente en el motivo de consulta y esta vez solventado por ellos mismos.

Una de las intervenciones de esta etapa, consistió en nombrarlo al padre, experto en el problema y colaborador en la terapia, ya que se negaba a concurrir.

Acordamos 10 sesiones más y decidimos, desde el equipo terapéutico, no sacar más a los chicos, aún cuando nos hablaran de problemas conyugales.

Algunas de las intervenciones fueron alrededor de la respuesta bronquial de Yanina, frente a situaciones de violencia entre los padres, acompañadas por reiteradas prescripciones del síntoma.

Las respuestas más inmediatas fueron:

- 1) Disminución del síntoma.
- 2) Modificación del manejo del mismo por parte de los padres.
- 3) Sustitución de los ruidos bronquiales por el diálogo.
- 4) Expresión del enojo de Yanina y su posibilidad de defenderse frente a las agresiones.
- 5) La pelea centrada en el subsistema conyugal, sin intermediaciones de los hijos.

Comentarios Finales

Intervenciones terapéuticas utilizadas.

1) Connotación positiva del síntoma como fortalecedor de la función parental. Prescripción y predicción del mismo.

2) Intervenciones sobre la regla paradójica del sometimiento al mandato histórico familiar.

3) Predicción de futuras crisis y posibles respuestas.

Incluimos además:

4) Desacuerdos en el equipo en términos de alianza a la morfostasis y morfogénesis.

5) Reestructuraciones espaciales, apuntando a la clarificación subsistémica, con el uso del espejo y la salida de los miembros tras de cámara.

6) Escultura familiar frente al espejo.

SUMMARY

We begin by considering the family as a growing system through two simultaneous processes:

1) progressive systematization (inclusion of members).

2) progressive segregation (leaving of members).

The normal functional family has got certain characteristics:

1) flexibility in the relationship rules

2) the organization has got a hierarchy

3) the interaction among the sub-systems is defined with clear and flexible limits

4) a clear and functional separation from the families of origin (parental families)

The disfunctional family is that one in which all or some of the previous premises are not fulfilled:

1) there is an inflexibility in the rules and a detention in the development.

2) there is an alteration in the hierarchic organization

3) there are diffuse and inflexible limits among the sub-systems

4) there is an indiscrimination regarding the families of origin (parental families)

Work Model

The case to be presented was dealt with "in dupla", that is to say, a therapist in the field and another one behind the Gesell Camera connected with an internal telephone.

The observer therapist function is to:

1) help in the reading of the multiple interactions in play (verbal, ludic, graphic, body).

2) rescue the therapist in case he got involved with the family

3) working-out of simultaneous participations.

Final Comments

Used therapeutic participations:

1) positive connotation of the symptom as a fortifier of the parental function. Prescription and prediction of same.

2) participations referring to the paradoxical rule of submission to the historic family order.

3) prediction of future crisis and possible responses.

We also included:

4) disagreements within the team regarding the "morphostasis" and "morphogenesis".

5) special restructurations, intended to clarify the sub-system with the use of the mirror and the leaving of the members behind the camera.

6) family sculpture in front of the mirror.

DESAFIO DE LOS ESQUEMAS COGNITIVOS EN PSICOTERAPIA FAMILIAR Y EN PSICOTERAPIA COGNITIVA

Lic. NIDIA CARRANZA OVIEDO*

Esta comunicación se propuso destacar el empleo de la técnica de "Desafío de los esquemas cognitivos disfuncionales" en psicoterapia familiar* y psicoterapias cognitivas.

En ambos modelos terapéuticos el uso de esta técnica tiene más de una similitud de propósito terapéutico que de ideología.

El rol del terapeuta familiar es estratégico y es el rol de un experto. Este rol de experto es el que le permite convertirse en desafiador y desde este rol el terapeuta puede interferir la interacción desafiando esquemas de pensamientos, mitos, jerarquías y límites favoreciendo así la flexibilidad y el crecimiento entre los miembros de la familia.

El psicoterapeuta cognitivo si bien actúa también desde un rol de experto no es este rol el que le permite el desafío de los esquemas cognitivos disfuncionales sino su ideología.

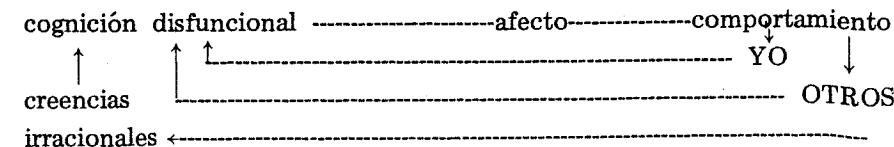
Para los psicoterapeutas cognitivos los esquemas cognitivos disfuncionales son causa de ciertas patologías y son los que las mantienen activas y las cronifican.

En esta ideología los síntomas ideológicos, afectivos conductuales u orgánicos pueden tener por base asunciones básicas no cuestionadas que originan esquemas de pensamientos disfuncionales.

En psicoterapia cognitiva el cambio es esperado sólo después de que se haya producido una modificación de los esquemas cognitivos.

El terapeuta cognitivo focaliza, redefine y reencuadra las creencias irracionales detectadas, como resultado de esta tarea se produce un cambio intelectual que origina un cambio de sentimientos y de conducta.

ESQUEMA COGNITIVO



Interpretación del esquema cognitivo.

La cognición determina y/o modifica el afecto.

El afecto determina el comportamiento.

El propio sujeto percibe su comportamiento y esto determina la calidad de su autoestima en sus dos vertientes emocional e intelectual.

Los otros cuando perciben el comportamiento de una persona

* Anchorena 1726, P.B., "B", (1425) Buenos Aires.

* Salvador Minuchin propone el empleo de esta técnica.

reaccionan y le dan al sujeto un feedback que determina la calidad de la autoestima, percepción ésta que se suma a la anterior.

La cognición está a su vez reforzada por las creencias irracionales y las creencias irracionales a su vez se refuerzan con la autopercepción de los afectos, el comportamiento y por el feedback de los otros.

Las cogniciones disfuncionales determinan conductas disfuncionales que provocan en el otro un feedback negativo. El propio sujeto a su vez se percibe fracasando con lo cual la autoestima continúa disminuyendo y la conducta se vuelve más disfuncional, continuándose así la realimentación del sistema, el cual se cronifica.

Lo urgente para el terapeuta cognitivo es restablecer rápidamente el funcionamiento eficiente del paciente.

El terapeuta cognitivo busca que el paciente prontamente pueda reformular sus esquemas conceptuales disfuncionales para mejorar su autoestima.

El cambio de la autoestima modifica los efectos y el comportamiento. La autopercepción de un comportamiento más eficiente refuerza los sentimientos positivos que mejoran la autoestima. Se rompe así el circuito negativo pensamiento - afecto - comportamiento, produciéndose el cambio terapéutico.

Para Salvador Minuchin el que se haga un desafío a los esquemas cognitivos de la familia no resulta de por sí en un cambio terapéutico, pero si considera que es una técnica que conduce al cambio, si se considera que un desafío a los esquemas cognitivos de la familia es un desafío a la estructura familiar en su totalidad.

SUMMARY

The challenge of cognitive schemes in both therapeutic models is more technical than conceptual.

Working with cognitive therapy, automatic thinking questioning of the basic assumptions, primary and secondary, is the principal technical instrument to obtain thinking reordering. At cognitive therapy, idea forming determines the affective world, and both are behavior forming.

Pathology is considered, at this therapeutic trend, as the result of disfunctional beliefs who are responsible of creating and perpetuating pathology.

Salvador Minuchin, in "Techniques of Family psychotherapy", shows the technique of "cognitive schemes challenge" as a tool used by the family therapist, from an expert role, to get an interactional change. This change is obtained through a new point of view.

At both therapeutic orientations: cognitive therapy and family therapy, defying and questioning cognitive styles have a common purpose: changing.

LUGAR DE LA PARADOJA EN LA TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA

Lic. INES DATES*

A partir de la preocupación por comprender qué significa hablar de paradoja dentro de la Terapia Familiar, especialmente por las así llamadas Intervenciones Paradojales, este trabajo intenta rastrear variaciones de énfasis en el significado del concepto a partir de su introducción, en "Hacia una Teoría de la Esquizofrenia".

Se describe el paso de lo paradójico concebido fundamentalmente como factor patógeno (dentro del fenómeno de doble vínculo) a considerárselo *también* un elemento necesario del crecimiento y el cambio. Y se intenta luego señalar algunas características que distingan a la situación paradójica-que-enferma de la que promueve creatividad.

La segunda línea de evolución en el significado del concepto que considero es la que comienza por entenderlo como un concepto explicativo diferenciador y por ende, situado "allá", en el "objeto" de la Psiquiatría, (familias de esquizofrénicos) para terminar finalmente por contagiar a esa misma psiquiatría o a parte de ella. Porque con el tiempo se advirtió que al incluir lo paradójico en la concepción de los fenómenos estudiados, lo que se había introducido era una nueva epistemología, basada en la idea de una realidad organizada en niveles jerárquicos y con circuitos de determinación circulares o más complejos, que vino a reemplazar la anterior concepción "plana" y de causación lineal hija de la física Newtoniana; y esta epistemología permite superar las paradojas que se le presentan al científico cuando es presa de una situación en la que se ve compelido a elegir entre oposiciones ficticias que lo ciegan a la profunda complementariedad de la realidad que lo circunda.

La noción de paradoja, además, hizo evidente y permitió formalizar el continuo y fútil movimiento que existe en el más estático de los estados de un sistema viviente. Al contener dentro de sí el par de opuestos de intensa actividad en un nivel (oscilación constante) y de estaticidad en un nivel superior, (ya que esa oscilación es incapaz de trascender el dilema paradójico), este concepto de paradoja nos abre la comprensión y nos permite enrolar en las filas de la terapia a las complejas fuerzas contenidas en las familias, especialmente en las llamadas "rígidas".

Propongo finalmente abandonar el calificativo de paradójicas para las intervenciones terapéuticas basadas en esta nueva epistemología dado que la paradoja para el científico, igual que el doble vínculo para el miembro de la familia, desaparece si se la trasciende a un nivel superior, y tal parece ser el resultado de esta nueva epistemología.

* Montes Grandes 1, (1640) Acassuso, Prov. de Buenos Aires.

Así, las intervenciones paradójicas son, dentro de esta concepción, profundamente "lógicas".

SUMMARY

Out of a concern for understanding the meaning of paradox as applied to Family Therapy, and specially of the so-called Paradoxical Interventions, this paper attempts to review the variations in emphasis in the meaning of the concept since its introduction in "Toward a Theory of Schizophrenia".

We describe the step from the paradox considered basically as pathogenic factor (in the double phenomenon) to considering it *also* a necessary element of growth and change. And we then attempt to point out some characteristics differentiating the paradoxical situation that sickens from the one that promotes creativity.

The second line of development in the meaning of the concept we consider is the one that begins by understanding it as a differentiating explanatory concept and therefore situated "there" in the "object" of Psychiatry (families of schizophrenics), finally infecting that same Psychiatry (or part of it); because in time it was discovered that when the paradox was included in the conception of the phenomena studied, what had been introduced was a new epistemology based on the idea of a reality organized on hierarchical levels and having circuits of circular or more complex determinations which took the place of the former "flat" conception and of lineal causality, child of Newtonian physics; this epistemology allows the scientist to overcome the paradoxes he encounters when he is prey to a situation in which he finds himself compelled to choose between fictitious positions which blind him to the profound complementarity of the surrounding reality.

Furthermore, the notion of paradox evidenced and allowed the formalization of the continuous and futile movement existing in the most static states of the living system. By containing in itself the opposite pairs of intense activity on one level (constant oscillation) and of static state on a higher level (since this oscillation is incapable of transcending the paradoxical dilemma), this concept of paradox opens our comprehension and allows us to enlist in the therapeutic ranks the complex forces contained in families, specially in those called "rigid".

FACTORES OBSTACULIZANTES Y FACILITADORES EN LA ADQUISICION DEL ROL DE TERAPEUTAS DE FAMILIA. RELATO DE UNA EXPERIENCIA DE ENTRENAMIENTO.

Lic. ALICIA URRIBARRI¹; Lic. SARA OLSTEIN²; Lic. FANNY BARANCHUK³; Lic. ROSA TRAJTENBERG⁴; Lic. SILVIA QUAGLIA⁵; Lic. ANA CLAUDIA LATERZA⁶; Dra. LILIA CANEVARO CACHIONE⁷; Dr. LAZARO KRAKOV⁸; Dr. JORGE BIANCHI⁹.

Se describe la experiencia de un grupo de terapeutas de familia en formación, con la coordinación del Dr. Alfredo Canevaro y la Lic. Alicia Arbiser.

Los tres niveles de abordaje al grupo familiar que proponen los coordinadores, permite que los conocimientos adquiridos con anterioridad interactúen con los actuales, apoyando, calificando o modificándolos.

Este proceso de integración y cambio, produce situaciones de crisis como movimientos en la identidad profesional; los aspectos organizadores u obstaculizantes del aprendizaje de un nuevo rol, se analizan en este trabajo.

SUMMARY

It describes the experience of a training group in Family Therapy, coordinated by Dr. Alfredo Canevaro and Lic. Alicia Arbiser.

The three level approach proposed by the coordinators, allows to integrate the previous knowledge which interact, with the new way of treating, qualifying or modifying them.

The integration and shifting process produces crisis situations in the professional identity. The organizing and obstructive factors that are present in the training of this new role are analyzed in this communication.

1 Las Heras 2027, 10°, "A", (1425) Buenos Aires.

2 Gascón 697, 10°, "4", (1181) Buenos Aires.

3 Arenales 3724, (1425) Buenos Aires.

4 José Hernández 2045, 3°, "B", (1426) Buenos Aires.

5 Rojas 141, 5°, "20", (1405) Buenos Aires.

6 Cabildo 1257, 13°, "D", (1426) Buenos Aires.

7 Bauness 2248, (1431) Buenos Aires.

8 Arenales 2552, 6°, "B", (1425) Buenos Aires.

9 Gral. Roca 3035, (1602) Florida, Prov. de Buenos Aires.

FAMILIA TERAPEUTICA, SU FUNDAMENTACION.

Dr. RAUL A. CHIRINOS* y Lic. INDIA ALEMAN**

Denominamos *familia terapéutica* a una actitud que va desde un reenfoque de la situación terapéutica en consultorio, hasta un modelo de Institución Intermedia.

La "situación terapéutica" está constituida por cuatro elementos:

1ro. *AMBITO*: un espacio físico donde se desarrollan fuerzas afectivas, determinado por los lugares que ocupan los protagonistas y el juego de relaciones entre ellos. Se trata de replicar ese campo de fuerzas, que es el ambiente propio de la familia, en el consultorio y en la Institución. Una característica fundamental es la correspondencia del *AMBITO* con los tipos de discursos enunciados, de los cuales cabe describir dos: el familiar y el terapéutico.

Hay lugares definidos, sobre todo en la llamada función jerárquica. El sillón o la mecedora de papá y el lugar de mamá están ampliamente establecidos en el sistema de la lengua. Los hijos no ocupan un lugar determinado, son vividos como seres que dan movimiento, vida y sentido a todos los lugares, y su ausencia es vivida como "la casa está vacía".

2do. *CLIMA*: Desde la Grecia Antigua, a través de la noción del simposium, el *CLIMA* de una situación tenía carácter esencial. Muccelli hacía notar que lo que nos queda de nuestra vida familiar, al común de los mortales, son ciertos *CLIMAS* por él llamados "existenciales", que fueron jalonando nuestra edad evolutiva.

No sufrimos solamente por efectos de significación, sino por estados de ánimo, que son consecuencia de ellos o no. Heidegger postula que una de las características de ser ahí es el "encontrarse" en el sentido que todos nos encontramos siempre en un determinado estado de ánimo. Desgraciadamente los hemos asumido, desde nuestra disciplina, como fenómenos de segunda categoría. Quede sí claro que asumiéndonos como terapeutas, en la situación y sintiéndonos las personas que somos, liberaremos nuestras palabras y éstas pesarán con el llamado buen sentido, en su plenitud.

3ro. *FUNCIONES ESPECIFICAS, ATRIBUTOS Y EMBLEMATICA*: En las coronaciones, al rey se le imponían la corona en su cabeza y en sus manos el cetro y el orbe.

Estos tres elementos constituyen la estructura simbólica de la jerarquía humana. El cetro representa lo genuino del poder, el orbe el territorio donde éste se aplica, y la corona, aludiendo a un nivel trascendente, desde dónde proviene el efecto de legitimación.

En lo referente a la familia, al padre y a la madre, les corresponde el poder para hacer cumplir la ley, dominar el territorio, que es su casa, donde se aplica, y un lugar más allá de ellos desde donde se

legitima esa posición: el amor, las leyes o lo sagrado. Sólo aquél que posee los atributos puede conferirlos. Esta operación de carácter ceremonial se realiza en la "situación terapéutica", si ésta se halla bien estructurada.

4to. *HABLA*: El *HABLA TERAPEUTICA* constituye una totalidad afectiva y conceptual que trasciende los marcos teóricos. Por lo tanto, para hacer eficaz nuestro discurso, es necesario figurarlo, es decir utilizar tropos o figuras retóricas.

En la "situación terapéutica", la intervención es primariamente de arte y secundariamente, de ciencia, y tiene por objeto no solamente reestructurar una situación, sino restablecer el sentido del discurso familiar, ese *HABLA* genuina correspondiente al discurso fundante.

SUMMARY

The notion of "Therapeutical family" has its grounds on a structure that takes into consideration the animic tempers, conscience of the function and a concordant speech that configures a different therapeutical attitude, which can be called "therapeutical speech".

A reflection is done about the innermost relations given between climat, and a speech that originates it, maintains it and is also able to transform it.

We observe a narrow relation between the dominated "tropos" or figures and its effects on people's feeling.

We postulate as one of the therapeutical needs, the "effect of legitimization" that refers to the three elements that conform a familiar situation: the climat, the function, the place and as emergent of all this, each one's speech that does as a privileged rule the identity of the system.

This postulation appears as a consequence of the observation and in two ways: one, the practice of the familiar therapy in the doctor's surgery and the other in a clinic-therapeutical institution of intermediate level, which explicitation has been done in another work presented at this congress.

* Virrey Olaguer y Feliú 2735, (1426) Buenos Aires.

** Gorostiaga 1731, (1426) Buenos Aires.

TEORIA SISTEMICA. SU APLICACION CLINICA Y PREVENTIVA

Dr. ELADIO MURGA SAGUE* y Dr. JUAN ANTONIO

BARBAGELATA**

Se refiere a la experiencia de un grupo interdisciplinario de profesionales de la salud mental de la Ciudad de Paraná.

Organizado como grupo de autogestión en el aprendizaje de la teoría y en la técnica del enfoque sistémico, y su aplicación en el campo clínico y preventivo de la familia.

SUMMARY

Area: Teaching and Institutions

Abstract: It reports the experience of an interdisciplinary group of mental health practitioners in the city of Paraná.

It has been organized as a self-governed group for the learning of the theory and technique of the systemic approach and for its application to the clinical and preventive field of the family.

PSICOANALISIS Y TERAPIA FAMILIAR. ALGUNAS ARTICULACIONES.

Dr. EDMUNDO ZIMMERMAN*

Este trabajo se propone indagar acerca de las articulaciones posibles entre psicoanálisis y terapia familiar. Examina algunos de los modelos propuestos y señala que éstos comparten la noción de lo que podría llamarse un "inconsciente familiar". El mismo operaría como una suerte de estructura básica que daría cuenta de las transacciones y modo de comunicación del grupo familiar. Está tramado por los mitos, las alianzas, los secretos, las expectativas, las delineaciones mutuas que los miembros de una familia comparten sin saberlo. Este modelo permitiría no sólo una mejor comprensión de los fenómenos patológicos del paciente en el seno de la familia sino también en el transcurso de un análisis individual.

Para que el psicoanálisis y la terapia familiar puedan fecundarse mutuamente se sugiere la necesidad de revisar y visitar algunos conceptos psicoanalíticos fundamentales y estudiar su correspondencia con ciertas hipótesis caras a los familiólogos. Se señalan algunas articulaciones como posibles temas de investigación: simbiosis/pseudomutualidad, principio de constancia/homeostasis familiar, mito/novela familiar, etc. Una concepción amplia del Edipo que ubicara la leyenda en una trama multigeneracional (inclusión de los mitos complementarios referentes a Layo, tal como lo propone Devereux) podría servir de nexo entre ambos campos de observación.

Por último, se examinan dos conceptos psicoanalíticos básicos —el de identificación proyectiva y el de duelo— en el contexto de las articulaciones descriptas. La identificación proyectiva pasa de ser un mecanismo unidireccional (en la acepción kleiniana original) a convertirse en el instrumento que permite —en el seno de la familia— las "delineaciones defensivas" descriptas por Zinner y Shapiro. Y en el duelo, algo más que un destino o una elección personales hace que "la sombra del objeto" recaiga sobre el melancólico. Todo un grupo familiar puede estar demandando de él que reviva el fantasma de un ausente.

SUMMARY

This paper intends to explore some possible relations between psychoanalysis and family therapy. Reviewing some proposed models it finds that they share the idea of what may be called a "family unconscious". This unconscious is a kind of basic structure which accounts for the transactions and ways of communications of the family group. It is weaved by the myths, the alliances, the secrets, the mutual delineations which the members of a family share without

* 25 de Junio 152, 7º, (3100) Paraná, Prov. de Entre Ríos.

** Santa Fe 515, (3100) Paraná, Prov. de Entre Ríos.

* Juan Mora Fernández 2952, (1425) Buenos Aires.

knowing it. This model allows not only a better understanding of the pathological phenomena of the patient in the family but also of his pathology in an individual analysis.

In order that psychoanalysis and family therapy may be mutually fertilizing it is suggested the necessity to review some basic psychoanalytical concepts and to study its correspondence with certain hypothesis dear to family therapists. Some of these relationships are proposed as possible themes for investigation: symbiosis/pseudomutuality, principle of constancy/family homeostasis, myths/family romance, etc. A wider conception of the Oedipus Complex placing the legend in a multigenerational context (including the complementary myths concerning Laius, as described by Devereux) may be a useful joint between both fields of observation.

Finally, two basic psychoanalytic concepts —mourning and projective identification— are considered under the light of these relationships. Projective identification ceases to be an unidirectional mechanism (in the original kleinian meaning) to become an instrument which allows —in a family context— the “defensive delineations” described by Zinner and Shapiro. And in mourning, something more than a personal choice or destiny makes the “shadow of the object” fall back upon the melancholic. A whole family group may be demanding on him to relive the ghost of an absent.

CONSTITUCION DE UN EQUIPO DE SALUD MATERNO INFANTIL EN CRUZ AZUL - SANATORIO QUINTANA.

Lic. CLARISA VOLOSCHIN DE SIMKIN*

En 1982, después de dos años de constituido el equipo, contamos con los siguientes profesionales: sociólogo sanitaria, psicólogo, 4 obstetras, 3 neonatólogos, un pediatra, 6 parteras de guardia activa.

El objetivo del equipo es trabajar de acuerdo a normas institucionizadas, según criterios multidisciplinarios de atención de la pareja, el grupo familiar, la mujer embarazada y de su bebé. En consecuencia esto implica unificación de normas de atención psicosocial, psicológica y médica en el tratamiento de la pareja en el momento de fundación de su propio grupo familiar.

Dificultades teóricas en la normatización de actividades de prevención de salud mental en el embarazo, parto y puerperio.

Los presupuestos teóricos provenientes del campo de la Salud Mental y su derivación hacia actividades institucionales específicas de atención médica son sólo posibles en forma parcial, por ser multivariantes y relativos a la situación histórica, económica y psicosocial del grupo familiar.

Esto significa que ante cada caso y situación por la que atraviesa la pareja, los profesionales deben pensar la norma a seguir, dependiendo su eficacia tanto del momento institucional como de la evolución histórica del equipo tratante.

Por otra parte, la decisión por parte del equipo de operar como continente en ciertas situaciones de riesgo para el embarazo, ocupa un lugar en la fantasía de la pareja difícil de clasificar a los fines de normatizar. Desde la institución y desde el equipo no se cuenta con indicadores evaluativos de que actividades de las que se llevaron a cabo, permitieron detener procesos que hubieran desembocado en una patología del embarazo, parto o puerperio.

En nuestro sistema, las cuarenta parejas atendidas mensualmente tienen la misma oportunidad de conocer su propio cuerpo, de entender sus reacciones durante el trabajo de parto y el parto, de vincularse tempranamente con su bebé desde otra perspectiva y de utilizar los recursos institucionales según su propia necesidad.

Para lograr este estilo de atención institucional, el equipo instrumenta a la pareja con conceptos provenientes del campo de Salud Mental y, por consiguiente, operamos desde la prevención.

Sin embargo, la capacidad de recepción del mensaje y la posibilidad de provocar conductas que indiquen la aceptación de nuestra ideología

* Soler 4418, 10º, “43”, (1425) Buenos Aires.

de trabajo, dependen de la propia historia familiar y de las resistencias que tenga la pareja para modificarse en un lapso corto.

Desde lo institucional, hemos comprendido que su personal deposita en la pareja embarazada las propias vivencias e historias familiares sobre embarazo y parto y que el rol del agente corrector, comienza desde la terapia de la tarea.

Nuestro equipo se propone indagar, a través de diversas investigaciones, los indicadores de riesgo psicológico y social de la pareja embarazada y los medios técnicos con que se cuenta para prevenirlo.

SUMMARY

The purpose of this team is to work according to institutionalized norms, and following multidisciplinary criteria, the attention of the couple, the family group, the pregnant woman and their baby. Consequently, this implies the unification of norms of psychosocial, psychological and medical attention in the treatment of the couple at the moment of the formation of their own family group.

According to our system, the fourty couples we check monthly, have the same opportunity of knowing their own body, of understanding their reactions during the experience of labour and labour itself, and of starting their relationship with their baby from a different perspective and using the facilities of the institution according to their own needs.

Our team's purpose is to investigate, through different researches the indicators of psychologic and social risk for the pregnant couple and the technical means which are available to prevent it.

ESTRUCTURA FAMILIAR Y ENFERMEDAD SOMATICA

Dra. FLORA CHADE*

La autora se plantea si la dolencia física sería la única posibilidad de un individuo en un contexto familiar, y analiza la historia y organización de la familia en relación al síntoma, en un intento de ver cómo contenido y proceso se afectan mutuamente. La historia familiar sustituye al recuerdo y en ella se encuentra la estructura familiar inconciente, históricamente determinada y conservada en forma estructural que actúa desde tiempos muy lejanos, tiene cohesión y fuerza, carácter universal y se expresa a través de normas, mitos y símbolos familiares.

Considera que la enfermedad surge cual proceso estocástico, como redundancia de hechos, o de contenidos simbólicos, organizándose un retículo de fantasías comunes y de significados que trascienden lo individual, lo familiar y que entroncan con lo filogenético, y cuyo significado es común y compartido. El contexto familiar es el que fija el significado de la enfermedad, y la autora arriesga que es como si en un momento dado todos los miembros de la familia estuviesen "enfermos de la misma enfermedad".

La enfermedad somática como expresión de ideas o conductas regladas por leyes universales puede ser "propiedad común" de los miembros del organismo familiar. Así se explicarían ciertos repertorios de enfermedades familiares cuya reiteración no puede fundamentarse por la herencia biológica.

Asimismo la variedad de enfermedades de una familia constituye el mosaico familiar compartido cuyas modificaciones corresponden a las modificaciones individuales. No se intenta pensar en cada miembro de la familia sino en un modelo circular, de causalidad mutua, donde se busca lo común y también las co-variaciones interdependientes vinculadas a lo individual del sujeto.

SUMMARY

The author raises the question whether physical disorder would be the only possibility of an individual in a certain family context and analyses the history and organization of the family in relation to the symptom in a attempt to see how content and process affect each other. The family history replaces the memory and the unconscious family structure lies in the first one. This structure is historically determined and kept up in a structural form which has been at work for many and remote years. It has cohesion and strength as well as universal character and it expresses itself through family patterns, myths and symbols.

The author considers that sickness springs as a stocastic process, as a redundancy of facts or symbolic contents. A network of common

* Aráoz 2885, 10°, "A", (1425) Buenos Aires.

fantasies and meanings which go beyond the individual or the family instance is organized. This network is connected with the phylogenetic and its meaning is common and shared. It is the family context which determines the significance of the disease and the author risks the idea that it is as if at a certain moment all the members of the family were "suffering from the same illness".

Somatic disease as the expression of ideas or patterns of behaviour ruled by universal laws can be "common property" of the members of the family organism. In this way certain repertoires of family diseases could be explained when its recurrence cannot be based on grounds of biological heredity.

Likewise the variety of diseases in a family makes up the shared family mosaic and its changes are correspondent with the individual changes. It is not attempted to think with each member of the family but rather about a circular model of mutual causality where the common is searched and also the interdependent co-variations related to the individual in the subject.

ALGUNOS CUESTIONAMIENTOS ACERCA DE LA FUNCION DEL TERAPEUTA

Dra. M. CRISTINA RAVAZZOLA DE MAZIERES*

Se trata de un análisis de: a) la relación Terapeuta-Consultante (paciente), pensada desde la perspectiva de considerarla un sistema abierto, y, por lo tanto, sujeta a tendencias cohesivas y a tendencias transformativas; y de b) la "función", entendida en la aplicación interaccional de su concepción matemática, del Terapeuta en ese sistema, a quien el Consultante "delega" lo que supone que no "tiene" o no "puede".

Este análisis lleva implícito, por un lado, la noción de un proceso, con sus propias leyes de funcionamiento, inscripto en una estructura constituida por componentes interrelacionados y que, en tanto proceso, toma en cuenta el factor tiempo para su definición; y, por el otro, el cuestionamiento de la posición paradójica del Terapeuta en esa estructura, por la que debe actuar asegurando un cambio que significa la disolución de la estructura que le da identidad como tal.

En el trabajo se muestran ejemplos ilustrativos de otras organizaciones estructurales en las que prevalecen las funciones cohesivas que mantienen estático el sistema, y se proponen algunos recursos técnicos que posibilitan al Terapeuta una meta-mirada sobre el sistema que le consienta una evaluación del momento del proceso adecuado para la elección de cada intervención transformativa.

Y, finalmente se plantea el desempeño de la función terapéutica siempre a cargo de un equipo de dos o más terapeutas, con diferente distancia con respecto al Consultante, como garantía de una "función" efectivamente terapéutica, especialmente en el caso de las complejas intervenciones familiares. (Un terapeuta en contacto directo con la familia, trabajando con otro que permanece fuera monitoreando la intervención, y participando en la elaboración de la misma, como un ejemplo.)

SUMMARY

This paper emphasizes the so called "function" of the Therapist as a member of the therapeutic system, function analysed from the point of view that the therapeutic system is an open system that, therefore, tends to preserve itself with cohesive tendencies while tends to promote growth and independence through differentiative lines of behavior.

The therapist, then, needs to belong to the structure Family-The-

* Dorrego 2381, (1425) Buenos Aires.

rapist and, at the same time, have a permanent perspective of it from outside the system, so as to be aware of the adequate intervention to assure change.

Different therapeutic approaches bring useful contributions to this issue, helping the therapist to create, in a way, alternative imaginary fields that enable him to, being inside the therapeutic system, dissociate himself and have a metaperspective of his relationship with the consultant in every moment of the therapeutic process.

The author stresses the point that specially in the difficult Family Therapy area, all this needs to be reinforced and the only successful way seems to be the real presence of another therapist, in a different level of involvement that, in a working team with the therapist, can bring the so much needed metaperspective.

EL ENFERMO ORGANICO. DE LA RELACION MEDICO - PACIENTE A LA TERAPIA FAMILIAR.

Dr. SAUL KAROL*

El autor se propone mostrar cómo desde diversos campos de la psicoterapia se pudo encontrar a la familia.

En su caso lo hizo como miembro de un equipo de interconsulta médico-psicológica, a su vez perteneciente a un importante servicio de Psicopatología incluido en un hospital general.

Señala que en su tarea institucional, basada sobre todo en los conceptos de Michael y Enid Balint acerca de la relación médico-paciente, la familia de este último era generalmente sólo tomada en cuenta como un dato de la historia clínica, a lo más para explicarse psicodinamismos o ansiedades; que esa carencia no se daba solamente en el país, citando al respecto alguna comunicación del exterior demostrativa, que en su práctica hospitalaria, a través de indicaciones terapéuticas, plan de cuidados y administración de otras medidas y recursos, sobre todo cuando el paciente ya pasa a su hogar, se "organiza" la enfermedad y con ello se actúa sobre el medio familiar, aun sin proponérselo conscientemente.

Luego, los conceptos del Dr. Bleger con respecto al encuadre psicoanalítico y la patología de su rigidez cuando ella se presenta, los del Dr. Ulloa referentes a la psicología institucional y a los fenómenos que se producen en toda institución que comúnmente se liga a la enfermedad y por último los desarrollos propios de la terapia familiar, que aúna a los clásicos de psicopatología, psicoanálisis, psicofarmacología, enriquecen un modo más abarcativo, comprensivo y humano de entender al enfermo y su entorno familiar, así como a la psicogénesis de muchas manifestaciones patológicas.

Enumera luego algunos conceptos que juzga muy significativos de terapeutas familiares de renombre: Stierlin, Jackson, Minuchin. Agrega datos de su propia experiencia, el autor, y un cierto número de situaciones que ejemplifican la importancia de los conceptos aprendidos de la terapia familiar para la comprensión y tratamiento de familias con un miembro orgánicamente enfermo.

SUMMARY

The author intends to show how the family was met with, working from diverse fields of psychotherapy. In his case, he did so as a member of a team for medico-psychological interconsultations within a large Psychopathology Department in a general hospital.

He points out that in his work in the institution, based mainly on

* 3 de Febrero 1729, (1426) Buenos Aires

the concepts of Michael and Enid Balint on the doctor-patient relationship. The family of the patient was generally taken into account only as a fact of the clinical history or at the most as an explanation of psychodynamics or anxieties; this deficit existed not only in his country, quoting a foreign text demonstrating this to be so; in his hospital practice, through therapeutic prescriptions, care plans and the administrations of other measures and resources, specially when the patient goes home, the illness becomes "organized" and in this way the patient acts upon the family milieu even without meaning to do so consciously.

Later, Dr. Bleger's concepts on the psychoanalytic setting and the pathology of its rigidity when present, those of Dr. Ulloa referring to institutional psychology and to the phenomena occurring in all institutions, commonly linked with the illness, and finally, the developments of family therapy itself which unite the classics of psychopathology, psychoanalysis, psychopharmacology, enrich a far-reaching, more comprehensive and humanitarian manner of reaching the patient and his family, as well as the psychogenesis of many pathological manifestations.

The author then enumerates some very meaningful concepts of family therapists of reknown: Stierlin, Jackson, Minuchin. He adds facts from his own experience, and a number of situations which exemplify the importance of the concepts taught by family therapy for the understanding and treatment of families with an organically ill member.

UN MODELO DE PROFILAXIS FAMILIAR: LA FORMACION DE AGENTES DE SALUD

Dr. ALBERTO VAZQUEZ*

* Bulnes 2515, 9º, "D", (1425) Buenos Aires.

FUNCION DEL ASISTENTE SOCIAL EN LA EVALUACION Y ORIENTACION DE FAMILIAS EN PROCESO DE DIVORCIO. ALGUNAS CONSIDERACIONES TEORICO - PRACTICAS.

Lic. MIRTHA CIMADORO*

* Pje. M. y Pelayo 339, (1407) Buenos Aires.

LOS ARGENTINOS DE ORIGEN JUDIO Y EL CONFLICTO DE UNA MISION IMPOSIBLE

Lic. SUSANA MUCHNIK*

* Gorostiaga 1731, (1426) Buenos Aires.

LABORATORIOS

FAMILIA, COMUNICACION Y RECURSOS EXPRESIVOS. (CUANDO, COMO Y POR QUE UTILIZARLOS.) PRESENTACION DE UN CASO CLINICO.

Coordinadora: Lic. EVA WALDMAN DE SLATOPOLSKY*

Sintetizadora: Lic. BERTA SPERBER**

El laboratorio comienza con la presentación de la coordinadora y del grupo sólo a través del nombre y de la profesión.

Se plantean los objetivos del laboratorio:

1. — vivenciar.
2. — reflexionar.

Fue un obstáculo en la puesta en marcha de la tarea lo limitado y bullicioso del espacio. Esto fue integrado por la coordinación como ejemplo de los muchos imprevistos que también son propios del trabajo con familias.

1er. MOMENTO: vivencial.

- a) Percepción del propio cuerpo.
- b) Reconocimiento del espacio individual y grupal.
- c) Concientización de zonas de tensión en el cuerpo.
- d) Movimiento y gesto.
- e) Reconocimiento de las manos. Diálogo entre ellas.
- f) Trabajo gestual en pareja con técnica de espejo.
- g) Trabajo con máscaras.
- h) Dramatización de una situación familiar con técnica de estatuas.

2do. MOMENTO: reflexivo.

a) Cuando, cómo y por qué implementar técnicas expresivas con familias.

b) Sentido del espacio - tiempo - movimiento y energía.

c) Ilustración de las preguntas sobre las técnicas en el campo clínico; actitud directiva del terapeuta, comprometida, importancia fundamental del timing, maniobras terapéuticas, indicaciones y contraindicaciones de la movilización de sentimientos.

— Se reconstituyó en el aquí y ahora una situación análoga a la de un sistema familiar.

— Se tomó al sistema familiar, su espacio y los espacios personales en el interior del sistema espacios que rodean, entornan a los individuos y que son ocupados por ellos.

— La situación vivencial fue la de percibir situaciones de cambio y transformación constante, donde el tiempo cobró significado fundamental.

— También se debió agregar a la complejidad espacial del sistema la

* Boedo 1342, 3º, (1239) Buenos Aires.

**Gorostiaga 1731, (1426) Buenos Aires.

toma en consideración de los movimientos de los mismos, los unos en relación con los otros.

— Todo este abordaje teórico técnico fue sintetizado con la utilización de la dramatización de la técnica de las estatuas, donde todo estuvo representado en manera abstracta pasando de la quietud al movimiento.

— La coordinadora prefirió no ahondar en un desarrollo teórico extenso a fin de que los presentes pudieran reflexionar consigo mismos acerca de lo vivenciado.

SUMMARY

The sense of this laboratory was centred in the understanding of when, how and why the expressive techniques should be used in the family therapeutic process.

For that purpose, the task was centred on the following values according to the Kantor's research:

— To respect the individual in his uniqueness and in what he shares with others. He must control his personal space to avoid harming or being harmed.

— The family system, its space and personal spaces within it were dealt with.

— The situation experienced was that of perceiving situations of change and transformation. The time got a fundamental meaning. It was observed that the individuals and the system evolved towards differentiation, complexity and integrity. It was also observed that in order to change, the individual had to transcend the system where he lived and for that purpose he had to know its functioning. Active and interventionist techniques were used. Work was done by means of bodily techniques using masks and the technique of statues.

MODOS Y NIVELES DE COMUNICACION

Lic. ESTERA GORANSKY*

* Santa Fe 435 Oeste, (5400) San Juan.